Zdraví blíž lidem

Studie reformy zdravotnictví, konzultační verze v3.1 (23. 10. 2026)

Josef Pavlovic, resortní tým Zdravotnictví

Datum verze: 23. 10. 2026

Čte se vám to lépe jako PDF? Tady je celá studie.

Připomínky nám ale prosím pošlete souhrnně, ne jako poznámky vepsané do PDF. Nejlepší cesta je formulář na webu **https://web-b5qk.vercel.app/studie**: u každého odstavce je tlačítko „Připomínka“ a dole na stránce formulář pro připomínku ke studii jako celku. Stačí jméno a e-mail; nic z toho nezveřejňujeme. Pokud píšete za organizaci, pošlete jednu souhrnnou připomínku s odkazem na část a odstavec studie.

Interaktivní grafy, časové osy a kalkulačky jsou ve čtečce na webu; v PDF jsou jejich statické podoby. Místa označená „Ověřit“ jsou údaje, které autoři zatím neověřili v primárním zdroji.

Obsah

Zdraví blíž lidem
- Stav dokumentu a jak ho číst
  - Střet zájmů
  - Z čeho studie vychází: Hospodářská strategie PEER
- Manažerské shrnutí
  - Co chceme
  - Co všechno se musí stát
  - Co na co navazuje a proč
  - Kolik to stojí a kdo to zaplatí
  - Kdy
  - Co děláme do voleb 2029
  - Co od vás potřebujeme
  - Co reforma nedělá a co ji nejvíc ohrožuje
- Část I — Výchozí stav: proč měnit
  - Nemocniční těžiště výdajů
  - Praktiků ubývá a stárnou
  - Odvratitelné hospitalizace a úmrtnost
  - Sestry a další personál
  - Dlouhodobá péče a sociálně-zdravotní pomezí
  - Peníze: pojištění ve schodku, rezervy klesá
  - Zdravotní rizika a prevence
  - Od problému k opatření
- Část II — Logika reformy
  - Cíl reformy a pět měřitelných cílů
  - Teorie změny
  - Tři vrstvy opatření
  - Pět pilířů
  - Varianty A, B a C
  - Cesta pacienta
  - Co reforma nedělá
- Část III — Jádro reformy: primární péče a digitální nástroje (pilíře 1 a 3)
  - J1 · Standard týmu sdružené péče a pětiletá smlouva
  - J2 · Sesterská složka úhrady a rozšířené kompetence sester
  - J3 · Kompetence praktiků
  - J4 · Návštěvní služba a doprava k lékaři
  - J5 · eŽádanka s triážním údajem, měření čekání a lidí bez praktika
  - Děti a PLDD: dětské týmy zůstávají
  - Večery, víkendy a pohotovost
  - Výkup praxí odcházejících lékařů
  - Ambulantní specialisté, konzultace lékař–lékař a zpětná zpráva
  - Pilíř 3 · Digitální nástroje a eŽádanka jako infrastruktura
  - Pilíř 3 · Dálkové sledování
  - Pilíř 3 · AI zapisovatel
  - Pilíř 3 · Portál pacienta a pravidla pro digitální nástroje
- Část III — Jádro reformy: síť lůžkové péče (pilíř 2)
  - Náběh přeměny 2024–2038
  - Výchozí stav po krajích
  - J6 Krajský plán sítě lůžkové péče
  - Jak vzniká krajský plán
  - J7 Kapacita následné a dlouhodobé péče jako podmínka přeměny
  - Fond přeměny a garance příjmu
  - Minimální objemy a centralizace
  - Porodnictví: porodní asistentky místo pouhého rušení porodnic
  - Indikační omezení místo objemových limitů
  - Pediatrická lůžka
  - Dojezd záchranné služby a garance dostupnosti
  - Pandemická rezerva
  - Pojistky
- Část III — Jádro reformy: prevence, daně za zdraví a péče doma (pilíře 4 a 5)
  - Pilíř 4: daně za zdraví podle Hospodářské strategie PEER
  - J8: daň z tichého vína a valorizace daní z lihu a piva
  - J9: pásmová daň ze slazených nápojů
  - Pil4.11 a Pil4.12: tabák a nikotin zdaněné víc, prevence odměněná
  - P4: Fond prevence zdravotních pojišťoven
  - Minimální cena alkoholu a další regulace bez výnosu
  - Ostatní prevence: zubní prevence, očkování, navigace, krátká intervence
  - Pilíř 5: sociální účet a pomezí zdravotní a sociální péče (P3)
  - Pilíř 5: péče doma a paliativní týmy
  - Pilíř 5: závěr života a dříve vyslovené přání
  - Harmonogram pilířů 4 a 5

- Část IV — Co na co navazuje a proč
  - Graf závislostí
  - Proč nejdřív A, pak B
  - Co když se to nepovede
  - Kdo plánuje, platí a řídí: dnes a po reformě
  - Toky peněz dnes a po reformě
- Část V — Peníze a lidé
  - Kolik stojí provoz
  - Úspory bez překryvů
  - Čistý náklad a citlivost
  - Varianty A, B, C
  - Náběh po letech
  - Investice
  - Odkud peníze
  - Lidé
  - Otevřenost modelu
- Část VI — Vztah k reformám, které prosazuje vláda
  - Deset předloh a náš postoj
  - Vládní reformy a náš plán na jedné ose
  - 1. 1. 2029: souběh
  - Co z toho plyne pro opoziční období
- Část VII — Legislativní mapa: co se musí změnit a jak velké to je
  - Vlna 0: co jde z opozice v letech 2027–2028
  - Vlna 1: peníze a daně (předložit 2030, účinnost 1. 1. 2031)
  - Vlna 2: primární péče (předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032)
  - Vlna 3: síť lůžkové péče (předložit 2031, přijmout 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033)
  - Vlna 4: dokončení (předložit 2032–2034, účinnost 2033 a později)
  - Jak dlouho trvá zákon
  - Legislativní zátěž podle let
  - Tři řízení vůči Evropské komisi
  - Co jde bez zákona
  - Věcné záměry k napsání v opozici
  - Ověřit před podáním návrhů
- Část VIII — Proces změny: fáze, brány a harmonogram 2026–2038
  - Fáze a brány
  - Harmonogram 2026–2038
  - Dva scénáře
  - Konzultační fáze 2026–2029
  - Pilot ve třech ORP
  - Řízení reformy
  - Pravidla rozhodování a kapacita státu
- Část IX — Ukazatele a vyhodnocení
  - Nadřazený cíl: +5 let života ve zdraví
  - Osm hlavních ukazatelů
  - Dvanáct doplňkových ukazatelů
  - Kdo měří a kdy
  - Data pro brány
  - Převodník z verze 2
- Část X — Rizika a pojistky
  - Matice rizik
  - Registr rizik
  - Co by nás zastavilo
  - Jak reforma zmenší rozsah
- Část XI — Deset oblastí Manifestu: policy briefy
  - 1. Hodnocení účelnosti a standard péče
  - 2. Rozšířená péče: možnost volby bez úplatků
  - 3. Pojišťovny, DRG a evidence nároků
  - 4. Transparence a otevřená data
  - 5. Dostupné léky
  - 6. Světový klinický výzkum
  - 7. Stomatologie
  - 8. Vzdělání a podmínky personálu
  - 9. Práva pacientů
  - 10. Duševní zdraví
  - Odchylky od programu 2021 shrnutě

Příloha A — Registr opatření

- Počty podle vrstvy a nástroje
- Jak číst registr
- Jádro a podmínky (J1–J10, P1–P5)
- Pilíře: doplňková opatření (Pil1.1–Pil5.7)
- Doprovod: 10 oblastí Manifestu (M1.1–M10.5)

Duplicity, které v3 sloučila
Legislativní zátěž podle roku

Příloha B — Vypořádání oponentního posudku
Vypořádání posudku
Deset výhrad verdiktu
Dvacet oprav
Otevřená ověření

Příloha C — Evidence a zdroje
Tabulka důkazů
Pilíř 1: týmy, kontinuita, sestry
Pilíř 2: lůžka, centralizace, obložnost
Pilíře 3 až 5: technologie, daně, paliativa
Citace, které se ve v3 mění
Seznam zdrojů
Datové zdroje
Legislativní zdroje
Odborná literatura
Vlastní podklady strany
Co zůstává ověřit před zveřejněním

Zdraví blíž lidem

Studie reformy zdravotnictví · verze 3.1 (konzultační) · 23. 10. 2026 · Josef Pavlovic

Stav dokumentu a jak ho číst

Toto je konzultační verze 3.1 z 23. 10. 2026 (verze 3 z 20. 10. 2026 s opravami čísel); slouží k získání podpory odborných subjektů pro plán, který chce předložit vláda vzešlá z voleb v říjnu 2029.

Termíny a cíle platí pro základní scénář „Vláda 2030“, ve kterém Piráti vstoupí do vlády od přelomu 2029/2030. Doplňkový scénář „Dnešní vláda převezme část“ má nízkou pravděpodobnost a počítá jen s vlnou 0 o 1–2 roky dříve.

Komu je určena. Hlavním čtenářem je odborná veřejnost: komory, sdružení praktiků, sestry, pojišťovny, kraje, obce, nemocnice, pacientské organizace, odbory a potenciální koaliční partneři. Veřejnost dostane zkrácenou verzi.

Jak připomínkovat. Připomínky lze vložit komentářem přímo do dokumentu, nebo poslat e-mailem resortnímu týmu. Ověřit: e-mailová adresa resortního týmu. První kolo připomínek končí 31. 3. 2027. Kulaté stoly proběhnou v roce 2027. Vypořádání bude zveřejněno před bránou `B1` (červen 2028).

Ověřujeme

Co se změnilo proti verzi 3. Verze 3.1 opravuje a dokládá čísla a přidává dvě opatření, která ve verzi 3 chyběla: komunitní porodní asistenci jako odpověď na rušení porodnic (`Pil2.6` , Část III), pravidla pro střet zájmů v komisích a poradních orgánech ministerstva (`M4.5` , oblast 4) a postupný růst daní z tabáku a nikotinu s podporou těch, kdo chodí na prevenci (`Pil4.11` a `Pil4.12` , pilíř 4; výnos mimo plánovací hodnotu 5 mld. Kč). Studie nově výslovně vychází ze schválené Hospodářské strategie PEER: přebírá její nadřazený cíl (+5 let života ve zdraví během jedné generace), pravidlo nejméně 40 % výnosu daní za zdraví pro Fond prevence zdravotních pojišťoven a model zvýhodnění těch, kdo aktivně pečují o své zdraví (`Pil4.12`); přehled je v oddílu „Z čeho studie vychází“. Ostatní opatření, jejich kódy ani model nákladů nemění. Pro ověření dat jsme použili i dokument MZ ČR, Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví 2025 (dále „MZ ČR 2025“), a kde to šlo, číslo dokládáme primárním zdrojem.

- Sestry: místo „přes 30 000 úvazků“ a „1 300 absolventek“ čísla z vládního programu pro nelékařské profese 2026–2037 (nejméně 24 000 úvazků všeobecných sester za 10 až 12 let; 680 absolventů VŠ a 570 VOŠ ročně); 440 sester ročně je asi čtvrtina všeobecných sester ze škol v letech 2026–2037, ne třetina; věk sester doplněn.
- Lůžka dlouhodobé péče: jeden zdroj čísla 39 000 (Přecechtěl a Hlávka 2025, zdravotní i sociální lůžka) a vedle něj zdravotní část potřeby (dnes chybí 2 až 3 tisíce, do roku 2035 dalších nejméně 8 tisíc); opravena věta o „pětině potřeby“.
- Rezidenční místa: skutečné počty 2023–2025 (VPL 150, 140, 140; pediatrie 80, 70, 70).
- DRG: vedle rozpětí krajských sazeb druhá veličina, podíl akutní lůžkové péče hrazené jednotnou základní sazbou.
- eŽádanka: první fáze pokrývá jen laboratorní a obrazová vyšetření, triážní údaj u ambulantních specialistů vyžaduje rozšíření; doplněn zdroj k eReceptu.
- Screening: Národní screeningové centrum, účast na kolonoskopii po pozitivním testu a nová cílová skupina 45–75 let od roku 2026.
- Kompetence sester: zmírněno podle platných vyhlášek; doplněna úprava indikace domácí péče sestrou od 1. 1. 2026.
- Sjednocené vedlejší nálezy: spotřeba alkoholu, počet atestací ve všeobecném praktickém lékařství, podíl lékařů nad 55 let.
- Kontrolní bod `B1` : místo písemné podpory aspoň 6 z 10 organizací plán projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi a jejich výhrady zapracované (rozhodnutí autora z 23. 10. 2026).

Co se změnilo proti verzi 2.

- Rámec: období 2029/2030 a dva scénáře.
- Tři vrstvy opatření; jádro tvoří 10 opatření.
- Přepočítaný model: čistý náklad v plném náběhu 15–25 mld. Kč ročně (ceny 2026).
- Daně za zdraví: jedno číslo, 5 mld. Kč ročně, a pravidlo rozdělení.
- Nové části: vztah k vládním reformám, legislativní mapa ve vlnách, proces s branami a co na co navazuje.
- 20 ukazatelů: 8 hlavních a 12 doplňkových.
- Registr opatření a vypořádání posudku jako samostatné záložky.

Jak číst. Tabulka ukazuje, která část odpovídá které roli. Manažerské shrnutí stačí pro první orientaci.

Část	O čem je	Pro koho hlavně
Manažerské shrnutí	Cíle, pilíře, čísla a termíny na jedné straně	Vedení subjektů, média
Část I Výchozí stav	Stav systému a data, ze kterých vycházíme	Odborná veřejnost
Část II Logika	Proč tato opatření a jejich pořadí	Koaliční partneři, politici
Část III Pilíře 1–5	Konkrétní opatření po pilířích (1+3, 2, 4+5)	Praktici, sestry, kraje, obce

Část	O čem je	Pro koho hlavně
Část IV Co na co navazuje	Vazby mezi opatřeními	Resortní týmy, odborníci
Část V Peníze a lidé	Náklady, financování, počty sester a týmů	Ministerstvo financí, pojišťovny
Část VI Vládní reformy	Vztah k reformám MZ a navrhované úpravy	Ministerstvo zdravotnictví
Část VII Legislativa	Zákony, novely a podzákonné předpisy ve vlnách	Právníci, legislativa
Část VIII Proces	Fáze, brány a řízení reformy	Kraje, obce, pacienti
Část IX Ukazatele	20 ukazatelů a jejich cíle	Analytici, nezávislý hodnotitel
Část X Rizika	Co může selhat a jak na to reagovat	Vedení reformy
Část XI Manifest	10 oblastí jako krátké policy briefy	Veřejnost
Záložka Registr opatření	Seznam opatření, rizik a ukazatelů	Projektová kancelář
Záložka Vypořádání posudku	Odpověď na každou připomínku oponentury	Oponenti, odborníci
Záložka Evidence a zdroje	Studie a PMID, na nichž stojí tvrzení	Odborníci, novináři

Oponentura. Verze 2 prošla oponentním posudkem z října 2026. Verze 3 vypořádává všechny jeho připomínky v záložce Vypořádání posudku. Ověřit: jména oponentů verzí 1 a 2 doplní RT.

Ověřujeme

Střet zájmů

Autor je členem Správní rady VZP, členem PEER a autorem HSPA Monitoru. Studie navrhuje pilot s VZP a mění složení správních rad, proto čtěte tyto části s tímto vztahem na paměti. Vyhodnocení pilotu zajišťuje nezávislý hodnotitel jmenovaný před startem. Ve Správní radě VZP se autor zdrží hlasování o pilotu a o smlouvách souvisejících s reformou.

Z čeho studie vychází: Hospodářská strategie PEER

Studie rozpracovává dva dokumenty strany. Manifest reformy českého zdravotnictví (7. 5. 2026) dává třináct oblastí a jejich sliby (Část XI). Hospodářská strategie Pirátské expertní ekonomické rady (PEER), schválený programový dokument strany ze srpna 2026, dává v kapitole 1.4 „Zdraví a soběstačnost přinesou silnější ekonomiku“ cíl, čísla a pravidla, ze kterých studie vychází. Kde se studie a strategie liší v rozsahu nebo načasování, platí strategie jako program strany a studie uvádí, proč s něčím v rozpočtu reformy počítá opatrněji.

Hospodářská strategie PEER (kap. 1.4)	Kde ve studii	Jak to studie přebírá
Nadřazený cíl: prodloužit délku života ve zdraví o 5 let během jedné generace	Co chceme; Část IX, nadřazený cíl	Převzato jako cíl, ke kterému míří všech pět cílů a 20 ukazatelů
Úhrady lékařům za krátké intervence a nasměrování k programům životního stylu, ne za počet prohlídek	`J1` (odměna za výsledky), `Pil4.9`	Převzato
Spotřební daň ze slazených nápojů, zdanění tichého vína, úprava daní z alkoholu; výnos 10 až 15 mld. Kč ročně	`J8`, `J9`, Pilíř 4	Převzata všechna tři opatření. Rozpočet reformy plánuje opatrně s 5 mld. Kč (rozpětí 5 až 7) a cíl PEER uvádí vedle; rozdíl není výdajem reformy
Nejméně 40 % výnosu účelově do Fondu prevence zdravotních pojišťoven	`P4`	Převzato; zákon navíc stanoví dolní hranici 2 mld. Kč pro roky nižšího výnosu
Přesun péče z lůžek: podíl nemocniční péče na rozpočtu z 46,5 % k průměru EU 36,4 % do roku 2035; regionální sítě nemocnic; kapacity domácí a terénní péče ve stejném čase	`J6`, `J7`, `Pil2.2`; `H6`	Převzat směr i podmínka souběžných kapacit; ukazatel PEER sledujeme vedle H6. Kolik z 10 procentních bodů pokryjí opatření studie, zatím nevyčíslujeme. Ověřit: propočet pro verzi 4
Hodnocení nákladové efektivity pro všechny hrazené intervence, se započtením úspor v sociálním systému	Oblast 1 (`M1.1` – `M1.4`)	Převzato, včetně sociálních úspor
Neformální pečující, terénní, asistenční a odlehčovací služby (navýšení financování o 40 až 50 mld. Kč za deset let), deinstitucionalizace, personál sociálních služeb	Pilíř 5, `P3`, `Pil5.4`	Převzat směr; navýšení je výdajem MPSV, krajů a obcí mimo model reformy (21,5 mld. Kč)
Financování dlouhodobé péče: u seniorů prověřit vyšší spoluúčast, pojištění dlouhodobé péče a majetkové testování; u lidí se zdravotním postižením stát a asi 3 % krajského a obecního RUD	`P3`	Převzato jako zadání k prověření ve fázi F1; zákon o pojištění dlouhodobé péče jen při rozhodnutí (vlna 4)
Zvýhodnění těch, kdo aktivně pečují o své zdraví: část pojistného navázaná na doložitelné zapojení a zlepšení v čase, ne na razítko z prohlídky; pilotně a povinně pro ročníky do 40 let, s reformou daně z příjmů fyzických osob	`Pil4.12`	Převzato
Další peníze přes odvody jsou vyčerpané; změna pojistného jen spolu s úpravou daně z příjmu	Část V	Převzato jako pravidlo: reforma odvody nemění, a pokud se pojistné někdy zvýší, pak jen s nižší daní z příjmu

Ověřujeme

Manifest a strategie se rozcházejí v jednom bodě. Manifest chce dnešní fond prevence pojišťoven přeměnit na fond rozšířené péče, strategie posílá výnos daní do Fondu prevence zdravotních pojišťoven. Studie drží obojí: dnešní fondy prevence, plněné ze zisku pojišťoven a bez pravidel, se mění na fondy rozšířené péče (`M2.3`) a nový Fond prevence zdravotních pojišťoven plní zákonem podíl daní za zdraví podle pravidel strategie (`P4`).

Manažerské shrnutí

Kolem roku 2038 má každý obyvatel svůj tým primární péče se sestrou, která má vlastní pacienty, 8 000 akutních lůžek je přeměněno na následnou a dlouhodobou péči a zdravotní pojištění má stabilní zdroj z daní za zdraví a nového vzorce platby státu. Reforma bude v plném náběhu stát čistě asi 21,5 mld. Kč ročně (rozpětí 15 až 25 mld. Kč, ceny 2026), tedy necelá 4 % dnešních výdajů zdravotního pojištění; první zákony nabývají účinnosti 1. 1. 2031 a 1. 1. 2032 ve scénáři „Vláda 2030“. Roky 2026 až 2029 jsou konzultační: představujeme plán a hledáme pro něj podporu; do voleb chceme mít dohodu s odborníky, hotové věcné záměry zákonů a běžící pilot.

Co chceme

Kolem roku 2038 má každý obyvatel Česka svůj tým primární péče a jmenovitého lékaře, ke specialistovi se dostane podle naléhavosti a na akutním lůžku leží jen tehdy, když ho skutečně potřebuje. Nad tím stojí cíl z Hospodářské strategie PEER: prodloužit délku života ve zdraví o pět let během jedné generace (dnes 61,2 roku u mužů a 62,4 roku u žen, průměr EU 63,5 a 64,2). Cíl se rozpadá na pět měřitelných cílů, jeden za každý pilíř; každý má hlavní ukazatel z Části IX. Hodnoty pro rok 2033 jsou data za rok 2032, tedy první rok účinnosti zákona o primární péči.

Cíl	Hlavní ukazatel	Dnes	2033	Kolem 2038
1. Každý má svůj tým a jmenovitého lékaře	lidé bez registrujícího praktika (H1); týmy a obsazená místa sester (H2); kontinuita, index UPC (H4)	0 týmů podle standardu; UPC se neměří	v ORP s týmem aspoň o polovinu méně lidí bez praktika; obsazeno aspoň 50 % míst sester; UPC aspoň 0,7	520 týmů a asi 4 000 sester navíc; 0 lidí bez praktika v ORP s týmem; obsazeno aspoň 80 % míst
2. Akutní lůžko jen tam, kde je potřeba	podíl akutní lůžkové péče na výdajích (H6)	29,7 % (2024); 48 036 akutních lůžek	28 %	26 %; 8 000 přeměněných lůžek (ze 48 036 na asi 40 000, ze 4,4 na 3,7 na 1 000 obyvatel)
3. Ke specialistovi podle naléhavosti	čekání podle triážní kategorie eŽádanky (H3)	neměří se	aspoň 80 % urgentních ve lhůtě	aspoň 90 % ve všech kategoriích
4. Méně nemocí, kterým lze předejít	odvratitelná úmrtnost (H7)	107,2 léčitelných úmrtí na 100 000 (EU 86,8)	sledujeme bez cíle; daně za zdraví účinné od 1. 1. 2031	sledujeme bez cíle; daně za zdraví 5 mld. Kč ročně, z toho 2 mld. Kč Fondu prevence
5. Péče doma, ne na lůžku z nouze	odvratitelné hospitalizace na 100 000 obyvatel (H5)	592	550	530

Všech pět cílů má jednu společnou podmínku: nesmějí růst přímé platby pacientů. Hlídá ji ukazatel katastrofických výdajů domácností (H8): dnes 6 % domácností, v nejchudší pětině 21 %, a nesmí se zhoršit. Cílové hodnoty jsou návrh k diskusi v konzultaci.

Co všechno se musí stát

Mezi schválením této verze 7. 12. 2026 a cílovým stavem kolem roku 2038 leží 29 kroků; 13 z nich lze udělat v opozici, zbytek potřebuje vládu od přelomu 2029/2030. Tabulka je úplná a v pořadí, v jakém kroky musí nastat; sloupec „závisí na“ odkazuje na čísla řádků. Termíny platí pro základní scénář „Vláda 2030“; co z toho může převzít dnešní vláda dřív, je označeno.

#	Co se musí stát	Nástroj	Kdo	Nejdřív kdy	Závisí na
1	Resortní tým schválí verzi 3 ke konzultaci (schůzky 27. 10., 9. 11. a 7. 12. 2026) a rozdělí věcné záměry mezi garanty	rozhodnutí RT	RT, Institut Pi	7. 12. 2026	—
2	Konzultace: první kolo připomínek, devět kulatých stolů, projednání plánu s 10 klíčovými subjekty a zapracování jejich výhrad	konzultace, memoranda, zveřejněné vypořádání	RT; SPL ČR, SPLDD ČR, ČAS, ČLK, VZP, SZP ČR, Asociace krajů ČR, SMO ČR, pacientské organizace, odbory	připomínky do 31. 3. 2027; stoly 2/2027–6/2028	1
3	Podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 (sestry u týmových praxí, platba za funkce) a do seznamu výkonů (konzultace lékař–lékař, telemonitoring, ultrazvuk u praktika)	úhradová vyhláška 2028, vyhl. 134/1998 Sb., vyhl. 55/2011 Sb.	kluby poskytovatelů a pojišťovny, které podnět převezmou; rozhoduje MZ	podat do 30. 6. 2027; účinnost 1. 1. 2028 jen při vůli dnešního MZ, jinak 1. 1. 2031	2
4	Dohoda o pilotu ve třech ORP: kraj, který se přihlásí, VZP a obce	smlouva pojišťovny s týmem podle § 17 zák. 48/1997 Sb.; rozpočty kraje a obcí	kraj, vedení VZP (ne Správní rada), obce	do 30. 6. 2027	2
5	Jmenování nezávislého hodnotitele pilotu, zveřejněný protokol a kontrolní ORP	smlouva o hodnocení	ÚZIS s univerzitou; kraj a VZP	do 12/2027	4
6	Pozměňovací návrhy k vládním předlohám: reforma v. z. p. 2030 (víceleté smlouvy i pro týmy), novela zák. 325/2021 Sb. (triážní údaj v eŽádance), reforma hygienické služby (prevence v NIVZ)	pozměňovací návrhy poslaneckého klubu	poslanecký klub	2027–2028 podle projednávání ve Sněmovně	2
7	Start pilotu ve třech ORP, provoz dva roky	smlouvy z řádku 4	týmy, VZP, kraj, obce	1. 1. 2028; provoz 2028–2029	4, 5

#	Co se musí stát	Nástroj	Kdo	Nejdřív kdy	Závisí na
8	Strana potvrdí plánovací hodnotu daní za zdraví pro rozpočet reformy (5 mld. Kč ročně, rozpětí 5–7) vedle cíle Hospodářské strategie PEER (10–15 mld. Kč) a pravidlo dělení podle PEER: nejméně 40 % Fondu prevence, nejméně 2 mld. Kč, zbytek platbě státu	usnesení strany	předsednictvo na návrh RT a PEER	do 6/2028	2
9	Brána B1 „Mandát“: připomínky vypořádané a zveřejněné; plán je projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi a jejich výhrady jsou zapracované; pilot podepsán (jinak náhradní smluvní model u jedné pojišťovny); plánovací hodnota daní potvrzena	veřejné rozhodnutí RT a strany	RT	6/2028	2, 4, 6, 7, 8
10	Věcné záměry: zákon o primární péči (s pracovním zněním a RIA), zákon o síti (s ústavním rozborem), finanční novela (§ 3c zák. 592/1992 Sb., zák. 353/2003 Sb.), zákon o dani ze slazených nápojů, zákon o Fondu prevence; stanovisko k SGEI a veřejné podpoře do 6/2029	věcné záměry, pracovní znění, právní stanoviska	RT a Institut Pi, garanti podle řádku 1	7/2028–12/2029; teze tří záměrů už k B1	9
11	Průběžné vyhodnocení pilotu po roce provozu, promítnuté do věcného záměru zákona o primární péči	zpráva hodnotitele	nezávislý hodnotitel	jaro 2029	7
12	Volební program 2029 s jádrem J1 – J10 , ohlášením daně ze slazených nápojů, personální bilancí po krajích a otevřeným modelem nákladů	program strany	strana	do voleb 10/2029	9, 10
13	Brána B2 „Koaliční smlouva“: jádro v koaliční smlouvě a programovém prohlášení; předlohy vln 1–3 v legislativním plánu vlády 2030	koaliční smlouva, usnesení vlády	vyjednávací tým, vláda	12/2029–1/2030	10, 12
14	Řízení ve vládě: řídicí výbor (MZ, MPSV, MMR, MF, pojišťovny, kraje, obce, praktici, pacienti), projektová kancelář (0,4 mld. Kč ročně), dva nové týmy legislativního odboru MZ	usnesení vlády, rozhodnutí ministra	vláda, MZ	do 3/2030	13
15	Vlna 1: nový vzorec platby státu (§ 3c zák. 592/1992 Sb., J10); daň z tichého vína a valorizace daní z lihu a piva (zák. 353/2003 Sb., J8 ; víno poloviční sazbou 2031–2032, plná 2033); zákon o Fondu prevence (P4)	jedna malá a dvě střední předlohy	MF s MZ	předložit 1. pololetí 2030; účinnost 1. 1. 2031	13, 14
16	Zákon o dani ze slazených nápojů (J9), pásma podle cukru	nový zákon, střední předloha	MF, Celní správa	přijat 2030; účinnost 1. 1. 2032	12, 13
17	Závěrečné vyhodnocení pilotu, promítnuté do paragrafového znění vlny 2; od 2030 rozšíření pilotu do dalších regionů	zpráva hodnotitele	nezávislý hodnotitel	2030	7, 11
18	Vlna 2: zákon o primární péči (nová hlava zák. 372/2011 Sb. a novela zák. 48/1997 Sb.: standard týmu, víceletá smlouva se všemi pojišťovnami, sesterská složka, registrace do 30 dnů; J1 – J4); novela zák. 325/2021 Sb. (J5), pokud triážní údaj neprošel v řádku 6	velká předloha; malá novela	MZ, tým pro primární péči	předložit 2. pololetí 2030; účinnost 1. 1. 2032	10, 13, 14, 17
19	Smluvní model před zákonem: pětileté smlouvy týmů se všemi pojišťovnami; standard týmu ve Věstníku MZ	smlouvy podle § 17 zák. 48/1997 Sb.; Věstník MZ	pojišťovny, MZ	od 2030	7, 13
20	Úhradová vyhláška 2031: sesterská složka úhrady, platba za funkce, nové výkony; kompetence sester (vyhl. 55/2011 Sb.)	vyhlášky MZ	MZ po dohodovacím řízení	1. 1. 2031	13, 14
21	Náběh týmů a sester: 60 týmů v roce 2031, 120 v roce 2032, 330 v roce 2035; personální bilance po krajích (P1) a rezidenční místa (P2)	smlouvy; rozhodnutí MZ a krajů	pojišťovny, týmy, kraje, MZ	od 2031	15, 19, 20
22	Vlna 3: zákon o síti lůžkové péče (J6 , J7 : krajský plán na 10 let, čtyři skupiny lůžek, fond přeměny, garance příjmu) s novelami zák. 48/1997 Sb., zák. 374/2011 Sb. a zák. 129/2000 Sb.; pověřovací akt SGEI před první výplatou garance	velká předloha; akt vlády a krajů	MZ, tým pro síť; kraje; vláda	předložit 2031, přijmout 2032; účinnost nejpozději 1. 1. 2033	10, 14
23	Brána B3 „Lidé a data“: obsazena aspoň polovina míst sester v týmech první vlny (registry pojišťoven); zákon o primární péči schválen; krajské plány rozpracované. Nesplněno = varianta B bez center	rozhodnutí řídicího výboru na doporučení hodnotitele	řídicí výbor	12/2031	18, 21, 22
24	Zákon o primární péči účinný; investice do center (17–23 mld. Kč) se uvolňují až po splněné B3	zákon; národní dotační program, EU fondy	MZ, obce, kraje	1. 1. 2032	18, 23
25	První krajské plány sítě (12–18 měsíců práce), s doloženou kapacitou následné a dlouhodobé péče a dojezdem záchranné služby	plán kraje podle zákona o síti	kraje	2033	22
26	Vlna 4: sestra v pokročilé praxi s preskripcí, základní sazba DRG zákonem, HSPA jako rámec hodnocení v zákoně (P5), hodnocení technologií rozšířením mandátu SÚKL a ÚZIS, sdílené financování sociálně-zdravotní péče (P3)	střední novely	MZ, MPSV, ÚZIS	předložit 2032–2034; účinnost 2033–2034	13, 23
27	Brána B4 „Nezávislé hodnocení“: zpráva hodnotitele před volbami; pokračovat, upravit, nebo zmenšit	zpráva ÚZIS s univerzitou; rozhodnutí řídicího výboru	nezávislý hodnotitel, řídicí výbor	2033	23, 25

#	Co se musí stát	Nástroj	Kdo	Nejdřív kdy	Závisí na
28	Přeměna akutních lůžek podle krajských plánů: 8 000 do roku 2038, asi 1 330 ročně; každé lůžko až po prokázané kapacitě dlouhodobé péče a dojezdu; stop při obložnosti nad 85 %	krajský plán; fond přeměny (investice 5–10 mld. Kč, garance příjmu asi 1 mld. Kč ročně 2033–2040)	kraje, nemocnice, pojišťovny	od 2033	22, 25, 27
29	Cílový stav: 520 týmů, asi 4 000 sester navíc, 8 000 přeměněných lůžek, podíl akutní lůžkové péče 26 %	—	—	kolem roku 2038	21, 28

V doplňkovém scénáři, kdy dnešní vláda část návrhů převezme, se posunou o jeden až dva roky dřív jen řádky 3, 6 a 19 (vyhlášky, Věstník, pozměňovací návrhy). Zákony, daně ani brány se v něm neposouvají.

Co na co navazuje a proč

Reforma běží ve třech řetězcích, které se potkávají ve čtyřech branách; dvě závislosti napříč řetězci určují, proč nelze nic přeskočit. Diagram se čte zleva doprava po řádcích; podrobný graf závislostí všech opatření `J1 – J10` a `P1 – P5` je v Části IV.

Pilot před zákonem, peníze před týmy, kapacita před přeměnou lůžek

Tři řetězce a čtyři brány · základní scénář Vláda 2030 · pořadí, nikoli měřítko

krok v pořadí · cílový stav řetězce · brána mezi obdobími · → bez A nejde B · - - → podmínka napříč řetězci

Textová verze

Řetězec Peníze

1. 2027–6/2028: Podněty do úhrad: do 30. 6. 2027: sestry, výkony; plánovací hodnota daní
2. 7/2028–2029: Znění a RIA: § 3c platba státu; víno, líh, pivo; slazené nápoje, fond
3. 2030–2031: Vlna 1 účinná: 1. 1. 2031: vzorec platby státu, víno, fond prevence
4. 2032: Peníze na týmy: slazené nápoje od 2032; platby týmům asi 6 mld. Kč ročně
5. 2033–2038: Plný náběh: 21,5 mld. Kč ročně (15–25, ceny 2026); daně 5 mld. Kč

Řetězec Primární péče

1. 2027–6/2028: Pilot ve 3 ORP: dohoda do 6/2027, smlouva podle § 17; provoz 2028–2029
2. 7/2028–2029: Věcný záměr: zákon o primární péči, znění a RIA; první zpráva z pilotu
3. 2030–2031: Smluvní model: pětileté smlouvy všech pojišťoven; vyhláška 2031
4. 2032: Zákon účinný: 1. 1. 2032; týmy a sestry nabíhají: 60 → 120 týmů
5. 2033–2038: 520 týmů: 4 000 sester navíc; nikdo bez praktika v ORP s týmem

Řetězec Síť lůžek

1. 2027–6/2028: Kulaté stoly: síť 2/2028, dlouhodobá péče 4/2028: pravidla plánu
2. 7/2028–2029: Záměr zákona o síti: ústavní rozbor; SGEI a veřejná podpora do 6/2029
3. 2030–2031: Zákon o síti: předložen 2031, účinný nejpozději 1. 1. 2033
4. 2032: Krajské plány: první 2033; kraj doloží kapacitu dlouhodobé péče
5. 2033–2038: Přeměna lůžek: 8 000 do roku 2038; stop při obložnosti nad 85 %

Brány

- B1 Mandát (6/2028): Připomínky jsou vypořádané a zveřejněné. Plán je projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi (praktici, sestry, lékařská komora, pojišťovny, kraje, obce, pacienti, odbory) a jejich výhrady jsou zapracované. Zkouška ve třech regionech je podepsaná. Strana potvrdila, s jakým výnosem daní za zdraví rozpočet reformy počítá.
- B2 Koaliční smlouva (12/2029–1/2030): Jádro plánu je v koaliční smlouvě a v programu vlády. Zákony jsou v plánu vlády na rok 2030.
- B3 Lidé a data (12/2031): V prvních týmech je obsazená aspoň polovina míst pro sestry. Zákon o primární péči je schválený. Kraje pracují na plánech sítě.
- B4 Nezávislé hodnocení (2033): Nezávislý hodnotitel (statistický ústav ÚZIS s univerzitou) vyhodnotí osm hlavních ukazatelů.

Závislosti napříč řetězci

- Vlna 1 účinná (peníze) → zákon o primární péči účinný: peníze před náběhem týmů.
- Zákon účinný a náběh týmů → přeměna lůžek: týmy před přeměnou lůžek.

Podklad: studie v3, ř. 71–123 (tabulka 29 kroků ř. 73–103, text ř. 107–123).

kritická cesta reformy · 3 řetězce, 4 brány · základní scénář Vláda 2030; pořadí, ne měřítko

Každá šipka znamená „bez A nejde B“: peníze z vlny 1 platí náběh týmů od roku 2032 a týmy, které od téhož roku snižují odvratitelné hospitalizace, předcházejí přeměně lůžek od roku 2033.

Pilot před zákonem. Zákon o primární péči má účinnost 1. 1. 2032, čtyři roky po startu pilotu, aby stál na domácích datech o tom, zda praktici do týmů vstupují a zda se daří obsadit místa sester. Verze 2 kladla zákon na rok 2029, půl roku po startu pilotu. Do účinnosti zákona týmy fungují na smlouvě s pojišťovnou podle § 17 zák. 48/1997 Sb., která zároveň zůstává náhradní cestou, kdyby se zákon zdržel.

Peníze a sestry před náběhem týmů. Platby týmů stojí v plném náběhu asi 6 mld. Kč ročně a sestry navíc další 4 mld. Kč; proto nabývá vlna 1 (vzorec platby státu, daň z vína, valorizace, fond prevence) účinnosti 1. 1. 2031, rok před zákonem o primární péči. Dřív to nejde: pevný vyměřovací základ z tisku 235 platí pro rok 2027 a nový vzorec může přijmout až nová vláda. Druhou podmínkou jsou lidé: reforma potřebuje asi 440 sester ročně, asi čtvrtinu všeobecných sester, které v letech 2026 až 2037 vyjdou z vysokých a vyšších odborných škol, proto nabíhá po etapách a platí jen obsazená místa.

Kapacita dlouhodobé péče před přeměnou lůžek. Lůžka následné péče jsou obsazená z 84 % a do roku 2035 bude potřeba asi 39 000 nových zdravotních i sociálních lůžek dlouhodobé a následné péče (Přecechtěl a Hlávka 2025) a 21 000 pečovatelů (studie pro APSS ČR 2026); přeměna bez náhradní kapacity by jen přesunula frontu. Akutní lůžko se proto nepřemění, dokud kraj neprokáže kapacitu následné a dlouhodobé péče a dojezd záchranné služby, a při obložnosti akutních lůžek nad 85 % se v kraji zastaví. Přeměna začíná s prvními krajskými plány v roce 2033, tedy až za týmy, které od roku 2032 snižují počet odvratitelných hospitalizací.

Věcné záměry v opozici. Velká předloha trvá od věcného záměru po účinnost 24 až 42 měsíců a od nástupu vlády v lednu 2030 zbývá do 1. 1. 2032 přesně 24 měsíců. Zákon o primární péči proto musí mít při nástupu vlády hotový věcný záměr i pracovní znění s RIA; ministerstvo navíc zvládne za jedno období jen dvě velké předlohy. Záměry píše resortní tým s Institutem Pi v letech 2028 a 2029 a kontrolním bodem je brána B2.

Data v reálném čase před branami. Údaje ÚZIS a OECD vycházejí se zpožděním jednoho až tří let, hodnotu za rok 2031 bychom znali nejdřív v roce 2033. Brána `B3` v prosinci 2031 přitom rozhoduje, zda se staví centra; proto stojí na registrech pojišťoven, Národním registru zdravotnických pracovníků a eŽádance s triážním údajem. Pravidlo zní: žádná brána bez dat; chybějí-li, brána se odkládá.

Kolik to stojí a kdo to zaplatí

Reforma bude v plném náběhu kolem roku 2038 stát čistě asi 21,5 mld. Kč ročně (rozpětí 15 až 25 mld. Kč, ceny 2026), tedy necelá 4 % dnešních výdajů zdravotního pojištění. V roce 2035, uprostřed náběhu s 330 týmy, je to asi 17 mld. Kč; úspory jsou skutečné, ale malé: 1,2 mld. Kč v roce 2038 a 3,6 mld. Kč v roce 2050, počítané bez překryvů. Proti verzi 2 (17,2 mld. Kč) je číslo vyšší, protože platby týmům jsou rozpočítané a úspory očištěné; celý model s citlivostí je v Části V.

- Platby týmům (lékařská složka, odměna za výsledky, příplatek za návštěvy) stojí asi 6 mld. Kč ročně (4,8 až 7,5 mld. Kč).
- Kolem roku 2038 bude pracovat 520 týmů sdružené péče a asi 4 000 sester navíc; dvě sestry na lékaře v týmu, tři až jako směr k roku 2050.
- Reforma potřebuje v průměru asi 440 sester ročně, tedy asi čtvrtinu všeobecných sester, které v letech 2026 až 2037 vyjdou z vysokých a vyšších odborných škol; jen nových všeobecných sester přitom systém potřebuje za 10 až 12 let nejméně 24 000 úvazků (vládní program pro nelékařské profese 2026–2037).
- Do roku 2038 přeměníme 8 000 akutních lůžek (z 48 036 na asi 40 000, tedy ze 4,4 na 3,7 na 1 000 obyvatel); fond přeměny stojí 5 až 10 mld. Kč investic a asi 1 mld. Kč ročně na garanci příjmu.
- Investice do center a přeměny lůžek stojí jednorázově 22 až 33 mld. Kč; po evropských fondech a dnešní státní podpoře zbývá zajistit 15 až 26 mld. Kč.

Varianty. Plná varianta stojí čistě 21,5 mld. Kč ročně, varianta bez center 18 mld. Kč a minimální varianta 11 mld. Kč; prevence, paliativa, konzultace a fond přeměny jsou ve všech třech. Základní je A; na B se reforma zmenší, když v prosinci 2031 nebude splněna brána B3.

	A plná, s centry	B bez center	C minimální
Čistý náklad 2038 (mld. Kč ročně)	21,5	17,8	11,3
Investice jednorázově (mld. Kč)	22–33	6–11	5–10
Praktici v týmech nebo smluvní síti 2038	75 %	65 %, jen kde je praxe	žádné týmy
Sester navíc 2038	asi 4 000	asi 3 450	0
Pomůže tam, kde praktik chybí	ano, obec nebo kraj založí tým	jen kde praxe je	ne
Kdy platí	základní varianta	brána `B3` nesplněna	srovnávací základ

Rozdíl A proti B (asi 3,8 mld. Kč ročně a 17 až 23 mld. Kč investic) kupuje další profese, budovy, spádovou odpovědnost a schopnost vstoupit tam, kde praxe zanikla: v obcích do 2 000 obyvatel jich v letech 2018 až 2022 zaniklo 428.

Kdo to zaplatí. Reformu zaplatí daně za zdraví (5 mld. Kč), státní rozpočet (asi 15,5 mld. Kč, z toho asi 13 mld. Kč vyšší platbou za státní pojištěnce, tedy asi 180 Kč měsíčně na osobu) a obce (asi 1 mld. Kč); 100 Kč měsíčně znamená 7,2 mld. Kč ročně. Daně za zdraví přinesou plánovaně 5 mld. Kč ročně (5 až 7): 2 mld. Kč dostane Fond prevence, zbytek zvýší platbu státu do zdravotního pojištění. Odvody z práce se nemění a nesnižují; vyšší odhady výnosu (10 až 17 mld. Kč) jsou horní scénář, který do rozpočtu reformy nepočítáme.

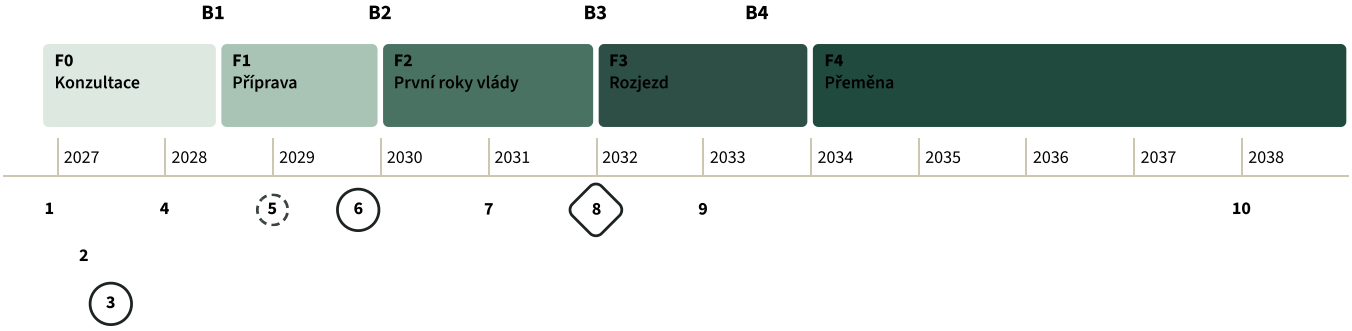
Pokud se dnešní podpora týmových praxí (asi 10 mld. Kč z pojištění do roku 2030 podle implementačního plánu MZ) udrží v úhradové vyhlášce i po roce 2030, lékařská složka ji nahradí a náklad nad plán MZ klesne asi na 19,5 mld. Kč. Model počítá konzervativně plnou částku.

Co reforma neřeší a co musí každá vláda. Při dnešních pravidlech příjmů bude zdravotnímu pojištění chybět asi 60 mld. Kč v roce 2035, 70 mld. Kč v roce 2038 a 104 mld. Kč v roce 2050 (ceny 2026); tuto mezeru musí řešit každá vláda. Reforma mezeru nezpůsobuje ani nezavírá: zvyšuje výdaje pojištění asi o 3,8 % a odpovídá na otázku, jakou péči za rostoucí výdaje dostaneme. Výpočet platby státu v jedné tabulce, včetně automatického růstu o 11,7 mld. Kč při vyšší sazbě pojistného, je v Části V.

Kdy

Harmonogram má tři pevné body: 30. 6. 2027 (dohoda o pilotu a podněty do dohodovacího řízení), volby do Sněmovny v říjnu 2029 a 1. 1. 2032 (účinnost zákona o primární péči). První dvě fáze jsou konzultační a přípravné, na 1. 1. 2029 reforma nic neklade, protože ten den nabíhá strop podle § 22b zák. 48/1997 Sb. a vrací se vzorec platby státu.

Reforma má pět fází a čtyři brány; první zákony začnou platit 1. 1. 2031 a 1. 1. 2032



1 **7. 12. 2026** Schválení verze 3 ke konzultaci

2 **31. 3. 2027** Konec prvního kola připomínek

3 **30. 6. 2027** Dohoda o zkoušce, návrhy do úhrad na rok 2028

4 **1. 1. 2028** Start zkoušky ve třech regionech

5 **1. 1. 2029** Nic neklademe Nabíhá strop pobytu podle § 22b zák. 48/1997 Sb., ruší se § 52 zák. 108/2006 Sb. a vrací se vzorec platby státu. Náš plán na tento den nic neklade.

6 **říjen 2029** Volby do Sněmovny

7 **1. 1. 2031** Nová platba státu, daně a fond prevence platí

8 **1. 1. 2032** Zákon o primární péči platí Ve stejný den začíná platit daň ze slazených nápojů (J9).

9 **1. 1. 2033** Zákon o síti nemocnic platí, první krajské plány Ve stejný den začíná platit plná sazba daně z tichého vína (J8).

10 **kolem roku 2038** 520 týmů, 8 000 změněných lůžek

1 krok nebo cíl účinnost zákona nebo pravidla pevný bod (30. 6. 2027, volby, 1. 1. 2032) den, na který reforma nic neklade

B brána: pokračovat, upravit, nebo zmenšit

Textová verze

Co	Kdy	Poznámka
F0 Konzultace	2026–2028	Kulaté stoly s odborníky, dohody o podpoře, návrhy ke vládním zákonům, dohoda o zkoušce ve třech regionech.
F1 Příprava	2028–2029	Hotové podklady zákonů, volební program, běžící zkouška.
F2 První roky vlády	2030–2031	Předložení zákonů. Peníze a daně platí od 1. 1. 2031.
F3 Rozjezd	2032–2033	Zákon o primární péči, zákon o síti nemocnic, první krajské plány.
F4 Přeměna	2034–2038	Týmů přibývá na 520, 8 000 lůžek mění účel, nezávislé hodnocení.
Brána B1 Mandát	červen 2028	Připomínky jsou vypořádané a zveřejněné. Plán je projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi (praktici, sestry, lékařská komora, pojišťovny, kraje, obce, pacienti, odbory) a jejich výhrady jsou zapracované. Zkouška ve třech regionech je podepsaná. Strana potvrdila, s jakým výnosem daní za zdraví rozpočet reformy počítá.
Brána B2 Koaliční smlouva	přelom let 2029 a 2030	Jádro plánu je v koaliční smlouvě a v programu vlády. Zákony jsou v plánu vlády na rok 2030.
Brána B3 Lidé a data	prosinec 2031	V prvních týmech je obsazená aspoň polovina míst pro sestry. Zákon o primární péči je schválený. Kraje pracují na plánech sítě.
Brána B4 Nezávislé hodnocení	rok 2033, před volbami	Nezávislý hodnotitel (statistický ústav ÚZIS s univerzitou) vyhodnotí osm hlavních ukazatelů.
Schválení verze 3 ke konzultaci	7. 12. 2026	
Konec prvního kola připomínek	31. 3. 2027	
Dohoda o zkoušce, návrhy do úhrad na rok 2028	30. 6. 2027	
Start zkoušky ve třech regionech	1. 1. 2028	
Nic neklademe	1. 1. 2029	Nabíhá strop pobytu podle § 22b zák. 48/1997 Sb., ruší se § 52 zák. 108/2006 Sb. a vrací se vzorec platby státu. Náš plán na tento den nic neklade.
Volby do Sněmovny	říjen 2029	
Nová platba státu, daně a fond prevence platí	1. 1. 2031	
Zákon o primární péči platí	1. 1. 2032	Ve stejný den začíná platit daň ze slazených nápojů (J9).
Zákon o síti nemocnic platí, první krajské plány	1. 1. 2033	Ve stejný den začíná platit plná sazba daně z tichého vína (J8).

Co	Kdy	Poznámka
520 týmů, 8 000 změněných lůžek	kolem roku 2038	

harmonogram 2026–2038 · 5 fází, 4 brány, klíčové účinnosti · základní scénář Vláda 2030; podrobný harmonogram v Části VIII

Každá brána má tři možné výsledky: pokračovat, upravit, nebo zmenšit; rozhodnutí i jeho důvody se zveřejňují. V doplňkovém scénáři, kdy dnešní vláda převezme část vlny 0, se o jeden až dva roky dřív posunou jen vyhlášky, Věstník a pozměňovací návrhy; zákony, daně ani brány ne.

Co děláme do voleb 2029

Do voleb v říjnu 2029 uděláme sedm věcí, z nichž žádná nepotřebuje vládní většinu; tři závisí na vůli ministerstva a pojišťovny, ostatní na nás. Výsledkem má být dohoda s odborníky, běžící pilot a hotové věcné záměry, se kterými může vláda předložit zákony v prvních měsících roku 2030.

- **Konzultace verze 3** (12/2026–3/2027): schválení resortním týmem 7. 12. 2026, první kolo připomínek do 31. 3. 2027, zveřejněné vypořádání před bránou B1.
- **Devět kulatých stolů** (2/2027–6/2028): standard týmu (2/2027), sestry (4/2027), pilot (5/2027), cesta pacienta a eŽádanka (9/2027), financování (11/2027), síť lůžek (2/2028), dlouhodobá péče (4/2028), prevence a daně (5/2028), bilanční konference (6/2028). Každý stůl má jeden zveřejněný výstup.
- **Podněty do úhrad 2028** (do 30. 6. 2027): sesterská složka u týmových praxí a platba za funkce do dohodovacího řízení; konzultace lékař–lékař, telemonitoring a ultrazvuk u praktika do seznamu výkonů; kompetence sester do vyhl. 55/2011 Sb. Rozhoduje dnešní MZ; v základním scénáři s přijetím nepočítáme.
- **Pilot ve třech ORP** (dohoda do 30. 6. 2027, hodnotitel do 12/2027, provoz od 1. 1. 2028): kraj, který se přihlásí, VZP a obce; 100 až 150 tisíc obyvatel, 30 až 50 mil. Kč ročně; průběžné vyhodnocení na jaře 2029. Bez dohody náhradní smluvní model u jedné pojišťovny.
- **Pozměňovací návrhy k vládním předlohám** (2027–2028): víceleté smlouvy i pro týmy do reformy v. z. p. 2030, triážní údaj do novely zák. 325/2021 Sb., prevence do reformy hygienické služby. Navazujeme na vládní reformy, ne protinávrhem.
- **Brána `B1` „Mandát“** (6/2028): plán je projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi a jejich výhrady jsou zapracované, pilot je podepsaný a strana potvrdila plánovací hodnotu daní za zdraví pro rozpočet reformy (5 mld. Kč ročně) vedle cíle PEER (10 až 15 mld. Kč). Co není projednané nebo zůstalo bez dohody, do volebního programu nejde.
- **Věcné záměry a program** (7/2028–12/2029): zákon o primární péči s pracovním zněním a RIA, zákon o síti s ústavním rozborem a stanoviskem k SGEI do 6/2029, finanční novela, daň ze slazených nápojů, zákon o Fondu prevence; volební program 2029 s jádrem `J1` – `J10` a text jádra pro koaliční smlouvu (brána `B2`).

Rozdělení věcných záměrů mezi členy resortního týmu projedná schůzka 9. 11. 2026; příprava běží v resortním týmu s Institutem Pi a poslaneckým klubem.

Co od vás potřebujeme

Do brány `B1` v červnu 2028 potřebujeme mít plán projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi a jejich výhrady zapracované; od každé skupiny čtenářů ale potřebujeme něco konkrétního dřív. Co nabízíme na oplátku, shrnuje mapa aktérů v Části VIII.

Kdo	Co potřebujeme	Do kdy
Praktici (SPL ČR, SPLDD ČR, mladí praktici)	Spolutvorbu standardu týmu a pětileté smlouvy; stanovisko, za jakých podmínek do týmu vstoupíte a co má obsahovat výkup praxe; souhlas s dětskými týmy a registrací dětí na venkově u praktika pro dospělé v týmu	pracovní skupina od 1. čtvrtletí 2027; kulatý stůl 2/2027
Sestry (ČAS) a komora (ČLK)	Sesterskou složku úhrady a kompetence sester, které jste ochotni hájit v dohodovacím řízení; od komory aspoň neutralitu ke kompetencím sester a k triážnímu údaji v eŽádance	kulatý stůl 4/2027; podnět do 30. 6. 2027
Pojišťovny (VZP, SZP ČR)	Smlouvu pilotu a sesterskou složku v dohodovacím řízení; data z registrů o lidech bez praktika a o obsazených místech, na kterých stojí brány; u zaměstnaneckých pojišťoven stejný standard smlouvy nebo náhradní model	návrh smlouvy 1. čtvrtletí 2027; dohoda do 30. 6. 2027
Kraje a obce (Asociace krajů ČR, SMO ČR)	Kraj, který se přihlásí k pilotu, a tři ORP; obecní prostory a senior taxi; připomínky k pravidlům krajského plánu sítě a k podmínce kapacity dlouhodobé péče	výzva krajům 1. čtvrtletí 2027; kulaté stoly 2/2028 a 4/2028
Nemocnice a odbory (AČMN, Asociace krajských nemocnic, LOK-SČL, OSZSP ČR)	Spolupráci na pravidlech přeměny: čtyři skupiny lůžek, garance příjmu, pojistka obložnosti 85 %, nabídka každému dotčenému zaměstnanci; vaše data o skutečné obložnosti a personálně obsaditelných lůžkách	kontakt 2027; kulatý stůl 2/2028
Ministerstvo financí, Národní rozpočtová rada, ekonomové	Technickou oponenturu otevřeného modelu (rozpětí 15–25 mld. Kč, tabulka platby státu) a stanovisko k účelovému vázání fondu prevence vůči zák. 218/2000 Sb. a 23/2017 Sb.	kulatý stůl 11/2027; stanovisko do 6/2029
Pacientské organizace	Připomínky k cestě pacienta, ke třem triážním kategoriím, k jmenovitému lékaři a ke 20 ukazatelům; co má měřit ukazatel katastrofických výdajů	od 12/2026; kulatý stůl 9/2027
Potenciální koaliční partneři	Společné autorství jádra a sdílený harmonogram; říct včas, které z opatření `J8` – `J10` (daně, platba státu) jsou pro vás nepřijatelná	setkání zdravotních expertů stran 2028–2029

Jak připomínkovat. První kolo připomínek končí 31. 3. 2027. Připomínku vložte komentářem přímo k odstavci v tomto dokumentu, nebo ji pošlete e-mailem resortnímu týmu; u každé prosíme o číslo opatření (J1 – J10 , P1 – P5) nebo části, které se týká. Každou připomínku vypořádáme písemně a vypořádání zveřejníme před bránou B1 v červnu 2028; nejvíc nám pomohou připomínky k tabulce kroků výše, k cílovým hodnotám ukazatelů a k předpokladům modelu v Části V.

Co reforma nedělá a co ji nejvíc ohrožuje

Pět věcí reforma výslovně nenavrhuje, i když se jí ve veřejné debatě přičítají nebo je navrhují jiné dokumenty.

- Nezavádí regulační poplatky ani příplatky za kratší čekání; katastrofické výdaje domácností se nesmí zhoršit (H8).
- Neruší dětské praktiky ani nemocnice: dětské týmy zůstávají a akutní lůžka se přeměňují na následnou, rehabilitační a paliativní péči, nikdy bez prokázané náhrady a dojezdu.
- Nikoho nenutí: vstup praktika do týmu je dobrovolný, kdo nevstoupí, zůstává u dnešní úhrady; povinné doporučení ke specialistovi nezavádíme, přímý přístup zůstává.
- Neprivatizuje: praktici zůstávají soukromí a hodnotu praxe neztratí, budovy center vlastní obec nebo kraj, pojišťovny ani nemocnice se neprodávají.
- Nesnižuje odvody z práce z daní za zdraví a neslibuje víc než 5 mld. Kč ročně; mezeru příjmů pojištění (70 mld. Kč v roce 2038) reforma nezavírá a neříká, že ano.

Tři největší rizika mají každé vlastní pojistku, která reformu předem zmenší nebo zastaví dřív, než nesplněný předpoklad zatíží rozpočet. Celý registr 19 rizik je v Části X.

Riziko	Časný signál	Pojistka
Nedostatek sester: reforma potřebuje asi 440 sester ročně, nemocnice a dlouhodobá péče soutěží o tytéž absolventky	obsazenost míst sester v pilotu a v týmech první vlny z registrů pojišťoven, čtvrtletně	náběh po etapách, plat na úrovni nemocniční sestry, platí se jen obsazené místo; brána B3 (12/2031): méně než polovina míst = varianta B bez center, investice do budov vázané na splněnou bránu
Podhodnocené náklady: platby týmům a počet sester rozhodují o výsledku	skutečné platby na pojištěnce v pilotu mimo rozpětí 4,8–7,5 mld. Kč v plném náběhu	plánování s rozpětím 15–25 mld. Kč místo bodu, zveřejněný otevřený model, přepočet z nákladů pilotu před bránou B2 ; neúspěch jednoho nástroje zastaví jen ten nástroj
Legislativní kapacita ministerstva: velká předloha trvá 24 až 42 měsíců a za období jdou jen dvě	věcné záměry nehotové k 12/2029; ve vládním plánu víc než dvě velké předlohy; neobsazené týmy legislativního odboru	věcné záměry a pracovní znění napsané v opozici, jen dvě velké předlohy (primární péče, síť), hodnocení technologií rozšířením mandátu SÚKL a ÚZIS místo nového zákona; začínat smlouvou a vyhláškou, ne zákonem

Platí čtyři pravidla rozhodování od roku 2026 do roku 2038 bez ohledu na to, kdo vládne: žádná brána bez dat; neúspěch nástroje zastaví jen ten nástroj; nesplněná brána B3 znamená variantu B; akutní lůžko se nepřemění, dokud kraj neprokáže kapacitu dlouhodobé péče a dojezd.

Část I — Výchozí stav: proč měnit

České zdravotnictví má těžiště v nemocnicích: akutní lůžková péče čerpá 29,7 % úhrad zdravotního pojištění, praktici pro dospělé 4,3 % (ÚZIS, 2024). Na tento poměr naráží stárnutí. Lidí nad 85 let bude v roce 2050 zhruba 509 tisíc místo 202 tisíc v roce 2021 a lidí nad 75 let s vysokou potřebou péče přibude asi dvakrát, ze 115 na 241 tisíc (ČSÚ, ÚZIS).

Systém má silné stránky, které reforma zachovává. Z povinného pojištění je hrazeno 85 % výdajů (průměr OECD 75 %) a nenaplněnou potřebu péče hlásí 0,5 % lidí (OECD 3,4 %; OECD Health at a Glance 2025). Výdaje na zdravotnictví ze všech zdrojů dosáhly 8,6 % HDP (ČSÚ, 2024); slabina tedy není v ceně, ale v tom, jak je péče organizovaná.

Studie odděluje dvě otázky. Mezera mezi výdaji a příjmy zdravotního pojištění při dnešních pravidlech příjmů je fiskální problém a řeší ji pravidla příjmů (podsekce Peníze níže a Část V). Reforma odpovídá na jinou otázku: jakou péči za rostoucí výdaje dostaneme.

Sedm podsekcí níže popisuje problémy, na které míří jádro reformy (J1 – J10) a jeho podmínky (P1 – P5). Mezinárodní data vycházejí se zpožděním jednoho až tří let a definice se mezi zeměmi liší, proto srovnání čteme jako řád velikosti. Tabulka na konci části přiřazuje každému problému příčinu a opatření.

Nemocniční těžiště výdajů

Na vlastní akutní lůžkovou péči šlo v roce 2024 29,7 % úhrad pojištění, tedy 150 mld. Kč. Celý lůžkový segment včetně nemocničních ambulancí a centrových léčiv čerpá 56,3 %, praktici pro dospělé 4,3 %.

Na akutní lůžka jde téměř sedmkrát víc peněz než na praktické lékaře pro dospělé

Podíl na úhradách zdravotních pojišťoven v roce 2024, v %. Celý lůžkový segment včetně nemocničních ambulancí a centrových léčiv čerpá 56,3 %.



Akutní lůžková péče	**29,7 %**
Nemocniční ambulance	**12,8 %**
Zbytek lůžkového segmentu, mj. centrová léčiva (dopočet)	**13,8 %**
Praktici pro dospělé	**4,3 %**
Ostatní péče mimo lůžkový segment (dopočet)	**39,4 %**

Akutní lůžková péče (29,7 %, asi 150 mld. Kč) dostává 6,9krát víc než praktici pro dospělé (4,3 %). Cílem studie je podíl akutní lůžkové péče 26 % kolem roku 2038; sledujeme ho spolu s podílem nemocničních ambulancí, aby nešel splnit přeúčtováním.

Zdroj: ÚZIS, NRHZS OIS-11-24 (verze 2026-01), úhrady 7 pojišťoven za rok 2024 z pololetní dodávky; praktici: ÚZIS 2024. „Ostatní“ a „zbytek“ jsou dopočet do celku.

ÚZIS, NRHZS OIS-11-24 (verze 2026-01), úhrady 7 pojišťoven za rok 2024 bez podsegmentu 1.7.1; rok 2024 z pololetní dodávky; praktici: ÚZIS 2024; „ostatní“ = dopočet do celku

Číslo 56,3 % se často cituje jako „polovina peněz do nemocnic“; samotná hospitalizační péče je ale 29,7 %. Studie proto sleduje podíl akutní lůžkové péče (podsegment 2.1.2) a cílí jeho pokles na 26 % kolem roku 2038. Ukazatel lze splnit i přeúčtováním výkonů do nemocničních ambulancí, proto se čte spolu s jejich podílem (12,8 %) a s výsledky péče (Část IX).

Odchylka od zahraničí je větší v kapacitě než v penězích. Podle NZIP má Česko 48 036 akutních lůžek, tedy 4,4 na 1 000 obyvatel (2024); v mezinárodní definici OECD je to 3,99 proti 2,38 ve Španělsku a 2,09 v Nizozemsku. Na lůžkovou kurativní péči jde podle zdravotnických účtů (SHA) 25,9 % celkových výdajů na zdraví, průměr OECD je 24,2 % (2023).

Česko hospitalizuje 17 990 lidí na 100 tisíc obyvatel ročně (ÚZIS NRH, 2024), průměr OECD je kolem 14 600. Standardní akutní lůžka byla v roce 2024 obsazená z 56 % (v roce 2015 z 65,6 %), lůžka následné péče z 84,2 % (ÚZIS, NRHZS). Akutní lůžka tedy stojí poloprázdná, zatímco následná jsou téměř plná. Produkce akutní lůžkové péče měřená ošetřovacími dny klesala za posledních deset let asi o 1,5 % ročně, aniž by na to reagovala síť nebo lůžkový fond, a řada nemocnic provozuje oddělení s obložností pod 50 % (MZ ČR, Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví 2025, s. 61 a 75).

Nízká obložnost neznamená, že lze 44 % lůžek zavřít: rozhodují personálně obsaditelná lůžka, sezónní špičky, obor a dojezd. Obložnost nad 85 % je spojena s vyšší úmrtností o 9 % (Madsen a kol., Health Affairs 2014), proto studie mluví o přeměně lůžek, ne o rušení. Úhrady (CZ-DRG, paušály, individuální dohody) přitom pořád víc odměňují objem a historické rozpočty než přesun pacienta do následné nebo ambulantní péče.

Praktiků ubývá a stárnou

Praktiků pro dospělé (PLD) je zhruba 5 500 a čistý úbytek je 110 až 180 ročně; personální bilance studie (Část V) s ním počítá s asi 3 900 až 4 500 PLD v roce 2035. Příčinou je věková struktura: 43,6 % lékařů oboru je starších 60 let.

Téměř polovina praktiků pro dospělé je starší 60 let

Aktivní lékaři oboru všeobecné praktické lékařství v ambulantní péči (6 120), podíl podle věku v %

43,6 % tedy asi 2 670 z 6 120 lékařů oboru



Mladší 60 let **56,4 %** 60 let a starší **43,6 %**

Ročně atestuje 150 až 200 nových praktiků, odchází jich víc. Graf zahrnuje všechny aktivní lékaře oboru, i ty, kteří nejsou registrujícími praktiky; registrujících praktiků pro dospělé je asi 5 500. Podíly užších pásem 60–64, 65–69 a 70+ text studie neuvádí, proto ukazujeme skupinu 60+ jako celek.

Zdroj: ÚZIS, NRZP a NRHZS, stav k 31. 3. 2023 (M. Matějková, Praktické lékařství v České republice, FaF UK 2024)

ÚZIS, NRZP a NRHZS, stav k 31. 3. 2023 (M. Matějková, Praktické lékařství v České republice, FaF UK 2024); pásma 60–64 a 65–69 dopočtena z kumulativních podílů 60+, 65+ a 70+

Graf zahrnuje všechny aktivní lékaře oboru v ambulantní péči (6 120), tedy i ty, kteří nejsou registrujícími praktiky; počet PLD v textu (asi 5 500) je užší.

Ročně atestuje ze všeobecného praktického lékařství 160 až 200 lékařů, odchází jich víc. V obcích do 2 000 obyvatel mezi lety 2018 a 2022 zaniklo 428 míst praktiků a vzniklo 291 (ÚZIS). Ordinace, kterou nikdo nepřevezme, zanikne a její pacienti hledají místo u sousedů, kteří už nemají kapacitu.

Praktiků pro děti a dorost (PLDD) je asi 2 050. Obor stárne podobně: průměrný věk je 56 let a z 292 pediatrů atestovaných v letech 2016 až 2022 šlo do ordinací jen 153 (ÚZIS 2023).

Typická ordinace je jeden lékař a jedna sestra a praktik nesmí ani to, co v zahraničí běžně dělá. Preskripční omezení „L“ ho nutí posílat chronika ke specialistovi kvůli receptu a řada výkonů (například ultrazvuk) mu není hrazena. Kolik času mu zabere administrativa, v Česku nikdo spolehlivě nezměřil.

Kolik dospělých nemá registrujícího praktika, systém neměří. Nepřímé údaje ukazují, že nejde o okrajový problém: asi 182 tisíc dětí do 19 let nemělo v roce 2022 vykázanou kapitaci u PLDD a dalších asi 90 tisíc měl v péči praktik pro dospělé (ÚZIS 2023). Týmové praxe zavedené od roku 2025 zaregistrovaly jen u VZP 43 705 lidí, kteří lékaře hledali (VZP, 15. 7. 2026).

Ověřit: počet dospělých pojištěnců bez registrujícího praktika podle registrů všech sedmi pojišťoven (výchozí hodnota pro ukazatel J5).

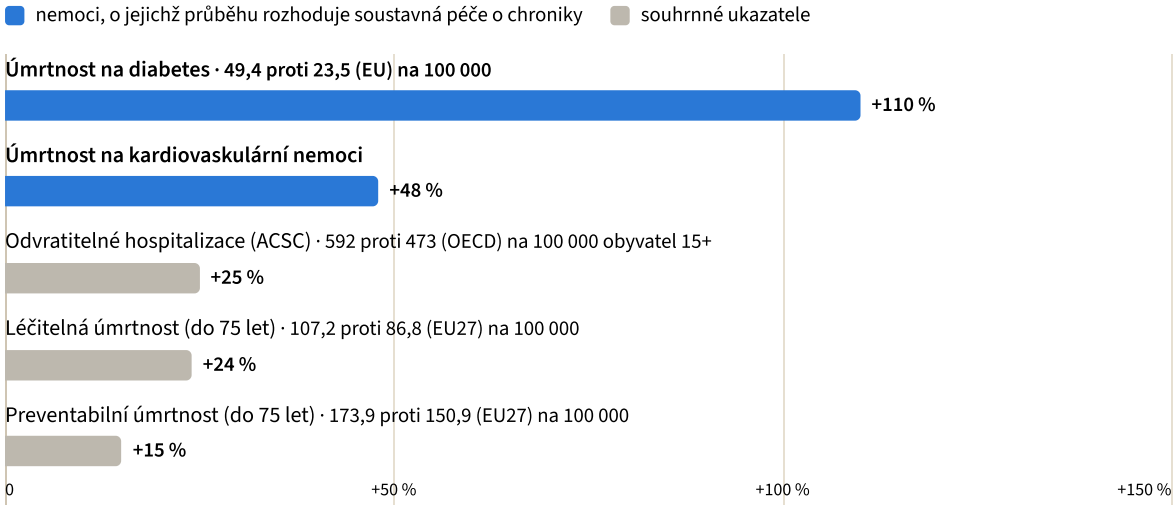
Ověřujeme

Odvratitelné hospitalizace a úmrtnost

Česko má o 25 % víc odvratitelných hospitalizací než průměr OECD (592 proti 473 na 100 tisíc) a léčitelná úmrtnost je o 24 % nad průměrem EU (107,2 proti 86,8). Největší odstup je u nemocí, o jejichž průběhu rozhoduje soustavná péče o chroniky.

Nejvíc zaostáváme u nemocí, o kterých rozhoduje péče o chroniky: úmrtnost na diabetes je dvojnásobná

O kolik procent je Česko nad průměrem EU (úmrtnost, standardizovaná) nebo OECD (odvratitelné hospitalizace)



U kardiovaskulárních nemocí uvádí studie jen rozdíl (+48 %), ne absolutní hodnoty. Česká akutní kardiologie přitom nezaostává; odstup vzniká v soustavné péči.

Zdroj: Eurostat hlth_cd_asdr2 a hlth_cd_apr (2023, standardizace ESP 2013); odvratitelné hospitalizace (ACSC): OECD Health at a Glance 2025, období 2021/2022, standardizace na populaci OECD 15+

Eurostat hlth_cd_asdr2 a hlth_cd_apr (2023, standardizace ESP 2013); ACSC: OECD Health at a Glance 2025, období 2021/2022, standardizace na populaci OECD 15+

Odvratitelné hospitalizace (ACSC) jsou přijetí pro diabetes, CHOPN, srdeční selhání, hypertenzi a astma, kterým lze předejít dobrou ambulantní péčí. Ukazatel je nepřímý: ovlivňuje ho i dostupnost specialistů, kódování a chování pacientů. Národní registrová řada ÚZIS a standardizovaný ukazatel OECD nejsou zaměnitelné, proto studie pracuje s řadou OECD.

Léčitelná úmrtnost měří, zda systém včas a správně léčí; preventabilní měří sílu prevence a vliv životního stylu. Česko zaostává v obou. U diabetu je úmrtnost 49,4 proti 23,5 na 100 tisíc v EU, u kardiovaskulárních nemocí o 48 % vyšší, aniž by česká akutní kardiologie zaostávala.

Pro srdeční selhání Česko hospitalizuje zhruba dvakrát častěji než Španělsko (OECD Health Statistics). Pozorovací evidence ukazuje, co pomáhá: lidé, kteří mají téhož praktika 15 a více let, mají asi o čtvrtinu nižší úmrtnost (Sandvik a kol., BJGP 2022; Pereira Gray a kol., BMJ Open 2018). Péče o chroniky vedená sestrou je stejně bezpečná nebo bezpečnější než péče vedená lékařem (Paier-Abuzahra a kol., Hum Resour Health 2024).

Sestry a další personál

Ve zdravotnictví působí asi 83 tisíc sester a asi 3 tisíce jich chybí; přes 12 tisíc všeobecných sester je starších 60 let a dalších 1 774 starších 70 let (NZIS; MZ ČR 2025, s. 111). Jen nových všeobecných sester je za 10 až 12 let potřeba nejméně 24 000 úvazků, zatímco 16 vysokých škol dnes dává asi 680 absolventů a 35 vyšších odborných škol asi 570 ročně (MZ ČR 2025, s. 112 a 114). Vládní program pro nelékařské zdravotnické profese na roky 2026 až 2037 (přes 12,8 mld. Kč) navyšuje kapacity prvních ročníků nejméně o 20 %, u všeobecného ošetřovatelství až o 40 %, a má na vysokých školách vychovat 11 078 všeobecných sester, 2 539 porodních asistentek a 1 547 dětských sester; vyšší odborné školy mají za stejnou dobu vychovat asi 11 000 všeobecných sester (vládní program pro nelékařské profese 2026–2037; MZ ČR 2025, s. 113–114).

Ukazatel	Česko	Srovnání	Zdroj, rok dat
Lékaři na 1 000 obyvatel	4,2	OECD 4,0	OECD Health Statistics, poslední dostupný rok
Podíl praktiků (PLD + PLDD) mezi lékaři	asi 17 %	OECD asi 23 %	ÚZIS NRZP; OECD Health at a Glance 2023
Lékaři ve věku 55 a více let	41 %	EU 35 %	OECD/EK Health at a Glance: Europe 2024, data 2022
Praktikující sestry na 1 000 obyvatel	9,0	OECD 9,2	ÚZIS 2024; OECD
Absolventi ošetřovatelství na 100 000 obyvatel	38,8, z toho všeobecné sestry asi 16	OECD 44,4	OECD Health Statistics, 2024
Fyzioterapeuti na 100 000 obyvatel	86	EU 147,5	ÚZIS 2024; Eurostat 2023
Pracovníci dlouhodobé péče na 100 lidí nad 65 let	2,1	OECD 5,7	OECD Health Statistics, 2023

Počtem sester na obyvatele Česko průměru odpovídá; problémem je věk, přesčasy a složení. Plně kvalifikovaných všeobecných sester promuje jen asi 16 na 100 tisíc obyvatel, zbytek absolventů tvoří praktické sestry a asistenti.

Primární péče sestry s vlastními pacienty skoro nemá. Typická ordinace má jednu sestru, která dělá hlavně administrativu a asistenci, a podmínky týmových praxí od roku 2025 sestry ani jiné profese nezahrnují. Kompetence sester se od roku 2022 rozšiřují: vyhláška 158/2022 Sb. rozšířila ve vyhlášce 55/2011 Sb. činnosti, které sestry dělají bez indikace lékaře, vyhláška 324/2024 Sb. přenesla část kompetencí v léčbě ran na specializovanou sestru a zákon 375/2022 Sb. umožnil sestrám se specializovanou způsobilostí předepisovat vybrané zdravotnické prostředky. Samostatnou práci v ordinaci praktika ale dál brzdí úhrada a chybějící protokoly.

Každá sestra pro primární péči se proto bude přetahovat s nemocnicemi a dlouhodobou péčí o tytéž absolventky. Fyzioterapeutů je zhruba o 40 % méně než v průměru EU a pracovníků dlouhodobé péče méně než polovina průměru OECD. Kolik sester týmy potřebují a v jakém tempu, počítá personální bilance v Části V.

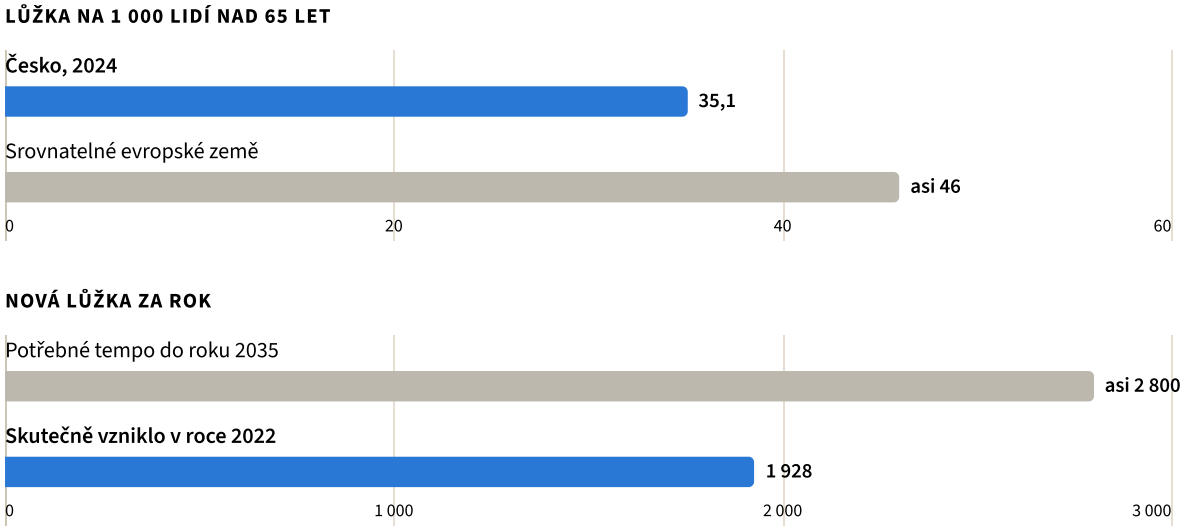
Číslo „přes 30 000 úvazků“ z verze 3 nahrazuje potřeba nejméně 24 000 úvazků všeobecných sester z vládního programu; věková struktura sester je doplněna výše (NZIS). Ověření z verze 3 k obojímu je tím uzavřené.

Dlouhodobá péče a sociálně-zdravotní pomezí

Na 1 000 lidí nad 65 let připadá 35,1 lůžka dlouhodobé péče, srovnatelné evropské země mají asi 46 (OECD 2024; Eurostat 2019/2020). Lůžek za deset let přibylo, seniorů ale rychleji.

Lůžek dlouhodobé péče máme o 24 % méně než srovnatelné evropské země a přibývají pomaleji, než je potřeba

Vlevo lůžka v zařízeních na 1 000 lidí nad 65 let; vpravo nová lůžka dlouhodobé a následné péče za rok



Lůžek za deset let přibylo, seniorů ale rychleji. Do roku 2035 bude potřeba zhruba 39 000 nových lůžek dlouhodobé a následné péče, o 53 % víc než v roce 2021.

Zdroj: OECD Health Statistics, DF_HEALTH_LTCR_BED (2024); srovnání: Eurostat hlth_rs_bdsns (HP.2), 2019/2020; potřeba: Přecechtěl a Hlávka, Studie efektivního zdravotnictví, 2025. Řada zahrnuje sociální pobytové služby i lůžka následné a dlouhodobé zdravotní péče.

OECD Health Statistics, DF_HEALTH_LTCR_BED (lůžka v zařízeních, 2014–2024); srovnání: Eurostat hlth_rs_bdsns (HP.2), 2019/2020; řada zahrnuje sociální pobytové služby i lůžka následné a dlouhodobé zdravotní péče

Do roku 2035 bude potřeba zhruba 39 000 nových lůžek dlouhodobé a následné péče, zdravotních i sociálních, o 53 % víc než v roce 2021 (Přecechtěl a Hlávka, Studie efektivního zdravotnictví, 2025). Tempo by muselo být asi 2 800 lůžek ročně; v roce 2022 jich vzniklo 1 928.

Zdravotní část této potřeby je menší. Pro zdravotní lůžka následné a dlouhodobé péče už dnes chybí nejméně 2 až 3 tisíce a do roku 2035 bude potřeba dalších nejméně 8 tisíc; spodní hranice predikcí je asi 4 700 lůžek do let 2030 až 2035 (MZ ČR 2025, s. 65 a 66). Obě řady uvádíme vedle sebe a nesčítáme je. Zbytek odhadu 39 000 tvoří pobytové sociální služby.

Studie Deloitte pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR (2026) počítá do roku 2035 s potřebou 35 tisíc pobytových míst a 21 tisíc úvazků terénních pečovatelů navíc; náklad sociální péče o seniory podle ní vzroste z asi 80 na 137 mld. Kč ročně. Studie vznikla na zakázku poskytovatelů a její vstupy Deloitte neověřoval. Rozdíl proti 39 000 je v rozsahu: Deloitte počítá jen sociální pobytové služby, první odhad i zdravotní lůžka následné péče.

Pobytová dlouhodobá péče leží na dvou resortech. Domovy pro seniory a se zvláštním režimem patří pod MPSV a kraje, léčebny dlouhodobě nemocných a následná lůžka pod MZ a pojišťovny. Dvojí financování a dvojí evidence znamenají, že za kapacitu jako celek nikdo neodpovídá.

Pro reformu je to tvrdá podmínka. Lůžka následné péče jsou obsazená z 84,2 %, takže rezerva tam není, a akutní lůžko nelze přeměnit, dokud kraj nemá kam pacienta přeložit. Když kapacita nevznikne, zůstane péče na rodinách: neformálních pečujících je podle téže studie 97 tisíc úvazků.

Peníze: pojištění ve schodku, rezervy klesá

Zdravotní pojištění hospodaří od roku 2023 se schodkem. Na rok 2026 pojišťovny plánují příjmy 555,8 mld. Kč a výdaje 570,8 mld. Kč, tedy schodek 14,9 mld. Kč.

Pojištění je ve schodku a zůstatek fondů klesl pod jeden měsíc výdajů

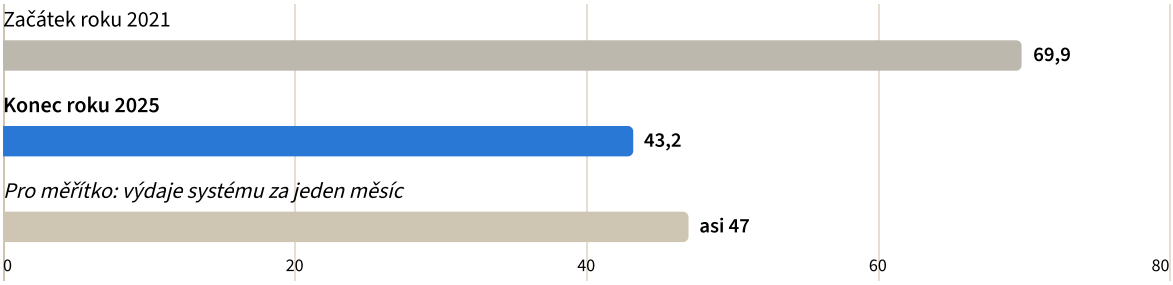
Vlevo zdravotně pojistné plány na rok 2026, vpravo zůstatek základních fondů všech sedmi pojišťoven; mld. Kč

PLÁN NA ROK 2026



Schodek **14,9 mld. Kč**; pojištění je ve schodku od roku 2023.

ZŮSTATEK ZÁKLADNÍCH FONDŮ



Zdroj: Zdravotně pojistné plány pojišťoven a jejich hodnocení MZ; rok 2026 = schválené plány (sněmovní tisk 280/0). Zůstatek fondů: důvodová zpráva k tisku 235.

Zdravotně pojistné plány pojišťoven a jejich hodnocení MZ; rok 2026 = schválené plány (sněmovní tisk 280/0)

Schodky se kryjí z rezerv. Studie používá jednu veličinu: zůstatek základních fondů zdravotního pojištění všech sedmi pojišťoven. Ten klesl z 69,9 mld. Kč na začátku roku 2021 na 43,2 mld. Kč na konci roku 2025 (důvodová zpráva k tisku 235).

Další čísla v oběhu měří jiné veličiny. Asi 32 mld. Kč je souhrn rezerv ke konci roku 2025 uváděný v kapitolách HSPA Monitoru (VZP asi 23, zaměstnanecké pojišťovny asi 9 mld. Kč); 45,7 mld. Kč jsou prostředky na účtech ke konci srpna 2026 podle odborů. Ověřit: definice všech tří veličin v primárních zdrojích (důvodová zpráva k tisku 235, výroční zprávy pojišťoven) a vazbu poklesu zůstatku na kumulované saldo.

Ověřujeme

Platba státu za státní pojištěnce je v roce 2026 2 188 Kč měsíčně a její podíl na výdajích pojištění klesl z 30,8 % v roce 2021 na 28,4 %, přestože státních pojištěnců přibývá. Vzorec podle § 3c zák. 592/1992 Sb. sleduje inflaci a polovinu růstu reálné mzdy, ne počet a věk státních pojištěnců. Pro rok 2027 tisk 235 stanovil pevný vyměřovací základ 18 362 Kč (platba 2 479 Kč); vzorec se má vrátit od roku 2029 a MZ avizuje zmrazení pro rok 2028.

Národní rozpočtová rada očekává růst výdajů zdravotního pojištění z 6,4 % HDP v roce 2026 na 6,9 % v roce 2036 a 7,5 % v roce 2056, při příjmech kolem 6,1 až 6,2 % HDP (Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 2026, tab. D.1). V cenách a při velikosti ekonomiky roku 2026 to dává mezeru asi 60 mld. Kč v roce 2035 a asi 104 mld. Kč v roce 2050 (přepočet studie, Část V). Je to podmíněný scénář při dnešních pravidlech příjmů, ne nevyhnutelnost. Ověřit: přesné hodnoty tabulky D.1 v primárním zdroji.

Ověřujeme

Ochrana před přímými platbami slábne u nejchudších. V roce 2023 mělo katastrofické výdaje na zdraví 21 % domácností nejchudší pětiny (v roce 2018 14 %) a asi 6 % všech domácností, hlavně kvůli doplatkům na léky a platbám u zubaře (WHO/Europe 2025).

Zdravotní rizika a prevence

Česko vypije 11,2 litru čistého alkoholu na osobu nad 15 let ročně (2023), asi o třetinu víc než průměr OECD, a 60 % dospělých má nadváhu nebo obezitu. Prevence přitom dostává méně peněz než v průměru OECD.

Ukazatel	Česko	Srovnání	Zdroj, rok dat
Registrovaná spotřeba alkoholu (l čistého alkoholu na osobu 15+)	11,2	OECD 8,5	OECD Health at a Glance 2025, data 2023
Nadváha a obezita dospělých (BMI ≥ 25)	60,0 %	EU 52,7 %	Eurostat EHIS, 2019
Obezita dospělých (BMI ≥ 30)	19,8 %	EU 16,5 %	Eurostat EHIS, 2019
Nadváha a obezita dětí 6–9 let	26,3 %	průměr zemí COSI 29,8 %	WHO COSI, 2019
Účast ve screeningu kolorektálního karcinomu	31,1 %	OECD 42 %	ÚZIS NRHZS 2024; OECD
Účast žen 50–69 let v mamografickém screeningu	60 %	OECD 55 %	OECD Health at a Glance 2025
Očkování proti chřipce, lidé nad 65 let	24,6 %	OECD 51 %, cíl EU 75 %	ÚZIS, sezóna 2025/26; OECD 2024
Výdaje na prevenci (% běžných výdajů na zdraví)	2,7 %	OECD 3,2 %	OECD SHA, 2023

Ceny alkoholu spotřebě odpovídají. Spotřební daň z piva patří k nejnižším v EU, tiché víno má sazbu nula a pivo bývá levnější než nealkoholické nápoje. Na spotřebních daních z alkoholu stát vybere kolem 15,5 mld. Kč ročně (líh přes 10, pivo asi 5, víno asi 0,5 mld. Kč).

Následky nese úmrtnost na chronická onemocnění jater, o 43 % vyšší než v EU a bez zlepšení za posledních pět let (graf odvratitelné úmrtnosti výše). Národní odhad včetně neregistrované spotřeby je asi 14,4 litru (ČSÚ, SZÚ); jde ale o jinou metodiku, kterou nelze srovnávat s průměrem OECD.

Bilanční spotřeba cukru je 30,8 kg na obyvatele (ČSÚ, 2024) a nezahrnuje sirupy, kterými se slazené nápoje často sladí. Slazené nápoje dnes žádnou zvláštní daň nemají.

Kde systém lidi aktivně zve, prevence funguje: na mamografii chodí víc žen než v průměru OECD. U screeningu tlustého střeva a očkování seniorů Česko zaostává. Na kolonoskopii po pozitivním testu se čekalo 84,2 dne (2024; v roce 2019 61,2 dne) a dorazí na ni jen 61,7 % lidí (ÚZIS). Screeningové programy koordinuje Národní screeningové centrum při ÚZIS, které vláda v této roli schválila v květnu 2025. Účast na kolonoskopii po pozitivním testu se v čase pohybuje jen mezi 60 a 70 % (MZ ČR 2025, s. 35 a 36). Od roku 2026 se má cílová skupina kolorektálního screeningu rozšířit na 45 až 75 let (tamtéž, s. 40).

Vyšší účast ve screeningu zvýší poptávku po kolonoskopii, kterou dnešní kapacita nepokryje. Ověřit: kapacita endoskopických pracovišť po krajích a její rezerva pro nárůst účasti.

Ověřujeme

Od problému k opatření

Každý problém výše má v jádru reformy (`J1 – J10`) nebo v jejích podmínkách (`P1 – P5`) aspoň jedno opatření. Jedinou výjimkou jsou katastrofické výdaje domácností, které studie řeší mimo jádro, a říká to otevřeně.

Problém (výchozí stav)	Co ho způsobuje	Opatření jádra a podmínky
Těžiště v akutní lůžkové péči: 29,7 % úhrad, obložnost standardních lůžek 56 %	Úhrady odměňují objem a historické rozpočty; síť lůžek nikdo neplánuje; není kam pacienta přeložit	`J6` krajský plán sítě a fond přeměny; `J7` kapacita následné a dlouhodobé péče jako podmínka přeměny; `J1` a `J4` přesun péče k týmům a domů
Praktiků ubývá o 110–180 ročně, 43,6 % je starších 60 let	Málo atestací, osamělá praxe bez zástupu, omezené kompetence, roční nejistota úhrady	`J1` tým sdružené péče a pětiletá smlouva; `J3` kompetence praktiků; `P2` rezidenční místa; `P1` nábor ze zahraničí a rychlejší aprobace
Lidé bez praktika, které nikdo nepočítá	Zánik praxí v malých obcích; chybí měření z registrů pojišťoven	`J5` měření lidí bez praktika; `J1` odpovědnost týmu za spádové území; `J4` návštěvní služba a doprava k lékaři
Odvratitelných hospitalizací o 25 % víc než v OECD, vysoká úmrtnost na diabetes a nemoci srdce	Péče o chroniky je nesoustavná, bez sester s kompetencemi a bez návštěv doma	`J1` jmenovitý ošetřující lékař a kontinuita v týmu; `J2` sesterská složka úhrady a kompetence sester; `J3` ; `J4`
Čekací doby se neměří, ke specialistovi se dostane dřív ten, kdo dřív zavolá	eŽádanka není povinná a nenese údaj o naléhavosti	`J5` eŽádanka s triážním údajem a měření čekání
Potřeba nejméně 24 000 nových úvazků všeobecných sester za 10–12 let, primární péče bez sester	Stárnutí sester, nízký přísun všeobecných sester, sesterská práce v ordinaci se neplatí	`J2` ; `P1` personální bilance po krajích
Do roku 2035 je potřeba asi 39 000 nových zdravotních i sociálních lůžek dlouhodobé a následné péče (z toho zdravotních dnes chybí 2–3 tisíce a do 2035 dalších nejméně 8 tisíc) a 21 000 pečovatelů	Dva resorty a dvojí financování, kapacitu nikdo neplánuje jako celek	`J7` ; `P3` sociální účet a sdílené financování sociálně-zdravotní péče; `J4`
Schodek pojištění od roku 2023, zůstatek základních fondů 69,9 → 43,2 mld. Kč	Platba státu nesleduje náklady na péči; stárnutí	`J10` nový vzorec platby státu; `J8` a `J9` , jejichž výnos nad pevnou část pro Fond prevence zvyšuje platbu státu

Problém (výchozí stav)	Co ho způsobuje	Opatření jádra a podmínky
Alkohol, cukr, obezita; nízký screening tlustého střeva a očkování seniorů	Nízké spotřební daně, nulová sazba na tiché víno, žádná daň ze slazených nápojů; prevence bez stabilního zdroje	J8 daň z tichého vína a valorizace daní z lihu a piva; J9 pásmová daň ze slazených nápojů; P4 Fond prevence
Katastrofické výdaje má 21 % domácností nejchudší pětiny	Doplatky na léky a platby u zubaře	Mimo jádro: policy briefy Dostupné léky a Reforma stomatologie (Část XI); ukazatel katastrofických výdajů (Část IX)
Výkonnost systému se hodnotí nahodile a se zpožděním	Chybí závazný rámec hodnocení a data v reálném čase	P5 HSPA jako oficiální rámec hodnocení v zákoně; J5

Dvě vazby z tabulky jsou závazné pro celý návrh. Podíl akutní lůžkové péče se čte spolu s podílem nemocničních ambulancí, aby pokles nevznikl jen přeúčtováním. Přeměna lůžek (J6) je vázaná na J7 : dokud kraj neprokáže kapacitu následné a dlouhodobé péče a dojezd záchranné služby, akutní lůžko se nepřemění.

Část II — Logika reformy

Reforma stojí na deseti opatřeních jádra, která mají kolem roku 2038 dát každému obyvateli tým primární péče a přeměnit 8 000 akutních lůžek na následnou péči. Tato část ukazuje, proč právě tato opatření, jak mají působit a co se stane, když některý předpoklad selže. Podrobnosti jednotlivých opatření jsou v Části III, peníze a lidé v Části V, termíny v Části VIII.

Cíl reformy a pět měřitelných cílů

Kolem roku 2038 má každý obyvatel Česka svůj tým primární péče, ke specialistovi se dostane podle naléhavosti a na akutním lůžku leží jen tehdy, když ho skutečně potřebuje. Všechny cílové roky platí pro základní scénář „Vláda 2030“, tedy Piráti ve vládě od přelomu 2029/2030.

Cíl se rozpadá na pět měřitelných cílů, jeden za každý pilíř. Každý má hlavní ukazatel z Části IX (kódy H1 až H8); cílové hodnoty jsou návrh k diskusi v resortním týmu a v konzultaci.

Cíl	Hlavní ukazatel	Dnes	2033 (data za 2032)	Kolem 2038	Pilíř
1. Každý má svůj tým a jmenovitého lékaře	lidé bez registrujícího praktika (H1); týmy a obsazená místa sester (H2); kontinuita, index UPC (H4)	0 týmů podle standardu; UPC se neměří	v ORP s týmem aspoň o polovinu méně lidí bez praktika; obsazeno aspoň 50 % míst sester; UPC aspoň 0,7	520 týmů; 0 lidí bez praktika v ORP s týmem; obsazeno aspoň 80 % míst sester	1
2. Akutní lůžko jen tam, kde je potřeba	podíl akutní lůžkové péče na výdajích (H6)	29,7 % (2024)	28 %	26 %; 8 000 přeměněných akutních lůžek (z 48 036 na asi 40 000)	2
3. Ke specialistovi podle naléhavosti	čekání podle triážní kategorie eŽádanky (H3)	neměří se	aspoň 80 % urgentních ve lhůtě	aspoň 90 % ve všech kategoriích	1 a 3
4. Méně nemocí, kterým lze předejít	odvratitelná úmrtnost (H7)	viz Část I	sledujeme bez cíle	sledujeme bez cíle; daně za zdraví plánovaně 5 mld. Kč ročně	4
5. Péče doma, ne na lůžku z nouze	odvratitelné hospitalizace na 100 000 obyvatel (H5)	592	550	530	5

Všech pět cílů má společnou podmínku: nesmějí růst přímé platby pacientů. Hlídá to osmý hlavní ukazatel, katastrofické výdaje domácností (H8): dnes 6 % domácností, v nejchudší pětině 21 %, a podle návrhu se nesmí zhoršit. Odvratitelnou úmrtnost sledujeme bez cíle, protože ji reforma ovlivňuje jen zčásti a se zpožděním.

Celostátní data ÚZIS přicházejí se zpožděním jednoho až tří let. Průběžné kroky proto měříme z dat, která existují v reálném čase: registry pojišťoven, Národní registr zdravotnických pracovníků a eŽádanka.

Teorie změny

Reforma působí přes pět řetězců, které vedou od peněz, lidí a pravidel k delšímu životu ve zdraví (nadřazený cíl z Hospodářské strategie PEER: +5 let během jedné generace); každý má měřitelný mezikrok a všechny stojí na čtyřech předpokladech. Diagram níže se čte zleva doprava: co do reformy vstupuje, co se dělá, co vznikne, co se změní pro pacienty a co z toho plyne pro celou populaci.

Pět řetězců změny platí, jen když se splní čtyři předpoklady

Čte se zleva doprava: vstupy, činnosti, výstupy, výsledky, dopady

činnost s opatřeními jádra (J) · vstup, výstup, výsledek · dopad na populaci · předpoklad · → vede k

Textová verze

Vstupy: Peníze: platby týmům, fond přeměny lůžek, daně za zdraví, platba státu (J10) · Lidé: sestry a praktici, rezidenční místa, nábor a aprobace · Pravidla a data: pětileté smlouvy, zákony vln 1 až 3, eŽádanka a registry.

Pět řetězců (činnost → výstup → výsledek; síla evidence)

1. Týmy → kontinuita: J1, J2, J3 Týmy: standard a smlouva, sestry, kompetence → Týmy v terénu: asi 520 kolem 2038, sestry v týmech → Kontinuita péče: index UPC roste, méně lidí bez lékaře. Evidence: střední; pozorovací studie.
2. Péče doma → méně příjmů: J4 Péče doma: návštěvní služba, doprava k lékaři → Péče u pacienta: návštěvy a kontroly podle protokolu → Méně příjmů: odvratitelné hospitalizace (ACSC) a rehospitalizace. Evidence: silná pro výsledky u chroniků, slabá pro úspory.
3. eŽádanka → termín včas: J5 eŽádanka: triážní údaj, měření čekání → Data o čekání: po kategoriích a krajích, veřejně → Termín včas: v lhůtě podle kategorie žádanky. Evidence: nízká; jde o nástroj měření, nikoli léčby.
4. Síť → péče blíž domovu: J6, J7 Síť: plán sítě, kapacita dlouhodobé péče → Přeměna lůžek: 8 000 do roku 2038, obložnost pod 85 % → Péče blíž domovu: akutní lůžková péče z 29,7 % na 26 %. Evidence: střední; závisí na politické vůli.
5. Daně → zdravější volby: J8, J9 Daně: víno, líh a pivo, slazené nápoje → Výnos a fond: 5 mld. Kč ročně, 2 mld. Kč do fondu prevence → Zdravější volby: méně alkoholu a cukru, víc screeningu. Evidence: silná.

Dopady: Zdraví: víc let ve zdraví, méně úmrtí, kterým šlo předejít · Spravedlnost: menší rozdíly mezi kraji a skupinami, bez vyšších plateb · Udržitelnost: síť, která obstojí ve stárnoucí společnosti.

Čtyři předpoklady

- Sestry: polovina míst obsazena do 12/2031 (brána B3); jinak varianta B.
- Data: eŽádanka a registry pojišťoven průběžně; jinak brána čeká.
- Peníze: vzorec platby státu a daně ve vlně 1; jinak varianta B.
- Dlouhodobá péče: kapacita v kraji před přeměnou lůžek; jinak lůžko zůstává.

Podklad: studie v3, ř. 386–404 (tabulka řetězců ř. 394–400); předpoklady podle pravidel rozhodování ř. 1954–1961.

teorie změny · 5 řetězců, 4 předpoklady

Každý článek má v Části IX svůj mezikrok a v ekonomickém modelu (Část V) svou citlivost. Úspory se tak neopírají o slabší článek víc, než unese jeho evidence.

Řetězec	Mezikrok, který měříme	Síla evidence	O co se opírá
Týmy → kontinuita	index obvyklého poskytovatele (UPC), lidé bez praktika	střední; pozorovací studie	Systematický přehled 22 studií spojuje kontinuitu s nižší úmrtností (Pereira Gray 2018, PMID 29959146). Norská registrová studie: lidé s týmž praktikem 15 a více let mají asi o čtvrtinu nižší úmrtnost (Sandvik 2022, PMID 34607797). Dokládá hodnotu kontinuity, ne účinek této reformy
Péče doma → méně příjmů	odvratitelné hospitalizace (ACSC), rehospitalizace	silná pro výsledky u chroniků, slabá pro úspory	Péče vedená sestrou je stejně bezpečná nebo bezpečnější (Paier-Abuzahra 2024); úspora nákladů prokázaná není (Laurant 2018). Dálkové sledování srdečního selhání snižuje hospitalizace, účinek se ukazuje až po 12 měsících (De Lathauwer 2025, PMID 39834044)
eŽádanka → termín včas	podíl vyšetření v lhůtě podle kategorie	nízká; jde o nástroj měření, ne léčby	Mechanismus je správní: bez triážního údaje nelze lhůtu garantovat ani kontrolovat
Síť → péče blíž domovu	podíl akutní lůžkové péče, obložnost, dojezd	střední; závisí na politické vůli	Obložnost nad 85 % zvyšuje úmrtnost o 9 % (Madsen 2014). Ve švédské studii připadalo na tři zachovaná lůžka jedno úmrtí méně (Siverskog 2022). Nový Zéland snížil lůžka bez ztráty přístupu, ale s vyšší zátěží a rehospitalizacemi (Davis 2007)
Daně → zdravější volby	spotřeba alkoholu, obsah cukru v nápojích, výnos	silná	Minimální cena alkoholu ve Skotsku: o 13,4 % méně úmrtí plně způsobených alkoholem (Wyper 2023, PMID 36963415). Daně ze slazených nápojů snižují nákupy (Andreyeva 2022, PMID 35648398)

Řetěz může selhat na třech místech. Velký tým bez jmenovitého lékaře sníží kontinuitu, sestry nemusí přijít a plán sítě nemusí nikdo schválit. Proto jsou kontinuita, personální bilance a zákon o síti tři věci, o které se studie stará nejvíc.

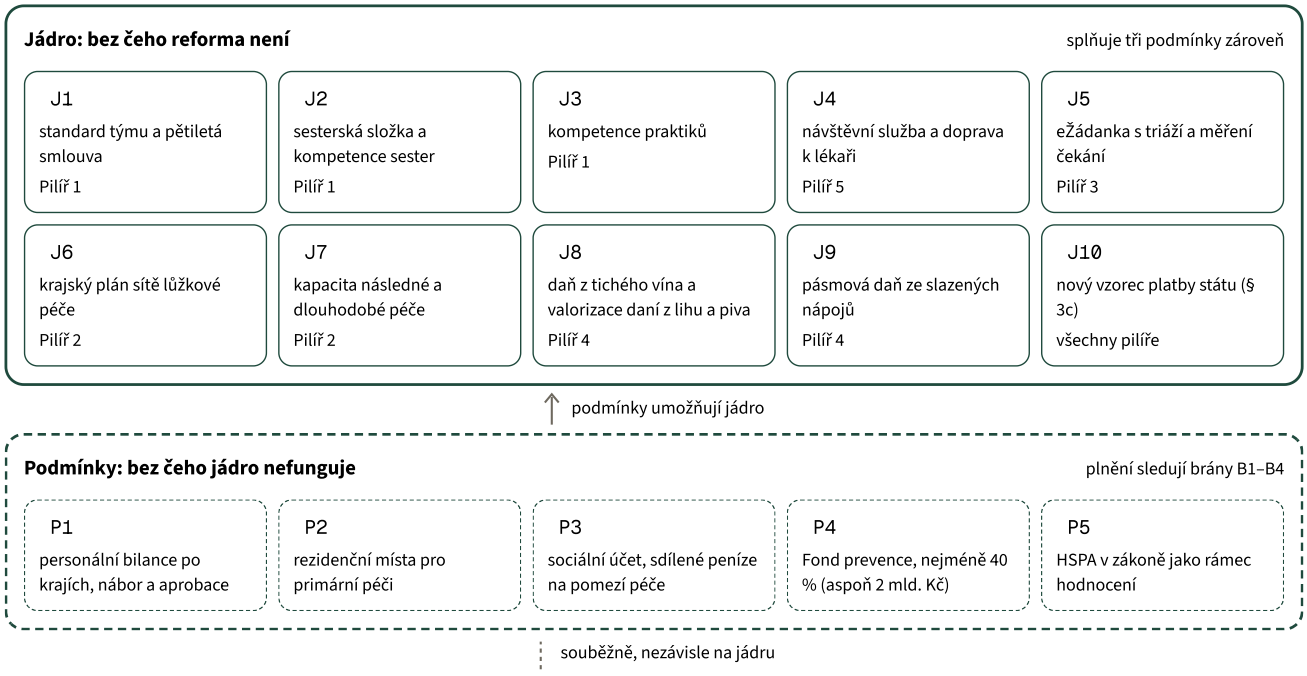
Platby týmům samy o sobě výsledky nezaručí. Nizozemské balíčkové platby za chroniky zvýšily výdaje (Karimi 2021, PMID 33947604). Proto se platí za funkce, které tým skutečně zajistí, a odměna za výsledky má strop.

Tři vrstvy opatření

Verze 2 obsahovala odhadem 150 až 170 opatření bez pořadí; verze 3 je dělí do tří vrstev a jádro tvoří jen deset z nich. Oponent napadne nejslabší článek, jako by byl nosný; proto musí být na první pohled vidět, co nosné je.

Bez deseti opatření jádra reforma není; pět podmínek ho drží

Tři vrstvy opatření; doprovod má vlastní harmonogram a jádro nezdržuje



Textová verze

Jádro: bez čeho reforma není

- J1 Standard týmu sdružené péče a pětiletá smlouva (Pilíř 1)
- J2 Sesterská složka úhrady a rozšířené kompetence sester (Pilíř 1)
- J3 Kompetence praktiků (preskripční omezení, nové výkony, USG) (Pilíř 1)
- J4 Návštěvní služba a doprava k lékaři (senior taxi) (Pilíř 5)
- J5 eŽádanka s triážním údajem, měření čekání a lidí bez praktika (Pilíř 3)
- J6 Krajský plán sítě lůžkové péče (10 let, čtyři skupiny lůžek, fond přeměny) (Pilíř 2)
- J7 Kapacita následné a dlouhodobé péče jako podmínka každé přeměny (Pilíř 2)
- J8 Daň z tichého vína (poloviční sazba pro malé vinaře) a valorizace daní z lihu a piva (Pilíř 4)
- J9 Pásmová daň ze slazených nápojů (Pilíř 4)
- J10 Nový vzorec platby státu za státní pojištěnce (všechny pilíře)

Podmínky: bez čeho jádro nefunguje (umožňují jádro)

- P1 Personální bilance po krajích (nábor ze zahraničí, zrychlení aprobací)
- P2 Rezidenční místa (praktici, pediatři)
- P3 Sociální účet a sdílené financování sociálně-zdravotní péče
- P4 Fond prevence zdravotních pojišťoven (nejméně 40 % výnosu daní za zdraví, nejméně 2 mld. Kč)
- P5 HSPA jako oficiální rámec hodnocení v zákoně

Doprovod: deset oblastí Manifestu jako policy briefy (souběžně, nezávisle na jádru)

1. Hodnocení účelnosti a standard péče: 4 opatření (M1.1, M1.2, M1.3, M1.4)
2. Rozšířená péče: 4 opatření (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4)
3. Pojišťovny, DRG, evidence nároků: 4 opatření (M3.1, M3.2, M3.3, M3.4)
4. Transparence a otevřená data: 5 opatření (M4.1, M4.2, M4.3, M4.4, M4.5)
5. Dostupné léky: 4 opatření (M5.1, M5.2, M5.3, M5.4)
6. Světový klinický výzkum: 4 opatření (M6.1, M6.2, M6.3, M6.4)
7. Stomatologie: 5 opatření (M7.1, M7.2, M7.3, M7.4, M7.5)
8. Vzdělání a podmínky personálu: 5 opatření (M8.1, M8.2, M8.3, M8.4, M8.5)
9. Práva pacientů: 5 opatření (M9.1, M9.2, M9.3, M9.4, M9.5)
10. Duševní zdraví: 5 opatření (M10.1, M10.2, M10.3, M10.4, M10.5)

Podklad: studie v3, ř. 406–431; registr opatření (registr.json); oblasti Manifestu ř. 2147–2158.

tři vrstvy opatření · 10 jádro, 5 podmínek, 10 oblastí doprovodu

Do jádra patří opatření, která splňují tři podmínky zároveň. Za prvé, bez něj se přeruší některý řetězec teorie změny. Za druhé, nelze ho nahradit jiným opatřením. Za třetí, má konkrétní právní nástroj a termín ve scénáři „Vláda 2030“.

Opatření jádra	Bez čeho by reforma nebyla	Právní nástroj
J1 Standard týmu a pětiletá smlouva	Tým by neměl definici ani stabilní příjem; praktik by do něj neměl důvod vstoupit	smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.; později nová hlava zák. 372/2011 Sb.
J2 Sesterská složka a kompetence sester	Sestry by v ordinacích zůstaly u administrativy; řetězec péče o chroniky by neexistoval	vyhl. 55/2011 Sb., úhradová vyhláška
J3 Kompetence praktiků	Nejlevnější páka: bez ní praktik dál posílá ke specialistovi kvůli preskripčním omezením a výkonům, které zvládne sám	seznam výkonů, úhradová vyhláška
J4 Návštěvní služba a doprava k lékaři	Lidé, kteří nedojdou, by zůstali bez péče do zhoršení	úhradová vyhláška; smlouvy s obcemi
J5 eŽádanka s triážním údajem a měření čekání	Bez něj nelze garantovat lhůtu ani poznat, zda reforma zkracuje čekání	novela zák. 325/2021 Sb.
J6 Krajský plán sítě lůžkové péče	Lůžka by se dál měnila podle nahodilých rozhodnutí vlastníků	zákon o síti
J7 Kapacita následné a dlouhodobé péče	Přeměna akutních lůžek by přesunula pacienty na chodby a do rodin	zákon o síti; podmínka každé přeměny
J8 Daň z tichého vína a valorizace daní z lihu a piva	Bez ní chybí zdroj i nástroj prevence	zákon o spotřebních daních
J9 Pásmová daň ze slazených nápojů	Jediný nástroj, který mění složení výrobků dřív, než začne platit	nový zákon (střední předloha, vlna 1)
J10 Nový vzorec platby státu	Reforma by neměla stabilní zdroj; platba za státní pojištěnce by dál závisela na ročním rozhodnutí	§ 3c zák. 592/1992 Sb.

Podmínky P1 až P5 samy péči nemění, ale bez nich jádro selže. Personální bilance (P1) rozhoduje, zda přijdou sestry; sociální účet (P3) rozhoduje, zda bude kam přesunout pacienty z akutních lůžek. Jejich plnění sledují brány v Části VIII.

Doprovod tvoří deset oblastí Manifestu. Každá dostane krátký policy brief s vlastním harmonogramem (Část XI). Zpoždění doprovodu jádro nezastaví, a naopak.

Rozsah jádra odpovídá kapacitě státu. Za jedno volební období lze realisticky přijmout dvě velké předlohy, zákon o primární péči a zákon o síti, plus střední daňový zákon (Část VII). Zapisovatel, dálkové sledování a další nástroje zůstávají v pilířích jako nástroje ověřované v pilotu. Úplný seznam všech opatření s nástrojem, nákladem a termínem je v záložce Registr opatření.

Pět pilířů

Deset opatření jádra se rozpadá do pěti pilířů; každý pilíř má jeden cíl a jeden hlavní ukazatel. Pilíře říkají, kde se péče mění; jádro říká, čím se mění. Podrobně je rozpracovává Část III.

Pilíř	Cíl	Opatření jádra	Hlavní ukazatel
1. Týmy sdružené péče a centra primární péče	Každý má svůj tým a jmenovitého lékaře	J1 , J2 , J3	lidé bez praktika (H1); týmy a místa sester (H2); kontinuita UPC (H4)
2. Méně akutních lůžek, víc následné péče	Akutní lůžko jen tam, kde je potřeba	J6 , J7	podíl akutní lůžkové péče na výdajích (H6)
3. Technologie jako pomocník, ne lékař	Ke specialistovi podle naléhavosti, čekání je vidět	J5	čekání podle triážní kategorie (H3)
4. Prevence a daně za zdraví	Méně nemocí, kterým lze předejít	J8 , J9 (s podmínkou P4)	odvratitelná úmrtnost (H7); doplňkově screening a spotřeba alkoholu
5. Stárnutí, péče doma a závěr života	Péče doma, ne na lůžku z nouze	J4 (s podmínkou P3)	odvratitelné hospitalizace (H5)

Nový vzorec platby státu (J10) nepatří do žádného pilíře, protože financuje všechny. Pilíř 3 má v jádře jen eŽádanku; zapisovatel a dálkové sledování se nejdřív ověří v pilotu.

Oproti verzi 2 se dva pilíře rozšiřují. Pilíř 1 má kompetence praktiků jako samostatné opatření (J3) a zachovává dětské praktiky. Pilíř 2 nově zahrnuje dětská lůžková oddělení a indikační omezení místo objemových limitů, která navrhoval už program 2021.

Varianty A, B a C

Reforma má tři varianty: plnou A s centry, B bez center a minimální C; základní je A a na B se zmenší, když v prosinci 2031 nebude splněna brána B3. Všechny tři vycházejí ze stejné diagnózy a stejných dat. Pozor na označení: verze 2 řadila varianty opačně (A byla dofinancování, C týmy a centra).

Verze 2 srovnávala neférově. Rozdíl mezi variantou bez center a s centry obsahoval paliativní týmy, prevenci, konzultace lékař s lékařem a fond přeměny lůžek, které na centrech vůbec nezávisí. Varianta bez center tak vycházela uměle levně a centra uměle „za málo navíc“. Ve verzi 3 jsou tyto položky i ve variantě B.

Složka	A: plná, s centry	B: bez center	C: minimální
Týmy podle standardu a pětiletá smlouva (J1)	ano, včetně týmů založených obcí nebo krajem	ano, jen z existujících praxí (týmová praxe, smluvní síť ordinací)	ne; dnešní podpora týmových praxí
Sestry navíc a sesterská složka (J2)	ano	ano	ne
Kompetence praktiků (J3)	ano	ano	ano
Centra primární péče: budovy a další profese pod jednou střechou	ano	ne	ne
Návštěvní služba a doprava k lékaři (J4)	ano	ano	ne
eŽádanka s triáží a měření čekání (J5)	ano	ano	ano
Hrazená konzultace lékař s lékařem a zpětná zpráva	ano	ano	ne
Mobilní paliativní týmy	ano	ano	ne
Plán sítě, kapacita dlouhodobé péče a fond přeměny (J6 , J7)	ano	ano	ne
Daně za zdraví a Fond prevence (J8 , J9 , P4)	ano	ano	ano
Nový vzorec platby státu (J10)	ano	ano	ano
Pomůže tam, kde praktik chybí	ano: obec nebo kraj založí tým	jen kde existuje praxe	ne
Kontinuita lékař a pacient	ohrožena ve velkých týmech; pojistka jmenovitý lékař a UPC	zachována, pojistka stejná	zachována
Závislost na sestrách	nejvyšší	vysoká	nízká
Čistý náklad v plném náběhu (ceny 2026)	asi 21,5 mld. Kč ročně (rozpětí 15 až 25)	asi 18 mld. Kč ročně (17,8)	asi 11 mld. Kč ročně (11,3)
Kdy platí	základní varianta	brána B3 nesplněna	srovnávací základ

Varianta C je zhruba prodloužení dnešní politiky ministerstva. Ministerstvo už plánuje 10 mld. Kč z veřejného zdravotního pojištění na podporu praxí; C k tomu přidává daně za zdraví, vzorec platby státu, kompetence praktiků a eŽádanku. Udrží dnešní síť, ale nepřivede sestry ani péči domů a venkovské ordinace dál zanikají bez náhrady.

Proč A, a ne B. Rozhoduje venkov: B předpokládá praxi, kterou lze posílit, ale v 428 obcích praxe mezi lety 2018 a 2022 zanikla. Pouze A umožňuje, aby obec, kraj nebo sousední tým převzal území jako celek. Rozdíl v nákladu mezi A a B kupuje právě tohle: budovy, další profese pod jednou střechou a schopnost vstoupit tam, kde trh selhal.

Kdy se reforma zmenší na B. Brána B3 „Lidé a data“ v prosinci 2031 má tři kritéria:

- v týmech první vlny je obsazena aspoň polovina míst sester, doloženo z registrů pojišťoven, ne z dat ÚZIS se zpožděním;
- zákon o primární péči je schválen;
- krajské plány sítě jsou rozpracované.

Když brána splněna není, Řídicí výbor reformy přejde na variantu B a centra se nestaví. Týmy v existujících praxích, sestry, paliativní týmy, prevence, konzultace a fond přeměny pokračují. Reforma se zmenší, nezastaví; investice do budov center se proto smluvně vážou až na splněnou bránu B3.

První signál dá už pilot ve třech ORP v letech 2028 a 2029. Ukáže, zda praktici do týmů vstupují a zda se daří obsadit místa sester; závěrečné vyhodnocení přijde v roce 2030 (Část VIII).

Cesta pacienta

Ke specialistovi se pacient dostane podle naléhavosti, kterou indikující lékař určí v eŽádance jednou ze tří kategorií: urgentní do 2 týdnů, do 6 týdnů, nebo plánovaná. Gatekeeping je měkký: přímý přístup ke specialistovi zůstává, žádanka dává přednost v objednání a garantovanou lhůtu. Ambulantní specialisté jsou druhým největším segmentem výdajů, asi 116 mld. Kč ročně.

Pořadí u specialisty určuje triáž v eŽádance; pacient se vrací ke svému týmu

Cesta pacienta po reformě · měkký gatekeeping, přímý přístup zůstává

Ke gynekologovi, očnímu lékaři, zubaři, psychiatrovi a do dispenzarizované onkologie se chodí bez doporučení jako dnes.

krok · eŽádanka s triáží · rozhodnutí · cesta v týmu · vstup mimo tým

Textová verze

Kroky a rozhodnutí

- Příznak: pacient se ozve svému týmu
- Tým sdružené péče: jmenovitý lékař a sestra; většinu potíží vyřeší sám
- Je potřeba specialista?
- eŽádanka s triáží: otázka, výsledky, kategorie: urgentní do 2 týdnů, do 6 týdnů, nebo plánovaná
- Ambulantní specialista: termín v lhůtě kategorie; kategorii smí zdůvodněně změnit
- Je potřeba hospitalizace?
- Nemocnice: akutní lůžko jen při potřebě
- Následná péče nebo domů: propouštěcí zpráva týmu, návštěvy, paliativní tým
- Triáž kraje nebo pojišťovny: pro lidi bez praktika a s varovnými příznaky; vystaví eŽádanku
- Přímý přístup: bez žádanky zůstává; se žádankou má pacient přednost
- Lhůta nedodržena: pojišťovna zajistí jiný termín; opakovaně: ztráta bonusu

Vazby

- Příznak → Tým sdružené péče
- Tým sdružené péče → Je potřeba specialista?
- Je potřeba specialista? → eŽádanka s triáží (ano)
- Je potřeba specialista? → Tým sdružené péče (ne: péče v týmu)
- eŽádanka s triáží → Ambulantní specialista
- Ambulantní specialista → Je potřeba hospitalizace?
- Je potřeba hospitalizace? → Nemocnice (ano)
- Je potřeba hospitalizace? → Tým sdružené péče (ne: zpětná zpráva)
- Nemocnice → Následná péče nebo domů
- Následná péče nebo domů → Tým sdružené péče (propuštění, návrat k jmenovitému lékaři)
- Příznak → Triáž kraje nebo pojišťovny (bez praktika nebo s varovnými příznaky)
- Příznak → Přímý přístup (přímo ke specialistovi)
- Triáž kraje nebo pojišťovny → eŽádanka s triáží
- Přímý přístup → Ambulantní specialista
- Lhůta nedodržena → Ambulantní specialista (jiný termín)

Ke gynekologovi, očnímu lékaři, zubaři, psychiatrovi a do dispenzarizované onkologie se chodí bez doporučení jako dnes.

Podklad: studie v3, ř. 488–518 (pravidla 1–8 ř. 496–503); J5 ř. 690–700.

cesta pacienta · 7 kroků, 2 rozhodnutí, 3 vstupy mimo tým

Pravidla, která ve verzi 2 chyběla, jsou následující.

- **Kdo posuzuje naléhavost.** Indikující lékař, tedy praktik nebo specialista, po klinickém posouzení. Nikdy úřad ani pojišťovna.
- **V jakém poli.** Povinné strukturované pole „triážní kategorie“ v eŽádance, vedle klinické otázky a výsledků. Zavádí ho pozměňovací návrh k vládní novele zák. 325/2021 Sb., která má eŽádanku učinit povinnou.
- **Změna kategorie.** Specialista smí kategorii změnit, pokud změnu zdůvodní v témže záznamu. Změny se vyhodnocují, aby bylo vidět, zda indikující lékaři kategorie systematicky nenadsazují.
- **Přímý přístup.** Bez žádanky lze ke specialistovi jít i nadále; pacient se žádankou má přednost v objednání. Ke gynekologovi, očnímu lékaři, zubaři, psychiatrovi a do dispenzarizované onkologie se chodí bez doporučení jako dnes.
- **Garance lhůty.** Pojišťovna garantuje termín podle kategorie. Když ho smluvní specialista ve lhůtě nenabídne, pojišťovna zajistí termín u jiného smluvního poskytovatele.
- **Sankce.** Netýká se pacienta. Poskytovatel, který lhůty opakovaně nedodrží, ztrácí bonus za dostupnost.
- **Měření.** Čekání se z eŽádanky zveřejňuje po odbornostech a krajích, zvlášť pro pacienty se žádankou a bez ní. Když se čekání pacientů bez žádanky prodlouží, pravidla se změní.

- **Lidé bez praktika.** Žádanku jim vystaví triáž kraje nebo pojišťovny, při varovných příznacích hned. Pojišťovna, která do 30 dnů nezajistí registraci, zajistí do té doby vyšetření lékařem nebo sestrou smluvního týmu.

Pravidla právně stojí na změně § 17 a § 46 zák. 48/1997 Sb. a na povinném triážním poli v eŽádance. Bez nich by zůstala deklarací, protože ambulantní specialisté jsou soukromí a váže je jen smlouva s pojišťovnou.

Cesta ke specialistovi končí návratem do týmu. Hrazená konzultace lékaře s lékařem a zpětná zpráva vracejí stabilního pacienta k jeho lékaři; platí se odpověď, ne přednost. Náklad těchto nových výkonů je v Části V.

Proč ne povinné doporučení. Dopis MUDr. Pavla Neničky z roku 2023 navrhl plné rodinné lékařství s povinným doporučením. Studie z něj přebírá kompetence praktika (J3), ale povinné doporučení ne: tam, kde praktik chybí, se mění v další frontu. To ukazují i země s praktikem jako vstupem do systému, Španělsko, Nizozemsko a Dánsko.

Kontinuita. Každý pacient má i v týmu jmenovitého ošetřujícího lékaře a svou sestru, zapsané v registru pojišťovny. Kontinuita je hlavní konstrukční zásada týmu, ne vedlejší ukazatel; měří ji index obvyklého poskytovatele (UPC), hlavní ukazatel H4.

Evidence tu jde dvěma směry. Kontinuita s týmž lékařem souvisí s nižší úmrtností (Pereira Gray 2018, PMID 29959146; Sandvik 2022, PMID 34607797). Vícečlenné týmy ale vztahovou kontinuitu často snižují (Bates 2025, PMID 41181853; Kegreiss 2026, DOI 10.1186/s12875-026-03507-y; Kovacevic 2023, PMID 37976620) a kontinuita s praxí ji nahrazuje jen zčásti (McDonald 2024).

Z toho plynou tři pojistky. Jmenovitý lékař je podmínkou standardu týmu (J1). Index UPC se měří za každý tým čtvrtletně z dat pojišťoven. Kontinuita je kontrolním bodem pilotu: klesne-li v pilotních týmech pod 0,7, upraví se standard týmu dřív, než ho převezme zákon o primární péči.

Plné bibliografické údaje všech tří zdrojů uvádí záložka Evidence a zdroje (E2). Starší práce Kegreiss a kol. 2023 (PMID 37909317) navíc ukazuje, že částečné úvazky praktiků zhoršují dostupnost a kontinuitu.

Co reforma nedělá

Šest věcí reforma výslovně nenavrhuje, i když se jí v veřejné debatě přičítají nebo je navrhují jiné dokumenty. Každá z nich by podkopala důvěru pacientů nebo zdravotníků, na které reforma spoléhá.

- **Nezavádí regulační poplatky** ani příplatky za kratší čekání. Programový text „Zdravotnictví pro 21. století“ poplatky navrhuje; studie tento návrh výslovně opouští a hlídá katastrofické výdaje domácností (H8).
- **Neruší dětské praktiky.** Péče o děti zůstává u praktiků pro děti a dorost a dětské týmy se zachovávají. Kde dětský praktik chybí, může se dítě registrovat u praktika pro dospělé v týmu.
- **Neruší nemocnice.** Mění účel části akutních lůžek na následnou, rehabilitační a paliativní péči. Žádné lůžko se nepřemění, dokud kraj neprokáže kapacitu následné a dlouhodobé péče a dojezd záchranné služby (J7).
- **Neprivatizuje.** Nemocnice ani pojišťovny se neprodávají. Praktici zůstávají soukromí a hodnotu své praxe neztratí; budovy center vlastní obec nebo kraj.
- **Nikoho nenutí.** Vstup praktika do týmu je dobrovolný; kdo nevstoupí, zůstává u dnešní úhrady. Povinné doporučení ke specialistovi reforma nezavádí.
- **Nesnižuje odvody z práce z daní za zdraví.** Fond prevence dostane nejméně 40 % výnosu, nejméně 2 mld. Kč ročně, zbytek výnosu zvyšuje platbu státu do veřejného zdravotního pojištění. Tvrzení politické verze 2 o nižších odvodech bylo chybou.

Část III — Jádro reformy: primární péče a digitální nástroje (pilíře 1 a 3)

Pět z deseti opatření jádra (J1 – J5) stojí v primární péči: kolem roku 2038 má fungovat asi 520 týmů sdružené péče, každý pro spádové území s 10 až 25 tisíci obyvatel. Pilíř 1 mění, kdo pacienta ošetří a jak se za to platí. Pilíř 3 dodává nástroje, bez kterých se týmová péče nedá řídit ani měřit.

Obojí stojí na dobrovolnosti. Nikdo nemusí do týmu vstoupit a funkční samostatná ordinace, která nezajistí nové funkce, zůstane u dnešní úhrady, ne u nižší.

Každé opatření jádra má jednotnou kartu: proč, co přesně, právní nástroj a vlna, kdo, kdy, na čem závisí, rizika a pojistky. Termíny platí pro základní scénář „Vláda 2030“; doplňkový scénář „Dnešní vláda převezme část“ by nástroje vlny 0 posunul o jeden až dva roky dřív. Souhrnné náklady pilíře a náběh sester a týmů po letech jsou v Části V.

J1 · Standard týmu sdružené péče a pětiletá smlouva

Proč. K 30. 6. 2026 fungovalo 241 týmových praxí (174 pro dospělé, 67 pro děti) a jen u VZP díky nim našlo praktika 43 705 lidí (VZP, 15. 7. 2026). Týmová praxe podle úhradové vyhlášky ale nevyžaduje sestry ani další profese a centrum primární péče z Implementačního plánu MZ č. 2.1 (prosinec 2025) zatím nemá právní definici. Praktiků pro dospělé je asi 5 500, třetina je starší 60 let a ubývá jich 110 až 180 ročně (ÚZIS k 31. 12. 2024).

Zahraniční zkušenost ukazuje, že rozhoduje úhrada, ne budova. Estonsko vázalo dotaci na smlouvu se skupinou praktiků a do roku 2022 vzniklo 60 středisek pro 44 % populace; samostatní praktici ale vstupovali pomalu, protože střediska neměla vyšší úhradu (Habicht a kol. 2023, PMID 36764032). Přehled 39 studií o multidisciplinárních týmech našel smíšené výsledky: lepší péči o chroniky, ale místy roztříštěnou vztahovou kontinuitu (Bates a kol. 2025, PMID 41181853).

Co přesně. Standard definuje minimální funkce týmu, ne jeho právní formu. Platíme za funkce: zástupnost, prodlouženou dostupnost, návštěvní službu, poradny chroniků a kontinuitu zaplatí pojišťovna stejně jedné společnosti i smluvní síti ordinací.

Prvek	Parametr standardu
Spádové území	10 až 25 tisíc obyvatel; plánovací jednotka, ne přidělení pacientů. Svobodná volba poskytovatele (§ 11 zák. 48/1997 Sb.) se nemění
Lékaři	Malý tým 5 až 7 lékařů pro dospělé a 2 pro děti, střední tým 8 až 13 a 3 až 4; ve velkých městech víc malých týmů v jednom centru
Jmenovitá dvojice	Každý registrovaný má jmenovitého ošetřujícího lékaře a sestru; zástup je výjimka
Další profese	Nutriční terapeut, fyzioterapeut, psycholog (0,75 úvazku), recepce 1,5 úvazku; malý tým je smí sdílet se sousedním
Dostupnost	Akutní stav týž den, neakutní do pěti pracovních dnů; ordinace ve všední dny do 19 hodin a v sobotu dopoledne
Forma	Jeden poskytovatel (s. r. o. nebo družstvo lékařů, organizace obce či kraje), nebo smluvní síť ordinací s vlastním IČO
Smlouva	Dobrovolný vstup, pětiletá smlouva se všemi pojišťovnami
Úhrada	Lékařská složka: 10 000 Kč měsíčně za desetinu úvazku nad první úvazek × krajský koeficient (navazuje na týmovou praxi). Sesterská a profesní složka: viz J2. Odměna za výsledky: až 10 % roční kapitace týmu

Odměna za výsledky se řídí osmi až deseti ukazateli, které tým ovlivní: prevence, kontrolovaní diabetici a hypertonici, očkování seniorů, dostupnost, nově registrovaní a kontinuita. Ukazatele jsou rizikově upravené věkovými indexy, které kapitace už používá, a registrace křehkého seniora 75+ nese bonus. Strop 10 % vychází z britské zkušenosti, kde platba za výsledky zlepšila procesní ukazatele jen mírně a se stropovým efektem (Roland a Guthrie 2016, PMID 27492602).

Platby týmům v plném náběhu odhadujeme na 4,8 až 7,5 mld. Kč ročně, ne na 2,5 mld. Kč jako ve verzi 2. Kolik z toho už kryje plán MZ (asi 10 mld. Kč z veřejného zdravotního pojištění na podporu praxí do roku 2030), rozlišuje Část V. Budova přichází až po týmu: dotaci na centrum dostane jen obec nebo kraj, a to se smlouvou o budoucím nájmu s týmem na nejméně deset let.

Právní nástroj. Vlna 0: smluvní model, tedy smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb. (dodatek smlouvy pojišťovny s týmem, pilot) a standard týmu a centra jako metodika ve Věstníku MZ. Vlna 2 (zákon o primární péči): nová hlava zák. 372/2011 Sb. s definicí týmu a centra, smluvní sítí, spádem, skutečnými majiteli a klinickou nezávislostí (rozsah L, 30 až 40 paragrafů). K tomu novela § 17 a § 46 zák. 48/1997 Sb. o víceleté smlouvě se všemi pojišťovnami a platbě za funkce.

Kdo. Standard spolutvoří SPL ČR, SPLDD ČR, SVL ČLS JEP a ČAS; pilotní smlouvu uzavírá VZP, zaměstnanecké pojišťovny přistupují dobrovolně. Pilot nese kraj, který se k pilotu přihlásí, a tři jeho ORP. Věcný záměr zákona připraví resortní tým s Institutem Pi, předlohu předloží MZ.

Kdy. Návrh standardu jde do konzultace v roce 2027 (fáze F0). Pilot ve třech ORP běží v letech 2028 a 2029, pokud se kraj a VZP dohodnou do června 2027; průběžné vyhodnocení přijde po roce provozu, závěrečné v roce 2030. Zákon o primární péči vláda předloží v roce 2030 s účinností od 1. 1. 2032; do té doby platí smluvní model.

Cílový stav je asi 520 týmů kolem roku 2038; náběh po letech uvádí Část V. V doplňkovém scénáři by metodika ve Věstníku vyšla už v roce 2027 a smluvní model by od roku 2028 nabízely všechny pojišťovny.

Na čem závisí. Bez `J2` je tým jen větší ordinace, bez `J5` nejde měřit dostupnost a počet lidí bez praktika, bez `J4` tým neobslouží ty, kdo nedojdou. Dále na `P1` (personální bilance po krajích), `P2` (rezidenční místa) a `J10` (platba státu). Víceleté smlouvy z vládní reformy „Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030“ chceme pozměňovacím návrhem otevřít i týmům.

Rizika a pojistky. Bez pojistek by design týmu (jeden poskytovatel, pětiletá smlouva, budova) zvýhodnil kapitálově silné řetězce proti společnostem lékařů. Navrhujeme šest pojistek:

- skutečný vlastník každého poskytovatele je veřejně dohledatelný;
- koncentrace se posuzuje ve spádovém území a obci: smlouvu, kterou by jeden vlastník ovládl většinu kapacity praktiků ve spádu, uzavře pojišťovna jen po veřejném posouzení a vyjádření obce;
- platby mezi propojenými firmami (nájem, služby, management) mají pravidla a jsou zveřejněné;
- zákon zaručí klinickou nezávislost lékaře a sestry vůči vlastníkovi;
- jeden vlastník smí mít nejvýš 20 % spádových území kraje (mimo organizace obcí a krajů);
- dotace na budovu jde jen obci nebo kraji.

Kontinuita je druhé hlavní riziko. Větší praxe mívají nižší kontinuitu (Barker a kol. 2017, PMID 28148478) a kontinuita s lékařem je spojena s nižší úmrtností (Pereira Gray a kol. 2018, PMID 29959146; Sandvik a kol. 2022, PMID 34607797). Kontinuita s praxí ji zčásti nahrazuje, ale ne plně (McDonald a kol. 2024, PMID 38806258).

Pojistkou je jmenovitý ošetřující lékař a sestra pro každého pacienta, malé týmy a index obvyklého poskytovatele (UPC) jako ukazatel odměny. UPC je zároveň kontrolním bodem pilotu: pokud v pilotních ORP klesne proti výchozímu stavu, upraví se design před předložením zákona. Pokud praktici do týmů nevstoupí, zůstává dobrovolnost, ochrana hodnoty praxe a záložní varianta B.

Pacient má svého lékaře a sestru; tým kolem nich sdílí další profese

Organigram týmu sdružené péče a jeho napojení na okolí

jmenovitá dvojice: střed týmu další části týmu a partneři tým sdružené péče

Textová verze

Tým: sedm částí

- Jmenovitá dvojice: ošetřující lékař a sestra pro každého registrovaného; zástup je výjimka; kontinuita se měří (UPC)
- Lékaři pro dospělé: malý tým 5–7, střední 8–13
- Lékaři pro děti: 2–4 lékaři, dětská sestra; dítě v 18 zůstává v týmu
- Sestry: poradny chroniků podle protokolů; hodnotí dálkové sledování
- Další profese: nutriční terapeut, fyzioterapeut, psycholog
- Návštěvní služba: ležící a křehcí, lidé po propuštění
- Recepce a třídění požadavků: 1,5 úvazku; akutní stav týž den

Šest partnerů týmu

- Zdravotní pojišťovny: pětiletá smlouva se všemi; platba za funkce a výsledky
- Obec a ORP: budova centra, senior taxi
- Kraj: telefonická triáž; plán sítě, pilot ve třech ORP
- Ambulantní specialisté: eŽádanka s triážním údajem; konzultace, zpětná zpráva
- Nemocnice a ZZS: propuštění s předáním týmu; pohotovost u urgentního příjmu
- Domácí a paliativní péče: sociální a pečovatelské služby; společný plán péče

Středem týmu je jmenovitá dvojice lékaře a sestry; ostatní profese a partneři kolem ní pracují, ale pacienta jí nepřebírají.

Podklad: studie v3, ř. 538–586 (standard týmu ř. 549–558); J2 ř. 598–606; J4 ř. 660–669.

organigram týmu sdružené péče · 7 částí týmu, 6 partnerů

Středem týmu je jmenovitá dvojice lékaře a sestry; ostatní profese a partneři kolem ní pracují, ale pacienta jí nepřebírají.

J2 · Sesterská složka úhrady a rozšířené kompetence sester

Proč. Jen nových všeobecných sester je za 10 až 12 let potřeba nejméně 24 000 úvazků, zatímco vysoké školy dnes dávají asi 680 a vyšší odborné školy asi 570 absolventů ošetřovatelství ročně (vládní program pro nelékařské profese 2026–2037; MZ ČR 2025, s. 112 a 114). Typická ordinace praktika má dnes asi jednu sestru na lékaře a úhrada neodměňuje, když jich má víc. Průměrný věk všeobecné sestry byl v roce 2023 48,2 roku (ÚZIS) a přes 12 tisíc všeobecných sester je starších 60 let (NZIS; MZ ČR 2025, s. 111).

Evidence je příznivá, ale ne bezvýhradná. Cochranový přehled 18 randomizovaných studií našel u péče vedené sestrou podobné nebo lepší zdravotní výsledky a vyšší spokojenost, úspora nákladů je ale nejistá (Laurant a kol. 2018, PMID 30011347). Přehled přehledů potvrzuje, že péče vedená sestrou je stejně bezpečná nebo bezpečnější (Paier-Abuzahra a kol. 2024, PMID 39529012).

Většina studií se týká sester v pokročilé praxi. Česká bakalářská sestra v ambulanci není nurse practitioner, proto kompetence přidáváme postupně a s protokoly.

Co přesně. Sesterská a profesní složka platí jen obsazenou funkci: neobsazené místo se neplatí a tým kvůli němu nepřijímá pacienty navíc.

Prvek	Návrh
Sestra nad poměr 1 : 1	83 000 Kč měsíčně za úvazek; kryje plat 62 177 Kč (ISPV 2025) s odvody 33,8 %, tedy asi 1,0 mil. Kč ročně
Další profese	70 000 Kč měsíčně za úvazek nutričního terapeuta, fyzioterapeuta nebo psychologa
Plat	Na úrovni nemocniční sestry stejné kvalifikace a praxe, bez nočních služeb; večery a soboty pokryje rozpis s příplatky
Podmínka smlouvy	Sestry placené ze sesterské složky tráví většinu času přímou prací s pacienty (Nizozemsko požaduje 75 %)
Koordinační sestra	Hodnotí upozornění z dálkového sledování a je současně sestrou své dvojice, ne samostatnou linkou

Kompetence přibývají ve třech krocích. První: poradny chroniků podle protokolu a hodnocení upozornění z dálkového sledování. Druhý: samostatná indikace sestry se specializací v ambulanci. Třetí: sestra v pokročilé praxi s předepisováním, které navazuje na priority ministra (sesterská preskripce).

Tři sestry na lékaře jsou dlouhodobý směr, ne podmínka; srovnávané země mají v primární péči 0,7 až 1 sestru na lékaře (Španělsko 0,9, Portugalsko asi 1, Dánsko 0,7 úvazku). Počty sester v týmech po letech a jejich náklad stanoví personální model v Části V.

Právní nástroj. Vlna 0: novela vyhl. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků (rozsah S), sesterská složka v úhradové vyhlášce podle § 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb. a smluvní dodatek v pilotu. Vlna 2: § 17 a § 18 zák. 48/1997 Sb. (platba za funkce, samostatná indikace sestry). Vlna 4: zák. 96/2004 Sb. a § 80 zák. 378/2007 Sb. (sestra v pokročilé praxi s předepisováním).

Kdo. MZ (vyhlášky), ČAS a odborné společnosti (protokoly poraden), pojišťovny a SPL ČR v dohodovacím řízení, vysoké školy (kapacity a specializace). Odbory jsou partnerem pro platovou paritu s nemocnicemi.

Kdy. Podnět do dohodovacího řízení o úhradách 2028 podáme do 30. 6. 2027; v pilotu platí sesterská složka smluvně od roku 2028. V základním scénáři přijde novela vyhl. 55/2011 Sb. v roce 2030 a sesterská složka do úhradové vyhlášky 2031. Samostatná indikace sestry platí od 1. 1. 2032, sestra v pokročilé praxi nejdřív od roku 2033.

V doplňkovém scénáři by sestry u týmových praxí vstoupily do úhradové vyhlášky už od 1. 1. 2028. Ministr zdravotnictví sesterské kompetence a preskripci sám uvádí mezi prioritami, takže tento krok může přijmout i dnešní vláda.

Na čem závisí. Na `P1` : personální bilance po krajích včetně náboru ze zahraničí a zrychlení aprobací musí být zveřejněná před předložením zákona o primární péči. Na `J1` (tým, který sestry zaměstná) a na Pilíři 2 (změna práce v nemocnicích). Brána `B3` v prosinci 2031 vyžaduje obsazení aspoň poloviny míst sester v týmech první vlny podle registrů pojišťoven; jinak reforma přechází na variantu B.

Rizika a pojistky. Hlavním rizikem je odliv sester z nemocnic, kde jich chybí už dnes. Pojistky jsou tři: přechod nemocničních sester do týmů podpoříme jen tam, kde se podle krajského plánu sítě práce v nemocnici prokazatelně změnila; plat v týmu je na nemocniční úrovni, ne vyšší; obsazenost nemocničních míst sledujeme čtvrtletně po krajích.

Oponentní posudek spočítal, že původní plán verze 2 by spotřeboval kolem 64 % vysokoškolských absolventek, ne 40 %. Proto platí scénář „polovina sester“: když jich přijde méně, reforma se zmenší na variantu B, nezastaví se. Riziko, že sestry budou dělat administrativu místo péče, kryje podmínka přímé práce ve smlouvě a zapisovatel z Pilíře 3.

`J3` · Kompetence praktiků

Proč. Rozvolnění kompetencí praktiků je nejlevnější páka reformy a verze 2 ji vynechala; oponentní posudek ji žádá jako samostatné opatření. Praktik dnes u řady léků jen pokračuje v léčbě na doporučení specialisty a pacient kvůli tomu chodí ke specialistovi na kontroly, které by zvládl praktik. Administrativa podle odhadů zabere 30 až 40 % času praktika (HSPA Monitor).

Návrh přebírá část dopisu MUDr. Pavla Neničky resortnímu týmu (2023): praktik s širšími kompetencemi včetně ultrazvuku. Nepřebírá povinné doporučení ke specialistovi ani sloučení PLDD do všeobecného lékařství, protože jdou proti dobrovolnosti, na které reforma stojí. Evidence o přínosu je převážně organizační a pilot ji musí doplnit měřením.

Co přesně.

- Revize preskripčních omezení po skupinách léčiv: tam, kde praktik dnes léčbu jen prodlužuje, ji smí po stanovení diagnózy zahájit nebo upravit podle doporučeného postupu. Seznam skupin navrhne SVL ČLS JEP s příslušnými odbornými společnostmi.
- Nové výkony v Seznamu zdravotních výkonů: cílené ultrazvukové vyšetření v ordinaci praktika podmíněné certifikovaným kurzem a malé výkony, které dnes pacienta posílají jinam.
- Nové výkony jsou hrazené ve výkonové složce nad kapitací, aby nebyly pro praktika ztrátové.
- Certifikované kurzy podle zák. 95/2004 Sb. a audit kvality nových výkonů.

Kompetence platí pro každého praktika, v týmu i mimo něj, a obdobně pro PLDD. Ověřit: kolik přípravků s preskripčním omezením na odbornost praktik dnes předepisuje jen na doporučení a kolik takových preskripcí ročně eviduje SÚKL. Ověřit: které ultrazvukové výkony smí dnes odbornost 001 vykazovat.

Ověřujeme

Právní nástroj. Bez nového zákona. Preskripční omezení mění SÚKL ve správním řízení o výši a podmínkách úhrady podle části šesté zák. 48/1997 Sb., na podnět MZ nebo pojišťovny. Výkony přibývají novelou vyhl. 134/1998 Sb. (Seznam výkonů, rozsah S až M) a jejich cena úhradovou vyhláškou. Jde o nástroje vlny 0.

Kdo. SVL ČLS JEP a SPL ČR (návrh), odborné společnosti specialistů (souhlas po skupinách), SÚKL (řízení), Pracovní skupina k Seznamu výkonů, pojišťovny.

Kdy. Podněty do Pracovní skupiny k Seznamu výkonů a k SÚKL podáme ve fázi F0, tedy v letech 2027 a 2028. V základním scénáři platí nové výkony od 1. 1. 2031 s úhradovou vyhláškou 2031 a revize preskripčních omezení proběhne po skupinách v letech 2030 až 2032. V doplňkovém scénáři může první výkon platit od 1. 1. 2028.

Na čem závisí. `J3` je nejméně závislé opatření jádra a může běžet jako první. Jeho efekt zesílí `J2` (sestra uvolní čas praktika), konzultace lékař–lékař v `J5` a zapisovatel z Pilíře 3.

Rizika a pojistky. Odpor odborných společností specialistů: revize jde po skupinách, s jejich účastí a se zpětnou zprávou, která specialistovi vrací informaci o pacientovi. Kvalita výkonů, zejména ultrazvuku: certifikace a audit. Přetížení praktiků: nové výkony jsou dobrovolné a placené. Revize nemění indikace léčiv, jen to, kdo je smí předepsat; pojišťovny sledují preskripci před revizi a po ní.

`J4` · Návštěvní služba a doprava k lékaři

Proč. Lidí ve věku 75+ s vysokou potřebou péče přibude zhruba dvakrát, ze 115 na 241 tisíc. Ordinace ve vesnicích končí odchodem lékaře, ne rozhodnutím úřadu, a děje se to už dnes. Návštěvní služba je podle § 7 odst. 3 zák. 372/2011 Sb. povinnou součástí péče registrujícího praktika, ale úhrada ji nezaplatí tak, aby fungovala pravidelně.

Evidence vede k cílení. Meta-analýza 64 randomizovaných studií s 28 642 seniory nenašla u plošných preventivních návštěv konzistentní vliv na úmrtnost, hospitalizace ani umístění do zařízení (Mayo-Wilson a kol. 2014, PMID 24622676). Návštěvy proto neslibují méně hospitalizací; jejich účelem je dostupnost pro ty, kdo do ordinace nedojdou.

Co přesně.

Prvek	Návrh
Komu	Ležící a křehcí pacienti, lidé po propuštění z nemocnice, pacienti v paliativní péči; ne plošné preventivní návštěvy
Organizace	Jeden až dva lékaři týmu mají v týdnu den na návštěvy; sestra dvojice jezdí na kontroly podle protokolu
Úhrada	Příplatek za lékařskou návštěvu po portugalském vzoru, 30 eur, nejvýš 20 návštěv měsíčně na lékaře
Pacient registrovaný jinde	Návštěvu poskytne tým spádu jako hrazený výkon s vyúčtováním mezi týmy, jak dnes funguje domácí péče
Senior taxi	Organizuje obec s rozšířenou působností nebo obec; dispečink sladí odvoz s termínem vyšetření
Návaznost	Domácí péče, mobilní paliativní tým a pečovatelská služba podle společného plánu péče (Pilíř 5)

Senior taxi model oceňuje na 0,34 mld. Kč ročně (205 ORP × 1,5 vozu × 1,1 mil. Kč), z rozpočtů obcí a krajů, ne z pojištění. V pilotu jde o asi 1,1 mil. Kč na vůz.

Právní nástroj. Vlna 0: příplatek za návštěvu smluvně v pilotu, poté v úhradové vyhlášce podle § 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.; výkon návštěvy sestry v Seznamu výkonů (vyhl. 134/1998 Sb.). Senior taxi nepotřebuje zákon: je to samostatná působnost obce podle zák. 128/2000 Sb., případně krajský dotační program. Vlna 2: dojezdové doby podle spádů v nařízení vlády 307/2012 Sb.

Kdo. Týmy a samostatní praktici (návštěvy), pojišťovny (příplatek), obce a ORP (senior taxi), kraje (dotace pro chudší obce), SMO ČR (vzorová smlouva o provozu).

Kdy. V pilotu od roku 2028. V základním scénáři vstoupí příplatek do úhradové vyhlášky 2031 a dojezdové doby do nařízení vlády s účinností zákona o primární péči 1. 1. 2032. Senior taxi mohou obce rozšiřovat kdykoli; v doplňkovém scénáři by příplatek platil od 1. 1. 2028.

Na čem závisí. Na `J1` (tým, který si rozdělí návštěvní dny) a `J2` (sestra pro kontroly doma). Na Pilíři 5 (domácí péče s delší indikací, paliativní týmy) a na `P3` (sdílené financování sociálně-zdravotní péče).

Rizika a pojistky. Obce nemají peníze na taxi: přednost mají spády s nejhorší dostupností a dopravu může převzít kraj. Návštěvy vytlačí ordinační čas: strop 20 placených návštěv měsíčně a ukazatel dostupnosti v odměně za výsledky. Delší cesta z vesnic po zániku ordinace: návštěvní služba a senior taxi musí v daném spádu fungovat od prvního dne týmu, ne až s budovou.

`J5` · eŽádanka s triážním údajem, měření čekání a lidí bez praktika

Proč. Ambulantní specialisté jsou druhým největším segmentem výdajů (asi 116 mld. Kč ročně), ale nikdo systémově neměří, jak dlouho pacienti čekají a kolik lidí nemá registrujícího praktika. Vládní novela zák. 325/2021 Sb. s povinnou elektronickou žádankou je na vládě; poprvé umožní vidět, kdo koho odeslal a kdy se pacient dostal na řadu. První fáze eŽádanky podle zák. 236/2025 Sb. ale pokrývá jen laboratorní a obrazová vyšetření (MZ ČR 2025, s. 140). Triážní údaj pro vyšetření u ambulantních specialistů proto vyžaduje rozšíření eŽádanky za tuto první fázi. Oponentní posudek upozornil, že „pořadí podle naléhavosti“ bez určení, kdo naléhavost posoudí, v jakém poli a s jakou sankcí, zůstane deklarací.

Země s povinným doporučením (Španělsko, Nizozemsko, Dánsko) zároveň ukazují, že bez dostupného praktika se doporučení mění v další frontu. Proto navrhujeme měkký gatekeeping, který pacientovi nic nebere a dává výhodu tomu, kdo přijde s žádankou.

Co přesně.

- Indikující lékař (praktik nebo specialista) vyplní v eŽádance triážní údaj: urgentní do 2 týdnů, do 6 týdnů, nebo plánované. Žádanka nese také klinickou otázku a dosavadní výsledky.
- Specialista smí kategorii změnit, změnu zdůvodní v odpovědi.
- Přímý přístup ke specialistovi bez žádanky zůstává. Pacient s žádankou má přednost v objednání a pojišťovna mu garantuje termín podle kategorie.
- Sankce se netýká pacienta. Poskytovatel, který opakovaně nedodrží lhůtu kategorie, ztrácí bonus za dostupnost.
- Rychlá cesta pro varovné příznaky (podezření na nádor, náhlé zhoršení) platí i pro lidi bez registrace, přes telefonickou triáž kraje nebo pojišťovny.
- Pojišťovna, která pojištěnci do 30 dnů nezajistí registraci, mu zajistí vyšetření lékařem nebo sestrou smluvního týmu. Doporučení vystaví vždy zdravotník po klinickém posouzení, nikdy úřad.

Měření má dvě části. Čekání od vystavení eŽádanky do vyšetření se zveřejňuje podle kategorií a zvlášť pro pacienty se žádankou a bez ní; když se čekání pacientů bez žádanky prodlouží, pravidla se změní. Počet pojištěnců bez registrujícího praktika zveřejňují pojišťovny čtvrtletně po ORP z vlastních registrů.

Údaje se tak dostanou do rozhodování bez zpoždění, které mají ročenky ÚZIS. Na těchto datech stojí brána B3.

Právní nástroj. Vlna 0: pozměňovací návrh k vládní novele zák. 325/2021 Sb. (povinné triážní pole, export údajů o čekání); bonus za dostupnost v úhradové vyhlášce. Vlna 2: § 17 a § 46 zák. 48/1997 Sb. (garance termínu podle kategorie, povinnost zajistit registraci do 30 dnů) a lhůty v nařízení vlády 307/2012 Sb. Pokud pozměňovací návrh neprojde, přijde malá novela zák. 325/2021 Sb. ve vlně 2.

Kdo. MZ a státní infrastruktura elektronizace (pole a export dat), pojišťovny (garance termínu, data o registracích), odborné společnosti se SPL ČR a SAS ČR (kritéria kategorií pro nejčastější diagnózy), ÚZIS a nezávislý hodnotitel (zveřejňování).

Kdy. Pozměňovací návrh podáme podle termínu vládní novely, nejpozději v roce 2028. Data o lidech bez praktika navrhujeme, aby pojišťovny zveřejňovaly dobrovolně už od roku 2027. V základním scénáři platí bonus za dostupnost od úhradové vyhlášky 2031 a zákonná garance termínu od 1. 1. 2032.

Na čem závisí. Na povinné eŽádance (Pilíř 3) a na kapacitě praktiků a týmů (J1 až J3): bez dostupného praktika by žádanka byla jen další papír. Na konzultaci lékař–lékař a zpětné zprávě (níže), které vracejí stabilní pacienty do péče týmu.

Rizika a pojistky. Inflace urgentních kategorií: specialista kategorii mění a zdůvodňuje, pojišťovna sleduje podíl urgentních žádanek podle indikujícího a sdílí ho s ním. Odpor specialistů: pobídky bez sankcí vůči pacientovi, placená konzultace a kritéria psaná s odbornými společnostmi. Přetížení praktiků: žádanka i bez návštěvy, u chroniků s roční platností, s přípravou sestrou; horší dostupnost pro lidi bez praktika kryje rychlá cesta a lhůta 30 dnů.

Děti a PLDD: dětské týmy zůstávají

Péči o děti dnes nese asi 2 050 praktických lékařů pro děti a dorost a reforma tuto odbornost neruší. Návrh na postupné sloučení PLDD do všeobecného lékařství z dopisu MUDr. Pavla Neničky (2023) nepřebíráme: šel by proti dobrovolnosti a proti SPLDD ČR i České pediatrické společnosti. Přebíráme z něj rozšíření kompetencí, které v J3 platí i pro PLDD.

Co navrhujeme:

- dětská sestra v každém týmu, který o děti pečuje (prevence podle protokolu, očkování, poradenství rodičům);
- tým s lékaři pro dospělé i pro děti, ve kterém dítě v osmnácti zůstává u téhož týmu a jeho dokumentace nemusí nikam putovat;
- tam, kde PLDD chybí, registraci dětí u praktika pro dospělé v týmu, s kapitací a podporou pediatra týmu; posudek odhaduje, že se to dnes týká asi 90 tisíc dětí na venkově;
- přednost pediatrie při výběru týmů do pilotu.

Dětské sestry jsou nejstarší skupinou ošetřovatelství s průměrným věkem 53,1 roku (ÚZIS, 2023), takže bez náboru dnes chybějí i stávajícím ordinacím. Text prof. Bronského pro resortní tým (2023) uvádí, že pediatři vstupují do primární péče typicky ve 35 až 45 letech po rodičovské. Rezidenčních míst pro budoucí PLDD podpořilo ministerstvo 70 v letech 2024 a 2025 (80 v roce 2023), a to jen ve variantě s praxí v ordinaci PLDD (dotační program MZ Rezidenční místa; MZ ČR 2025, s. 97–98). Počet rezidenčních míst proto patří do podmínky P2.

Ověřit: plné jméno autora a přesný název textu prof. Bronského pro resortní tým. Dětská lůžka, která jsou podle téže práce hypertrofická, řeší Pilíř 2; dětská pohotovost zůstává u nemocnic s dětským oddělením.

Ověřujeme

Večery, víkendy a pohotovost

Od 1. 1. 2026 zajišťují lékařskou pohotovost pro dospělé nemocnice s urgentním příjmem (zák. 290/2025 Sb.) a reforma tuto změnu nevrací. Malý tým by pohotovost neunesl: minimální rozsah podle vyhl. 380/2025 Sb. je asi 31 hodin týdně. Dětská pohotovost zůstává u nemocnic s dětským oddělením.

Pořadí kroků:

- Prodloužená ordinační doba týmů do 19 hodin a v sobotu dopoledne, placená jako funkce týmu (J1).
- Krajská telefonická triáž, která je zároveň vstupem do rychlé cesty pro lidi bez praktika (J5). Provozovatele, financování a napojení na záchrannou službu je třeba dohodnout s kraji.
- Pohotovost v centru primární péče jen tam, kde pracuje víc než deset lékařů, dobrovolně a nejdřív po účinnosti zákona o primární péči 1. 1. 2032.

Prodlouženou ordinační dobu a pohotovost model verze 2 oceňuje odhadem na 0,75 mld. Kč ročně; aktuální číslo je v Části V. Ověřit: zda kraje po účinnosti zák. 290/2025 Sb. provozují telefonickou triáž a v jakém rozsahu.

Ověřujeme

Výkup praxí odcházejících lékařů

Hodnota praxe se odhaduje na 2 až 3 mil. Kč a registrovaní pacienti jsou její hlavní součástí; tým ji proto musí umět vykoupit, jinak do něj starší praktici nevstoupí. Uvnitř týmu, který je jedním poskytovatelem, jsou pacienti registrovaní u týmu a „kmen“ jednotlivého lékaře právně neexistuje. Hodnotu vloženou lékařem musí zachytit smlouva.

Jak to funguje:

- lékař vloží praxi do společnosti za podíl odpovídající její hodnotě, nebo si ponechá IČO a vstoupí do smluvní sítě;
- při odchodu do důchodu tým podíl vyplatí za předem dohodnutou cenu a splácí ho z vlastních příjmů za pět až deset let;

- vzorová společenská smlouva s jednotnou metodikou ocenění (počet registrovaných a roční kapitace), nezávislým odhadem a pravidly pro současný odchod více společníků (pořadí výplat, rozložení splátek, pojištění);
- státní záruka za úvěr, případně zvýhodněný úvěr z národních zdrojů, pokud evropské fondy výkup nepřipustí.

Výkup je převod mezi lékaři, ne nový náklad systému. Tým ho hradí z kapitace stejně, jako dnes kupující lékař splácí kupní cenu z budoucích příjmů, a smlouva s pojišťovnou ho nesmí obsahovat jako samostatnou platbu. Verze 2 odhadla objem na 3 až 7,5 mld. Kč za dvanáct let; přepočet na posunutý náběh týmů je v Části V.

Výkup doplňuje nástroj, o kterém se jednalo už v dohodovacím řízení 2027: jednorázový příspěvek 250 až 500 tisíc Kč na převzetí praxe v okresu s nedostatkem praktiků, podmíněný pětiletým závazkem provozu. Vzorovou smlouvu připraví resortní tým se SPL ČR v roce 2027; na smluvní úrovni funguje bez zákona, státní záruka potřebuje rozpočtové rozhodnutí vlády v roce 2030.

Ambulantní specialisté, konzultace lékař–lékař a zpětná zpráva

Model verze 2 počítá se třemi novými výkony za 1,5 mld. Kč ročně: 3 miliony žádanek se zpětnou zprávou a přímým objednáním po 300 Kč a 1,5 milionu konzultací po 400 Kč. Část se vrátí v méně kontrolních návštěvách, s tou ale model nepočítá. Platí se odpověď, ne přednost.

Výkon	Co obnáší	Co získá specialista
Konzultace lékař–lékař	Praktik položí otázku elektronicky, specialista odpoví bez návštěvy pacienta	Placený čas bez obsazeného termínu
Zpětná zpráva	Specialista vrátí stabilního pacienta do péče týmu s plánem kontrol	Méně kontrol stabilních pacientů, volnou kapacitu pro nové
Přímé objednání	Tým rezervuje termín v kalendáři specialisty přímo ze žádanky	Pacienta s vyplněnou otázkou a výsledky

Sdílená péče o chroniky běží podle protokolů týmů a odborných společností: kdo kontroluje stabilního pacienta, kdy se vrací ke specialistovi a co musí obsahovat zpráva. Bez doporučení zůstává přístup ke gynekologovi, očnímu lékaři, zubaři, psychiatrovi a do dispenzarizované onkologie.

Výkony přibývají novelou vyhl. 134/1998 Sb. ve vlně 0 a jejich cena úhradovou vyhláškou. V základním scénáři platí od 1. 1. 2031, v doplňkovém mohou platit od 1. 1. 2028; podnět do Pracovní skupiny k Seznamu výkonů podáme v roce 2027. Náhradu objemových limitů indikačními omezeními a revizní činností řeší Pilíř 2.

Riziko, že zpětná zpráva bude další papír, snižuje její vazba na eŽádanku: odpověď je strukturovaná a odchází elektronicky. Riziko odporu SAS ČR a odborných společností snižuje to, že jde o nové placené výkony, ne o sankce.

Pilíř 3 · Digitální nástroje a eŽádanka jako infrastruktura

Pilíř 3 obsahuje čtyři nástroje a jen jeden z nich je umělá inteligence: eŽádanka (infrastruktura), dálkové sledování (prahová pravidla), zapisovatel (AI) a portál pacienta. Do pilíře patří jen to, co má oporu v datech nebo v platném právu; ostatní má ověřit pilot.

Výchozí stav je nerovnoměrný. eRecept (téměř 86 milionů vystavených receptů v roce 2024; SÚKL, statistiky eReceptu; MZ ČR 2025, s. 91) a eNeschopenka fungují, ale souhrn pacienta nikdy nepoužilo 66,4 % lékařů a online se objedná 19,6 % lidí proti 39,8 % v EU. AI používá nebo testuje 67,6 % zdravotnických zařízení (MZ, únor 2026), zatím bez pravidel a bez primární péče.

Evropský prostor zdravotních dat ukládá sdílet souhrn pacienta a eRecepty od roku 2029 a laboratoře, snímky a propouštěcí zprávy od roku 2031. Centra primární péče mají být místem, kde to bude fungovat jako první.

eŽádanka. Vládní novela zák. 325/2021 Sb. zavádí povinnou elektronickou žádanku a my na ni navazujeme, nestavíme vlastní systém. Pozměňovacím návrhem (vlna 0) chceme do standardu žádanky doplnit čtyři prvky, na kterých stojí J5 :

- povinné triážní pole se třemi kategoriemi a možností změny specialistou se zdůvodněním;
- strukturovanou klinickou otázku a odpověď, která slouží zároveň jako zpětná zpráva;
- vazbu na objednávací kalendář specialisty pro přímé objednání;
- časová razítka vystavení, objednání a vyšetření s exportem pro pojišťovny a ÚZIS, ze kterého se počítá čekání.

Pacient žádanku vidí na Portálu lékaře a pacienta, který MZ spustilo v lednu 2026 v pilotním režimu. Výchozí stav: novela zákona o elektronizaci (zák. 236/2025 Sb.) je účinná od 1. 1. 2026 a první fáze eŽádanky pokrývá laboratorní a obrazová vyšetření (MZ ČR 2025, s. 129 a 140); triážní pole pro ambulantní specialisty proto znamená rozšíření eŽádanky za tuto fázi. Ověřit: aktuální stav a harmonogram dnešní vládní novely zák. 325/2021 Sb. (č. j. 748/26) v legislativním procesu.

Ověřujeme

Pilíř 3 · Dálkové sledování

Dálkové sledování zavádíme jen tam, kde je jasné, co měřit a kdy jednat; nejsilnější oporu má u srdečního selhání. Meta-analýza 41 studií se 16 312 pacienty našla nižší riziko hospitalizace (poměr šancí 0,78) i úmrtí (0,81) (De Lathauwer a kol. 2025, PMID 39834044). Účinek se ale ukazuje hlavně při sledování delším než 12 měsíců a některé velké studie byly negativní, takže dvouletý pilot ho zachytí jen zčásti.

Diagnóza	Co se měří	Síla evidence	Jak zavádět
Srdeční selhání	Hmotnost denně, tlak, tep	Silná	Po propuštění z nemocnice, první v řadě
Hypertenze	Saměření tlaku s úpravou léčby	Střední; přínos dělá saměření, ne přenos dat	Saměření v poradně sestry, telemonitoring jen tam, kde pomůže organizaci
CHOPN, diabetes	Podle protokolu	Slabá	Jen v pilotu, rozhodne měření

U hypertenze snížilo saměření s titrací léčby systolický tlak po roce o 3,5 mm Hg proti běžné péči a s telemonitoringem o 4,7 mm Hg, rozdíl mezi oběma variantami ale nebyl významný (McManus a kol. 2018, TASMINH4, PMID 29499873). Model proto počítá úspory jen u srdečního selhání, hierarchicky a bez překryvu s ostatními hospitalizacemi; číslo je v Části V.

Kapacitu určuje sestra, ne aplikace. Při 250 sledovaných a 5 % horších měření jde o 12,5 upozornění denně, tedy asi dvě hodiny práce; proto má koordinační sestra limit 150 až 250 pacientů a pacient sledovaný telefonicky se počítá dvakrát až třikrát. Třídění má tři stupně: automatický filtr podle prahů nastavených lékařem, sestra, lékař.

Provoz běží v pracovní době s jasnou instrukcí, kdy volat 155. Pro lidi bez chytrého telefonu jsou k dispozici váha a tlakoměr, které odesílají data samy, pečující osoba jako uživatel přes elektronickou identitu, nebo telefonát sestry.

Právní základ už existuje: § 11c zák. 372/2011 Sb. a vyhl. 30/2025 Sb. Chybí výkony a jejich úhrada v Seznamu výkonů (vlna 0) a kompetence sestry hodnotit upozornění ve vyhl. 55/2011 Sb. (J2). V pilotu běží smluvně od roku 2028, v základním scénáři jako hrazený výkon od 1. 1. 2031, v doplňkovém od 1. 1. 2028.

Pilíř 3 · AI zapisovatel

První randomizované studie ukazují u AI zapisovatele mírný a nejistý přínos, ne úsporu, se kterou by šlo plánovat. Verze 2 tvrdila, že zapisovatel zkrátí čas na zápisy „o asi desetinu“; to platí jen pro jeden ze dvou testovaných nástrojů v krátké studii a tvrzení opravujeme.

Studie	Design	Výsledek
Lukac a kol. 2025, NEJM AI (PMID 41497288)	238 ambulantních lékařů ze 14 oborů, dva nástroje proti kontrole, dva měsíce	Nabla zkrátila čas v zápisech o 9,5 % (95% CI −17,2 až −1,8 %), DAX bez významného účinku (−1,7 %). Nástroje se použily ve 30 až 34 % návštěv; lékaři hlásili „občasné“ klinicky významné nepřesnosti
Afshar a kol. 2025, NEJM AI (PMID 41625485)	66 zdravotníků, stupňovité zavádění, 24 týdnů	Nižší pracovní vyčerpání a o 0,36 hodiny denně kratší čas na zápisy; pokles práce mimo pracovní dobu nebyl robustní

Citaci Chowdhury a kol. (JAMIA 2026, PMID 41729180) z verze 2 ve v3 nepoužíváme: studie srovnávala jen dva nástroje mezi sebou, bez skupiny bez zapisovatele. Zapisovatel tedy může ulehčit práci a snížit vyčerpání, ale studie nedokládají čas pro další pacienty. Reforma s ním nepočítá jako se zdrojem kapacity a neslíbí díky němu méně lékařů.

Pilot změří tři věci: čistou úsporu času po kontrole a opravách zápisu, chybovost zápisů v češtině a to, zda se zlepšila dostupnost. Systém ukládá návrh i schválené znění a za zápis odpovídá lékař, který ho podepsal.

Model verze 2 počítá s cenou 2 300 Kč na lékaře a měsíc podle amerických ceníků; českou cenu zjistí až pilot nebo výběrové řízení. Klasifikaci zapisovatelů (zda jde o zdravotnický prostředek) musí vyjasnit metodika MZ a SÚKL. Ověřit: zda už SÚKL k AI zapisovatelům vydal stanovisko.

Ověřujeme

Pilíř 3 · Portál pacienta a pravidla pro digitální nástroje

Pacientská část nemá vzniknout jako nový portál: navazujeme na Portál lékaře a pacienta, který MZ spustilo v lednu 2026 v pilotním režimu. Do dvou let od nástupu vlády v něm chceme pacientovi zpřístupnit čtyři věci:

- souhrn pacienta, výsledky a zprávy, v souladu s termíny Evropského prostoru zdravotních dat;
- objednání k týmu a u specialisty ze žádanky, včetně stavu čekání podle kategorie;
- přehled, kdo do jeho záznamu nahlížel;
- přístup pečující osoby přes elektronickou identitu.

Pro lidi, kteří portál nepoužijí, zůstává telefon a recepce týmu; žádná služba nesmí být dostupná jen online. Ověřit: harmonogram MZ pro přechod Portálu lékaře a pacienta z pilotního do ostrého provozu.

Ověřujeme

Pro všechny nástroje pilíře platí stejná pravidla:

- každé klinické rozhodnutí dělá člověk a pacient ví, kdy komunikuje se systémem;
- data se ukládají v EU, v českém zdravotnickém systému napojeném na eZdraví, a přístup má jen tým, který pacienta léčí;
- nástroje, které vyhodnocují stav pacienta, mají certifikaci zdravotnického prostředku nejméně třídy IIa a plní povinnosti vysoce rizikové AI podle AI Actu;
- odpovědnost je rozdělená předem: zdravotník za rozhodnutí, výrobce za nástroj;

- kybernetická bezpečnost podle NIS2 a ochrana před závislostí na jednom dodavateli: otevřené standardy a státem definovaná rozhraní.

Ověřit: datum, od kdy platí povinnosti vysoce rizikové AI pro zdravotnické prostředky po zjednodušujících změnách AI Actu.

Ověřujeme

Pilot v Pilíři 3 sleduje šest údajů: čas na administrativu před zapisovatelem a po něm, chybovost zápisů, počet upozornění na koordinační sestru za den, neplánované hospitalizace u srdečního selhání proti kontrolním ORP, podíl pacientů na aplikaci, telefonu a přes pečující osobu a vyzvedávání léků podle eReceptu.

Část III — Jádro reformy: síť lůžkové péče (pilíř 2)

Do roku 2038 navrhujeme přeměnit 8 000 akutních lůžek na následnou, rehabilitační, dlouhodobou a sociálně-zdravotní péči, tedy z 48 036 na zhruba 40 000 (asi 3,7 na 1 000 obyvatel). Jde o přeměnu, ne o rušení. Lůžko změní účel, až když kraj prokáže, že pacient má kam jít a že záchranná služba dojede včas.

Výchozím bodem je jediný základ: lůžkový fond podle NZIP/ÚZIS za rok 2024, tedy 48 036 nasmlouvaných akutních lůžek (4,4 na 1 000 obyvatel). Údaj OECD (3,99 na 1 000) používáme jen pro mezinárodní srovnání, protože vychází z jiné definice. Směr 3,5 na 1 000, tedy dalších asi 1 900 lůžek, platí až po roce 2038 a jen při splněných ukazatelích.

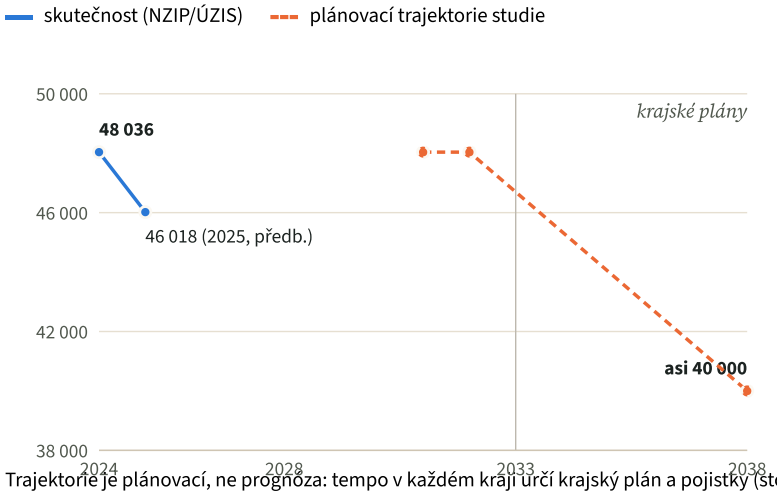
Hlavním ukazatelem pilíře je podíl vlastní akutní lůžkové péče na úhradách pojišťoven: z 29,7 % v roce 2024 na 26 % kolem roku 2038. Podíl měří výsledek změny péče, ne škrt: nemocnice dostanou v korunách víc, nové peníze ale půjdou hlavně do primární, domácí a následné péče. Aby ukazatel nešlo splnit přeúčtováním do nemocničních ambulancí, sledujeme vedle něj počet akutních lůžek, obložnost a odvratitelné hospitalizace (Část IX).

Pilíř stojí na dvou opatřeních jádra: `J6` (krajský plán sítě) a `J7` (kapacita následné a dlouhodobé péče jako podmínka každé přeměny). Hlavním nástrojem je nový zákon o síti lůžkové péče ve vlně 3: předložit 2031, přijmout 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033, první krajské plány 2033. Část sítě lze měnit i bez zákona, jak ukazuje centralizace onkochirurgie (první vlna – játra, slinivka, jícen – od 1. 9. 2026 podle Věstníku MZ 10/2026, další obory 2027–2030); tuto cestu budeme ministerstvu navrhovat už ve fázi F0.

Náběh přeměny 2024–2038

Do roku 2038 změní účel asi 8 000 akutních lůžek, většina až s krajskými plány od roku 2033

Akutní lůžka v Česku: skutečnost 2024 a 2025 (předběžně) a plánovací trajektorie studie 2031–2038; ze 4,4 na 3,7 lůžka na 1 000 obyvatel



Trajektorie je plánovací, ne prognóza: tempo v každém kraji určí krajský plán a pojistky (stop při obložnosti nad 85 %). Plán počítá od základu 48 036 lůžek z roku 2024; předběžný pokles v roce 2025 by jen zmenšil počet lůžek, které zbývá přeměnit. V letech 2010 až 2013 ubylo 5 914 akutních lůžek, ale lůžek následné a dlouhodobé péče přibylo jen 22. To se nesmí opakovat.

Zdroj: NRHZS, datový souhrn OIS-11-28 (zpracováno 30. 6. 2026; rok 2025 předběžně); plánovací trajektorie studie v3

NRHZS, datový souhrn OIS-11-28 (2010–2025, rok 2025 předběžně) · plánovací trajektorie studie 2031–2038

Trajektorie je plánovací, ne prognóza: tempo v každém kraji určí krajský plán a pojistky, takže skutečná křivka může být pozvolnější. Do roku 2032 jde jen o dobrovolné přeměny podle smluv s pojišťovnami a o minimální objemy; hlavní část přeměny přijde až s krajskými plány od roku 2033. Pokles v letech 2010 až 2013 ukazuje, co se nesmí opakovat: akutní lůžka ubyla, následná nepřibyla.

Výchozí stav po krajích

Rezerva je v akutních lůžkách, nedostatek v následných: v roce 2024 byla standardní akutní lůžka obsazená z 56,0 %, lůžka následné a dlouhodobé péče z 85,4 %. V osmi krajích přesahuje obložnost následných lůžek 85 %, takže tam nemá přeměněné akutní lůžko kam „odevzdat“ pacienta, dokud nevznikne nová kapacita (J7).

Kraj	Akutní lůžka 2024	Obložnost standardních akutních lůžek (%)	Lůžka následné a dlouhodobé péče 2024	Obložnost následných lůžek (%)
Hl. m. Praha	8 441	55,3	3 175	84,8
Jihomoravský	6 119	56,1	2 660	82,0
Moravskoslezský	5 327	60,7	3 580	87,7
Středočeský	3 920	60,7	3 700	87,1
Ústecký	3 813	45,7	2 032	80,7
Olomoucký	2 876	58,8	1 854	88,3
Jihočeský	2 836	55,4	1 105	74,8
Královéhradecký	2 752	57,8	1 561	87,2
Plzeňský	2 670	57,9	2 070	91,7
Vysočina	2 324	54,7	2 014	80,5
Zlínský	2 151	61,4	1 573	88,5
Pardubický	1 935	46,0	1 782	85,2
Liberecký	1 885	55,4	762	83,5
Karlovarský	987	55,4	683	88,8
Česko	48 036	56,0	28 551	85,4

Zdroj: NRHZS, datový souhrn OIS-11-28 (https://www.nzip.cz/data/2378-luzkovy-fond-akutni-nasledna-dlouhodoba-pece-datovy-souhrn) (zpracováno 30. 6. 2026), vlastní výpočet; obložnost = ošetřovací dny / (lůžka × 365). Sestavy ÚZIS SSS-05-02 a SSS-05-03 uvádějí pro následná lůžka 84,2 %, protože počítají jinou metodikou. Praha slouží i pacientům ze Středočeského kraje, proto krajská čísla nelze číst jako potřebu obyvatel kraje.

Průměr 56 % neznamená, že lze 44 % lůžek zavřít. V roce 2024 mělo 58 akutních pracovišť (zařízení a obor) roční obložnost standardních lůžek nad 85 %, celkem 1 791 lůžek; malá oddělení navíc potřebují rezervu na zimní špičky. Krajský plán proto rozhoduje podle oboru, sezóny, personálu a dojezdu, ne podle průměru.

Předběžná data za rok 2025 ukazují 46 018 akutních lůžek, o 2 018 méně než v roce 2024; největší úbytky vykázaly Krajská zdravotní (−368), Nemocnice Pardubického kraje (−122) a FN Brno (−121). Cíl kolem 40 000 lůžek v roce 2038 se tím nemění, zmenšil by se jen počet lůžek, která zbývá přeměnit. Pojišťovny se během roku 2024 s řadou nemocnic dohodly na redukci akutních lůžek a vzniku lůžek následné péče (MZ ČR 2025, s. 82), což podporuje výklad trvalého snížení. Ověřit: zda jde o trvalé snížení, nebo o změnu ve vykazování smluvních lůžek.

Ověřujeme

J6 Krajský plán sítě lůžkové péče

Od roku 2033 bude mít každý kraj desetiletý plán služeb, ze kterého teprve vyplyne počet lůžek ve čtyřech skupinách: akutní, následná, dlouhodobá a sociálně-zdravotní. Plán navrhuje kraj, schvaluje ministerstvo zdravotnictví a spor rozhodne vláda.

- **Proč.** Celostátní plánování lůžek zákon nezná: kraj vydává oprávnění a většinu nemocnic vlastní, síť ale fakticky určují pojišťovny smlouvami (§ 46 až 52 zák. 48/1997 Sb.). Nikdo tak neodpovídá za to, že s ubylým akutním lůžkem přibude následné. V letech 2010 až 2013 ubylo 5 914 akutních lůžek, lůžek následné a dlouhodobé péče přibylo 22 (NRHZS).
- **Co přesně.** Plán na deset let s revizí po třech letech vychází z potřeb regionu, dojezdů, oborů, sezónních špiček a personálně obsaditelných lůžek. Každé nemocnici určí jednu ze tří rolí: specializované centrum, regionální nemocnice s urgentním příjmem, nebo okresní nemocnice jako zdravotní centrum regionu (následná a rehabilitační péče, jednodenní chirurgie, diagnostika, ambulance, zázemí pro týmy primární péče). Obsahuje personální plán a kontrolní body, které musí být splněny před každou přeměnou oddělení (diagram níže).
- **Právní nástroj.** Nový zákon o síti lůžkové péče (rozsah L, 40 až 70 paragrafů, vlna 3) a novela § 46 až 52 zák. 48/1997 Sb.: pojišťovny musí plán naplnit a výběrová řízení vypisovat podle něj. Dále menší novely zák. 374/2011 Sb. (plán pokrytí záchrannou službou jako podmínka sloučení oddělení), zák. 129/2000 Sb. a zák. 372/2011 Sb. (působnost kraje, soulad oprávnění s plánem) a pověřovací akt SGEI. Před věcným záměrem musí být hotový ústavní rozbor zásahu do samosprávy krajů (čl. 8 a 101 Ústavy) a do vlastnického práva (čl. 11 Listiny). Ověřit: nálezy Ústavního soudu k omezení krajské samosprávy zákonem ve veřejném zájmu.

Ověřujeme

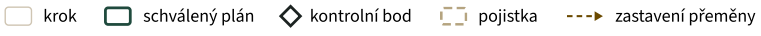
- **Kdo.** Kraj plán navrhuje a nese za něj spoluodpovědnost; ministerstvo vydá metodiku a plán schvaluje; ÚZIS dodá data o potřebách a dojezdech; pojišťovny síť naplnit smlouvami. Soukromí vlastníci nemocnic, kteří drží zhruba pětinu akutních lůžek, mají stejná pravidla, stejné kontrolní body a stejnou garanci příjmu. V opozici připraví věcný záměr resortní tým s Institutem Pi a poslaneckým klubem; ve vládě posilíme legislativní odbor ministerstva o tým pro síť.

- **Kdy (scénář „Vláda 2030“).** F0 (11/2026–6/2028): metodika krajské analýzy, výpočet výchozích dojezdů z otevřených dat, jednání s Asociací krajů ČR a soukromými vlastníky. F1 (7/2028–12/2029): hotový věcný záměr. `B2` : zákon v legislativním plánu vlády 2030. F2: předložení 2031. F3: přijetí 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033; kraje potřebují na plán 12 až 18 měsíců, první plány schválené 2033. F4 (2034–2038): přeměna podle plánů, první revize 2036. V doplňkovém scénáři „Dnešní vláda převezme část“ jde o 1 až 2 roky dřív jen vlna 0: metodika, minimální objemy ve Věstníku a dobrovolné přeměny smluvně, zákon ne.
- **Na čem závisí.** Na `J7` (kapacita následné a dlouhodobé péče), na personální bilanci po krajích (`P1`) a na sociálním účtu (`P3`). Dále na zákonu o primární péči (vlna 2), aby pacient po propuštění měl kam jít, a na legislativní kapacitě ministerstva: bez týmu pro síť sklouzne vlna 3 o rok.
- **Rizika a pojistky.** Odpor krajů a soukromých vlastníků vyvažuje garance příjmu, platba za připravenost pro urgentní příjmy a investice z fondu přeměny. Riziko, že lůžka ubudou dřív než náhrada, kryjí zákonné kontrolní body a pravidlo, že akutní lůžko se nepřemění bez prokázané kapacity a dojezdu. Odlivu personálu brání nabídka každému dotčenému zdravotníkovi předem: nové místo v nemocnici nebo regionu, placená rekvalifikace, přechod do týmu primární, domácí či paliativní péče a příspěvek na dojíždění. Kdyby zákon neprošel, zůstává smluvní cesta a Věstník; neúspěch zákona nezastaví zbytek reformy.

Jak vzniká krajský plán

Krajský plán sítě: kraj navrhuje, MZ schvaluje, spor rozhodne vláda

Návrh zákona o síti lůžkové péče · první plány 2033, revize po třech letech



Textová verze

Kroky, kontrolní bod a pojistka

- 1 Data a metodika: MZ a ÚZIS: potřeby, dojezdy, personál, sezónní špičky
- 2 Návrh plánu na 10 let: kraj: služby, čtyři skupiny lůžek, personální plán
- 3 Veřejné projednání: pojišťovny, nemocnice včetně soukromých, obce, ZZS
- 4 MZ: kontrolní body splněny?
- Nesplněno: plán se vrací kraji
- 5 Schválení MZ: plán je závazný; pojišťovny naplní síť podle § 46
- Spor: rozhoduje vláda: rozhodnutí s veřejným odůvodněním
- Kontrolní body kroku 4: dojezd: urgentní příjem do 30 minut pro 95 % obyvatel; kapacita následné péče (J7); obložnost akutních lůžek do 85 %; personál pro novou roli; pandemická rezerva intenzivní péče
- 6 Přeměna po milnících: fond přeměny vyplácí garanci příjmu a investice
- 7 Revize po třech letech: plán na 10 let se reviduje, první revize 2036
- Stop přeměny v kraji: obložnost nad 85 % nebo chybí kapacita (J7)

Vazby

- 1 Data a metodika → 2 Návrh plánu na 10 let
- 2 Návrh plánu na 10 let → 3 Veřejné projednání
- 3 Veřejné projednání → 4 MZ: kontrolní body splněny?
- 4 MZ: kontrolní body splněny? → Nesplněno (ne)
- Nesplněno → 2 Návrh plánu na 10 let (přepracovat)
- 4 MZ: kontrolní body splněny? → 5 Schválení MZ (ano)
- 4 MZ: kontrolní body splněny? → Spor: rozhoduje vláda (spor)
- Spor: rozhoduje vláda → 5 Schválení MZ
- 5 Schválení MZ → 6 Přeměna po milnících
- 6 Přeměna po milnících → 7 Revize po třech letech
- 7 Revize po třech letech → 2 Návrh plánu na 10 let (další plán)
- 6 Přeměna po milnících → Stop přeměny v kraji (pojistka) (pojistka)

Podklad: studie v3, ř. 882–898 (J6); kontrolní body J7 ř. 904; dojezd ř. 958; pandemická rezerva ř. 968; pojistky ř. 978–984.

proces krajského plánu sítě · 7 kroků, 1 kontrolní bod, spor a pojistka

Plán, který nesplní kontrolní body, se vrací kraji; trvá-li spor, rozhodne vláda s veřejným odůvodněním. Ani schválený plán neopravňuje k přeměně, dokud konkrétní oddělení nesplní milníky, a pojistka obložnosti ji může v kraji kdykoli zastavit.

J7 Kapacita následné a dlouhodobé péče jako podmínka přeměny

Žádné akutní lůžko se nepřemění, dokud kraj neprokáže místo pro pacienta po akutní fázi a dojezd záchranné služby v garantovaném čase. Kapacita mimo akutní lůžko musí vzniknout před přeměnou, ne po ní.

- **Proč.** Lůžka následné a dlouhodobé péče jsou obsazená z 85,4 %, v osmi krajích nad 85 %. Do roku 2035 bude potřeba zhruba 39 000 nových zdravotních i sociálních lůžek dlouhodobé a následné péče (Přecechtěl a Hlávka 2025) a 21 000 pečovatelů (studie pro APSS ČR 2026). Ze zdravotních lůžek už dnes chybí nejméně 2 až 3 tisíce a do roku 2035 bude potřeba dalších nejméně 8 tisíc (MZ ČR 2025, s. 65). Bez této kapacity by přeměna jen přesunula čekání z akutního lůžka na rodinu.
- **Co přesně.** Kontrolní bod v zákonu o síti: přeměnu oddělení lze schválit, až kraj doloží (a) volná místa v následné, rehabilitační a dlouhodobé péči v dojízdné vzdálenosti, (b) kapacitu domácí péče a sociálních služeb, (c) dojezd a urgentní příjem podle garance a (d) obložnost akutních lůžek pod 85 %. Přeměněné lůžko dostane standard, aby nevznikly nové LDN: tři druhy lůžek s různým cílem a úhradou (rehabilitační následná s cílem návratu domovů, dlouhodobá ošetřovatelská, paliativní), plán s cílem a dobou pobytu od prvního dne a tým včetně fyzioterapeuta, ergoterapeuta, geriatra, nutričního terapeuta a sociálního pracovníka. Veřejné ukazatele: dekubity, pády, rehospitalizace do 30 dnů, podíl propuštěných domovů a doba čekání na následnou péči na akutním lůžku.
- **Právní nástroj.** Kontrolní bod v zákonu o síti lůžkové péče (vlna 3). Standard a vyšší sazba vázaná na standard v úhradové vyhlášce (§ 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.) s klasifikací pacientů podle § 41aa. Sdílené financování sociálně-zdravotních lůžek novelou § 36 zák. 108/2006 Sb. a § 22b zák. 48/1997 Sb. (vlna 4), navazující na zák. 38/2025 Sb. a rekodifikaci MPSV.
- **Kdo.** Kraj jako zřizovatel nemocnic i plánovatel sociálních služeb, MZ a MPSV, pojišťovny, obce (SMO ČR) a poskytovatelé sociálních služeb. Spory mezi resorty řeší Řídicí výbor reformy.
- **Kdy (scénář „Vláda 2030“).** F0: měření čekání na následnou péči na akutních lůžkách z dat pojišťoven, návrh standardu s odbornými společnostmi, podnět do dohodovacího řízení o úhradách 2028 (do 30. 6. 2027). F1: věcný záměr kontrolního bodu jako součást zákona o síti. F2: standard a sazba v úhradových vyhláškách 2031 a 2032. F3: kontrolní bod platí od účinnosti zákona o síti, první posouzení s plány 2033. F4: kapacita roste o krok dřív než přeměna.
- **Na čem závisí.** Na sociálním účtu a sdíleném financování (`P3`), na pečovatelích a sestrách (`P1`) a na investicích do pobytových kapacit; studie v2 odhadla 3 až 5 mil. Kč na pobytové lůžko. Přeměna akutního lůžka na následné je přitom levnější než nová stavba (0,6 až 1,2 mil. Kč na lůžko, níže), proto je fond přeměny i nástrojem J7.
- **Rizika a pojistky.** Když kapacita nevznikne, přeměna v kraji stojí; to je záměr pojistky, ne selhání reformy, a ostatní kraje pokračují. Proti novým LDN působí standard, veřejné ukazatele a sazba podmíněná standardem. Proti lůžku bez lidí působí personální plán jako součást kontrolního bodu.

Fond přeměny a garance příjmu

Fond přeměny má dvě části: jednorázovou investici 5 až 10 mld. Kč (0,6 až 1,2 mil. Kč na přeměněné lůžko) a provozní garanci příjmu v letech 2033 až 2040 v průměru asi 1 mld. Kč ročně, s vrcholem asi 1,3 mld. Kč v letech 2035 až 2038. Obě části jsou odhady s nízkou jistotou a nahradí je dopadová studie zákona o síti.

Podmínka vázat investici na přeměnu lůžek už existuje: v jedné z aktivit výzvy IROP 2021–2027 na lůžkovou následnou péči dostane dotaci jen poskytovatel, který zruší 20 akutních lůžek a zřídí 20 následných, převážně pro geriatrické pacienty, s návazností na zdravotní a sociální služby v domácím prostředí (výzva IROP; MZ ČR 2025, s. 148). Ověřit: číslo výzvy IROP a počet takto přeměněných lůžek.

Ověřujeme

Garance dorovnává rozdíl mezi dnešní úhradou oddělení a úhradou za jeho novou roli po dobu přechodu. Model počítá s rozdílem asi 1 500 Kč na lůžko a den při 60% obložnosti a s přechodem v průměru tři roky; zákon ho omezí na nejvýš pět let na oddělení. Částka 2,6 mld. Kč ročně je jen teoretický strop pro situaci, kdy by všech 8 000 lůžek bylo v garanci současně; při rozložení přeměny do let 2033 až 2038 vychází v letech 2033 až 2040 celkem asi 7,9 mld. Kč.

Garance se vyplácí po splněných milnících: nová lůžka následné péče v provozu, ambulance otevřená, personál převeden. Vyplácí se od roku 2033, kdy přeměnu začnou řídit první krajské plány; dobrovolné přeměny, které pojišťovny sjednají smluvně ještě před účinností zákona, model do garance nezapočítává. Provozní garance je výdajem veřejného zdravotního pojištění, investice jde ze státního rozpočtu a evropských fondů: započtení do celkového nákladu reformy viz Část V.

Veřejná podpora a SGEI. Garance i investice jsou veřejnou podporou, jakmile je dostane nemocnice jako podnik, a to i krajská akciová společnost. Rozhodnutí Komise 2012/21/EU vyjímá z notifikace vyrovnávací platby nemocnicím za službu obecného hospodářského zájmu bez ohledu na výši, pokud splní jeho podmínky. Potřebný je pověřovací akt s obsahem a dobou závazku, územím, parametry výpočtu platby a opatřeními proti nadměrné vyrovnávací platbě, kterou je třeba kontrolovat nejméně jednou za tři roky.

Pověření může být nejvýš desetileté, nejde-li o významnou investici, což odpovídá délce krajského plánu a jeho tříletým revizím. Stejným režimem lze krýt platbu za připravenost urgentních příjmů a nezbytných akutních kapacit. Soukromá nemocnice dostane investiční podporu jen se závazkem provozovat novou roli nejméně 15 let; investice nad rámec pověření posoudí ÚOHS jako koordinátor veřejné podpory, případně Komise. Ověřit: zda pověření vydá vláda, kraj, nebo oba, a jak sladit patnáctiletý závazek s desetiletým limitem pověření.

Ověřujeme

Minimální objemy a centralizace

Od 1. 9. 2026 soustřeďuje ministerstvo nejnáročnější onkochirurgii do center bez nového zákona (první vlna – játra, slinivka, jícen – podle Věstníku MZ 10/2026, další obory 2027–2030); stejnou cestou navrhujeme minimální objem a personální standard pro porodnictví, kardiologii, traumatologii a dětská lůžková oddělení. Centralizaci onkochirurgie podporujeme a navrhujeme ji vyhodnotit jako vzor.

Precedent bez zákona. Věstník MZ č. 6/2026 (28. 5. 2026) vydal metodické pokyny pro chirurgii jater, žlučových cest a slinivky a pro chirurgii jícnu; účinnost této první vlny od 1. 9. 2026 stanovil Věstník MZ 10/2026 a další obory následují v letech 2027–2030. Reforma používá tři páky: akreditaci centra s minimálním objemem, úhradový koeficient (výkon mimo centrum se hradí jen z 25 % místo dnešních 50 %) a smlouvy pojišťoven podle § 17 zák. 48/1997 Sb. Podle podkladů pracovní skupiny MZ (4/2026) byla devadesátidenní úmrtnost po resekci jater v letech 2022 až 2024 6,15 % v pracovištích nad 20 výkonů ročně a 11,76 % v menších.

Co říká evidence. Metaanalýza Grilli a kol. (2021, PMID 33944635) shrnula 41 studií, z toho 15 hodnotících politiku centralizace; souhrnný poměr šancí pooperační úmrtnosti byl 0,68 (95% interval spolehlivosti 0,54 až 0,85) při vysoké heterogenitě. Autoři sami uvádějí, že důkazy jsou nízké kvality a velikost efektu je pravděpodobně nadsazená. Centralizace je tedy spojena s nižší úmrtností, ale nevíme přesně o kolik; proto ji zavádíme s měřením, ne jako slib.

U porodnictví platí opačné varování. Uzavírání venkovských porodnic v USA bylo spojeno s nárůstem porodů mimo nemocnici a v nemocnicích bez porodnice (Kozhimannil a kol., JAMA 2018, PMID 29522161). Standardní lůžka gynekologie a porodnictví byla v roce 2024 obsazená jen z 39,4 % ve 100 pracovištích (NRHZS), přesto platí: žádné sloučení porodnice bez plánu dojezdu a posílené výjezdové základny.

Jak. Prahy objemu a personální standard navrhnou odborné společnosti z dat ÚZIS a ministerstvo je vydá ve Věstníku; podmínkou úhrady se stanou v úhradové vyhlášce a smlouvách. Pro nezbytné kapacity, které objem nesplnit nemohou, ale jsou potřeba kvůli dojezdu, platí platba za připravenost po vzoru německé reformy nemocnic. V opozici (F0) dáváme podnět ministerstvu; ve vládě vyjdou Věstníky 2030 až 2031 a prahy začnou platit s úhradovými vyhláškami 2031 a 2032. V doplňkovém scénáři to může udělat dnešní ministerstvo už od roku 2028.

Porodnictví: porodní asistentky místo pouhého rušení porodnic

Debata o malých porodnicích dnes končí u otázky, které zavřít. Uznáváme, že síť porodnic v dnešní podobě neudržíme: porodů ubývá (v roce 2024 se narodilo asi 84 tisíc dětí, v roce 2010 asi 117 tisíc; ČSÚ), standardní lůžka gynekologie a porodnictví jsou obsazena ze 39,4 % a odborné společnosti žádají minimální objemy kvůli bezpečnosti (`Pil2.1`). Ověřit: přesné počty narozených a návrh minimálního objemu porodů na porodnici, se kterým pracuje ministerstvo a Česká gynekologická a porodnická společnost. Odmítáme ale rušení bez odpovědi na otázku, co dál. Odpovědí je péče porodních asistentek: nejlevnější a u fyziologických těhotenství nejlépe doložená forma péče, kterou český systém dnes téměř nehradí.

Ověřujeme

- **Co.** Hrazená péče porodní asistentky v těhotenství, u fyziologického porodu a v šestinedělí, včetně návštěv doma. Centra porodní asistence v porodnicích a komunitní (terénní) porodní asistentky se smlouvou s pojišťovnou a s dohodou o spolupráci s nejbližší porodnicí, aby měla každá žena jasnou cestu k lékaři, když ji potřebuje. Porodní asistentka smí vést fyziologický porod už dnes (§ 5 vyhl. 55/2011 Sb.); chybí výkony v seznamu výkonů, jejich úhrada a smlouvy pojišťoven. Ověřit: které výkony porodní asistentky (odbornost 921) jsou dnes v seznamu výkonů a kolik smluv s komunitními porodními asistentkami pojišťovny v roce 2025 uzavřely.

Ověřujeme

- **Podmínka každé změny v síti.** Žádné sloučení ani uzavření porodnice bez tří věcí zároveň: plánu dojezdu a posílené výjezdové základny (`Pil2.4`), smlouvy pojišťovny s komunitními porodními asistentkami v dotčeném území a vyhodnocení po dvou letech (podíl porodů mimo zdravotnické zařízení, předčasné porody, převozy za porodu). Kraj to doloží v plánu sítě (`J6`) stejně jako u ostatních lůžek.
- **Proč.** Cochranův přehled 15 studií se 17 674 ženami (Sandall a kol. 2016, PMID 27121907) ukázal u kontinuální péče vedené porodní asistentkou méně zásahů (méně epidurálů, nástřihů hráze a instrumentálních porodů), méně předčasných porodů a nižší ztrátu plodu před 24. týdnem bez zhoršení ostatních výsledků. Anglická studie Birthplace (BMJ 2011, PMID 22117057) se 64 538 porody s nízkým rizikem nenašla u jednotek vedených porodními asistentkami rozdíl v závažných výsledcích pro dítě proti porodnici a našla výrazně méně zásahů; vyšší riziko měly jen plánované porody doma u prvorodiček. Navazující ekonomická analýza (Schroeder a kol. 2012, PMID 22517916) spočítala porody v těchto jednotkách jako levnější než v porodnici. Zánik porodnice bez náhrady naopak zvyšuje podíl porodů mimo nemocnici a předčasných porodů (Kozhimannil 2018, E12).
- **Nástroj.** Vlna 0 bez zákona: nové výkony porodní asistentky a jejich úhrada v seznamu výkonů (vyhl. 134/1998 Sb.) a v úhradové vyhlášce, smlouvy podle § 17 zák. 48/1997 Sb., metodika centra porodní asistence ve Věstníku MZ. Podmínka pro změny v síti porodnic patří do zákona o síti (`J6` , vlna 2).
- **Kdy.** Podnět do seznamu výkonů a do dohodovacího řízení o úhradách 2028 podáme do 30. 6. 2027 (F0); smlouvy s komunitními porodními asistentkami od úhradové vyhlášky 2031; podmínka v zákoně o síti od roku 2033 s krajskými plány. V doplňkovém scénáři může dnešní ministerstvo výkony zařadit od 1. 1. 2028.
- **Kolik.** Nevyčísleno. Péče porodní asistentky je levnější než porod vedený lékařem, úspora ale vzniká jen tam, kde porodnice skutečně změní roli. Ověřit: propočet v modelu nákladů pro verzi 4 a přenos anglických nákladů do českých úhrad.

Ověřujeme

- **Pojistka.** Komunitní porodní asistence nenahrazuje porodnici u rizikových těhotenství. Hranici rizika a postup předání určí odborné společnosti porodníků a porodních asistentek ve Věstníku MZ; bez dohody o předání pojišťovna smlouvu neuzavře.

Indikační omezení místo objemových limitů

Vracíme návrh pirátského programu 2021, který ve verzi 2 chyběl: objemové limity v úhradové vyhlášce postupně nahradit indikačními omezeními a revizí. Pojišťovna zaplatí každý indikovaný případ podle CZ-DRG a kontroluje, zda byl indikován správně, místo aby kontrolovala, kolik ho bylo.

Dnešní úhradová vyhláška každoročně omezuje, kolik péče nad referenční období pojišťovna nemocnici zaplatí. Limit chrání historické rozpočty, a tím i historická lůžka: centrum, které má podle plánu sítě převzít výkony z jiné nemocnice, narazí na svůj strop. Na konci roku navíc vede k odkládání plánovaných výkonů a prodlužuje čekání.

Indikační kritéria pro skupiny výkonů s největším rizikem nadužívání navrhnou odborné společnosti; nové výkony bude hodnotit rozšířený mandát SÚKL a ÚZIS, případně institut HTA (vlna 4). Opatření propojuje tři věci, které reforma potřebuje: sbližování základních sazeb CZ-DRG z 1 : 1,7 na 1 : 1,3 do roku 2031 (priorita dnešního ministra), hodnocení technologií a dostupnost podle plánu sítě.

Sbližování sazeb sledujeme dvěma veličinami. Rozpětí krajských základních sazeb (1 : 1,7) měří, jak daleko jsou sazby od sebe. Podíl akutní lůžkové péče hrazené jednotnou základní sazbou měří, kolik péče už je sjednoceno: v roce 2022 to bylo 3,4 %, v roce 2025 přes 25 % a cílem je aspoň 30 % (MZ ČR 2025, s. 74, 76 a 82).

Fiskální riziko neomezeného objemu kryje víceletý rámec úhrad z vládní reformy veřejného zdravotního pojištění 2030 a revize pojišťoven, která neindikovaný případ neuhradí. Nástrojem je úhradová vyhláška (§ 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.) a indikační omezení v seznamu výkonů (vyhl. 134/1998 Sb.); zákonem se DRG ukotví ve vlně 4. První skupiny výkonů bez limitu navrhujeme pro úhradovou vyhlášku 2031; v opozici k tomu dáme podněty do dohodovacího řízení. Ověřit: které skupiny výkonů mají v ČR dostatečně přesná data o indikaci pro první vlnu.

Ověřujeme

Pediatrická lůžka

Standardní dětská akutní lůžka byla v roce 2024 obsazená z 36,3 %; ze 84 pracovišť se standardními dětskými lůžky jich 75 mělo obložnost pod 50 %. Verze 2 dětská lůžka neřešila; prof. Bronský (2023) přitom síť dětských lůžkových oddělení označil za hypertrofickou.

V roce 2024 bylo nasmlouváno 2 290 standardních akutních lůžek dětského lékařství a jejich obložnost klesla z 41,1 % v roce 2015 (NRHZS, OIS-11-28, vlastní výpočet). Standardní neonatologická lůžka byla obsazená z 47,0 %. Opačný problém má dětská a dorostová psychiatrie: hospitalizací dětí do 19 let na akutních psychiatrických lůžkách bylo v roce 2023 podle ÚZIS 4 067, téměř dvakrát víc než v roce 2013.

Dětská lůžková oddělení proto přidáváme k oborům, pro které krajský plán stanoví minimální standard. Rozhodovat nemá jen objem, ale nepřetržitá přítomnost pediatra, dostupnost dětské intenzivní péče a převozu a dojezd pro děti z venkova. Oddělení, které standard nesplní, se nezavře, ale změní náplň: krátkodobá observační lůžka u urgentního příjmu, denní stacionář, dětská rehabilitace, dětská paliativní lůžka a tam, kde chybí, dětská a dorostová psychiatrie.

Ambulantní pediatrie se přeměna netýká. Praktické lékaře pro děti a dorost nerušíme a dětské týmy primární péče zachováváme (pilíř 1). Standard navrhne Česká pediatrická společnost s ÚZIS ve fázi F0 a F1, ministerstvo ho vydá ve Věstníku ve fázi F2 a krajské plány ho uplatní od roku 2033. Ověřit: krajské rozložení potřeby lůžek dětské a dorostové psychiatrie.

Ověřujeme

Dojezd záchranné služby a garance dostupnosti

Krajský plán nebude schválen, pokud by po přeměně nemělo aspoň 95 % obyvatel kraje urgentní příjem do 30 minut jízdy. Pro zbylých 5 % v horských a pohraničních oblastech musí plán posílit pozemní a leteckou záchrannou službu a síť proškolených prvních respondentů.

Dnes dostupnost upravují dva předpisy: nařízení vlády 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb a zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě s plánem pokrytí a dojezdem do 20 minut. Žádný z nich ale neváže změnu sítě nemocnic na dojezd do urgentního příjmu. Garanci proto vkládáme do zákona o síti jako kontrolní bod a NV 307/2012 Sb. doplníme o dojezdové doby podle spádů (vlna 2).

Urgentní příjem, který pacienta stabilizuje, odlišujeme od specializovaného centra (iktového, kardiovaskulárního, traumatologického); pro centra platí vlastní standardy dojezdu a převozu. Sloučení akutního oddělení smí nastat až po posílení výjezdové základny a schváleném plánu dojezdů, nikdy naopak; podmínku doplní novela zák. 374/2011 Sb. ve vlně 3. K tomu patří krajská telefonická triáž propojená s dispečinkem a záchranná služba, která může ošetřit na místě a předat pacienta týmu primární péče.

Výchozí dojezdy do urgentních příjmů pro každou obec spočítáme ve fázi F0 z otevřených dat a nabídneme metodiku ÚZIS; ve vládě se výpočet stane povinnou přílohou každého krajského plánu. Ověřit: dostupnost dat o skutečných dojezdových časech záchranné služby po krajích a jejich srovnatelnost.

Ověřujeme

Pandemická rezerva

Krajský plán musí rezervu pro pandemii a hromadná neštěstí pojmenovat, ne ji tiše zrušit: navrhujeme rezervu odpovídající 15 % lůžek intenzivní péče, celostátně asi 860 z 5 727 lůžek (2024). Vysoký počet lůžek intenzivní péče byl v pandemii covidu-19 aktivem, i když mezinárodní srovnání kvůli různým definicím čteme jen jako směr.

Přeměna 8 000 lůžek se týká především standardních akutních lůžek. Počet a úroveň lůžek intenzivní péče má sjednotit koncepční materiál ministerstva k restrukturalizaci intenzivní péče ohlášený ve Věstníku (4/2026); plán sítě na něj naváže. Ověřit: stav a obsah tohoto materiálu.

Ověřujeme

Součástí plánu je krajský plán rozšíření: která nemocnice, kolik lůžek a s jakým personálem v krizi otevře. Přeměněná lůžka následné péče v akutních nemocnicích si ponechají rozvody medicinálních plynů a monitoraci, aby se v krizi mohla vrátit do akutního režimu. Rozhoduje personál: plán proto počítá se sestrami z následné péče jako se zálohou pro akutní provoz a s jejich pravidelným výcvikem.

Pojistky

Přeměna se v kraji zastaví, jakmile obložnost standardních akutních lůžek v některém oboru překročí 85 %. Dánská data spojují takovou obložnost s o 9 % vyšší úmrtností; cílová obložnost kolem 70 % při nižším počtu lůžek je tedy bezpečná, výš už ne.

Pojistka	Spouštěč	Co se stane	Kdo měří
Obložnost 85 %	Obložnost standardních akutních lůžek v oboru a kraji nad 85 % za 12 měsíců nebo v zimní špičce (prosinec až únor)	Přeměna v kraji a oboru stojí, dokud obložnost neklesne	Pojišťovny a ÚZIS měsíčně, nezávislý hodnotitel
Kapacita následné péče (J7)	Kraj nedoloží místa v následné, rehabilitační a dlouhodobé péči	Oddělení se nepřemění	Kraj, schvaluje MZ
Dojezd	Urgentní příjem do 30 minut by po změně mělo méně než 95 % obyvatel	Plán ani změna se neschválí	ÚZIS, záchranná služba kraje
Výsledky pacientů	Růst rehospitalizací do 30 dnů nebo úmrtnosti po hospitalizaci v kraji nad dlouhodobý trend	Mimořádná revize plánu v kraji	Nezávislý hodnotitel čtvrtletně
Personál	Nová role oddělení není personálně obsazená	Garance příjmu se nevyplatí, přeměna čeká	Kraj, pojišťovna

Prahy zimní špičky a výsledků pacientů jsou návrh; upřesní je dopadová studie zákona o síti. Neúspěch v jednom kraji zastaví jen ten kraj, ne reformu.

Co říká evidence. Madsen a kol. (Health Affairs 2014, PMID 25006151) analyzovali 2,65 milionu příjmů na interní oddělení dánských nemocnic v letech 1995 až 2012. Vysoká obložnost byla oproti nízké spojena s o 9 % vyšší nemocniční i třicetidenní úmrtností; jde o pozorovací studii, tedy o souvislost, ne prokázanou příčinu.

Siverskog a Henriksson (Social Science & Medicine 2022, PMID 36206659) srovnali všech 21 švédských regionů v letech 2001 až 2019. Lůžka i úmrtnost klesaly všude, ale regiony, které ubraly méně personálně obsazených lůžek, měly v průměru větší pokles úmrtnosti, což odpovídá jednomu úmrtí méně na tři zachovaná lůžka. Autoři výsledek považují za stabilní a přiklánějí se ke kauzálnímu výkladu; Švédsko ale vycházelo z mnohem menšího počtu lůžek, takže míru efektu nelze přenést do Česka 1 : 1. Poučení pro nás: lůžko se nesmí ubrat bez náhrady, proto přeměna, ne rušení, a měření úmrtnosti po krajích.

Davis a kol. (Medical Care 2007, PMID 18007169) popsali Nový Zéland v letech 1988 až 2001: lůžek ubyla třetina, obyvatel přibyla skoro pětina, a přesto počet propuštěných rostl a přístup zranitelných skupin se udržel. Délka pobytu se zkrátila na polovinu a neplánované rehospitalizace vzrostly o čtvrtinu; věkově standardizovaná úmrtnost do 60 dnů klesla o čtvrtinu, ale vyšší zátěž její pokles zpomalila. Proto mezi pojistky patří rehospitalizace a zátěž personálu, ne jen počet lůžek.

Část III — Jádro reformy: prevence, daně za zdraví a péče doma (pilíře 4 a 5)

Daně za zdraví vynesou podle plánu 5 mld. Kč ročně (rozpětí 5–7). Z toho 2 mld. Kč dostane Fond prevence a zbytek zvýší platbu státu do veřejného zdravotního pojištění. Péče doma pak stojí na kapacitě mimo zdravotnictví: do roku 2035 musí přibýt asi 39 000 lůžek dlouhodobé a následné péče, zdravotních i sociálních (Přecechtěl a Hlávka 2025), a 21 000 pečovatelů.

Část popisuje dvě opatření jádra (J8 , J9), dvě podmínky (P4 , P3) a navazující kroky prevence a péče doma. Termíny platí pro základní scénář „Vláda 2030“, tedy pro Piráty ve vládě od přelomu 2029/2030. V doplňkovém scénáři „Dnešní vláda převezme část“ přicházejí v úvahu jen kroky vlny 0 (seznam výkonů, vyhláška, poslanecký návrh), a to o 1 až 2 roky dříve.

Kód	Opatření	Právní nástroj	Předložení	Účinnost
J8	Tiché víno 23,40 Kč/l s poloviční sazbou pro malé vinaře; automatická valorizace lihu a piva	novela zák. 353/2003 Sb.	2030	1. 1. 2031; plná sazba vína 1. 1. 2033
J9	Pásmová daň ze slazených nápojů	nový zákon	2030	1. 1. 2032
P4	Fond prevence	nový zákon	2030	1. 1. 2031
P3	Sociální účet a sdílené financování sociálně-zdravotní péče	zák. 108/2006 Sb. a 48/1997 Sb.	vlna 4	2033 a později

Kód	Opatření	Právní nástroj	Předložení	Účinnost
Pilíř 5	Delší a samostatná indikace domácí péče sestrou	zák. 48/1997 Sb.	2030	1. 1. 2032

Pilíř 4: daně za zdraví podle Hospodářské strategie PEER

Daně za zdraví jsou opatřeními Hospodářské strategie PEER: spotřební daň ze slazených nápojů, zdanění tichého vína a úprava daní z alkoholu, s očekávaným výnosem 10 až 15 mld. Kč ročně. Pro rozpočet této reformy plánujeme opatrně s 5 mld. Kč ročně v plném náběhu, s rozpětím 5 až 7 mld. Kč. Plánovací hodnota je záměrně dolní hranice: reforma s ní vystačí, i kdyby výnos zklamal. Postupný růst daní z tabáku a nikotinu (`Pil4.11`) stojí vedle tohoto čísla jako výhled, do plánovací hodnoty ho nepočítáme. Britská pásmová daň vybrala 327 mil. £ ročně proti plánovaným 500 mil. £, protože výrobci cukr odstranili. Český líh po zvýšení sazby o více než pětinu (10 %, 10 % a 5 % v letech 2024 až 2026) vybral méně než před ním.

Složka	Statický výnos, mld. Kč	Výnos po reakci, mld. Kč	Klíčový předpoklad
Tiché víno, 23,40 Kč/l	3,7–4,6	3,3–4,3	19,5 l vína na obyvatele, tichá vína 75–93 % objemu, elasticita −0,69
Pásmová daň ze slazených nápojů	2,1–2,5	asi 1,5 (1,3–1,8)	britský výnos na obyvatele (134 Kč); reformulace výnos dál snižuje
Valorizace lihu a piva	1–1,5	0–1	líh 2024 až 2026: vyšší sazba, ale inkaso pod úrovní roku 2023
Součet	6,8–8,6	4,6–7,1, tedy 5–7	všechny tři kroky současně

Výnos se počítá jednou. Všechny tři kroky jsou součástí daňového balíčku Hospodářské strategie PEER (asi +80 mld. Kč čistě), takže v této reformě slouží jako zdroj zdravotnictví a v konsolidaci se musí odečíst.

Cíl PEER 10 až 15 mld. Kč dává plná podoba opatření: víno zdaněné podle obsahu alkoholu, cukerná daň nad britskou úrovní a úprava daní z alkoholu obecně. Rozpočet reformy s ním zatím nepočítá, protože výnos těchto daní klesá s reakcí spotřeby, o kterou zdravotně jde, a s erozí základu; zkušenost s lihem v letech 2024 až 2026 a s britskou cukernou daní to ukazuje. Co výnos přinese nad 5 mld. Kč, rozdělí se podle pravidla PEER: nejméně 40 % Fondu prevence, zbytek platbě státu.

Zdroj	Mld. Kč ročně	Co předpokládá	Jak s ním nakládáme
Tato studie	5 (5–7)	sazby běžné v Evropě, víno 23,40 Kč/l, britská pásmová daň, valorizace	plánovací hodnota pro rozpočet reformy
Hospodářská strategie PEER	10–15	víno podle alkoholu, cukerná daň nad britskou úrovní, úprava daní z alkoholu	program strany a cílová hodnota; rozpočet reformy s ní zatím nepočítá
PAQ Research	12–17 (alkohol)	pivo a víno zdaněné podle obsahu alkoholu	horní scénář; daň podle gramu alkoholu viz výhled po roce 2033 níže
Strukturální reforma Česka v6	až asi 15	valorizace, tiché víno a případně slazené nápoje; součást balíku asi 80 mld. Kč	v6 chápe vázání výnosu jako politické pravidlo; studie váže zákonem 40 % výnosu podle PEER, nejméně 2 mld. Kč

Brána `B1` (6/2028) proto vyžaduje, aby strana veřejně rozlišovala cíl programu (10 až 15 mld. Kč) a plánovací hodnotu pro rozpočet reformy (5 mld. Kč). Důvod je praktický: jinak oponent použije vyšší číslo jako slib a nižší jako přiznání. Autor je členem PEER (viz prohlášení o střetu zájmů).

Zdravotní účinek je skromnější než výnos. Zdanění vína sníží spotřebu čistého alkoholu o 0,1 až 0,2 l na osobu, tedy o 1 až 2 % z 11,2 l. Větší pokles by vyžadoval minimální cenu a dostupnostní opatření, která přicházejí později; cíl pro spotřebu alkoholu v Části IX proto vychází z tohoto mechanismu, ne z cíle −15 % z verze 2.

`J8` : daň z tichého vína a valorizace daní z lihu a piva

Tiché víno je od roku 2031 zdaněno sazbou 23,40 Kč/l s dvouletým náběhem a poloviční sazbou pro malé vinaře. Líh a pivo se jen valorizují, protože zvyšování sazeb lihu v letech 2024 až 2026 výnos nepřineslo.

Karta `J8`	Daň z tichého vína a valorizace
Proč	Tiché víno je jediný alkohol s nulovou sazbou: tvoří 75–93 % objemu trhu s vínem (ČSÚ podíl nepublikuje, ISP 2019 uvádí 93 %), ale 0,24 % inkasa spotřebních daní. Elasticita poptávky po víně je −0,69 (Wagenaar 2009); zdražení lahve za 100–150 Kč o 12–18 % sníží spotřebu vína o 8–12 %. Líh rezervu nemá: po zvýšení sazby o více než pětinu je inkaso pod úrovní roku 2023 (8,97 mld. Kč), proto u lihu a piva navrhujeme jen valorizaci.
Co přesně	(1) Sazba 23,40 Kč/l, shodná se šumivým vínem, s náběhem: poloviční sazba 2031–2032, plná od 2033. (2) Nezávislí vinaři s průměrnou produkcí do 1 000 hl ročně platí trvale polovinu (11,70 Kč/l) a mají zjednodušenou evidenci. (3) Sazby lihu a piva se automaticky valorizují o inflaci, bez skokových zvýšení. (4) Přechodná pomoc s náklady zavedení.
Právní nástroj	Novela zák. 353/2003 Sb. (rozsah M): sazby, nová snížená sazba, valorizace v § 70. Unijní základ: čl. 9a směrnice 92/83/EHS ve znění směrnice (EU) 2020/1151 dovoluje sníženou sazbu pro nezávislé malé producenty do 1 000 hl ročně, nejvýše o 50 % pod národní základní sazbou. Největší část předlohy tvoří režim malých vinařů (daňové sklady, zjednodušená evidence).
Kdo	Předkládá Ministerstvo financí, sazby spravuje Celní správa, zdravotní odůvodnění dodá MZ. Ve fázích F0 a F1 připravuje věcný záměr resortní tým s Institutem Pi a konzultuje ho s vinařskými, pivovarskými a lihovarskými organizacemi.
Kdy (základní scénář)	F0 (11/2026–6/2028): konzultace a podněty. Brána `B1` (6/2028): strana přijala číslo 5 mld. Kč. F1 (do 12/2029): věcný záměr a volební program. Předložení 2030 (vlna 1), účinnost 1. 1. 2031; víno s poloviční sazbou 2031–2032, s plnou od 1. 1. 2033.

Karta J8	Daň z tichého vína a valorizace
Na čem závisí	Na vládě s Piráty od přelomu 2029/2030 a na koaliční shodě přes moravský blok napříč stranami. Dále na novém vzorci platby státu (J10), který převede zbytek výnosu do pojištění, a na zákonu o Fondu prevence (P4). Ověřit: podíl objemu vína od producentů do 1 000 hl ročně; bez něj nelze vyčíslit náklad poloviční sazby.
Rizika a pojistky	(1) Vinaři: dvouletý náběh, poloviční sazba pro malé, jednodušší administrativa a přechodná pomoc. Ověřit: zda odhad 3,3–4,3 mld. Kč počítá malé vinaře jako osvobozené (verze 2), nebo zdaněné. (2) Přeshraniční nákupy: Ověřit sazby tichého vína v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku; pokles inkasa se nesmí číst jako pokles pití (zkušenost s lihem). (3) TRIS: sazba daně se podle našeho čtení nenotifikuje; notifikaci vyžaduje až zdravotní varování a minimální cena (vlna 4). (4) Veřejná podpora: snížená sazba pro malé vinaře je selektivní výhoda a patří do posouzení veřejné podpory. Ověřit: zda stačí čl. 9a směrnice, nebo je nutné oznámení Komisi. (5) Návrh MF z roku 2023 uváděl tři sazby a osvobození malých vinařů. Ověřit: jak je MF slučovalo se směrnicí; pokud osvobození šlo, studie zbytečně přitvrzuje.

Ověřujeme

J9 : pásmová daň ze slazených nápojů

Daň ze slazených nápojů začne platit 1. 1. 2032 a vynese asi 1,5 mld. Kč ročně (1,3 až 1,8) s klesající tendencí. Její hlavní účinek není ve výběru, ale v přepsaných recepturách. Zdravotní cíl proto má přednost před výnosem.

Karta J9	Pásmová daň ze slazených nápojů
Proč	Poptávka po slazených nápojích je elastická: elasticita −1,59, promítnutí daně do ceny 82 % a průměrný pokles prodejů o 15 % bez doložené substituce (Andreyeva 2022, 86 studií, PMID 35648398). Britská pásmová daň, ohlášená 2016 a účinná 2018, snížila podíl nápojů nad 5 g cukru na 100 ml o 33,8 bodu ještě před účinností (Scarborough 2020). Obezita dívek ve věku 10–11 let klesla o 1,6 bodu, v nejchudším kvintilu o 2,4 bodu; u chlapců se nezměnila (Rogers 2023, PMID 36701272). V Česku má nadváhu nebo obezitu 26,3 % dětí ve věku 6–9 let.
Co přesně	Nula pod 4,5 g cukru na 100 ml (britská hranice od 2028), nižší sazba do 8 g, vyšší nad 8 g; sazby na britské úrovni, asi 6 a 8 Kč/l (přesně je kalibruje dopadová studie 2028). Plátcem je výrobce a dovozce, sladidla se nedaní a slazené mléčné nápoje nemají plošnou výjimku. Mimo daň jsou nápoje bez přidaného cukru a nejmenší výrobci. Polský model nevolíme: daní pevnou částkou i sladidla, takže motivaci k odslazení oslabuje.
Právní nástroj	Nový zákon o dani ze slazených nápojů (rozsah L, 25–35 paragrafů): pásma, plátce, osvobození, správa Celní správou, určení výnosu. TRIS: pásma podle složení mohou být de facto technickým předpisem, protože fiskální opatření motivuje ke složení výrobku (čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2015/1535); Ověřit právně, standstill je tři měsíce. Veřejná podpora: posouzení osvobození nejmenších výrobců; Ověřit hranici osvobození (britská hranice: 1 mil. litrů ročně).
Kdo	Předkládá Ministerstvo financí, vybírá Celní správa; MZ stanoví zdravotní cíle a evaluaci. O pásmech a době ohlášení jedná s výrobci a dovozci nápojů resortní tým a později vláda (jednání 2030).
Kdy (základní scénář)	Ohlášení ve volebním programu 2029; přijetí zákona 2030 (vlna 1); účinnost 1. 1. 2032. Dvouleté ohlášení (2030–2031) slouží k reformulaci. Evaluace od prvního dne: základní data o prodejích a obsahu cukru se sbírají už před účinností.
Na čem závisí	Na zákoně o Fondu prevence (P4), z něhož se financují programy ve školách; na mikrosimulaci dopadu na nízkopříjmové domácnosti hotové před předložením a na kompenzacích mimo daň (například přídavky na děti); dále na kapacitě Celní správy a koaliční shodě.
Rizika a pojistky	(1) Výnos nižší než plán: britský výnos klesl z plánovaných 500 na 327 mil. £, proto plánujeme 1,5 mld. Kč jako klesající. (2) Přeshraniční nákupy: Polsko (od 2021) i Slovensko (od 2025) slazené nápoje zdaňují, motiv nákupu za hranicí je tedy slabý; Ověřit: Německo a Rakousko. (3) Regresivita: daň tvoří větší podíl výdajů chudších domácností, ty ale snižují spotřebu víc (Quiroz-Reyes 2025); pojistkou jsou kompenzace mimo daň a prevence ve školách. (4) Rozpuštění vázání: britský výnos se v obecném rozpočtu rozpustil, proto zákonná částka pro Fond prevence. (5) Odpor průmyslu: dvouleté ohlášení, které v Británii umožnilo reformulaci. (6) TRIS a veřejná podpora jsou dvě ze tří řízení vůči Evropské komisi.

Ověřujeme

Pil4.11 a Pil4.12 : tabák a nikotin zdaněné víc, prevence odměněná

Tabák a nikotin do daní za zdraví patří, jejich výnos ale do čísla 5 mld. Kč nepočítáme. Důvod je stejný jako u lihu: cílem je, aby se kouřilo méně, a klesající spotřeba inkaso stahuje. Zákon už dnes zvyšuje sazby z cigaret o 5 % ročně do roku 2027 a zahřívaný tabák o 15 % ročně a od roku 2024 zdaňuje náplně do elektronických cigaret a nikotinové sáčky s náběhem sazeb do roku 2027 (zák. 353/2003 Sb. ve znění konsolidačního balíčku; Ověřit přesné sazby a jejich kalendář). Po roce 2027 plán končí. Navrhujeme pokračovat, předvídatelně a bez skoků.

- **Co (Pil4.11).** Od roku 2028 automatická valorizace sazeb z tabáku a nikotinu o inflaci a k tomu růst o 5 % ročně nad inflaci, dokud podíl daní na ceně nejprodávanějších cigaret nedosáhne 75 % doporučených WHO (Ověřit: dnešní podíl, odhadem kolem 70 %). Zahřívaný tabák, náplně do elektronických cigaret a nikotinové sáčky se zdaní podle obsahu nikotinu tak, aby se přechod mezi výrobky daňově nevyplácel.

  Ověřujeme

- **Výnos.** Inkaso daně z tabákových výrobků je asi 60 mld. Kč ročně (Ověřit: inkaso 2024 a 2025 podle Celní správy). Při elasticitě poptávky kolem −0,4 přinese každý rok růstu o 5 % nad inflaci odhadem 1,5 až 2 mld. Kč navíc, s klesající tendencí; po pěti letech asi 6 až 8 mld. Kč ročně nad dnešní úroveň v reálném vyjádření. Ověřit v modelu pro verzi 4. Toto číslo vedeme jako výhled vedle plánovací hodnoty 5 mld. Kč, ne jako její součást.

  Ověřujeme

- **Kam výnos jde (Pil4.12).** Reálný přírůstek nad úroveň roku 2027 jde zákonem přednostně na podporu těch, kdo aktivně pečují o své zdraví, podle Hospodářské strategie PEER. (1) Hrazené odvykání kouření včetně léků a poradenství pro každého, kdo se o to pokusí; dnes pojišťovny hradí jen část a jen některým (Ověřit rozsah dnešní úhrady); odhadem 0,5 mld. Kč ročně. (2) Zvýhodnění na pojistném: pojišťovna může navázat část pojistného na aktivní a doložitelnou péči pojištěnce o vlastní zdraví a nabídnout mu nižší platbu.

Neodměňuje razítko z prohlídky, ale širší koš chování: pravidelný pohyb, nekouření, střídmost v alkoholu, práci s hmotností a spánkem a účast v ověřených programech (odvykání kouření, pohybové a nutriční programy). Rozhoduje zapojení a zlepšení v čase, ne aktuální zdravotní stav; preventivní prohlídka je vstupní bod a měření, ne cíl. Kdo se ze zdravotních důvodů zapojit nemůže, zvýhodnění neztrácí. Zavádí se pilotně a povinně pro ročníky do 40 let, spolu s reformou daně z příjmů fyzických osob. Ověřit: právní formu slevy na pojistném a její soulad s rovností pojištěnců. (3) Programy pro lidi s prediabetem a nadváhou u nutričního terapeuta týmu (`Pil4.10`).

Ověřujeme

- **Proč obojí.** Zdanění tabáku řadí WHO mezi nejúčinnější opatření vůbec („best buy“); spotřebu snižuje nejvíc u mladých a u lidí s nízkými příjmy, na které ale také nejvíc dopadá finančně. Podpora odvykání a zvýhodnění na pojistném tento dopad vracejí těm, kdo pro své zdraví něco dělají. Hospodářská strategie PEER zvýhodnění výslovně navrhuje (kap. 1.4, podle nizozemského vzoru) a Manifest předpokládá zdanění tabáku jako WHO Best Buy (oblast 8).
- **Nástroj a kdy.** Novela zák. 353/2003 Sb. spolu s `J8` (vlna 1, předložení 2030, účinnost 1. 1. 2031). Roky 2028 až 2030 dnešní plán nepokrývá, proto v roce 2027 dáme současné vládě podnět, aby ho prodloužila. Vázání přírůstku patří do zákona o Fondu prevence (`P4`); zvýhodnění na pojistném do novely zák. 592/1992 Sb. spolu s reformou daně z příjmů fyzických osob, pilot pro ročníky do 40 let od 1. 1. 2032. Ověřit: zda vázání přírůstku jedné daně obstojí v rozpočtových pravidlech stejně jako pevná částka pro fond.

Ověřujeme

- **Rizika a pojistky.** Nelegální trh a nákupy v Polsku a na Slovensku: růst 5 % ročně je pod tempem let 2024 až 2027 a podíl nelegálních cigaret se sleduje každý rok (Ověřit dnešní odhad); při jeho růstu nad dohodnutou mez se tempo zpomalí. Příspěvek vázaný na prevenci nesmí vyloučit lidi, kteří na prohlídku nemohou: platí i pro prohlídku sestrou týmu doma (`J4`).

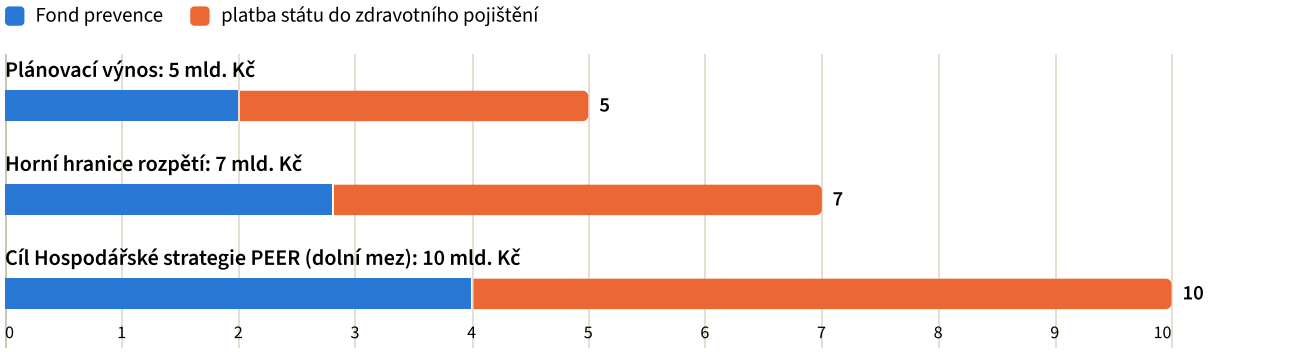
`P4` : Fond prevence zdravotních pojišťoven

Podle Hospodářské strategie PEER jde nejméně 40 % výnosu daní za zdraví účelově do Fondu prevence zdravotních pojišťoven (dále Fond prevence), nejméně však 2 mld. Kč ročně, valorizovaných o inflaci; zbytek výnosu zvýší platbu státu do pojištění.

Prevence dostane nejméně 40 % výnosu daní za zdraví, vždy aspoň 2 mld. Kč; zbytek zvýší platbu státu do pojištění

Rozdělení ročního výnosu daní za zdraví v plném náběhu, mld. Kč: plánovací výnos 5 mld. Kč, horní hranice rozpětí 7 mld. Kč a dolní mez cíle PEER 10 mld. Kč

Pravidlo v zákoně o fondu (podle Hospodářské strategie PEER): Fond prevence zdravotních pojišťoven dostane nejméně 40 % výnosu, vždy aspoň 2 mld. Kč ročně (valorizovaně); zbytek zvyšuje platbu státu za státní pojištěnce. Odvody z práce se nesnižují.



5 mld. Kč: fond 2 (40 % výnosu), pojištění 3, tedy asi 40 Kč měsíčně navíc za každého státního pojištěnce

7 mld. Kč: fond 2,8 (40 % výnosu), pojištění 4,2, tedy asi 60 Kč měsíčně navíc za každého státního pojištěnce

10 mld. Kč: fond 4 (40 % výnosu), pojištění 6, tedy asi 80 Kč měsíčně navíc za každého státního pojištěnce

Při plánovací hodnotě kryjí 2 mld. Kč prevenci, se kterou počítá model (1,3 mld. Kč), a komunitní programy (0,7 mld. Kč). Částku nad 2 mld. Kč při vyšším výnosu přidělí rada fondu programům s doloženým účinkem; rozpočet reformy s ní zatím nepočítá.

Zdroj: Studie v3.1, Část III (pilíř 4 a P4) a Hospodářská strategie PEER, kap. 1.4; 100 Kč měsíčně na státního pojištěnce odpovídá 7,2 mld. Kč ročně (6,0 mil. státních pojištěnců)

pravidlo rozdělení daní za zdraví · plánovací výnos 5 mld. Kč, horní hranice rozpětí 7 mld. Kč a dolní mez cíle PEER 10 mld. Kč · tři scénáře

Pravidlo spojuje podíl ze strategie PEER s pevnou dolní hranicí. Podíl 40 % zajistí, že s vyšším výnosem roste i prevence. Dolní hranice 2 mld. Kč chrání prevenci v letech, kdy výnos klesá, což u cukerné daně nastane, jakmile výrobci sníží obsah cukru. Verze 2 počítala jen s podílem, a protože cukerná daň měla jít z 96 % do fondu a škol, nedalo se z ní poznat, kolik prevence skutečně dostane.

Při plánovací hodnotě 5 mld. Kč dostane Fond prevence 2 mld. Kč, které kryjí prevenci započtenou v modelu (1,3 mld. Kč, viz Část V) a komunitní programy (0,7 mld. Kč). Při výnosu 7 mld. Kč dostane 2,8 mld. Kč a při cíli PEER 10 až 15 mld. Kč 4 až 6 mld. Kč; částku nad 2 mld. Kč model zatím nerozepisuje a rada fondu ji přidělí programům s doloženým účinkem.

Zbytek, 3 mld. Kč při plánovací hodnotě a 4,2 mld. Kč při výnosu 7 mld. Kč, nepřijde jako samostatná dotace. Zvyšuje základ platby státu podle nového vzorce (`J10` , § 3c zák. 592/1992 Sb.), kde 100 Kč měsíčně na státního pojištěnce odpovídá 7,2 mld. Kč ročně; zbytek tedy činí asi 40 až 60 Kč měsíčně. Nesnižuje odvody z práce; opačné tvrzení v politické verzi 2 bylo chybné. Výpočet vzorce včetně automatického růstu platby při vyšší sazbě je v jedné tabulce v Části V.

Karta P4	Fond prevence zdravotních pojišťoven
Proč	Prevence se dnes financuje nahodile, z fondů pojišťoven a z programů bez evaluace: jde na ni 2,74 % běžných výdajů (OECD 3,2 %), tedy odhadem 18 až 19 mld. Kč. Britské vázání výnosu se po roce rozpustilo v obecném rozpočtu, polské (96,5 % do Národního fondu zdraví) drží. Pevná zákonná částka chrání prevenci i před poklesem výnosu.
Co přesně	Fond prevence zdravotních pojišťoven zřízený zákonem podle Hospodářské strategie PEER; příjem tvoří nejméně 40 % výnosu daní za zdraví, nejméně však 2 mld. Kč ročně (valorizovaně), přednostně i při nižším výnosu. Výnos se rozdělí pojišťovnám podle počtu pojištěnců s věkovou váhou jako při přerozdělení; pojišťovny ho vedou odděleně a o programech rozhoduje společná rada podle zákonných pravidel. Z fondu se platí navigace po screeningu, očkování, krátká intervence, dostupná adiktologická léčba a pomoc rodinám závislých, fluorid a voda ve školách, programy pro děti s nadváhou a neziskové organizace. Rada fondu každý rok veřejně vyúčtuje, na co peníze šly, za každou pojišťovnu zvlášť. Dnešní fondy prevence pojišťoven, plněné ze zisku a bez pravidel, se přemění na fondy rozšířené péče (vlna 2, `M2.3`), aby se dva účely a dva zdroje nemíchaly.
Právní nástroj	Zákon o Fondu prevence zdravotních pojišťoven (rozsah M–L, 15–25 paragrafů; vlna 1) s novelou zák. 280/1992 Sb. a 551/1991 Sb. o fondech pojišťoven. Účelové vázání výnosu daní musí obstát vůči zák. 218/2000 Sb. a 23/2017 Sb. Ověřit: zda vést fond jako zvláštní fond každé pojišťovny se společnými pravidly, nebo jako společný účet ve zdravotním pojištění.

Karta P4	Fond prevence zdravotních pojišťoven
Kdo	Zřizuje stát zákonem (MZ a MF), peníze vedou pojišťovny; o programech rozhoduje společná rada se zástupci MZ, MF, pojišťoven, krajů, SMO ČR, pacientských organizací a odborných společností; složení je předmětem konzultace. Programy hodnotí ÚZIS s univerzitou jako nezávislý hodnotitel reformy.
Kdy (základní scénář)	Konzultace s MF a NRR od fáze F0. Brána B1 (6/2028): strana potvrdila plánovací hodnotu a pravidlo rozdělení podle PEER. Předložení 2030 (vlna 1) spolu s J8 a J10, účinnost 1. 1. 2031; příjem z daně ze slazených nápojů od 1. 1. 2032.
Na čem závisí	Na J8, J9 a J10; na souhlasu MF a NRR s pevným vázáním v rozpočtových pravidlech; na tom, že strana potvrdí plánovací hodnotu a pravidlo rozdělení (B1); na evaluaci od prvního dne.
Rizika a pojistky	(1) Rozpuštění vázání jako ve Spojeném království: částka je v zákoně a roční vyúčtování je veřejné. (2) Nižší výnos v náběhu: fond má přednost, platba státu z daní za zdraví roste výrazněji až od 2032–2033 (odvozený odhad výnosu: 2031 asi 1,7–3,2 mld. Kč, 2032 asi 3,0–5,0 mld. Kč, od 2033 5–7 mld. Kč). (3) Programy bez účinku: každý má kontrolovanou časovou řadu a po třech letech se rozhoduje o jeho pokračování. (4) Pojišťovny použijí fond na marketing místo prevence: zákon vymezí, co se z fondu smí platit, a programy hodnotí ÚZIS s univerzitou.

Ověřujeme

Minimální cena alkoholu a další regulace bez výnosu

Minimální cena za gram alkoholu přichází až ve vlně 4 (účinnost 2033 a později), protože nejdřív musí obstát daně. Ve Skotsku od roku 2018 snížila počet úmrtí plně způsobených alkoholem o 13,4 % proti stavu bez opatření, asi 150 úmrtí ročně (kontrolovaná přerušená časová řada se srovnáním s Anglií; Wyper 2023, PMID 36963415). Největší pokles nastal ve čtyřech nejchudších decilech.

Stát na minimální ceně nic nevybere, protože cenový rozdíl zůstává obchodníkům. Vyšší DPH přinese jen 0,2 až 0,5 mld. Kč.

Verze 2 odvodila pro Česko 200 až 400 odvrácených úmrtí ročně při polovičním skotském účinku. Posudek správně namítl, že tento přenos nemá oporu, protože Česko má jinou strukturu spotřeby (pivo, víno). Verze 3 proto počet úmrtí neslíbí; interval nejistoty pro konkrétní cenovou hranici spočítá dopadová studie v roce 2028.

Právní překážkou je test přiměřenosti podle rozsudku SDÚE C-333/14 (Scotch Whisky Association): minimální cena omezuje volný pohyb zboží a obstává jen tehdy, nelze-li stejného cíle dosáhnout méně restriktivně, zejména daní. Proto nejdřív daně a minimální cena až po vyhodnocení jejich účinku. Zákon o minimální ceně (rozsah M) vyžaduje notifikaci TRIS a analýzu dopadu na pivo.

Opatření	Právní nástroj	Termín	Poznámka
Zmocnění obcí omezit noční prodej alkoholu v obchodech (22 až 6 h)	zák. 65/2017 Sb., 128/2000 Sb.	vlna 4 (rozsah S–M)	jeden prodejní den navíc = +3,4 % spotřeby (Sherk 2018); Ověřit: zda lze předložit dříve jako poslanecký návrh
Zpřísnění reklamy tam, kde ji sledují děti (sportovní přenosy, sociální sítě)	zák. 40/1995 Sb.	vlna 4	bez výnosu
Zdravotní varování na obalech alkoholu (riziko rakoviny)	nový zákon; notifikace TRIS (tříměsíční standstill)	vlna 4	Yukon: −6,6 % prodeje označených produktů, studii ukončil zásah průmyslu; Irsko varování odložilo na 2028
Daň podle gramu alkoholu ve všech nápojích	sjednocení sazeb v zák. 353/2003 Sb.	debata do voleb 2029, účinnost nejdřív 2033	+2 až +3 mld. Kč nad víno 23,40 Kč/l; největší politická cena; do plánovací hodnoty se nepočítá

Ověřujeme

Ostatní prevence: zubní prevence, očkování, navigace, krátká intervence

Prevenci mimo daně hradíme jen tam, kde má doložený účinek: fluoridový lak a pečetění u dětí, očkování seniorů, navigaci po pozitivním screeningu a krátkou intervenci u praktika. Každá položka je ve studii jen jednou; zubní prevence zde nahrazuje obecné „hrazené hygieny“ z Manifestu.

Opatření	Co přesně	Evidence	Nástroj a termín
Zubní prevence do 18 let	Hrazený fluoridový lak dvakrát ročně, pečetění fisur prvních stálých molárů a instruktáž, od 1. třídy; provádí i dentální hygienistka ve škole. Rutinní odstraňování kamene a leštění se nehradí. Náklad 0,3–0,5 mld. Kč ročně při plném pokrytí.	Lak: −43 % kazů stálých zubů (Marinho 2013, PMID 23846772). Pečetění: OR 0,12 ve dvou letech (Ahovuo-Saloranta 2017, PMID 28759120). Školní programy s lakem −32 % (Griffin 2025). Rutinní hygiena u dospělých bez doloženého přínosu (Lamont 2018).	Podnět do seznamu výkonů (vyhl. 134/1998 Sb.) s cílem 1. 1. 2028; zákon (zák. 48/1997 Sb., příloha 1) ve vlně 2, účinnost 1. 1. 2032. Šetření orálního zdraví dětí v 5, 12 a 15 letech (2028, pak každých pět let).
Očkování seniorů proti chřipce	Pozvání sestrou týmu, očkování v lékárnách hrazené a bez předpisu (lékárníci mohou očkovat od roku 2024), připomínka v aplikaci. Cíl 40 % kolem roku 2038 (30 % v roce 2033); verze 2 uváděla 60 % do roku 2035, což evidence k očkování v lékárnách nepodporuje, proto jsme cíl podle posudku snížili (ukazatel D7, Část IX).	Lékárníci: nárůst proočkovanosti o 0 až 10 bodů, nejvíc při největší autonomii (Spinks 2020, PMID 32674753).	Hrazený výkon v seznamu výkonů a úhradové vyhlášce. Ověřit: výchozí proočkovanost 65+; bez ní je cíl 40 % jen orientační.
Navigace po pozitivním screeningu	Sestra týmu do týdne zavolá, objedná a ohlídá. Pilot ve dvou krajích s evaluací.	Dokončení kolonoskopie RR 1,27 (1,10–1,46), osm studií, střední jistota, americká data ze znevýhodněných populací (Gonzalez Mosquera 2026, PMID 42618855).	Hrazený výkon po pilotu. Ověřit: start a financování pilotu.
Krátká intervence u praktika	Hrazený výkon navazující na rizikový screening při preventivní prohlídce (vyhl. 70/2012 Sb. ve znění 403/2025 Sb.).	−20 g alkoholu týdně, tedy asi dvě piva; 69 randomizovaných studií, střední jistota (Kaner 2018, PMID 29476653). Účinek malý, ale levný.	Podnět do seznamu výkonů s cílem 1. 1. 2028. Není náhradou cenových opatření.

Ověřujeme

Navigace zvyšuje i poptávku po kolonoskopii, a bez kapacity endoskopie by tedy prodloužila čekání. Pilot proto měří kapacitu v kraji a cíl pro čekání se neslibuje, dokud ji nezměří. Screeningové programy koordinuje Národní screeningové centrum (vládou schváleno v květnu 2025), které zavedlo koordinátory screeningových programů a krajské koordinátory (MZ ČR 2025, s. 35 a 44–45); pilot navigace stavíme na nich. Na kolonoskopii po pozitivním testu dnes dochází jen 60 až 70 % lidí (tamtéž, s. 36). Ověřit: u navigace, očkování a krátké intervence plátce výkonu (pojišťovna úhradou, nebo Fond prevence); prevence se v modelu počítá jen jednou.

Ověřujeme

Zubní prevenci jsme proti Manifestu zužili na to, co má doklady. První verze ocenila hygienu na 0,8 až 1,4 mld. Kč ročně bez jediné citace účinnosti; verze 3 počítá 0,3 až 0,5 mld. Kč. Ověřit: zda je tento náklad součástí prevence 1,3 mld. Kč v modelu (Část V), nebo stojí mimo.

Ověřujeme

Strava a pohyb: aktualizace vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování (cukr, sůl) s kontrolou skladby jídel, omezení reklamy na nezdravé potraviny dětím podle nutričního profilu WHO a nutriční terapeut v týmu s programy pro lidi s prediabetem. Diabetes Prevention Program snížil výskyt cukrovky o víc než polovinu (Knowler 2002), v běžné praxi méně. Program škola podporující zdraví (SZÚ, 102 základních a středních a 86 mateřských škol v roce 2025) nemá evaluaci, a rozšíří se jen po pilotu v jednom kraji s kontrolním srovnáním po třech letech.

Z programu 2021 nepřebíráme daňové zvýhodnění zaměstnavatelů za prevenci, protože má vysoké mrtvé náklady.

Pilíř 5: sociální účet a pomezí zdravotní a sociální péče (P3)

Lidí nad 75 let s vysokou potřebou péče (příspěvek III a IV) přibude ze 115 tisíc v roce 2024 na 241 tisíc v roce 2050 a nad 85 let z 62 na 165 tisíc (ÚZIS). Pracovníků dlouhodobé péče máme 2,5 na 100 seniorů, průměr OECD je 5,6. Péče se nejvíc rozpádá na pomezí, kde zdravotní i sociální potřebu platí jiný rozpočet a řídí jiné ministerstvo.

Do roku 2035 musí přibýt asi 39 000 lůžek dlouhodobé a následné péče, zdravotních i sociálních (Přecechtěl a Hlávka 2025), a 21 000 pečovatelů, jinak nelze přeměnit jediné akutní lůžko (J7). Zdravotní část potřeby je menší (dnes chybí 2 až 3 tisíce lůžek, do roku 2035 dalších nejméně 8 tisíc; MZ ČR 2025, s. 65), většina leží v pobytových sociálních službách. Jediná ucelená kvantifikace sociální části je studie Deloitte pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR (červen 2026), tedy studie na zakázku poskytovatelů, jejíž vstupy Deloitte neověřoval; přebíráme jen vstupy, ne doporučení. Kapacita pobytových služeb je 76 tisíc lůžek a v roce 2035 bude potřeba 111 tisíc, terénních pečovatelů je 34 tisíc úvazků a bude potřeba 55 tisíc.

Náklad sociální péče o seniory vzroste z asi 80 mld. Kč (2024) na asi 137 mld. Kč (2035), tedy o 57 mld. Kč ročně. Jednotkové náklady Deloitte jsou nižší než podle ČSÚ (domov pro seniory 495 oproti 665 tisícům Kč na klienta a rok), skutečný účet tedy může být vyšší. Investice do pobytové kapacity činí 3 až 5 mil. Kč na lůžko.

Celý účet je veden vedle čistého nákladu reformy, ne v něm (viz Část V); reforma zdravotnictví jej nezaplatí ani nezlevní. Rozdíl 35 tisíc (verze 2 a Deloitte: rozdíl 111 a 76 tisíc, jen pobytové sociální služby) a 39 tisíc (Přecechtěl a Hlávka: i zdravotní lůžka následné péče) je hlavně v rozsahu; zdravotní část odhaduje MZ ČR 2025 (s. 65 a 66) zvlášť. Ověřit: jak se obě řady překrývají; studie používá vyšší hodnotu, dokud nebude rozdíl úplně vysvětlen.

Ověřujeme

Pokud kapacita nevznikne, péče doma znamená péči dcerou: modelově 136 tisíc úvazků neformálních pečujících v roce 2035 proti dnešním 97 tisícům. Proto je samostatným ukazatelem počet neformálních pečujících a počet dnů na akutním lůžku z čekání na místo v sociální službě.

Karta P3	Sociální účet a sdílené financování sociálně-zdravotní péče
Proč	Bez sociální kapacity zůstane senior na akutním lůžku, protože nemá kam jít, a rodiny nesou náklady samy. Pomezí rozdělují dva rozpočty a dvě ministerstva, což vede k převozům tam a zpět.
Co přesně	(1) Veřejně sledovaný roční přehled sociálního účtu dlouhodobé péče: zdravotní, sociální a neformální péče vedle sebe. (2) Sdílené financování: pojišťovna může hradit část sociální služby, pokud tím ušetří ve zdravotnictví, a naopak. (3) Piloty se společným rozpočtem pojišťoven a kraje. (4) Koordinátor péče v týmu (zdravotně-sociální pracovník nebo sestra). (5) Jedno šetření pro příspěvek na péči i plán péče. (6) Rozhodnutí o samostatném pojištění dlouhodobé péče do roku 2031 (Německo má pojištění od 1995, Japonsko od 2000, Nizozemsko od 2015 oddělilo akutní, dlouhodobou a komunitní péči).
Právní nástroj	Novela § 36 zák. 108/2006 Sb. ve vazbě na § 17a a § 22b zák. 48/1997 Sb. (rozsah M; vlna 4). Navazuje na zák. 38/2025 Sb. (od 1. 1. 2029 strop pobytu podle § 22b a zrušení § 52 zák. 108/2006 Sb.), na reformu příspěvku na péči (zák. 300/2025 Sb., převážně od 1. 6. 2028; § 8a: člověk v terminálním stavu se na 12 měsíců považuje za závislého ve stupni III) a na rekodifikaci sociálních služeb MPSV (2031). Samostatný zákon o pojištění dlouhodobé péče (rozsah L) jen tehdy, pokud padne rozhodnutí.
Kdo	MPSV (sociální účet, rekodifikace) a MZ; pojišťovny, kraje a obce jako plátci a objednavatelé; Asociace krajů ČR a SMO ČR v Řídicím výboru; poskytovatelé sociálních služeb (APSS ČR) jako konzultační partner.
Kdy (základní scénář)	F1: jednání s MPSV od 2028, věcný záměr do 12/2029. Pilot společného rozpočtu v kraji, který se k pilotu přihlásí; Ověřit: termín a zda jde smluvně bez novely. Zákon ve vlně 4 (účinnost 2033 a později). Rozhodnutí o pojištění dlouhodobé péče do roku 2031.
Na čem závisí	Na MPSV a MF (zdroj sociálního účtu), na koaliční smlouvě (B2) a na datech o čekání na místo v sociální službě. Kapacita je podmínkou přeměny: kraj bez ní lůžka nepřemění (J7).

Karta P3	Sociální účet a sdílené financování sociálně-zdravotní péče
Rizika a pojistky	(1) Resorty se nedohodnou: pojistkou je pilot společného rozpočtu a účast MPSV v Řídicím výboru. (2) Sociální kapacita nevznikne: kontrolní body přeměny se nesplní a akutní lůžko se nepřemění, takže riziko nese tempo reformy, ne pacient. (3) Péče se přesune na rodiny: sociální účet je veřejně sledovaná položka, doplňují ho odlehčovací služby a koordinátor. (4) Podklad Deloitte je studie na zakázku poskytovatelů: vstupy je třeba nezávisle ověřit.

Ověřujeme

Pilíř 5: péče doma a paliativní týmy

Péče doma stojí na pěti krocích a zákon vyžaduje jen jeden z nich: delší a samostatnou indikaci domácí péče s účinností 1. 1. 2032. Ostatní kroky jdou úhradou, smlouvou a vyhláškou.

Krok	Co se mění	Nástroj	Termín (základní scénář)
1. Návštěvní služba týmu a senior taxi (J4 , pilíř 1)	Lékař a sestra preventivně navštěvují křehké seniory ve spádu; senior taxi stojí 0,34 mld. Kč ročně.	Pětiletá smlouva týmu (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.), obce	Pilot 2028–2029; dál podle zákona o primární péči (1. 1. 2032)
2. Delší a samostatná indikace domácí péče	Dnes indikuje praktik na tři měsíce, jiný lékař na 14 dnů (§ 22 zák. 48/1997 Sb.). Od 1. 1. 2026 smí sestra se specializovanou způsobilostí v domácí péči indikaci ošetřujícího lékaře upravit nebo doplnit, pokud to lékař v indikaci umožní (MZ ČR 2025, s. 121). Navrhujeme delší lhůtu a z tohoto kroku samostatnou indikaci sestrou se specializací. Úhradová vyhláška 2027 přidává domácí péči 8,5 %.	Zák. 48/1997 Sb. (§ 18, § 22; vlna 2); vyhl. 55/2011 Sb. pro činnosti sester (vlna 0)	Vyhláška 2028 (rozhodne dnešní MZ); zákon 1. 1. 2032
3. Mobilní paliativní tým v okrese	Dnes má úhradu přes 40 poskytovatelů; doporučení je jeden tým na 70 až 150 tisíc obyvatel. Model počítá 0,9 mld. Kč ročně jako plnou cenu všech 150 týmů (6 mil. Kč na tým); je to horní mez.	Úhrada pojišťoven, smlouva	Podnět do dohodovacího řízení o úhradách 2028 (do 30. 6. 2027); jinak úhradová vyhláška 2031
4. Společný plán péče a koordinátor	Plán týmu, pečovatelské služby a rodiny; koordinátor v týmu.	Hrazený výkon „plánování péče“ (vyhl. 134/1998 Sb.)	Podnět 1. 1. 2028; jinak úhradová vyhláška 2031
5. Podpora pečujících rodin	Odlehčovací, terénní a asistenční služby, edukace, kontakt na sestru mimo pracovní dobu, dlouhodobé ošetřovné. Hospodářská strategie PEER počítá s navýšením financování terénních a odlehčovacích služeb o 40 až 50 mld. Kč za deset let a s růstem částečných úvazků ze 7 % na 15 % do roku 2040.	MPSV, kraje, obce, pojišťovny	Navýšení je výdajem MPSV, krajů a obcí mimo model reformy. Ověřit: rozložení po letech a nositel

Ověřujeme

Samostatnou indikaci sestrou podporuje přehled přehledů, podle něhož je péče vedená sestrou stejně bezpečná nebo bezpečnější (Paier-Abuzahra 2024, PMID 39529012); úspora nákladů prokázána není (Laurant 2018). Navazujeme na prioritu ministra zdravotnictví, sesterskou preskripci, a návrh podáme jako pozměňovací návrh k vládní předloze.

Paliativní týmy: 0,9 mld. Kč je horní mez, protože úhradu už dnes má přes 40 poskytovatelů, a skutečný přírůstek bude nižší. Nedostatek paliativních lékařů řešíme náběhem od největších nemocnic a sdílením týmu v kraji, aby týmy nezůstaly jen na papíře.

Domov je možnost, ne povinnost. Kdo žije sám, nemá vhodné bydlení nebo si nepřeje zemřít doma, musí mít dostupnou odlehčovací službu, krizový příjem do pobytového zařízení a lůžkovou paliativní péči v hospici nebo na paliativním lůžku nemocnice blízko domova. Úspěch se proto neměří počtem úmrtí doma, ale souladem místa péče s přáním člověka a únosností péče pro pečující.

Pilíř 5: závěr života a dříve vyslovené přání

Doporučení pro plánování péče na konci života u nás existují od roku 2010 (Česká lékařská komora) a má je i Společnost pro paliativní medicínu, ale běžná praxe je nepoužívá. Problémem není chybějící návod, nýbrž že rozhovor o přáních pacienta nikdo nehradí a nikdo ho nezaznamenává tak, aby ho navázaný poskytovatel našel. Proto navrhujeme čtyři kroky bez nového zákona.

- **Hrazený výkon plánování péče.** Rozhovor praktika nebo sestry s křehkým pacientem a rodinou dostane vlastní kód a časový limit (úhradová vyhláška, totéž jako krok 4 v předchozí tabulce).
- **Konziliární paliativní tým v nemocnicích se 200 a více lůžky akutní péče.** Tým radí oddělením, nepřebírá pacienty a činnost se hradí jako konzilium. Začínáme největšími nemocnicemi, kde je nejvíc pacientů na konci života.
- **Nabídka plánu péče při hospitalizaci křehkého seniora.** Při příjmu pacienta ve splňujícím profilu (věk, křehkost, opakované příjmy) se nabízí rozhovor o přáních, nikdy se nevyžaduje.
- **Plán ve sdíleném záznamu a úhrada péče doma i v domách seniorů.** Plán vidí záchranná služba, ambulance i dům seniorů; úhrada paliativní péče v pobytových službách navazuje na kartu P3.

Dříve vyslovené přání upravuje § 36 zák. 372/2011 Sb. a pro nemocného je dnes obtížné ho platně vyslovit, nelze ho dohledat a poskytovatel je nemusí respektovat. Navrhujeme jednodušší ověření podpisu, centrální registr dostupný poskytovateli a povinnost přání respektovat, pokud se nezměnily okolnosti. Ověřit: přesné znění § 36 odst. 2 až 6 před předáním návrhu.

Ověřujeme

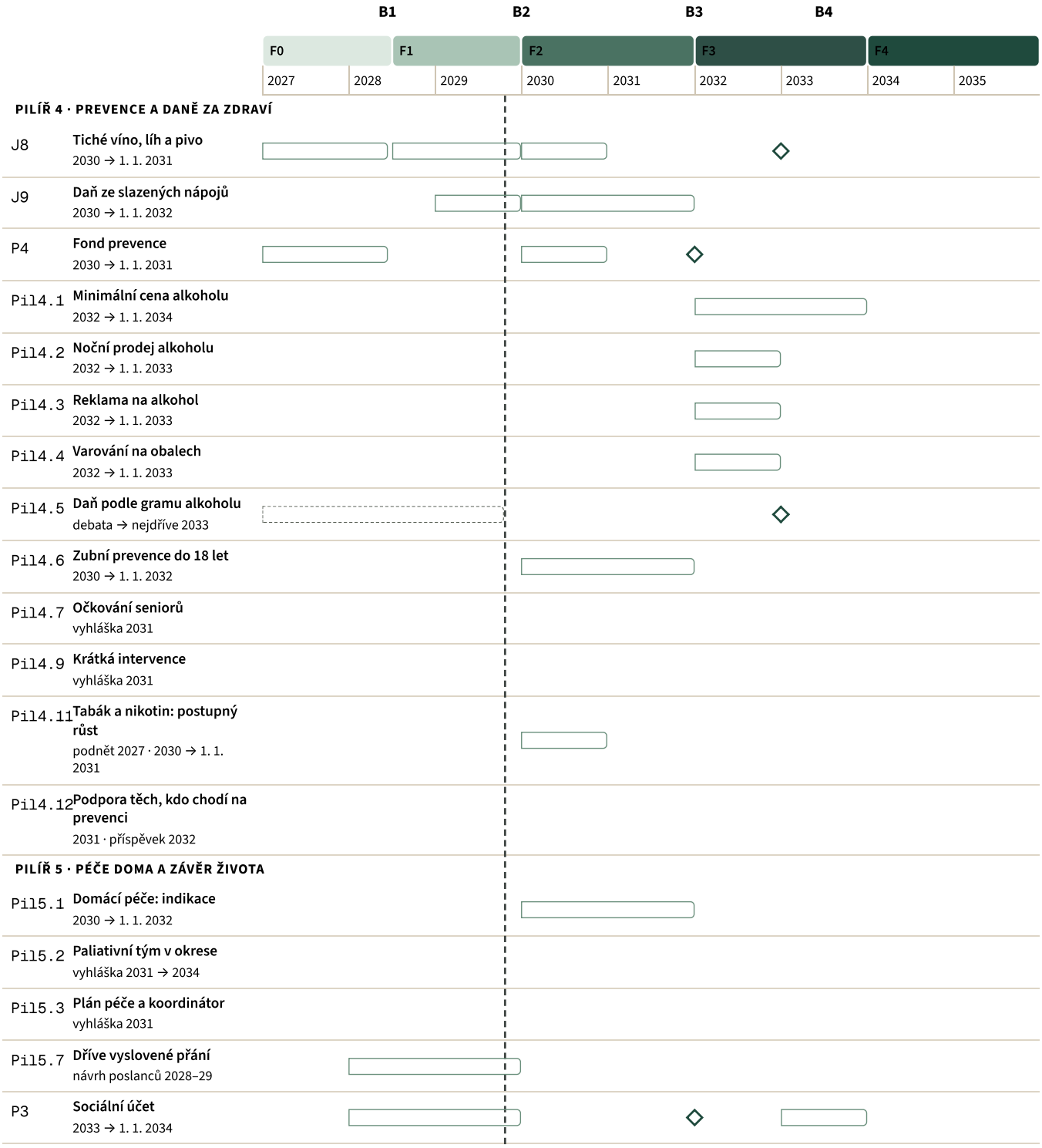
Zákonnou změnu podáme jako poslanecký návrh v letech 2028 až 2029 a nebudeme čekat na vládní novelu. Euthanasii záměrně neřešíme: je to samostatná etická debata, která by překryla praktické kroky, na kterých se lze dohodnout. K § 8a zák. 300/2025 Sb. viz kartu P3.

Riziko	Co se stává	Pojištění
Papírové týmy	Tým je ve smlouvě, ale nikoho nenavštěvuje.	Úhrada za úkon a vykazování místa přání pacientů; smlouva se neobnoví bez činnosti
Formalita	Plán se vyplní pro úhradu a nikdo ho neotevře.	Plán vidí záchranná služba a ambulance; kontrola vzorku záznamů
Nedostatek paliativních lékařů	Týmy se nepodaří obsadit.	Start v největších nemocnicích, sdílené týmy v kraji, výcvik sester
Tlak na pacienta	Rozhovor se vnímá jako nátlak na odmítnutí léčby.	Nabídka, nikdy povinnost; přání lze kdykoli změnit

Harmonogram pilířů 4 a 5

Daň z vína začíná platit 1. 1. 2031, cukerná daň navazuje 1. 1. 2032 a plná sazba vína 1. 1. 2033.

Daně za zdraví začnou platit v letech 2031 až 2033, z péče doma vyžaduje zákon jen jeden krok z pěti



podněty, konzultace, věcný záměr · začátek studie neuvádí · zákon: od předložení po účinnost · náběh

ohlášení, notifikace (pod pruhem) · účinnost (u vyhlášky rok) · ◇ další stupeň, rozhodnutí · ◇ nejdříve · brány B1 až B4

volby, říjen 2029

Pod názvem opatření je rok předložení zákona a den jeho účinnosti; u vyhlášek rok, na který platí.

Bez termínu ve studii, proto nejsou na ose: `Pil4.8` navigace po pozitivním screeningu; `Pil4.10` strava a pohyb; `Pil5.4` podpora pečujících rodin; `Pil5.5` konziliární paliativní tým v nemocnicích; `Pil5.6` nabídka plánu péče při hospitalizaci.

Textová verze

Opatření	Termín	Zdroj
J8 Tiché víno, líh a pivo	Předložit 2030, účinnost 1. 1. 2031; víno poloviční sazba 2031–2032, plná 1. 1. 2033	ř. 1002, 1044, 2491
J9 Daň ze slazených nápojů	Ohlášení v programu 2029; předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032; dvouleté ohlášení 2030–2031	ř. 1003, 1058, 2492
P4 Fond prevence	Teze do B1 (6/2028); předložit 2030, účinnost 1. 1. 2031; příjem z daně ze slazených nápojů od 1. 1. 2032	ř. 1004, 1080, 2497
Pil4.1 Minimální cena alkoholu	Notifikace 2031–2032; předložit 2032, účinnost 1. 1. 2034	ř. 1086, 2517
Pil4.2 Noční prodej alkoholu	Ověřit: dřívější poslanecký návrh; předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	ř. 1096, 2518
Pil4.3 Reklama na alkohol	Předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	ř. 1097, 2519
Pil4.4 Varování na obalech	Předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	ř. 1098, 2520
Pil4.5 Daň podle gramu alkoholu	Debata do voleb 2029; účinnost nejdříve 2033	ř. 1099, 2521
Pil4.6 Zubní prevence do 18 let	Zákon předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032	ř. 1107, 2522
Pil4.7 Očkování seniorů	Úhradová vyhláška nové vlády (2031)	ř. 1108, 2523
Pil4.9 Krátká intervence	Úhradová vyhláška nové vlády (2031)	ř. 1110, 2525
Pil4.11 Tabák a nikotin: postupný růst	Podnět současné vládě 2027; předložení 2030, účinnost 1. 1. 2031 (doplňkový scénář: prodloužení dnešního plánu od 2028)	ř. 1092 a násl., registr Pil4.11
Pil4.12 Podpora těch, kdo chodí na prevenci	S Národním fondem prevence od 1. 1. 2031; příspěvek za prevenci od 1. 1. 2032	ř. 1092 a násl., registr Pil4.12
Pil5.1 Domácí péče: indikace	Zákon předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032	ř. 1006, 1149, 1186, 2527
Pil5.2 Paliativní tým v okrese	Úhradová vyhláška 2031; náběh 2031–2034	ř. 1150, 2528
Pil5.3 Plán péče a koordinátor	Úhradová vyhláška 2031	ř. 1151, 2529
Pil5.7 Dříve vyslovené přání	Poslanecký návrh 2028–2029, závisí na většině	ř. 1171, 1186, 2533
P3 Sociální účet	Věcný záměr do 12/2029; předložit 2033, účinnost 1. 1. 2034; rozhodnutí o pojištění dlouhodobé péče do konce 2031	ř. 1005, 1138, 1186, 2496
Pil4.8 Navigace po pozitivním screeningu	Pilot s evaluací (start ověřit); výkon po pilotu	ř. 1109, 2524
Pil4.10 Strava a pohyb	Termín v textu neuveden (ověřit); vyhodnocení po třech letech	ř. 2526
Pil5.4 Podpora pečujících rodin	Ověřit	ř. 1152, 2530
Pil5.5 Konziliární paliativní tým v nemocnicích	Start v největších nemocnicích; termín neuveden	ř. 2531
Pil5.6 Nabídka plánu péče při hospitalizaci	Termín neuveden	ř. 2532

harmonogram pilířů 4 a 5 · základní scénář Vlády 2030

Zákony o daních a o fondu se předkládají v roce 2030, novela o indikaci domácí péče nabývá účinnosti 1. 1. 2032 a dříve vyslovené přání jde jako poslanecký návrh už v letech 2028 až 2029. Sociální účet (P3) se rozbíhá po roce 2033 a rozhodnutí o pojištění dlouhodobé péče padne do konce roku 2031.

Část IV — Co na co navazuje a proč

Reforma stojí na třech řetězcích, které musí doběhnout v letech 2031 až 2038 v pevném pořadí:

- **Peníze:** daně za zdraví a nový vzorec platby státu, obojí účinné 1. 1. 2031 → peníze na náběh týmů od roku 2032.
- **Primární péče:** sestry, data a pilot → pětiletá smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb. → zákon o primární péči účinný 1. 1. 2032.
- **Lůžka:** krajský plán sítě (první plány 2033), kapacita následné a dlouhodobé péče a dojezd záchranky → přeměna 8 000 akutních lůžek do roku 2038.

Kdo některý článek přeskočí, reformu nezrychlí. Ohrozí tím všechno, co na tom článku stojí.

Tato část je mapa celé reformy. Ukazuje, které z deseti opatření jádra (J1 – J10) a pěti podmínek (P1 – P5) musí přijít dřív než jiná, proč a co se stane, když jeden článek selže. Doprovodná opatření z Manifestu (Část XI) mají vlastní harmonogram, proto v grafech nejsou.

Termíny platí pro základní scénář „Vláda 2030“: Piráti ve vládě od přelomu 2029/2030, velké zákony předložené v letech 2030 a 2031. Fáze a brány B1 – B4 podrobně popisuje Část VIII, zákony po vlnách 0–4 Část VII.

Graf závislostí

Obě větve kritické cesty míří do let 2031 a 2032: peníze a sestry podmiňují náběh týmů, pilot a data podmiňují zákon o primární péči a lůžka čekají na dlouhodobou péči. Šipka v grafech znamená „bez A nejde B“, silná šipka leží na kritické cestě.

Peníze a sestry musí být na místě dřív, než týmy v roce 2032 naběhnou

Graf závislostí 1/2: peníze a lidé · šipka = bez A nejde B · silná šipka = kritická cesta

jádro (J1–J10) · podmínka (P1–P5) · zákon, krok nebo souhrn · výsledek · brána · kritická cesta · závislost

Textová verze

Uzly

- J8 Víno a valorizace: zák. 353/2003 Sb. · vlna 1; účinnost 1. 1. 2031
- J9 Slazené nápoje: nový zákon · vlna 1; přijat 2030, účinný 2032
- Daně za zdraví: plán 5 mld. Kč ročně (5–7); odvody z práce se nesnižují
- P4 Fond prevence: zákon o fondu · vlna 1; nejméně 40 %, aspoň 2 mld. Kč
- J10 Vzorec platby státu: § 3c zák. 592/1992 Sb. · vlna 1; účinnost 1. 1. 2031
- Peníze na týmy: kapitace a víceletá platba; 4,8–7,5 mld. Kč ročně
- P1 Personální bilance: po krajích, nábor ze zahraničí; a rychlejší aprobace
- J2 Sestry v týmech: sesterská složka · vlna 0; kompetence: vyhl. 55/2011 Sb.
- P2 Rezidenční místa: noví praktici pro dospělé; i pro děti (PLDD zůstávají)
- J3 Kompetence praktiků: preskripce, nové výkony (USG); seznam výkonů · vlna 0
- B3 Brána · 12/2031: polovina míst sester obsazena?
- Týmy sdružené péče: náběh od 1. 1. 2032: kolem roku 2038 asi 520 týmů; nesplněná B3 = varianta B bez center

Vazby (bez A nejde B)

- J8 Víno a valorizace → Daně za zdraví (kritická cesta)
- J9 Slazené nápoje → Daně za zdraví
- Daně za zdraví → P4 Fond prevence (2 mld. Kč)
- Daně za zdraví → J10 Vzorec platby státu (zbytek 3–5 mld. Kč) (kritická cesta)
- J10 Vzorec platby státu → Peníze na týmy (kritická cesta)
- Peníze na týmy → Týmy sdružené péče: náběh od 1. 1. 2032 (kritická cesta)
- P1 Personální bilance → J2 Sestry v týmech (kritická cesta)
- J2 Sestry v týmech → B3 Brána · 12/2031 (kritická cesta)
- B3 Brána · 12/2031 → Týmy sdružené péče: náběh od 1. 1. 2032 (ano → s centry; ne → varianta B) (kritická cesta)
- J3 Kompetence praktiků → Týmy sdružené péče: náběh od 1. 1. 2032
- P2 Rezidenční místa → Týmy sdružené péče: náběh od 1. 1. 2032

Podklad: studie v3, ř. 1188–1208 a 1224–1232 (Část IV); vlny podle ř. 85–95.

graf závislostí 1/2 · peníze a lidé · J8–J10, J2, J3, P1, P2, P4, brána B3

Peníze přicházejí dvěma cestami, ale kritická je jen jedna: nový vzorec platby státu. Daň ze slazených nápojů náběh nebrzdí, protože začne až rok po vlně 1. U lidí rozhoduje brána `B3`; když do 12/2031 nebude obsazena polovina míst sester, reforma pokračuje ve variantě B.

Zákon o primární péči stojí na pilotu, přeměna lůžek na dlouhodobé péči

Graf závislostí 2/2: péče a síť · šipka = bez A nejde B · silná šipka = kritická cesta

jádro (J1–J10) podmínka (P1–P5) zákon, krok nebo souhrn výsledek brána kritická cesta závislost

Textová verze

Uzly

- Dohoda o pilotu: kraj, VZP a obce do 6/2027; tři ORP v jednom kraji
- J1 Pětiletá smlouva: podle § 17 zák. 48/1997 Sb.; vlna 0, bez nového zákona
- J5 eŽádanka s triáží: novela zák. 325/2021 Sb.; měří čekání a lidi bez lékaře
- Pilot ve třech ORP: provoz 2028–2029; vyhodnocení 2029 a 2030
- J4 Návštěvy a doprava: návštěvní služba týmu; senior taxi s obcemi
- Data v reálném čase: registry pojišťoven, NRZP; podklad pro brány a HSPA (P5)
- Zákon o primární péči: nová hlava zák. 372/2011 Sb.; vlna 2, účinnost 1. 1. 2032
- Týmy sdružené péče: náběh od 1. 1. 2032; kolem roku 2038 asi 520 týmů
- B1–B4 Brány: B3 rozhodne o centrech; hodnotí ÚZIS s univerzitou
- Zákon o síti: přijat 2032 · vlna 3; účinný nejpozději 1. 1. 2033
- P3 Sociální účet: sdílené financování; zák. 108/2006 Sb. · vlna 4
- Dojezd záchranky: plán pokrytí ZZS; zák. 374/2011 Sb. · vlna 3
- J6 Krajský plán sítě: 10 let, čtyři skupiny lůžek; první krajské plány 2033
- J7 Dlouhodobá péče: do 2035 chybí asi 39 000 lůžek; a asi 21 000 pečovatelů
- Přeměna 8 000 lůžek: z 48 036 na asi 40 000 do 2038; fond přeměny 5–10 mld. Kč; stop při obsazenosti nad 85 %

Vazby (bez A nejde B)

- Dohoda o pilotu → Pilot ve třech ORP (kritická cesta)
- J1 Pětiletá smlouva → Pilot ve třech ORP (kritická cesta)
- Pilot ve třech ORP → Zákon o primární péči (kritická cesta)
- Zákon o primární péči → Týmy sdružené péče (kritická cesta)
- J4 Návštěvy a doprava → Týmy sdružené péče
- J5 eŽádanka s triáží → Data v reálném čase (kritická cesta)
- Data v reálném čase → B1–B4 Brány (kritická cesta)
- B1–B4 Brány → Týmy sdružené péče (kritická cesta)
- Zákon o síti → J6 Krajský plán sítě (kritická cesta)
- J6 Krajský plán sítě → Přeměna 8 000 lůžek (kritická cesta)
- J7 Dlouhodobá péče → Přeměna 8 000 lůžek (kritická cesta)
- P3 Sociální účet → J7 Dlouhodobá péče
- Dojezd záchranky → Přeměna 8 000 lůžek (kritická cesta)

Podklad: studie v3, ř. 1188–1210 a 1212–1240 (Část IV); vlny 0–3 ř. 77–99.

graf závislostí 2/2 · péče a síť · J1, J4–J7, P3, zákony vln 0–3, brány

V primární péči vede kritická cesta přes dohodu o pilotu do 6/2027, smlouvu a pilot k zákonu účinnému 1. 1. 2032; data z eŽádanky a registrů pojišťoven živí brány. V síti lůžek se přeměna nehne, dokud nejsou splněny tři podmínky najednou: krajský plán, kapacita dlouhodobé péče a dojezd záchranky. Přeměna zároveň navazuje na týmy, které od roku 2032 snižují počet odvratitelných hospitalizací.

Proč nejdřív A, pak B

Šest řetězců určuje, kdy může reforma doručit první výsledky; každý má svůj důvod, který se nedá obejít politickou vůlí.

Proč věcné záměry píšeme v opozici

Velká předloha trvá od věcného záměru po účinnost 24 až 42 měsíců, střední novela 11 až 21 měsíců. Má-li zákon o primární péči platit od 1. 1. 2032, musí ho vláda předložit v roce 2030. To jde jen s věcným záměrem hotovým v den nástupu vlády.

Věcné záměry zákona o primární péči, zákona o síti, finanční novely a daňových zákonů proto vznikají ve fázi F1 (7/2028–12/2029) s resortním týmem a Institutem Pi. Kontrolním bodem je brána B2 : jádro v koaliční smlouvě a předlohy v legislativním plánu vlády na rok 2030.

Druhým důvodem je kapacita ministerstva. Za jedno volební období realisticky zvládne dvě velké předlohy (zákon o primární péči a zákon o síti) a čtyři až šest menších. Na 1. 1. 2029 reformní zákony neklademe: ten den naběhne strop podle § 22b zák. 48/1997 Sb. ze zák. 38/2025 Sb. a v říjnu 2029 budou volby.

Proč smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb. dřív než nová hlava zákona

Pětiletou smlouvu týmu s pojišťovnou lze uzavřít už dnes, dodatkem smlouvy podle § 17 zák. 48/1997 Sb. Sesterská složka a nové výkony mohou přijít úhradovou vyhláškou a seznamem výkonů od 1. 1. 2028, pokud je MZ převezme z dohodovacího řízení končícího 30. 6. 2027. Smlouva tak spustí týmy o čtyři roky dřív, než začne platit zákon.

Nová hlava zák. 372/2011 Sb. (vlna 2) pak ukotví to, co smlouva vyzkoušela: definici týmu, minimální funkce, spádové území a víceletou smlouvu se všemi pojišťovnami. Obrácené pořadí by znamenalo psát standard naslepo. Smlouva navíc zůstává náhradní cestou, kdyby se zákon zdržel.

Proč pilot před zákonem

Pilot ve třech ORP běží v letech 2028 a 2029, pokud se kraj, který se k pilotu přihlásí, a VZP dohodnou do 6/2027. Průběžné vyhodnocení po roce provozu se promítne do paragrafového znění. Závěrečné vyhodnocení v roce 2030 přijde během projednávání ve Sněmovně.

Zákon o primární péči proto může být účinný nejdřív 1. 1. 2032. Verze 2 ho kladla na rok 2029, tedy půl roku po startu pilotu, a nestál by na žádných domácích datech. Nezávislý hodnotitel je jmenován před startem pilotu, aby výsledky nehodnotil ten, kdo pilot navrhl.

Proč daně, vzorec platby státu a sestry před náběhem týmů

Platby týmům stojí v plném náběhu 4,8 až 7,5 mld. Kč ročně, sestry jsou samostatná položka (viz Část V). Proto vlna 1 nabývá účinnosti 1. 1. 2031, rok před zákonem o primární péči: nový vzorec platby státu (§ 3c zák. 592/1992 Sb.), daň z tichého vína a valorizace daní z lihu a piva. Daň ze slazených nápojů je přijata v roce 2030 a účinná od 1. 1. 2032, aby výrobci měli čas změnit receptury.

Daně za zdraví mají plánovací výnos 5 mld. Kč ročně (rozpětí 5–7). Fond prevence z nich dostane podle pravidla PEER nejméně 40 %, nejméně 2 mld. Kč, a zbytek, 3 až 4,2 mld. Kč, zvyšuje platbu státu do zdravotního pojištění; odvody z práce nesnižuje. Dřív než v roce 2031 to nejde: pevný vyměřovací základ z tisku 235 platí pro rok 2027 a nový vzorec může přijmout až nová vláda.

Druhou podmínkou jsou lidé. Ročně dnes dokončí studium ošetřovatelství asi 680 absolventů vysokých a asi 570 vyšších odborných škol, jen nových všeobecných sester je přitom za 10 až 12 let potřeba nejméně 24 000 úvazků (MZ ČR 2025, s. 112 a 114) a praktiků pro dospělé ubývá 110 až 180 ročně. Bez personální bilance po krajích (`P1`), rezidenčních míst (`P2`) a širších kompetencí sester a praktiků (`J2` , `J3`) nemají týmy koho zaměstnat.

Proč data v reálném čase před branami

Většina ukazatelů ÚZIS a OECD vychází se zpožděním jednoho až tří let, hodnotu za rok 2031 bychom znali nejdřív v roce 2033. Brána `B3` (12/2031) přitom rozhoduje, zda se staví centra, nebo reforma přejde na variantu B. Musí proto stát na datech, která existují hned: registrech pojišťoven, Národním registru zdravotnických pracovníků (NRZP) a eŽádance.

eŽádanka s triážním údajem (`J5`) je proto první krok, ne poslední. Triážní pole navrhne poslanecký klub pozměňovacím návrhem k vládní novele zák. 325/2021 Sb.; neprojde-li, přijde ve vlně 2. Pravidlo zní: žádná brána bez dat, a chybějí-li data, brána se odkládá.

Proč kapacita dlouhodobé péče před přeměnou akutních lůžek

Senior, který nemá kam odejít, zůstane na akutním lůžku, a přeměna bez náhradní kapacity jen přesune frontu. Lůžka následné péče jsou dnes obsazená z 84 % a do roku 2035 bude potřeba asi 39 000 nových zdravotních i sociálních lůžek dlouhodobé a následné péče (Přecechtěl a Hlávka 2025) a 21 000 pečovatelů (studie pro APSS ČR 2026). Akutní lůžko se proto nepřemění, dokud kraj neprokáže kapacitu následné a dlouhodobé péče (`J7`) a dojezd záchranné služby.

Přeměna začne s prvními krajskými plány sítě v roce 2033 a do roku 2038 se týká 8 000 lůžek (z 48 036 na asi 40 000). Jde až za primární péčí, protože počítá s tím, že týmy od roku 2032 sníží počet odvratitelných hospitalizací. Obsazenost akutních lůžek nad 85 % přeměnu v daném kraji zastaví; vyšší obsazenost souvisí s vyšší úmrtností (Madsen 2014: +9 %).

Sdílené financování sociálně-zdravotní péče (`P3`) přijde zákonem až ve vlně 4. Do té doby se proto akutní lůžka přeměňují hlavně na lůžka následné a dlouhodobé péče hrazená ze zdravotního pojištění.

Co když se to nepovede

Každé ze 13 rizik níže má předem dohodnutou náhradní cestu, takže selhání jednoho článku reformu nezastaví. Platí čtyři pravidla rozhodování: žádná brána bez dat; neúspěch nástroje zastaví jen ten nástroj; nesplněná brána `B3` znamená variantu B; akutní lůžko se nepřemění bez prokázané kapacity následné a dlouhodobé péče a dojezdu.

Co se nepovede	Co to ohrozí	Náhradní cesta
Kraj, VZP a obce se do 6/2027 nedohodnou na pilotu	Zákon o primární péči bez domácích dat; brána B1	Náhradní smluvní model u jedné pojišťovny (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.); vyhodnotit týmové praxe z úhradové vyhlášky
Sesterská složka nebude v úhradové vyhlášce 2028 (rozhoduje dnešní MZ)	Sestry v týmech před rokem 2031	Sestry v pilotu platit dodatkem smlouvy; podnět znovu do dohodovacího řízení; úhradová vyhláška 2031 nové vlády
eŽádanka bez triážního údaje (pozměňovací návrh neprojde)	Měření čekání, měkký gatekeeping, data pro brány	Triážní údaj ve vlně 2 (novela zák. 325/2021 Sb.); do té doby data z registrů pojišťoven a NRZP
Nový vzorec platby státu nebude přijat k 1. 1. 2031	Peníze na náběh týmů od 2032	Reforma se zmenší na variantu B; týmy, sestry, prevence, paliativa, konzultace a fond přeměny zůstávají
Daně za zdraví nepřinesou plánovaných 5 mld. Kč	Fond prevence a přírůstek platby státu	Fond dostane přednostně své 2 mld. Kč a menší je přírůstek platby státu; veřejně slibujeme jen plánovací hodnotu
Do 12/2031 není obsazena polovina míst sester v týmech první vlny (B3)	Centra primární péče	Varianta B: týmy bez center; vše, co na centrech nezávisí, běží dál
Zákon o primární péči se zpozdí	Standard týmu a víceletá smlouva se všemi pojišťovnami	Smlouvy podle § 17 zák. 48/1997 Sb. pokračují; standard týmu ve Věstníku MZ
Zákon o síti se zpozdí nebo neobstojí v ústavním rozboru	Krajské plány sítě a fond přeměny	Dnešní nástroje: výběrová řízení pojišťoven (§ 46 zák. 48/1997 Sb.), NV 307/2012 Sb., minimální objemy ve Věstníku jako u onkochirurgie
Kraj neprokáže kapacitu následné a dlouhodobé péče nebo dojezd	Přeměnu akutních lůžek v tom kraji	Přeměna stojí; akutní lůžka přednostně na následná a dlouhodobá v téže nemocnici
Obsazenost akutních lůžek v kraji přesáhne 85 %	Bezpečnost pacientů	Přeměna v kraji se zastaví, dokud obsazenost neklesne
Rezidenční místa a nábor ze zahraničí nestačí na úbytek praktiků	Počet týmů, území bez praktika	Kompetence sester a praktiků (J2 , J3); děti na venkově registrované u praktika pro dospělé v týmu
Věcné záměry nebudou hotové do brány B2	Účinnost velkých zákonů 2032	Priorita dvěma velkým zákonům; institut HTA nahradit rozšířením mandátu SÚKL a ÚZIS
HSPA se nedostane do zákona (P5)	Pravidelné nezávislé hodnocení	Nezávislý hodnotitel (ÚZIS + univerzita) na základě smlouvy s MZ; zpráva před bránou B4

Kdo plánuje, platí a řídí: dnes a po reformě

Dnes za cestu pacienta systémem neodpovídá nikdo a šest děr má společný kořen: plán, peníze a péče patří různým institucím. Organigramy ukazují, kdo v systému plánuje, kdo platí a kdo řídí. Řízení samotné reformy (řídicí výbor, projektová kancelář reformy) popisuje Část VIII.

Dnes za cestu pacienta neodpovídá nikdo: plán, platba a péče jsou oddělené

Kdo v systému plánuje, platí a řídí, stav 2026 · čísla v kroužku jsou díry

PRAVIDLA A ROZPOČTY

MZ 6
zákony, vyhlášky, úhrady
Věstník, seznam výkonů

MF
státní rozpočet
platí za státní pojištěnce

MPSV
sociální služby
příspěvek na péči

PLATBA

Zdravotní pojišťovny: VZP a šest zaměstnaneckých 5
správní rady · roční úhrady a smlouvy s poskytovateli · fondy prevence
výběrová řízení podle § 46 zák. 48/1997 Sb.

VLASTNICTVÍ A PLÁN

Kraje
vlastní nemocnice a záchrannou službu
oprávnění, plán sociálních služeb

Obce
budovy ordinací, sociální služby
některé vlastní nemocnice

DATA A DOHLED

ÚZIS 3
statistiky NZIS se zpožděním 1–3 roky
čekání na péči se neměří

SÚKL
registrace, ceny a úhrady léků
dozor nad léčivy

PÉČE

Praktický lékař, většinou sám 4
soukromá praxe · kapitace a výkony · sestra jen někde
praktiků pro dospělé ubývá 110 až 180 ročně

Specialisté
soukromé ambulance
platba za výkony

Nemocnice 1
kraje, stát, obce,
soukromí vlastníci

Sociální služby 2
jiný rozpočet
a jiná dokumentace

ČLOVĚK

Pacient
platí pojistné (za státní pojištěnce stát) a cestu systémem hledá sám

Kde systém selhává

1. Síť lůžek nikdo neplánuje jako celek: kraj vlastní, pojišťovna nasmlouvá, MZ reguluje.
2. Zdravotní a sociální péče mají dva rozpočty a dvě ministerstva; senior uvízne mezi nimi.
3. Data přicházejí se zpožděním 1–3 roky a čekání na péči se neměří.
4. Za lidi bez praktika neodpovídá nikdo; cestu systémem si pacient hledá sám.
5. Prevence je rozdrobená ve fondech prevence sedmi pojišťoven.
6. Výkonnost systému nikdo nezávisle a pravidelně nehodnotí.

instituce **1** díra: chybějící vazba nebo odpovědnost

Textová verze

Pravidla a rozpočty: MZ: zákony, vyhlášky, úhrady; Věstník, seznam výkonů (díra 6) · MF: státní rozpočet; platí za státní pojištěnce · MPSV: sociální služby; příspěvek na péči
Platba: Zdravotní pojišťovny: VZP a šest zaměstnaneckých: správní rady · roční úhrady a smlouvy s poskytovateli · fondy prevence; výběrová řízení podle § 46 zák. 48/1997 Sb. (díra 5)
Vlastnictví a plán: Kraje: vlastní nemocnice a záchrannou službu; oprávnění, plán sociálních služeb · Obce: budovy ordinací, sociální služby; některé vlastní nemocnice
Data a dohled: ÚZIS: statistiky NZIS se zpožděním 1–3 roky; čekání na péči se neměří (díra 3) · SÚKL: registrace, ceny a úhrady léků; dozor nad léčivy
Péče: Praktický lékař, většinou sám: soukromá praxe · kapitace a výkony · sestra jen někde; praktiků pro dospělé ubývá 110 až 180 ročně (díra 4) · Specialisté: soukromé ambulance; platba za výkony · Nemocnice: kraje, stát, obce,; soukromí vlastníci (díra 1) · Sociální služby: jiný rozpočet; a jiná dokumentace (díra 2)

Člověk: Pacient: platí pojistné (za státní pojištěnce stát) a cestu systémem hledá sám

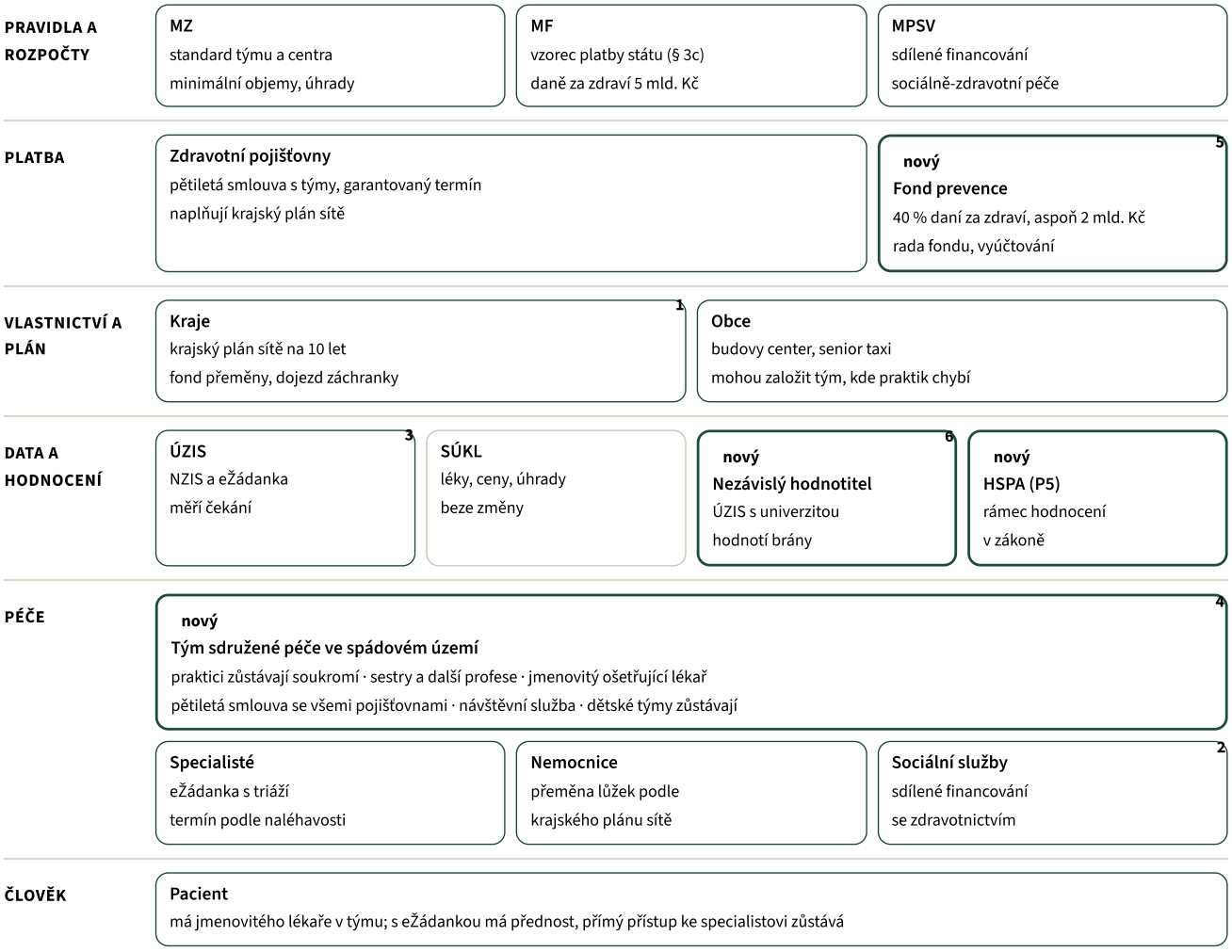
Podklad: studie v3, ř. 1280–1286; díry vycházejí z tabulky problém → příčina ř. 348–362 a z ř. 882–884, 1222.

organigram · dnes (2026) · 6 vrstev, 6 děr

Díry nevznikly chybou jedné instituce. Každá dělá svou práci, ale nikdo nemá za úkol celek, a proto se stav nedá opravit jedním zákonem.

Po reformě péči řídí tým ve spádu a síť lůžek plánuje kraj

Kdo plánuje, platí a řídí kolem roku 2038 · čísla v kroužku = díra, kterou prvek zavírá



Textová verze

Nové prvky: tým sdružené péče, Fond prevence, nezávislý hodnotitel, HSPA jako zákonný rámec hodnocení.

Pravidla a rozpočty: MZ: standard týmu a centra; minimální objemy, úhrady (mění se úloha) · MF: vzorec platby státu (§ 3c); daně za zdraví 5 mld. Kč (mění se úloha) · MPSV: sdílené financování; sociálně-zdravotní péče (mění se úloha)

Platba: Zdravotní pojišťovny: pětiletá smlouva s týmy, garantovaný termín; naplňují krajský plán sítě (mění se úloha) · Fond prevence: 40 % daní za zdraví, aspoň 2 mld. Kč; rada fondu, vyúčtování (nový prvek, zavírá díru 5)

Vlastnictví a plán: Kraje: krajský plán sítě na 10 let; fond přeměny, dojezd záchranky (mění se úloha, zavírá díru 1) · Obce: budovy center, senior taxi; mohou založit tým, kde praktik chybí (mění se úloha)

Data a hodnocení: ÚZIS: NZIS a eŽádanka; měří čekání (mění se úloha, zavírá díru 3) · SÚKL: léky, ceny, úhrady; beze změny (beze změny) · Nezávislý hodnotitel: ÚZIS s univerzitou; hodnotí brány (nový prvek, zavírá díru 6) · HSPA (P5): rámec hodnocení; v zákoně (nový prvek)

Péče: Tým sdružené péče ve spádovém území: praktici zůstávají soukromí · sestry a další profese · jmenovitý ošetřující lékař; pětiletá smlouva se všemi pojišťovnami · návštěvní služba · dětské týmy zůstávají (nový prvek, zavírá díru 4) · Specialisté: eŽádanka s triáží; termín podle naléhavosti (mění se úloha) · Nemocnice: přeměna lůžek podle; krajského plánu sítě (mění se úloha) · Sociální služby: sdílené financování; se zdravotnictvím (mění se úloha, zavírá díru 2)

Člověk: Pacient: má jmenovitého lékaře v týmu; s eŽádankou má přednost, přímý přístup ke specialistovi zůstává (mění se úloha)

Podklad: studie v3, ř. 1288–1290 (čtyři nové prvky); úlohy institucí podle Části III a VIII.

organigram · cílový stav kolem 2038 · 4 nové prvky

Reforma nestaví nad systém nový řídicí úřad. Mění úlohy těch, kdo už existují: kraj plánuje síť, pojišťovna uzavírá pětiletou smlouvu, stát platí za státní pojištěnce podle vzorce. Nové jsou čtyři prvky: tým sdružené péče, Fond prevence, nezávislý hodnotitel a HSPA jako zákonný rámec hodnocení. Každá z šesti děr tak má svého vlastníka.

Toky peněz dnes a po reformě

Reforma v plném náběhu kolem roku 2038 přidává do systému tři nové fondy a jeden nový zdroj, daně za zdraví ve výši 5 mld. Kč ročně; odvody z práce se nemění. Hlavní tok zůstává stejný: pojistné a platba státu jdou přes zdravotní pojišťovny k poskytovatelům.

Reforma přidává tři nové fondy a jeden nový zdroj, odvody z práce nemění

Toky peněz dnes a po reformě · částky v mld. Kč ročně, ceny 2026

DNES

PO REFORMĚ, PLNÝ NÁBĚH KOLEM ROKU 2038

Kdo zaplatí 21,5 mld. Kč ročně (2038) = provoz 22,8 − úspory 1,2

Stát: vyšší platba za děti, důchodce a studenty	**13 mld. Kč**
Stát: přímé výdaje (řízení, fond přeměny, sledování na dálku)	**2,6 mld. Kč**
Daně za zdraví: do zdravotního pojištění	**3 mld. Kč**
Daně za zdraví: Fond prevence	**2 mld. Kč**
Obce a kraje: odvoz k lékaři, provoz center	**1 mld. Kč**

Model studie v3. Vyšší platba státu nejsou nové peníze, ale přesun ze státního rozpočtu.

nový prvek · mění se · beze změny · nový tok · dnešní tok

Textová verze

Dnes: zdroje, prostředníci a příjemci

- Pojistné z práce: zaměstnanci, zaměstnavatelé a OSVČ
- Státní rozpočet: platba za státní pojištěnce; 2 188 Kč měsíčně (2026)
- Spotřební daně: líh, pivo, tabák; do rozpočtu bez vazby na zdraví
- MPSV, kraje, obce a klienti: příspěvek na péči, dotace
- Zdravotní pojišťovny: výdaje 2026: 570,8 mld. Kč; roční úhrady podle vyhlášky
- Praktici: kapitace a výkony; úhrady na jeden rok
- Specialisté a nemocnice: výkony, DRG, paušály; akutní lůžka 29,7 % úhrad
- Prevence: fondy prevence pojišťoven; bez společných cílů
- Sociální služby: jiný rozpočet; bez vazby na zdravotní péči

Dnešní toky

- Pojistné z práce → Zdravotní pojišťovny
- Státní rozpočet → Zdravotní pojišťovny
- Spotřební daně → Státní rozpočet
- Zdravotní pojišťovny → Praktici
- Zdravotní pojišťovny → Specialisté a nemocnice
- Zdravotní pojišťovny → Prevence
- MPSV, kraje, obce a klienti → Sociální služby (dva oddělené rozpočty)

Po reformě, plný náběh kolem roku 2038

- Pojistné z práce: beze změny; odvody z práce se nesnižují
- Státní rozpočet: nový vzorec § 3c od 2031; reforma: asi 180 Kč měsíčně
- Daně za zdraví: 5 mld. Kč ročně (5–7); 2 do fondu prevence, 3 do platby státu
- MPSV, kraje, obce a klienti: mimo zdravotní pojištění
- Zdravotní pojišťovny: pětiletá smlouva s týmy; naplňují krajský plán sítě
- Fond přeměny: investice 5–10 mld. Kč jednorázově; garance asi 1 mld. Kč, 2033–2040
- Fond prevence pojišťoven: nejméně 40 % daní za zdraví
- Sociální účet: sdílené financování; se zdravotnictvím, vlna 4
- Týmy sdružené péče: kapitace a víceletá platba; navíc asi 6 mld. Kč (4,8–7,5)
- Specialisté a nemocnice: přeměna 8 000 lůžek; akutní lůžka 26 % úhrad
- Prevence: screening, očkování 1,3 mld. Kč; komunitní programy 0,7 mld. Kč
- Sociálně-zdravotní péče: péče doma, dlouhodobá; a paliativní péče

Toky po reformě

- Pojistné z práce → Zdravotní pojišťovny
- Státní rozpočet → Zdravotní pojišťovny
- Zdravotní pojišťovny → Specialisté a nemocnice

- Daně za zdraví → Státní rozpočet (nový tok)
- Daně za zdraví → Fond prevence pojišťoven (nový tok)
- Státní rozpočet → Fond přeměny (nový tok)
- MPSV, kraje, obce a klienti → Sociální účet (nový tok)
- Zdravotní pojišťovny → Týmy sdružené péče (nový tok)
- Fond přeměny → Specialisté a nemocnice (nový tok)
- Fond prevence pojišťoven → Prevence (nový tok)
- Sociální účet → Sociálně-zdravotní péče (nový tok)

Podklad: studie v3, ř. 1292–1300; Část V: výdaje v. z. p. ř. 1366, platba státu ř. 1446, zdroje ř. 1442, fond přeměny ř. 1334, prevence ř. 1330–1331.

toky peněz dnes a po reformě · částky z ekonomického modelu v3 (Část V), ceny 2026

Změny jsou tři. Peníze na týmy jdou pětiletou smlouvou místo roční úhrady, prevence má vlastní fond s pevným příjmem a přeměna lůžek má vlastní fond s milníky. Sociální účet dlouhodobé péče stojí mimo zdravotní pojištění i mimo čistý náklad reformy; jeho růst a zdroje rozebírá Část V.

Vyšší platba státu není nový zdroj veřejných financí, ale přesun ze státního rozpočtu. Za samotnou reformu jde asi o 13 mld. Kč, tedy asi 180 Kč měsíčně za státního pojištěnce; 100 Kč měsíčně znamená 7,2 mld. Kč ročně. Celou tabulku platby státu, včetně automatického růstu o 11,7 mld. Kč při vyšší sazbě, obsahuje Část V.

Část V — Peníze a lidé

Reforma bude v plném náběhu kolem roku 2038 stát čistě asi 21,5 mld. Kč ročně (rozpětí 15 až 25 mld. Kč, ceny 2026), tedy necelá 4 % dnešních výdajů zdravotního pojištění. Mezera v příjmech, kterou přinese hlavně stárnutí, je přitom víc než trojnásobná: 70 mld. Kč v roce 2038 při dnešních pravidlech. Reforma odpovídá na to, jakou péči za rostoucí výdaje dostaneme; mezeru řeší pravidla příjmů.

Proti verzi 2 (17,2 mld. Kč) je číslo vyšší a poctivější. Platby týmům jsou rozpočítané (6,1 místo 2,5 mld. Kč), úspory jsou spočtené bez překryvů a model počítá s tím, že praktiků ubývá. Všechny částky jsou v cenách a při velikosti ekonomiky roku 2026, pokud není řečeno jinak.

Kolik stojí provoz

Provoz reformy včetně rezervy stojí v roce 2038 asi 22,8 mld. Kč a v roce 2050 asi 28,5 mld. Kč. Do modelu patří jen to, co přibude; praktici, většina sester a dnešní ordinace už v systému jsou. Největší položky jsou platby týmům a sestry navíc.

Položka (mld. Kč ročně)	2038	2050	Z čeho vychází
Sestry navíc v týmech	3,97	9,55	4 000 sester (2038), 9 600 (2050) × 0,998 mil. Kč; plat 62 177 Kč (ISPV 2025, platová sféra), odvody 33,8 %
Platby týmům: lékařská složka	3,73	4,22	příplatek ke kapitaci 38 Kč na registrovaného a měsíc (33–44) × 8,2 mil. registrovaných v týmech (75 % populace; 2050: 85 %)
Platby týmům: odměna za výsledky	1,60	1,81	strop 10 % úhrad praktiků pro dospělé (21,7 mld. Kč) = 2,2; střed při plnění asi 75 %
Platby týmům: příplatek za návštěvy	0,80	1,05	160 000 křehkých pacientů × 5 návštěv × 1 000 Kč; 2050 úměrně růstu lidí 75+ s vysokou potřebou péče
Pohotovost a prodloužená ordinační doba	0,75	0,75	odhad v2; mimo lékařskou složku
Další profese (nutriční terapeut, fyzioterapeut, 0,75 psychologa, 1,5 recepce)	1,73	1,73	520 týmů × 4,25 úvazku, asi 3,3 mil. Kč na tým
Provoz center, pokud obec dotuje nájem	0,53	0,53	300 budov (150 nových, 150 rekonstruovaných) × 1,75 mil. Kč
Kompetence praktiků: nové výkony, ultrazvuk, vzdělávání (J3)	0,50	0,50	odhad; samostatné opatření
Senior taxi	0,34	0,34	205 ORP × 1,5 vozu × 1,1 mil. Kč
Zapisovatel a dálkové sledování	0,66	0,66	5 630 praktiků × 2 300 Kč měsíčně + 0,5 mld. Kč na aplikaci a přístroje
Paliativní týmy	0,90	0,90	150 týmů × 6 mil. Kč; horní mez, přes 40 poskytovatelů už úhradu má
Prevence z Fondu prevence: screening, navigace, očkování, dentální prevence	1,30	1,30	odhad v2
Prevence z Fondu prevence: komunitní programy	0,70	0,70	zbytek 2 mld. Kč fondu při plánovací hodnotě
Konzultace lékař–lékař, zpětná zpráva, přímé objednání	1,50	1,50	3 mil. žádanek × 300 Kč + 1,5 mil. konzultací × 400 Kč
Koordinace reformy (projektová kancelář, nezávislé hodnocení)	0,40	0,40	odhad
Fond přeměny: garance příjmu nemocnic	1,31	0	4 000 lůžek v tříleté garanci × 1 500 Kč/den × 60 % obložnost
Provoz celkem	20,71	25,95	
Rezerva 10 % (IT, vzdělávání, vybavení, rezidenční místa, nábor)	2,07	2,59	odhad
Provoz včetně rezervy	22,78	28,54	

Proti verzi 2 se změnilo pět věcí. Platby týmům jsou rozpočítané, prevence obsahuje i komunitní programy, kompetence praktiků jsou samostatná položka a provoz center počítá s 300 budovami jako tabulka investic (ne se 400). Sester je méně, protože model odvozuje lékaře v týmech z úbytku praktiků. Model počítá s platovou úrovní sester, protože sestra z nemocnice za mzdový medián ambulance (44 218 Kč) nepřejde.

Platby týmům rozpočítané. Položka 2,5 mld. Kč z verze 2 nemohla pokrýt tři složky platby. Lékařská složka je příplatek ke kapitaci za registrovaného v týmu: 38 Kč měsíčně dává 3,7 mld. Kč, tedy asi 74 000 Kč měsíčně na lékaře v týmu. To odpovídá dnešní záloze týmové praxe (až 200 000 Kč měsíčně na praxi se třemi úvazky). Odměna za výsledky má strop 10 % úhrad praktiků pro dospělé (2,2 mld. Kč) a vyplácí se podle ukazatelů kvality a kontinuity. Příplatek za návštěvy hradí domácí návštěvy křehkých pacientů. Celkem 6,1 mld. Kč ročně, rozpětí 4,8 až 7,5 mld. Kč.

Co už je v plánu MZ. Implementační plán MZ č. 2.1 (prosinec 2025) počítá s asi 10 mld. Kč ze zdravotního pojištění na podporu praxí do roku 2030 a s 2 mld. Kč ze státního rozpočtu. Pokud se podpora týmových praxí udrží v úhradové vyhlášce i po roce 2030, lékařská složka ji nahradí a náklad reformy nad plán MZ klesne asi o 2 mld. Kč (na 19,5 mld. Kč). Model počítá plnou částku. Projekce NRR stojí na demografii a nedemografickém růstu nákladů, ne na jednotlivých opatřeních, takže plán MZ v ní samostatně vidět není.

Ověřit: rozložení 10 mld. Kč z implementačního plánu 2.1 po letech.

Ověřujeme

Mimo provoz, ale v dohledu. Výkup praxí odcházejících lékařů (0,3 až 0,6 mld. Kč ročně) je transfer mezi lékaři hrazený z kapitace, ne nový náklad. Sociální účet dlouhodobé péče je samostatný účet mimo zdravotní pojištění (viz Lidé níže).

Úspory bez překryvů

Reforma ušetří v roce 2038 asi 1,2 mld. Kč a v roce 2050 asi 3,6 mld. Kč ročně. Verze 2 počítala 1,7 a 4,1 mld. Kč, ale tři položky se překrývaly: hospitalizace pro srdeční selhání jsou podmnožinou odvratitelných hospitalizací (ACSC) a ty jsou podmnožinou všech hospitalizací. Model proto počítá hierarchicky a každá úroveň započítá jen případy, které nezapočítala úroveň pod ní.

Úroveň (mld. Kč ročně)	2038	2050	Výpočet
Srdeční selhání: dálkové sledování	0,24	0,24	32 600 hospitalizací × 50 % v monitoringu × −20 % = 3 260 případů × 73 600 Kč
Ostatní odvratitelné hospitalizace: týmy a sestry pro chroniky	0,11	0,33	mezera Česko 592 vs. OECD 473 na 100 tisíc obyvatel 15+ = 11 080 případů; dorovnáme 50 % (2038) a 75 % (2050), tedy 4 900 a 8 310 případů, minus 3 260 u srdečního selhání; 65 000 Kč za případ
Ostatní hospitalizace: přeměna lůžek a ambulantizace	0,90	3,08	mezera 17 990 vs. 14 600 na 100 tisíc = 369 500 případů; ubude 10 % (2038) a 30 % (2050), minus odvratitelné; 60 000 Kč za případ, polovinu spotřebuje následná a domácí péče
Celkem	1,24	3,64	

Úspory jsou skutečné, ale malé, a rostou s tím, jak týmy a přeměna lůžek dozrávají. Silná primární péče přináší lepší zdraví a méně zbytečných hospitalizací, celkové výdaje ale spíš zvyšuje. Model nezapočítává lepší hospodaření (až 5 mld. Kč, dokud nebudou schválena konkrétní opatření) ani zdravotní dividendu prevence a daní za zdraví. Účinek týmů na kontinuitu je pozorovací evidence; citlivost úspor ukazuje graf níže.

Čistý náklad a citlivost

Čistý náklad reformy v plném náběhu je asi 21,5 mld. Kč ročně, s rozpětím 15 až 25 mld. Kč. V roce 2035, uprostřed náběhu s 330 týmy, je to asi 17 mld. Kč; v roce 2050, kdy mají týmy tři sestry na lékaře, asi 25 mld. Kč.

mld. Kč ročně	2035	2038	2050
Provoz včetně rezervy	17,6	22,8	28,5
Úspory	−0,7	−1,2	−3,6
Čistý náklad	16,9	21,5	24,9
Podíl na výdajích v. z. p. 2026 (570,8 mld. Kč)	3,0 %	3,8 %	4,4 %

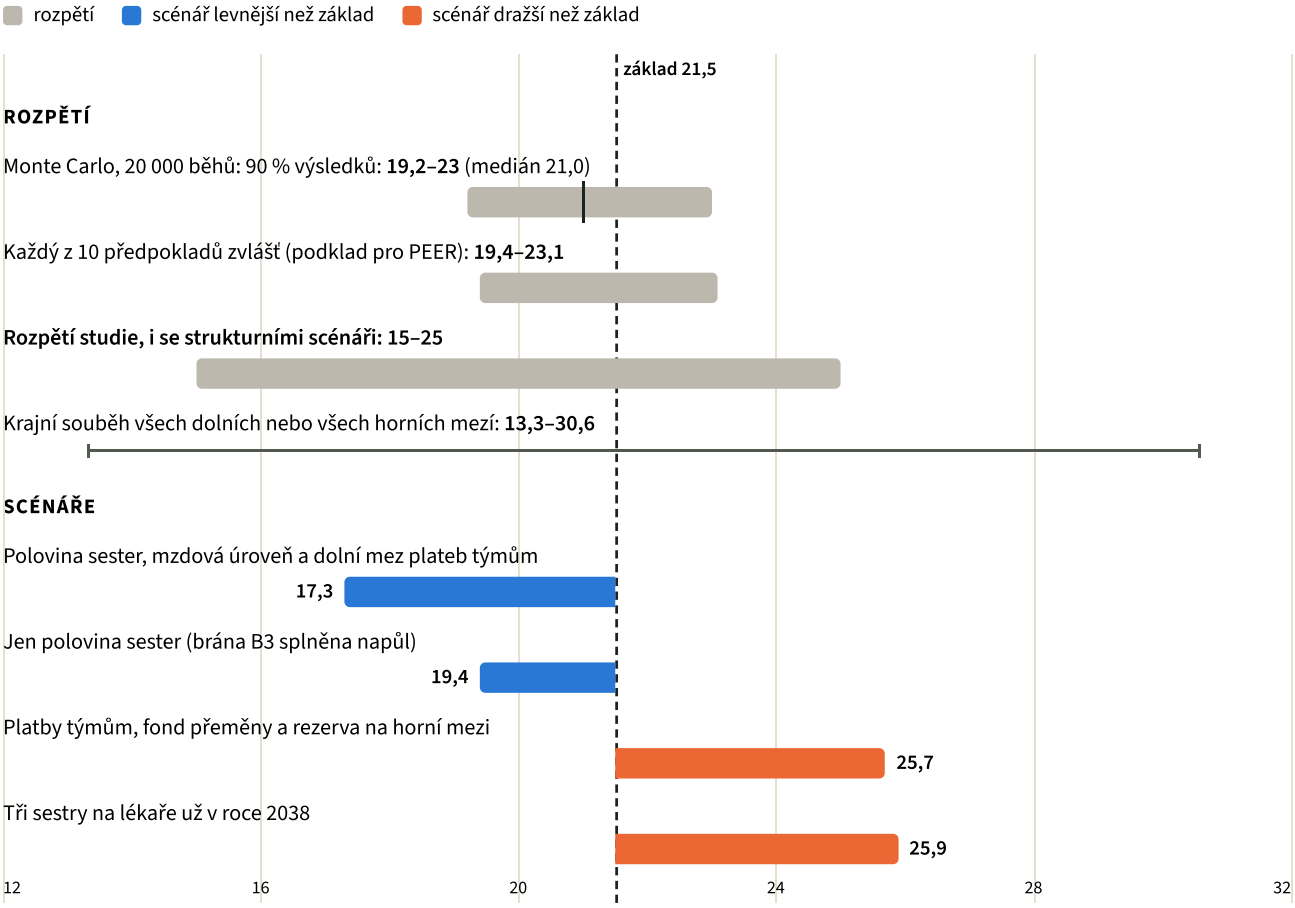
Rozpětí verze 2 (16,4 až 18,1 mld. Kč) vycházelo jen z kolísání úspor. Verze 3 mění všech deset hlavních předpokladů najednou v simulaci Monte Carlo (20 000 běhů, trojúhelníková rozdělení): medián je 21,0 mld. Kč a 90 % běhů leží mezi 19,2 a 23,0 mld. Kč. Rozpětí 15 až 25 mld. Kč pokrývá i strukturní scénáře mimo tyto předpoklady.

Scénář	Čistý náklad 2038 (mld. Kč)
Jen polovina sester (brána `B3` splněna napůl)	19,4
Polovina sester, mzdová úroveň a dolní mez plateb týmům	17,3
Platby týmům, fond přeměny a rezerva na horní mezi	25,7
Tři sestry na lékaře už v roce 2038	25,9

Souběh všech dolních mezí (13,3) nebo všech horních mezí (30,6 mld. Kč) je krajní případ; v simulaci vyšlo nad 25 mld. Kč méně než 0,1 % běhů.

Čistý náklad v roce 2038 drží mezi 15 a 25 mld. Kč; víc ho posune souběh několika změn než jeden předpoklad

Čistý náklad reformy v roce 2038, mld. Kč ročně; svislá čára je základní odhad 21,5 mld. Kč



Svislá značka v pruhu Monte Carlo je medián. V simulaci vyšlo nad 25 mld. Kč méně než 0,1 % běhů. Nejvíc rozhoduje cena a počet personálu: každých 1 000 sester navíc nebo méně změní náklad asi o 1,1 mld. Kč ročně. Rozpis deseti předpokladů jednotlivě (tornádo) ve zveřejněném textu není; ukazujeme jejich souhrnné rozpětí.

Zdroj: Ekonomický model studie v3 (model_v3.py), Monte Carlo 20 000 běhů s trojúhelníkovými rozděleními, ceny 2026. Rozpětí jednotlivých předpokladů: podklad pro PEER, 20. 10. 2026.

model_v3.py · citlivost čistého nákladu 2038 na 10 předpokladů; Monte Carlo 20 000 běhů

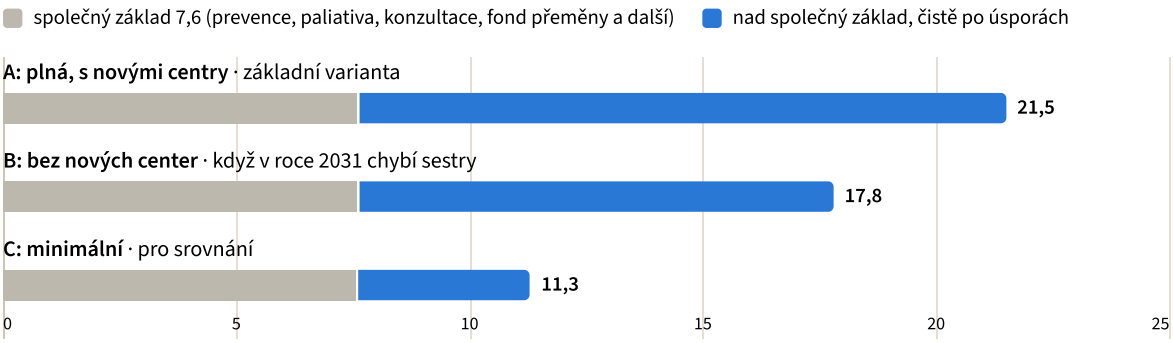
O výsledku rozhoduje cena a počet personálu: platby týmům, počet sester na lékaře a podíl praktiků, kteří do týmů vstoupí. Každých 1 000 sester navíc nebo méně změní náklad asi o 1,1 mld. Kč ročně včetně rezervy. Model je statický a nediskontuje; nezahrnuje dynamické účinky vyšších odvodů na zaměstnanost ani zdravotní dividendu prevence.

Varianty A, B, C

Plná varianta A stojí čistě 21,5 mld. Kč ročně, varianta B bez center 17,8 mld. Kč a minimální varianta C 11,3 mld. Kč. Verze 2 srovnávala neférově: rozdíl mezi variantami obsahoval paliativní týmy, prevenci, konzultace a fond přeměny, které na centrech nezávisí. Ve verzi 3 mají všechny tři varianty stejný společný základ 7,6 mld. Kč: prevence z Fondu prevence, paliativní týmy, konzultace a eŽádanka, kompetence praktiků, dálkové sledování, senior taxi, koordinace a fond přeměny.

Plná varianta A stojí 21,5 mld. Kč ročně, varianta B bez center 17,8 a minimální C 11,3

Čistý náklad v roce 2038, mld. Kč ročně; všechny tři varianty mají stejný společný základ 7,6 mld. Kč



A proti B: asi 3,8 mld. Kč ročně kupuje další profese, budovy, spádovou odpovědnost a vstup tam, kde praxe není.

B proti C: asi 6,5 mld. Kč ročně kupuje sestry a platby týmům místo plošného zvýšení kapitace.

Prevence, paliativní péče, konzultace lékařů a fond přeměny nemocnic jsou ve všech třech variantách. Rozdíl mezi A a B kupuje budovy, další profese v týmu a možnost, aby obec nebo kraj založily tým tam, kde ordinace zanikla. Varianta B je záložní plán: když brána B3 v prosinci 2031 nebude splněna, reforma pokračuje jako B, ne od nuly.

Zdroj: Ekonomický model studie v3 (model_v3.py), ceny 2026

model_v3.py · varianty A, B, C v roce 2038

Rozdíl A proti B (asi 3,8 mld. Kč ročně a 17 až 23 mld. Kč investic) kupuje další profese, budovy, spádovou odpovědnost a schopnost vstoupit tam, kde praxe není. Rozdíl B proti C (asi 6,5 mld. Kč) kupuje sestry a platby týmům místo plošného zvýšení kapitace.

	A plná (týmy a centra)	B bez center	C minimální
Praktici v týmech nebo smluvní síti 2038	75 % (4 220)	65 % (3 660), jen kde je praxe	žádné týmy
Sester navíc 2038	asi 4 000	asi 3 450	0
Investice (mld. Kč jednorázově)	22–33 (centra 17–23, lůžka 5–10)	6–11 (lůžka 5–10, úprava praxí 1,1)	5–10 (lůžka)
Pomůže tam, kde praktik chybí	ano: obec nebo kraj založí tým	jen tam, kde praxe je	ne
Doba do plného účinku	8 až 10 let	5 až 7 let	1 až 2 roky
Když sestry nepřijdou	zmenší se na B	zmenší se	nic se nezmění

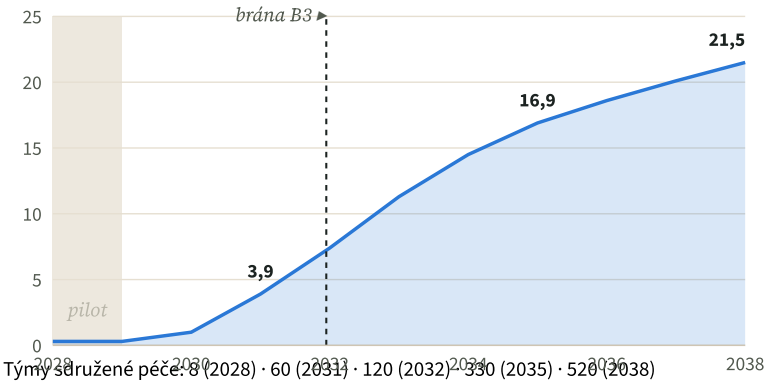
Varianta B je záložní plán: všechno, co obsahuje, je i ve variantě A. Když brána `B3` „Lidé a data“ v prosinci 2031 nebude splněna, reforma pokračuje jako varianta B, ne od nuly. Úspory varianty C zahrnují jen dálkové sledování srdečního selhání a polovinu úspor z přeměny lůžek (předpoklad modelu).

Náběh po letech

Reforma nabíhá jedenáct let: od osmi týmů pilotu v roce 2028 k 520 týmům kolem roku 2038. Harmonogram následuje scénář „Vláda 2030“: pilot ve třech ORP 2028–2029, smluvní model (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.) od roku 2030, první úhradová vyhláška nové vlády 2031 a zákon o primární péči účinný od 1. 1. 2032. Nový tým obsadí v prvním roce polovinu míst sester; neobsazené místo se neplatí.

Náklad nabíhá jedenáct let a většina peněz se utratí až po bráně B3 v prosinci 2031

Čistý náklad reformy po letech, mld. Kč ročně; varianta A, scénář „Vláda 2030“, ceny 2026



Týmy sdružené péče: 8 (2028) · 60 (2031) · 120 (2032) · 330 (2035) · 520 (2038)

Šedě pilot ve třech ORP 2028–2029. Smluvní model běží od roku 2030, zákon o primární péči je účinný od 1. 1. 2032. Nový tým obsadí v prvním roce polovinu míst sester; neobsazené místo se neplatí.

Zdroj: Ekonomický model studie v3 (model_v3.py); kumulativně 2028–2038 asi 116 mld. Kč. Počty týmů: studie v3, Části I a V.

model_v3.py · náběh 2028–2038, scénář Vláda 2030

Kumulativně stojí náběh 2028–2038 asi 116 mld. Kč. Prevence z Fondu prevence nabíhá 2031–2033 s výnosem daní za zdraví, paliativní týmy, senior taxi a konzultace 2031–2034, fond přeměny 2033–2040. Polovina výdajů přijde až po bráně B3 v prosinci 2031, takže svěží data o obsazení míst sester rozhodnou dřív, než se utratí většina peněz.

Investice

Investice do center a přeměny lůžek stojí v letech 2030–2038 jednorázově 22 až 33 mld. Kč; po evropských fondech a dnešní státní podpoře zbývá zajistit 15 až 26 mld. Kč. Do čistého ročního nákladu se investice nepočítají.

Typ	Počet	Cena za kus	Celkem (mld. Kč)
Nové centrum	150	80 mil. Kč (120 ve vysoké variantě)	12,0 (18,0)
Rekonstrukce stávající budovy	150	25 mil. Kč	3,75
Úprava dnešních prostor praxí	220	5 mil. Kč	1,1
Fond přeměny, investiční část	8 000 lůžek	0,6 až 1,2 mil. Kč na lůžko	5 až 10
Celkem hrubě			22 až 33 (centra 17 až 23)
Evropské fondy a státní rozpočet (implementační plán MZ 2.1)			−5,0 a −2,0
Zbývá zajistit			15 až 26

Odhad má nízkou jistotu. Obecní projekty stály 70 až 191 mil. Kč za novostavbu, ceny nezahrnují pozemky a vybavení a IROP 2021–2027 výstavbu ordinací praktiků nepodporuje. Zbytek má pokrýt národní dotační program, podíl obcí a krajů a programování evropských fondů po roce 2027. Předpokladem rozdělení je inventura obecních středisek (kolik jich je a v jakém stavu).

Odkud peníze

Zdravotnímu pojištění bude při dnešních pravidlech příjmů chybět asi 60 mld. Kč v roce 2035, 70 mld. Kč v roce 2038 a 104 mld. Kč v roce 2050 (ceny 2026). Tuto mezeru musí řešit každá vláda, ať reformuje, nebo ne; za reformu odpovídají navrhovatelé. Jde o podmíněný scénář Národní rozpočtové rady, ne o nevyhnutelný účet.

Mezera a potřeba celkem. NRR (Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, září 2026, tab. D.1) počítá s výdaji v. z. p. 6,4 % HDP v roce 2026, 6,9 % v roce 2036 a 7,5 % v roce 2056 a s příjmy kolem 6,1 až 6,2 % HDP. Model výdaje lineárně interpoluje, příjmy klesají z 6,20 na 6,15 % HDP (2050) a rozdíl násobí HDP roku 2026 (asi 8 920 mld. Kč).

mld. Kč ročně (ceny 2026)	2035	2038	2050
Mezera při dnešních pravidlech příjmů (NRR)	59,7	70,0	104,4
Čistý náklad reformy	16,9	21,5	24,9
Potřeba celkem	76,5 (0,86 % HDP)	91,6 (1,03 % HDP)	129,3 (1,45 % HDP)

Ověřit: hodnoty příjmů v. z. p. po letech přímo v tab. D.1 NRR.

Ověřujeme

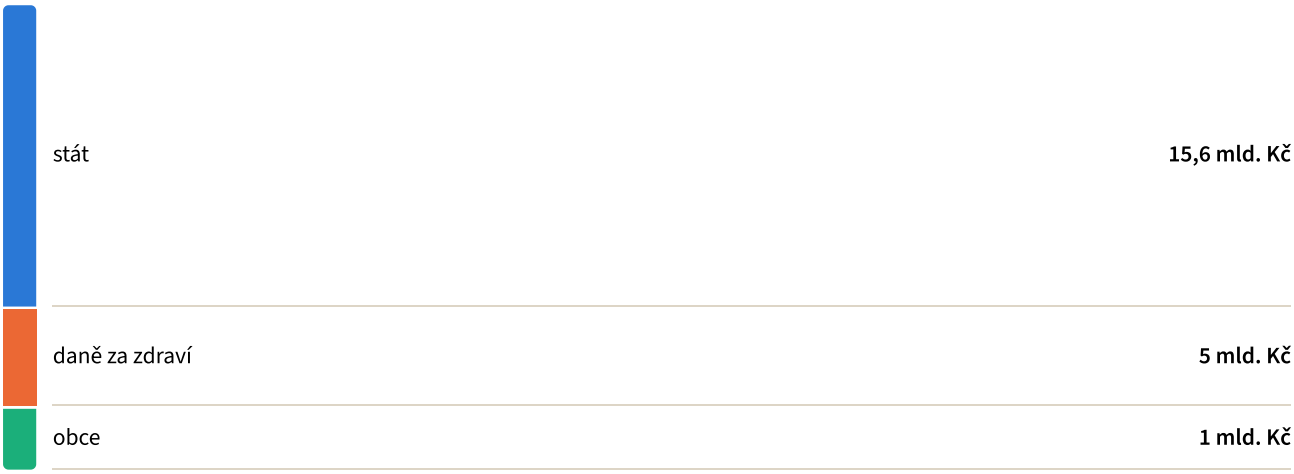
Nominální částku „96 mld. Kč“ z verze 2 vypouštíme, protože ignorovala reálný růst ekonomiky. Model je v cenách a při velikosti ekonomiky 2026; nominální částku dá násobení nominálním růstem HDP (asi 4,5 % ročně), tedy ×1,49 v roce 2035, ×1,70 v roce 2038 a ×2,88 v roce 2050. Potřeba 76,5 mld. Kč v roce 2035 tak odpovídá nominálně asi 114 mld. Kč.

Kdo zaplatí reformu. Čistý náklad 21,5 mld. Kč v roce 2038 kryjí daně za zdraví (5 mld. Kč), státní rozpočet (15,6 mld. Kč) a obce a kraje (1 mld. Kč). Přes vyšší platbu za státní pojištěnce jde 13 mld. Kč, tedy asi 180 Kč měsíčně na osobu; 100 Kč měsíčně znamená 7,2 mld. Kč ročně (6,0 mil. státních pojištěnců).

Většinu z 21,5 mld. Kč ročně zaplatí stát, daně za zdraví přinesou 5 mld. Kč

Tok peněz v roce 2038, mld. Kč ročně: vlevo zdroje čistého nákladu, vpravo provoz včetně rezervy (22,8 mld. Kč před odečtením úspor 1,2)

ODKUD PENÍZE PŘIJDOU

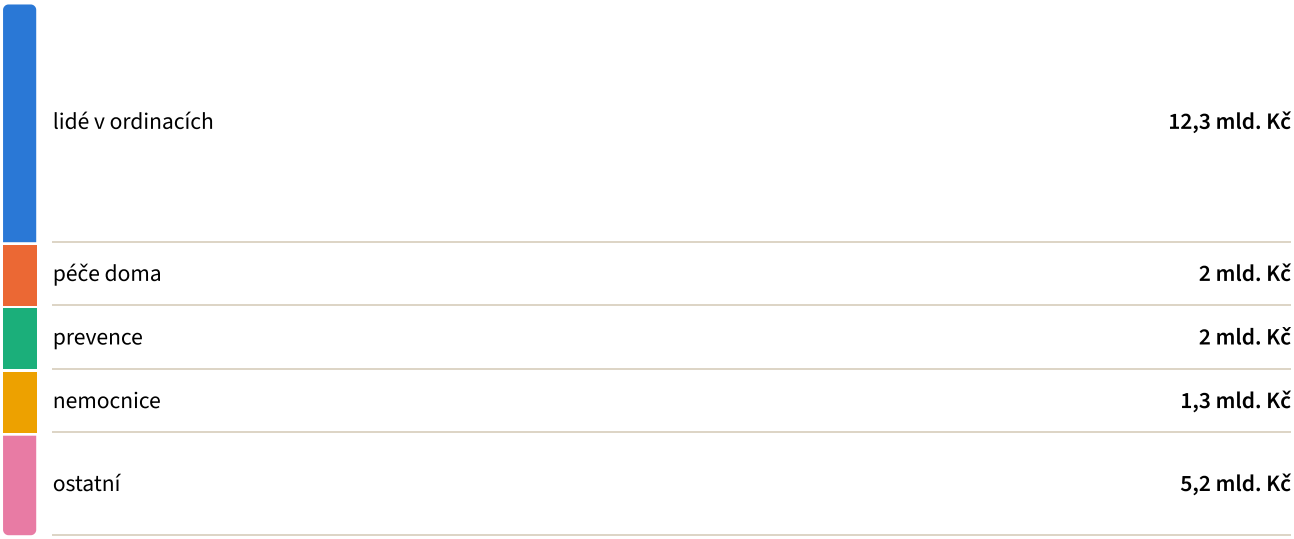


stát	15,6 mld. Kč
daně za zdraví	5 mld. Kč
obce	1 mld. Kč

21,6 mld. Kč ročně

↓ 21,5 mld. Kč čistě
= provoz 22,8 − úspory 1,2

NA CO PŮJDOU



lidé v ordinacích	12,3 mld. Kč
péče doma	2 mld. Kč
prevence	2 mld. Kč
nemocnice	1,3 mld. Kč
ostatní	5,2 mld. Kč

22,8 mld. Kč provoz včetně rezervy

Stát: vyšší platba za děti, důchodce a studenty	13
Stát: přímé výdaje (řízení, fond přeměny, sledování na dálku)	2,6
Daně za zdraví: do zdravotního pojištění	3
Daně za zdraví: Fond prevence	2
Obce a kraje: odvoz k lékaři, provoz center	1

Přes vyšší platbu za státní pojištěnce jde 13 mld. Kč, tedy asi 180 Kč měsíčně na osobu. Není to nový zdroj, ale přesun ze státního rozpočtu.

Zdroj: Model studie v3. Vyšší platba státu nejsou nové peníze, ale přesun ze státního rozpočtu. Ekonomický model studie v3; provoz včetně rezervy, ceny roku 2026.

model_v3.py · tok peněz na reformu, 2038

Platba státu v jedné tabulce. Platba za státního pojištěnce je v roce 2026 2 188 Kč měsíčně. Pro rok 2027 stanoví tisk 235 pevný vyměřovací základ 18 362 Kč (platba 2 479 Kč), na rok 2028 MZ avizuje zmrazení a v roce 2029 se vrací vzorec podle § 3c zákona 592/1992 Sb. Nový vzorec, který bude sledovat náklady péče o státní pojištěnce, přijme nová vláda s účinností od 1. 1. 2031. Vyšší sazba o 1 p. b. přinese z práce a OSVČ 25 až 29 mld. Kč a zároveň automaticky zvýší platbu státu o 162 Kč měsíčně, tedy o 11,7 mld. Kč.

Zdroj 2038 (mld. Kč)	1. Bez vyšší sazby	2. Sazba 13,5 → 14,5 % v rámci daňové reformy
Potřeba celkem (mezera 70,0 + reforma 21,5)	91,6	91,6
Daně za zdraví → Fond prevence	2,0	2,0
Daně za zdraví → platba státu do v. z. p.	3,0	3,0
Obce a kraje přímo (senior taxi, provoz center)	1,0	1,0
Státní rozpočet přímo (koordinace, fond přeměny, dálkové sledování)	2,6	2,6
Sazba pojistného: práce a OSVČ	0	27,0
Sazba pojistného: automatický růst platby státu (§ 3c)	0	11,7
Platba státu: nový vzorec	83,0	44,3
Platba státu nad projekci NRR celkem	83,0 (asi 1 150 Kč měsíčně)	56,0 (asi 780 Kč měsíčně, z toho 162 Kč automaticky)
Kdo nese: stát / práce / spotřeba / obce	93 / 0 / 6 / 1 %	64 / 29 / 6 / 1 %

V roce 2035 vychází platba státu ve variantě 1 na 68,2 mld. Kč (asi 950 Kč měsíčně), ve variantě 2 na 41,2 mld. Kč (asi 570 Kč). Vyšší platba státu není nový zdroj veřejných financí, ale přesun ze státního rozpočtu, jak upozorňuje i NRR. Varianta 2 zvyšuje sazbu jen jako součást daňové reformy s vyšší slevou na poplatníka; volba mezi variantami je politické rozhodnutí pro program 2029.

Co už je v plánu MZ a v projekci NRR. Projekce NRR stojí na dnešních pravidlech příjmů; ověřit, zda už zahrnuje jednorázové navýšení platby státu pro rok 2027 (tisk 235). Plán MZ na podporu týmových praxí (asi 10 mld. Kč z pojištění do roku 2030) se s platbami týmům může překrýt nanejvýš o 2 mld. Kč ročně (viz Kolik stojí provoz).

Daně za zdraví. Plánovací výnos je 5 mld. Kč ročně (rozpětí 5 až 7): tiché víno 3,3 až 4,3, slazené nápoje asi 1,5 a valorizace lihu a piva 0 až 1 mld. Kč po reakci poptávky. Plného výnosu se dosáhne v roce 2033: valorizace a víno platí od 1. 1. 2031 (víno s poloviční sazbou 2031–2032), daň ze slazených nápojů od 1. 1. 2032.

Rozdělení výnosu (mld. Kč ročně)	Plánovací 5	Horní hranice 7
Fond prevence (pevně, valorizováno)	2,0	2,0
Zdravotní pojištění přes platbu státu	3,0	5,0
Snížení odvodů z práce	0	0

Fond kryje přesně položky prevence v modelu (1,3 mld. Kč screening, navigace, očkování a dentální prevence a 0,7 mld. Kč komunitní programy), takže prevence není kryta dvakrát. Cíl Hospodářské strategie PEER (10 až 15 mld. Kč) a odhad PAQ Research (12 až 17 mld. Kč) předpokládají zdanění vína a piva podle obsahu alkoholu; rozpočet reformy s nimi zatím nepočítá a plánuje s 5 mld. Kč. Co přinesou navíc, rozdělí se podle pravidla PEER (nejméně 40 % Fondu prevence). Daně za zdraví jsou součástí daňového balíčku PEER a nesmějí se počítat dvakrát. Reforma odvody z práce nemění; podle strategie PEER se pojistné, pokud se někdy zvýší, mění jen spolu s úpravou daně z příjmu, aby celkové zdanění práce nerostlo.

Rezervy pojišťoven. Studie používá jednu veličinu: zůstatek základních fondů zdravotního pojištění všech pojišťoven ke konci roku 2025, 43,2 mld. Kč (důvodová zpráva k tisku 235; na začátku roku 2021 69,9 mld. Kč). Jiná čísla měří něco jiného: asi 32 mld. Kč uvádějí kapitoly knihy HSPA podle reportingu pojišťoven (VZP asi 23, zaměstnanecké asi 9) a 45,7 mld. Kč uvádějí odbory jako zůstatky na účtech ke konci srpna 2026. Pro měřítko: měsíční výdaje systému jsou asi 47 mld. Kč.

Ověřit: definice čísel 32 a 45,7 mld. Kč (pravděpodobně disponibilní část po povinných rezervách, resp. všechny fondy včetně rezervních a provozních).

Ověřujeme

Lidé

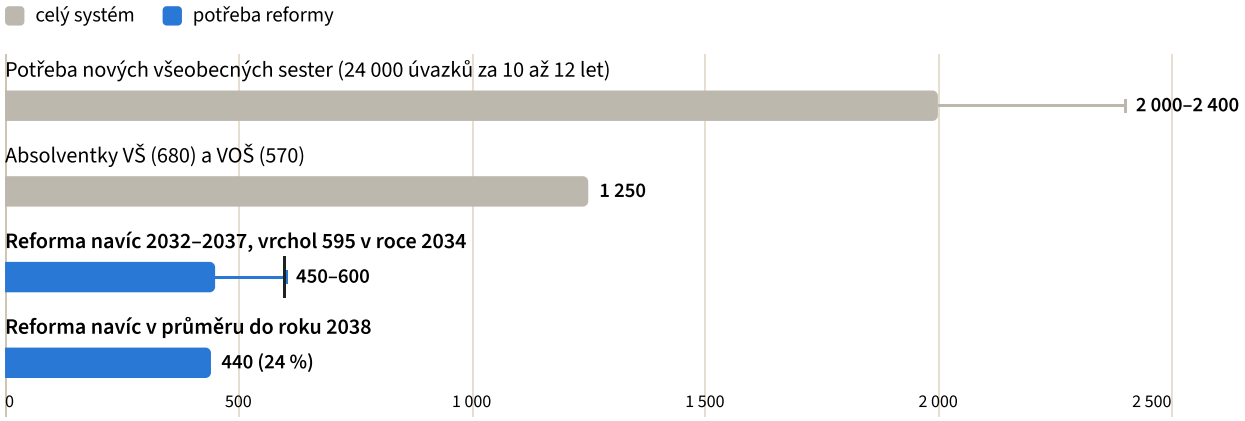
Reforma potřebuje do roku 2038 asi 4 000 sester navíc, v průměru 440 ročně, tedy asi čtvrtinu všeobecných sester, které v letech 2026 až 2037 vyjdou z vysokých a vyšších odborných škol (11 078 z vysokých škol a asi 11 000 z VOŠ, dohromady asi 22 000 za 12 let, tedy asi 1 840 ročně; vládní program pro nelékařské profese 2026–2037; MZ ČR 2025, s. 114). Verze 2 počítala s 5 400 sestrami do roku 2035, což při startu týmů po volbách znamenalo 830 ročně (64 % absolventek na tehdejším základu 1 300 ročně). Nižší číslo verze 3 plyne z pozdějšího a delšího náběhu a z toho, že praktiků, ke kterým se sestry vážou, ubývá.

Sestry: poptávka proti nabídce. Jen nových všeobecných sester potřebuje systém za 10 až 12 let nejméně 24 000 úvazků, tedy při rozložení do 12 let asi 2 000 ročně; vysoké a vyšší odborné školy jich v letech 2026 až 2037 dají asi 1 840 ročně (vládní program pro nelékařské profese 2026–2037; MZ ČR 2025, s. 112–114). Reforma přidává v letech 2032–2037 450 až 600 sester ročně, tedy 23 až 30 % k potřebě náhrady; vrchol je 595 sester v roce 2034 (asi 32 % všeobecných sester, které ten rok vyjdou ze škol, na stejném základu 1 840 ročně).

Bilance bez reformy je záporná už dnes. Proti potřebě 24 000 úvazků stojí 11 078 všeobecných sester z vysokých škol a asi 11 000 z VOŠ, takže za 12 let chybí asi 2 tisíce všeobecných sester i bez reformy (dopočet studie z čísel MZ ČR 2025, s. 114). Asi 4 000 sester pro týmy jsou nad tímto rámcem.

Reforma potřebuje v průměru 440 sester ročně, asi čtvrtinu absolventek, které mají vyjít ze škol do roku 2037; ve vrcholu 2034 asi třetinu

Všeobecné sestry za rok. Potřeba náhrady: nejméně 24 000 úvazků za 10 až 12 let. Studie v3 pracovala s 30 000 úvazky do roku 2037 a 1 300 absolventkami ročně; čísla jsme opravili podle vládního programu.



Vrchol 595 sester v roce 2034 je 32 % z asi 1 840 všeobecných sester, které mají podle vládního programu ročně vyjít z vysokých a vyšších odborných škol (dnes jich vychází 1 250; studie v3 uváděla 46 % z 1 300). Týmy proto přebírají nemocniční sestry jen tam, kde se podle plánu sítě práce v nemocnici prokazatelně změnila, a brána B3 v prosinci 2031 měří obsazení míst sester; když nebude splněna, reforma pokračuje jako varianta B.

Zdroj: Vládní program pro nelékařské zdravotnické profese 2026–2037 a MZ ČR 2025 (potřeba a absolventky); ekonomický model studie v3 (potřeba reformy)

model_v3.py · náhrada úvazků sester do 2037: nejméně 24 000 úvazků všeobecných sester, absolventky VŠ a VOŠ ročně (vládní program 2026–2037); verze 3 počítala s 30 000 úvazky a 1 300 absolventkami

Hrozí přetahování sester z nemocnic, proto týmy přebírají nemocniční sestry jen tam, kde se podle plánu sítě práce v nemocnici prokazatelně změnila. Přeměna 8 000 akutních lůžek část sester uvolní, model to ale nezapočítává. Proto je personální bilance po krajích (`P1`) podmínkou, ne přílohou: absolventky, odchody, návraty, úvazky a nábor ze zahraničí. Oporou bilance mohou být plánovací modely, které MZ s Univerzitou Karlovou, ÚZIS a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů vytváří v evropském projektu JA HEROES (pilotně pro fyzioterapeuty a domácí péči, připravují se modely pro všeobecné sestry), a záměr zřídit Národní centrum pro plánování a forecasting zdravotnických pracovníků (MZ ČR 2025, s. 113); predikce personálních kapacit je i programovým cílem NIKEZ (tamtéž, s. 58). Brána `B3` v prosinci 2031 měří obsazení míst sester z registrů pojišťoven; když nebude splněna, reforma pokračuje jako varianta B.

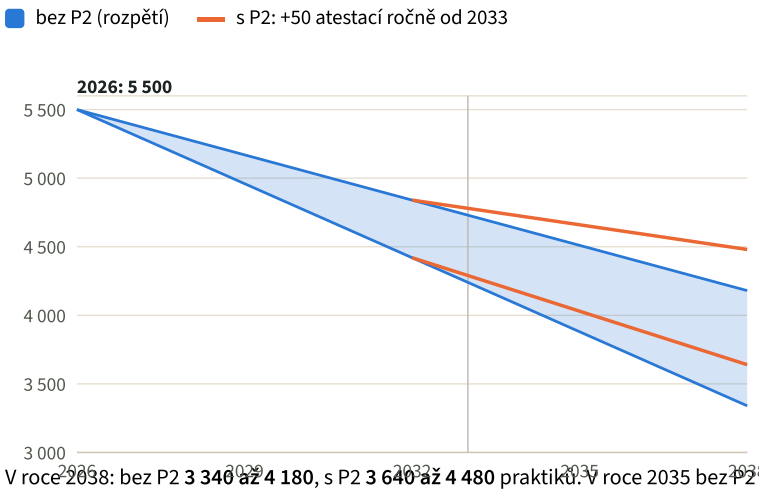
Vyšší odborné školy dnes vychovají asi 570 diplomovaných všeobecných sester ročně, od roku 2021 přijímají o 40 až 50 % víc studentů a za 12 let mají vychovat asi 11 000 všeobecných sester (MZ ČR 2025, s. 112 a 114). Ověřit: roční počet absolventek oboru praktická sestra a kolik jich nastoupí do zdravotnictví.

Ověřujeme

Praktici. Praktiků pro dospělé je dnes asi 5 500 a ubývá jich 110 až 180 ročně; do roku 2035 jich zbude asi 3 900 až 4 500 (5 500 − 9 × 110 až 180). Ročně atestuje 160 až 200 lékařů a 43,6 % praktiků pro dospělé je starších 60 let (ÚZIS 3/2023), takže odchody se mohou zrychlit a dolní mez klesnout. Model s tím počítá v citlivosti, ne ve výpočtu.

Úbytek praktiků rezidenční místa nezastaví: P2 přidá do roku 2038 asi 300 lékařů

Praktici pro dospělé, počet; rozpětí podle úbytku 110 až 180 ročně. P2 = +50 atestací ročně od roku 2033 (předpoklad modelu)



V roce 2038: bez P2 **3 340 až 4 180**, s P2 **3 640 až 4 480** praktiků. V roce 2035 bez P2 3 880 až 4 510.

Úbytek nahrazují hlavně sestry v týmech, nové výkony praktiků a sdílené zastupování. Rezidenční místa P2 musí potvrdit ministerstvo a odborné společnosti. Téměř polovina (43,6 %) praktiků je starší 60 let, odchody se tedy mohou zrychlit a dolní mez klesnout.

Zdroj: Model studie v3 (model_v3.py); 5 500 praktiků pro dospělé v roce 2026 (ÚZIS). Roky po 2035 jsou aritmetika téhož pravidla do konce náběhu reformy.

model_v3.py · 5 500 PLD (2026), úbytek 110–180 ročně; P2 = +50 atestací ročně od 2033 (předpoklad)

Reforma úbytek nezastaví, ale má ho nahradit: sestry přebírají péči o chroniky, kompetence praktiků (J3) vracejí do ordinace výkony od specialistů a tým dělí zastupování. Rezidenční místa (P2) model počítá jako 50 atestací ročně navíc od roku 2033; to je předpoklad, který musí potvrdit MZ a odborné společnosti. Ministerstvo podpořilo ve všeobecném praktickém lékařství 150 rezidenčních míst v roce 2023 a po 140 v letech 2024 a 2025, v pediatrii 80, 70 a 70 (dotační program MZ Rezidenční místa; MZ ČR 2025, s. 97). Předpoklad +50 atestací ročně proto vyžaduje počet míst zvýšit, ne jen udržet. Absolventů všeobecného lékařství přitom od školního roku 2025/26 přibývá o víc než 300 ročně (tamtéž); úzkým místem je volba oboru a rezidenční místo. Dětských praktiků je asi 2 050; dětské týmy zachováváme a model počítá s úbytkem 40 ročně (nízká jistota).

Dlouhodobá péče. Do roku 2035 bude potřeba asi 39 000 nových zdravotních i sociálních lůžek dlouhodobé a následné péče (Přecechtěl a Hlávka 2025) a 21 000 pečovatelů (studie pro APSS ČR, 6/2026). Zdravotních lůžek následné a dlouhodobé péče dnes chybí nejméně 2 až 3 tisíce a do roku 2035 bude potřeba dalších nejméně 8 tisíc (MZ ČR 2025, s. 65). Přeměna 8 000 akutních lůžek tak řádově odpovídá zdravotní části potřeby; zbytek potřeby leží v pobytových sociálních službách, a proto je podmínkou P3. Proto platí i pravidlo J7 : žádné akutní lůžko se nepřemění, dokud kraj neprokáže kapacitu následné a dlouhodobé péče a dojezd záchranné služby.

Lůžka a fond přeměny	Hodnota
Akutní lůžka dnes (NZIP/ÚZIS)	48 036, tedy 4,4 na 1 000 obyvatel
Cíl do roku 2038	přeměnit 8 000, na asi 40 000 (3,7 na 1 000)
Směr po roce 2038, jen při splněných ukazatelích	3,5 na 1 000, tedy −9 900 lůžek
Fond přeměny, investice	5 až 10 mld. Kč (0,6 až 1,2 mil. Kč na lůžko)
Fond přeměny, garance příjmu	7,9 mld. Kč v letech 2033–2040; průměr asi 1 mld. Kč ročně, vrchol 1,3 mld. Kč
Pojistka	obložnost akutních lůžek nad 85 % zastaví přeměnu v kraji

Garance platí tři roky na lůžko (1 500 Kč za lůžko a den při 60% obložnosti) a přeměna běží po prvních krajských plánech sítě v letech 2033–2038. Kdyby se všech 8 000 lůžek přeměnilo v jednom roce, stála by garance až 2,6 mld. Kč ročně; rovnoměrné tempo snižuje vrchol na polovinu. Sociální účet dlouhodobé péče (růst asi o 57 mld. Kč ročně do roku 2035, investice 100 až 175 mld. Kč podle studie pro APSS ČR) leží mimo zdravotní pojištění i mimo čistý náklad reformy.

Otevřenost modelu

Model je skript v Pythonu bez externích knihoven (model_v3.py, verze z 20. 10. 2026); jediným příkazem vypíše všechna čísla této části včetně tornáda a simulace Monte Carlo (pevné semínko 2026). Zveřejníme ho spolu s konzultační verzí studie, i s tabulkou vstupů, aby si ho kdokoli přepočítal se svými předpoklady. Verze 2 otevřený skript slibovala, ale nezveřejnila ho.

Vstup	Hodnota	Zdroj	Jistota
Mezera v. z. p.	6,4 → 6,9 → 7,5 % HDP výdaje (2026, 2036, 2056), příjmy 6,1–6,2 %	NRR 9/2026, tab. D.1	střední
HDP 2026	8 920 mld. Kč	570,8 mld. Kč výdajů = 6,4 % HDP	střední
Týmy kolem 2038	520	10,9 mil. obyvatel, asi 21 000 na tým	nízká
Praktici pro dospělé a děti	5 500 a 2 050 (2026), úbytek 110–180 a 40 ročně	ÚZIS; úbytek PLDD vlastní předpoklad	střední / nízká
Podíl praktiků v týmech	75 % (2038), 85 % (2050)	vlastní předpoklad	nízká
Sester navíc na lékaře	1 (2038), 2 (2050)	etapy Pilíře 1	nízká
Plat sestry	62 177 Kč, odvody 33,8 %	ISPV 2025	vysoká
Platby týmům	38 Kč na registrovaného a měsíc; odměna 1,6; návštěvy 0,8 mld. Kč	oponentní posudek, zálohy týmových praxí	nízká
Úspory	50 % / 75 % mezery ACSC; 10 % / 30 % mezery hospitalizací	OECD, ÚZIS, De Lathauwer 2025	střední / nízká
Fond přeměny	1 500 Kč na lůžko a den, 60 % obložnost, 3 roky	vlastní odhad	nízká
Platba státu	100 Kč měsíčně = 7,2 mld. Kč; +1 p. b. sazby = 27 mld. Kč z práce a 11,7 mld. Kč automaticky	6,0 mil. státních pojištěnců; vyměřovací základ 2026	vysoká / střední
Daně za zdraví	5 mld. Kč (5–7)	HSPA Monitor 8/2026, britský výnos daně ze slazených nápojů, elasticity	střední

Model je statický a nediskontuje, všechny částky jsou v cenách a při velikosti ekonomiky roku 2026. Nezahrnuje dynamické účinky vyšších odvodů na zaměstnanost, zdravotní dividendu prevence ani lepší hospodaření, dokud nebude doložené konkrétními opatřeními. Každé číslo z této části má ve skriptu svůj výpočet a mění se jen změnou vstupu.

Ověřit: veřejnou adresu, kde bude model a tabulka vstupů zveřejněny (repozitář HSPA Monitoru, nebo web strany).

Ověřujeme

Část VI — Vztah k reformám, které prosazuje vláda

Deset vládních předloh a opatření z let 2025–2028 otevírá stejné paragrafy, které potřebuje náš plán, především § 17 zákona 48/1997 Sb. Proto na ně v letech 2026–2028 navazujeme pozměňovacími návrhy (PN) a podněty do dohodovacího řízení a nepředkládáme protinávrh.

Platí tři zásady. Co vláda dělá správně, nepřepisujeme: víceleté dohody, centralizaci onkochirurgie a povinnou eŽádanku. Kde nechává mezeru, doplňujeme: týmy sdružené péče, sesterskou složku úhrady a triážní údaj. Kde se rozcházíme, říkáme to otevřeně a s důvodem.

Stav je k 20. 10. 2026. Reforma pojištění existuje zatím jen jako prezentace ministerstva z 22. 9. 2026 a paragrafové znění není veřejné, takže hodnotíme záměr, ne text. Údaj, který jsme nemohli ověřit v primárním zdroji, značíme „Ověřit:“.

Ověřujeme

Deset předloh a náš postoj

Devět z deseti řádků vede ke konkrétnímu PN nebo podnětu; u tisku 235 už nový PN podat nelze. Centralizace onkochirurgie běží bez zákona, proto pro ni zákonný PN nenavrhujeme. Kódy `J1` – `J10` a `P1` – `P5` označují opatření jádra a podmínky plánu.

Reforma, předloha	Stav k 20. 10. 2026	Co dělá	Průnik s plánem	Náš postoj	Konkrétní PN nebo podnět	Kdy
Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030 (novela zák. 48/1997, 280/1992, 551/1991 a 372/2011 Sb.)	Představeno 22. 9. 2026, vnitřní připomínkové řízení; paragrafové znění není veřejné. Ověřit: záznam ve VeKLEP (k 20. 10. jsme ho nenašli).	Víceleté dohody o úhradách, síti a personálu; vyhláška jen publikuje dohody; rozhodčí řízení; správní rady o 9 členech; Kancelář ZP; odměna 500–1 500 Kč za prevenci (věk 45–75 let).	`J1`, `J2`, `J5`, `P4`, `P5`	Podpořit rámec víceletých dohod; pozměnit prevenci a orgány; jinak u „soutěžního prostředí“.	(1) Do víceletých dohod zapsat pětiletou smlouvu týmu a sesterskou složku (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.). (2) Kancelář ZP zveřejňuje čekací doby a UPC. (3) Odměnu za prevenci hradit jen z fondu prevence a měřit pokrytí (52,6 % v roce 2023). (4) Zastoupení pojištěnců řešit v devíti místech a elektronických volbách, ne samostatně (tisk 479). (5) Soutěž mezi pojišťovnami jen po dopadové studii.	Připomínky v meziresortním řízení 2027; PN ve Sněmovně 2027

Reforma, předloha	Stav k 20. 10. 2026	Co dělá	Průnik s plánem	Náš postoj	Konkrétní PN nebo podnět	Kdy
Centralizace onkochirurgie	Platí bez zákona: Věstník MZ 6/2026 (28. 5.) a 10/2026 (20. 8.). Játra, slinivka a jícen od 1. 9. 2026; gynekologie a rektum od 1. 1. 2027; plíce od 1. 1. 2028; urologie 2027–2030.	Soustřeďuje 4 109 z 17 096 ročních výkonů šesti oborů do center vysoce specializované péče; necentrovým nemocnicím výkony odsmluvňuje.	J6 , J7	Podpořit a použít jako důkaz, že část sítě jde bez zákona; důkazy hodnotit zdrženlivě (Grilli: OR 0,68, nízká kvalita).	Žádný zákonný PN. Podnět: po každé vlně zveřejnit dojezd, čekání a 90denní úmrtnost; stejný nástroj (Věstník) použít pro minimální objemy ve čtyřech oborech vlny 0.	Průběžně 2026–2030; podnět 2027
Zákon 38/2025 Sb. (sociálně-zdravotní pomezí)	Platí od 1. 3. 2025; další kroky 1. 1. 2027 a 1. 1. 2029; nový zákon o sociálních službách se očekává 2031.	Zavádí sociálně-zdravotní službu (§ 36 zák. 108/2006 Sb.) a lůžka (§ 9 odst. 2 písm. e zák. 372/2011 Sb.). Od 2029 hradí pojišťovna pobyt nad 90 dnů jen s indikací schválenou revizním lékařem (§ 22b zák. 48/1997 Sb.), prodloužení o 180 dnů; § 52 zák. 108/2006 Sb. se ruší.	J7 , P3	Podpořit cíl; jinak v načasování: strop nesmí dopadnout na kraj bez kapacity následné péče.	Při první novele, která § 22b otevře, výjimka nebo odklad pro kraj bez bilance lůžek dlouhodobé péče (J7); zveřejnit krajskou bilanci čekajících na místo. Ověřit: která předloha to bude.	2027–2028
Sněmovní tisk 235 (platba státu, zák. 592/1992 Sb.)	2. čtení skončilo 23. 9. 2026; podány PN č. 1796 (základ 17 540 Kč místo 18 362 Kč) a č. 1813; stanovisko výboru je tisk 235/3 (15. 10.); 3. čtení zatím nebylo.	Pevný vyměřovací základ 18 362 Kč od 1. 1. 2027 (platba 2 479 Kč měsíčně, asi +21 mld. Kč); do roku 2029 vypíná automatický vzorec § 3c.	J10	Peníze na 2027 nezpochybňujeme, vyžadujeme termínovaný plán reforem (stanovisko klubu z 8. 7. 2026). Trvalé pravidlo jinak: vzorec J10.	Nový PN už podat nelze. Ověřit: hlasování klubu o PN č. 1796 a 1813. Pro rok 2028 požadovat v rozpočtu pravidlo místo zmrazení.	3. čtení podzim 2026; rozpočet 2028 v roce 2027
Úhradová vyhláška 2027 a cyklus 2028	Dohoda ve 12 z 15 segmentů (18. 6. 2026); návrh vyhlášky rozděluje 604,8 mld. Kč; do Sbírky do 31. 10. 2026.	Stanoví hodnotu bodu, úhrady a regulace na rok podle § 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.	J1 , J2 , J3 , J5	Využít: vlna 0 projde v tomto cyklu bez zákona.	Podněty do dohodovacího řízení 2028: sesterská složka u týmových praxí, výkony pro praktiky (například USG), telemonitoring, konzultace lékař–lékař; do seznamu výkonů (vyhl. 134/1998 Sb.) přes Pracovní skupinu k SZV.	Podněty do 30. 6. 2027; účinnost 1. 1. 2028
Novela zák. 325/2021 Sb. (povinná eŽádanka)	Návrh MZ ve VeKLEP (č. j. vlády 748/26); verze pro jednání vlády z 30. 9. 2026, vláda ho zatím neprojednala. Ověřit: termín povinnosti (návrh uvádí 1. 7. 2027).	Zavádí povinnou eŽádanku, elektronickou dokumentaci a první fázi EHDS.	J5	Podpořit a doplnit.	Povinný triážní údaj (urgentní do 2 týdnů, do 6 týdnů, plánované); specialista smí kategorii změnit se zdůvodněním; měření čekání podle kategorie; přímý přístup bez žádanky zůstává; pacienta nesankcionovat.	Sněmovna 2027, po schválení vládou
Reforma hygienické služby (zákon o Národním institutu veřejného zdraví)	Vnitřní připomínkové řízení od přelomu 9/10 2026; meziresortní řízení plánováno na 4/2027, vláda 30. 8. 2027. Ověřit: účinnost 1. 1. 2028 (harmonogram je těsný).	Sloučí 14 krajských hygienických stanic, SZÚ a dva zdravotní ústavy (17 institucí) v jeden ústřední orgán podřízený vládě.	P4 , P5	Podpořit sloučení; doplnit hodnocení zdraví.	Pětiletá zpráva o zdraví podle rámce HSPA (P5) a otevřená data; institut vyhodnocuje výdaje Fondu prevence (P4).	Připomínky 4/2027; Sněmovna 2027–2028
Sesterská preskripce (priorita ministra)	Záměr MZ; paragrafové znění neznáme. Ověřit: předloha a termín. Dnes sestry léky nepředepisují (§ 80 zák. 378/2007 Sb.).	Rozšiřuje kompetence nelékařů (preskripce sester, očkování v lékárnách).	J2 , J3 , vlna 4	Podpořit a navázat úhradou.	Kompetence musí mít úhradu: samostatná indikace sestry a platba za sesterskou složku v dohodovacím řízení. Sestra v pokročilé praxi s předepisováním zůstává ve vlně 4 (2033).	Podněty 2027; vyhl. 55/2011 Sb. 2028
Konvergence CZ-DRG	Priorita ministra do voleb 2029: zúžit rozpětí krajských základních sazeb z 1 : 1,7 na 1 : 1,3 do 2031. Druhá veličina: jednotnou základní sazbou se hradí přes 25 % akutní lůžkové péče (2025; 3,4 % v roce 2022; cíl aspoň 30 %; MZ ČR 2025, s. 74, 76 a 82). Ověřit: veřejný dokument MZ s trajektorií rozpětí sazeb.	Sbližuje krajské sazby; status zařízení má být samostatný koeficient.	J6 , vlna 4	Podpořit konvergenci; jinak v dopadu na přeměnu lůžek.	Podnět: spočítat dopad konvergence po krajích spolu s krajským plánem sítě. Základní sazbu zákonem (§ 41a) řešit až ve vlně 4 (2033).	Každý cyklus 2027–2031

Reforma, předloha	Stav k 20. 10. 2026	Co dělá	Průnik s plánem	Náš postoj	Konkrétní PN nebo podnět	Kdy
Zákony 289/2025 a 290/2025 Sb.	Platí od 1. 1. 2026.	289/2025: fond obecně prospěšných činností místo rezervního fondu (až 0,5 % pojistného, asi 2,5 mld. Kč), evropské HTA, úhrada očkování přes SÚKL. 290/2025: pohotovosti organizují pojišťovny, nemocniční ombudsman.	P2 , P4 , vlna 4	Navázat, nepřepisovat.	Rezidenční místa (P2) hradit z fondu obecně prospěšných činností; HTA řešit rozšířením mandátu SÚKL a ÚZIS; zdravotnického ombudsmana odvodit z nemocničního.	P2 v dohodovacím řízení 2027; ostatní ve vlnách 2 a 4

Ověřujeme

Poznámka k tisku 235: PN č. 1796 by zvýšil platbu státu asi o 13 mld. Kč místo 21 mld. Kč, tedy o asi 8 mld. Kč méně než vládní návrh (výpočet HSPA Monitoru: 17 540 × 0,135 = 2 368 Kč měsíčně, rozdíl 111 Kč na pojištěnce).

Vládní reformy a náš plán na jedné ose

Do voleb 2029 běží vládní předlohy souběžně s našimi fázemi F0 a F1; naše zákony přijdou až po nich



Sesterská preskripce a konvergence CZ-DRG v ose chybí, protože nemají veřejný termín.

Textová verze

Dráha a řádek	Termíny a kroky	Zdroj
Vláda: Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030	22. 9. 2026: Představeno jako prezentace ministerstva; vnitřní připomínkové řízení. Paragrafové znění není veřejné, záznam ve VeKLEP jsme k 20. 10. nenašli (Ověřit).	ř. 1547
Vláda: Centralizace onkochirurgie	1. 9. 2026: Játra, slinivka a jícen (Věstník MZ 6/2026 a 10/2026); platí bez zákona. 1. 1. 2027: Gynekologie a rektum. 1. 1. 2028: Plíce. 2027–2030: Urologie.	ř. 1548
Vláda: Zákon 38/2025 Sb. (sociálně-zdravotní pomezí)	od 1. 3. 2025: Zákon platí. 1. 1. 2027: Další krok zákona. 1. 1. 2029: Pojišťovna hradí pobyt nad 90 dnů jen s indikací revizního lékaře (§ 22b zák. 48/1997 Sb.); ruší se § 52 zák. 108/2006 Sb. 2031: Očekává se nový zákon o sociálních službách.	ř. 1549

Dráha a řádek	Termíny a kroky	Zdroj
Vláda: Sněmovní tisk 235 (platba státu)	23. 9. 2026: Druhé čtení skončilo; podány pozměňovací návrhy č. 1796 a 1813; třetí čtení zatím nebylo (podzim 2026). 1. 1. 2027: Pevný vyměřovací základ 18 362 Kč (platba 2 479 Kč měsíčně, asi +21 mld. Kč); do roku 2029 se vypíná automatický vzorec § 3c. 1. 1. 2029: Vrací se automatický vzorec § 3c zák. 592/1992 Sb.; rok 2028 má podle ministra zůstat bez valorizace.	ř. 1550
Vláda: Úhradová vyhláška 2027 a cyklus 2028	do 31. 10. 2026: Návrh vyhlášky rozděluje 604,8 mld. Kč; do Sbírky (dohoda ve 12 z 15 segmentů z 18. 6. 2026). 1. 1. 2027: Vyhláška 2027 platí. 1. 1. 2028: Účinnost vyhlášky 2028 (podněty do dohodovacího řízení se podávají do 30. 6. 2027).	ř. 1551
Vláda: Novela zák. 325/2021 Sb. (povinná eŽádanka)	30. 9. 2026: Verze pro jednání vlády; vláda ji zatím neprojednala. 1. 7. 2027: Termín povinné eŽádanky, který uvádí návrh. Ověřit.	ř. 1552
Vláda: Reforma hygienické služby	od přelomu 9/10 2026: Vnitřní připomínkové řízení. 4/2027: Plánované meziresortní řízení. 30. 8. 2027: Plánované jednání vlády. 1. 1. 2028: Účinnost; harmonogram je těsný. Ověřit.	ř. 1553
Plán: Konzultace	7. 12. 2026: Resortní tým schválí verzi 3 ke konzultaci. 31. 3. 2027: Konec prvního kola připomínek. 2/2027–6/2028: Devět kulatých stolů; bilanční konference 6/2028 před bránou B1.	ř. 75–76, 1879–1887
Plán: Podněty a pozměňovací návrhy	do 30. 6. 2027: Podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 a do seznamu výkonů. 2027–2028: Pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030, novele zák. 325/2021 Sb. a reformě hygienické služby (podle projednávání ve Sněmovně).	ř. 77, 80, 1547–1556
Plán: Pilot ve třech ORP	do 30. 6. 2027: Dohoda kraje, VZP a obcí. 1. 1. 2028: Start provozu; provoz dva roky. jaro 2029: Průběžné vyhodnocení po roce provozu.	ř. 78, 81, 85, 1935–1940
Plán: Poslanecké návrhy	2028–2029: Jednodušší „dříve vyslovené přání“ s registrem; dobrovolné zveřejňování počtu lidí bez praktika po regionech.	ř. 1171, STEPS_2029
Plán: Věcné záměry a program	7/2028–12/2029: Věcné záměry zákonů o primární péči, o síti, finanční novely a daňových zákonů. do voleb 10/2029: Volební program 2029 s jádrem J1–J10.	ř. 84, 86

časová osa · vládní reformy 2026–2029 a fáze F0–F1 plánu

Do voleb v roce 2029 běží vládní předlohy souběžně s našimi fázemi F0 a F1 (konzultace, pilot, věcné záměry). Naše zákony se předkládají v roce 2030 a platí nejdřív od 1. 1. 2031, tedy za pravým okrajem osy. Sesterská preskripce a konvergence CZ-DRG v ose chybí, protože nemají veřejný termín.

1. 1. 2029: souběh

Na 1. 1. 2029 připadají tři vládní události a o devět měsíců později volby do Sněmovny.

- **Strop podle § 22b zák. 48/1997 Sb.** (zákon 38/2025 Sb.): pojišťovna hradí pobyt nad 90 dnů jen s indikací schválenou revizním lékařem, prodloužení nejvýše o 180 dnů. Důvodová zpráva odhaduje úsporu asi 200 mil. Kč ročně; skutečný dopad závisí na kapacitě sociálních služeb.
- **Zrušení § 52 zák. 108/2006 Sb.:** zaniká dnešní úprava sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Zůstává sociálně-zdravotní služba a lůžko podle zákona 38/2025 Sb. Ověřit: přechodná ustanovení.

Ověřujeme

- **Konec pevného základu z tisku 235:** pro rok 2029 se vrací automatický vzorec § 3c zák. 592/1992 Sb. (růst cen plus polovina růstu reálné mzdy). Rok 2028 má podle ministra zůstat bez valorizace.

Náš plán na tento den nic neklade ze tří důvodů. Za prvé, žádný z našich zákonů nemůže být účinný dřív než 1. 1. 2031 (vlna 1) a 1. 1. 2032 (vlna 2); do té doby postupujeme smlouvami, vyhláškou a pilotem. Za druhé, poskytovatelé a pojišťovny budou v roce 2029 zavádět strop pobytu a nové pravidlo platby státu, takže další změna téhož dne by znemožnila oddělit jejich dopady. Za třetí, pilot ve třech ORP běží v letech 2028–2029 a potřebuje stabilní prostředí pro čisté vyhodnocení.

V roce 2029 děláme tři věci. Sledujeme, kolik lidí nad 90 dnů čeká v kraji na místo v následné péči; tato data jsou podmínkou opatření `J7` i brány B3. Návrat vzorce § 3c bereme jako výchozí stav, který v roce 2031 nahradí nový vzorec J10. A ve volebním programu ohlašujeme daň ze slazených nápojů s účinností od 1. 1. 2032.

Strop může zvýšit tlak na akutní lůžka. Proto kraj, kde obložnost akutních lůžek přesáhne 85 %, přeměnu zastaví bez ohledu na plán sítě.

Co z toho plyne pro opoziční období

Do voleb v roce 2029 potřebujeme pět kroků; nejbližší termín je 9. 11. 2026 a nejdůležitější 30. 6. 2027, kdy končí dohodovací řízení o úhradách na rok 2028. V opozici je nese resortní tým (RT) s Institutem Pi a poslaneckým klubem; žádný z kroků nevyžaduje vládní většinu.

Termín	Krok	Kdo
9. 11. 2026	Rozdělit deset předloh z tabulky mezi členy RT; každá dostane gestora a termín podnětu (schůzka RT).	RT
do 31. 3. 2027 (návrh)	Připravit podklady pro dohodovací řízení 2028: sesterská složka, výkony pro praktiky, telemonitoring, konzultace lékař–lékař; předat je SPL ČR, SPLDD ČR, ČAS a VZP.	RT, Institut Pi
do 30. 6. 2027	Podat podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 a dohodnout s krajem a VZP pilot ve třech ORP (jinak náhradní smluvní model u jedné pojišťovny).	RT, VZP, kraj, který se k pilotu přihlásí
2027, po zveřejnění ve VeKLEP	Poslat připomínky v meziresortním řízení k reformě pojištění a hygienické službě; připravit pět PN k pojištění a PN o triážním údaji k eŽádance pro druhé čtení ve Sněmovně.	poslanecký klub, RT
do 6/2028 (brána `B1`)	Zveřejnit, které PN a podněty byly přijaty a které ne, spolu s vypořádáním připomínek k verzi 3 jako podklad pro bránu B1.	RT, Institut Pi

Těchto pět kroků není alternativou k pilotu ani k věcným záměrům zákonů: ty běží souběžně a popisuje je Část VIII.

Část VII — Legislativní mapa: co se musí změnit a jak velké to je

Reforma vyžaduje čtyři až šest nových zákonů, novely 16 zákonů, šest až sedm podzákonných předpisů a tři řízení vůči Evropské komisi. Odhadujeme 250 až 350 stran paragrafového znění a zhruba dvakrát tolik důvodových zpráv a dopadových studií (RIA). Stav předpisů je k 20. 10. 2026.

To je víc, než ministerstvo zdravotnictví zvládne za jedno volební období. Proto předlohy řadíme do pěti vln a tam, kde to jde, začínáme smlouvou a vyhláškou, ne zákonem. Novými zákony jsou zákon o síti lůžkové péče, zákon o dani ze slazených nápojů, zákon o Fondu prevence a zákon o minimální ceně alkoholu; podmíněně přibude zákon o institutu pro hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a zákon o pojištění dlouhodobé péče. Zákon o primární péči je nová hlava zákona 372/2011 Sb. s doprovodnými změnami dalších zákonů.

Vlna 0 (2027–2028) běží z opozice: přes ministerstvo, VZP, dohodovací řízení a pozměňovací návrhy k vládním předlohám. Vlny 1 až 4 předpokládají vládu s Piráty od přelomu 2029/2030 (základní scénář „Vláda 2030“). Převezme-li dnešní vláda část našich návrhů (doplňkový scénář s nízkou pravděpodobností), posune se o jeden až dva roky dopředu jen vlna 0.

Rozsah předloh měříme třemi stupni. Hranice 35 paragrafů je pracovní a slouží k plánování kapacity, ne k právní kvalifikaci.

Stupeň	Definice	Rozsah znění	Průvodní dokumenty
S (malá)	novela do 10 novelizačních bodů	1–3 strany	zkrácená RIA
M (střední)	novela o 10–50 bodech, nebo nový zákon či hlava do 35 paragrafů	5–20 stran	RIA, paragrafové znění
L (velká)	novela nad 50 bodů, nebo nový zákon či hlava nad 35 paragrafů	20–50 stran	věcný záměr, plná RIA, ústavní rozbor

Tabulky uvádějí ustanovení, rozsah, předkladatele, rok předložení, účinnost a vazbu na opatření jádra (`J1` – `J10`) a podmínky (`P1` – `P5`). Označení „doprovod“ patří opatřením mimo jádro a podmínky.

Vlna 0: co jde z opozice v letech 2027–2028

Vlna 0 má devět kroků: pět závisí na vůli ministerstva nebo pojišťovny, čtyři na hlasování Sněmovny, kde Piráti nemají většinu. Nejlevnější cestou opozice jsou pozměňovací návrhy, protože vládní předlohy z let 2026 až 2027 otevírají právě ty paragrafy, které studie potřebuje. Návrh musí věcně souviset s předmětem předlohy (nález Pl. ÚS 77/06 o přílepcích; Ověřit: spisová značka).

Ověřujeme

Nástroj a ustanovení	Co se mění	Rozsah	Kdo	Předložení	Účinnost	Vazba
Smlouva pojišťovny s týmem podle § 15 a § 17 zák. 48/1997 Sb.	Pilot a pětiletá smlouva dodatkem: sesterská složka, příplatek za návštěvu, odměna za výsledky	vzor smlouvy	VZP, kraj, obce	dohoda do 6/2027	pilot 2028	`J1` , `J2` , `J4`
Úhradová vyhláška na rok 2028; § 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.	Sestry u týmových praxí, platba za funkce	S (ročně)	MZ po dohodovacím řízení	podněty do 30. 6. 2027	1. 1. 2028	`J1` , `J2`
Seznam výkonů; vyhl. 134/1998 Sb.	Telemonitoring, konzultace lékař–lékař, zpětná zpráva, plánování péče, navigace, krátká intervence, fluoridový lak a pečetění, USG u praktika	S–M	MZ, pracovní skupina k SZV	podněty 2027	1. 1. 2028	`J2` , `J3` , `J5`
Činnosti sester; vyhl. 55/2011 Sb.	Poradny chroniků, hodnocení upozornění z telemonitoringu	S	MZ (souladné s prioritou ministra: sesterská preskripce)	podněty 2027	2028	`J2`
Věstník MZ; metodika	Standard týmu a centra; minimální objemy pro čtyři obory podle vzoru onkochirurgie (první vlna – játra, slinivka, jícen – od 1. 9. 2026 podle Věstníku MZ 10/2026, další obory 2027–2030)	metodika	MZ	2027	2027–2028	`J1` , `J6`
Pozměňovací návrhy k reformě veřejného zdravotního pojištění 2030; zák. 48/1997, 551/1991, 280/1992 Sb.	Víceleté smlouvy i pro týmy primární péče	S	poslanecký klub	Sněmovna 2027	podle předlohy MZ, 2028	`J1`
Pozměňovací návrhy k novele zák. 325/2021 Sb.	Triážní údaj v eŽádance (urgentní do 2 týdnů, do 6 týdnů, plánované); měření čekání	S	poslanecký klub	2. čtení 2027	podle předlohy	`J5`
Pozměňovací návrhy k reformě hygienické služby	Prevence a fond v novém ústředním orgánu (NIVZ od 2028)	S	poslanecký klub	2027–2028	NIVZ od 2028	`P4`
Poslanecký návrh; § 36 zák. 372/2011 Sb.	Dříve vyslovené přání bez ověřeného podpisu, registr	S	poslanecký klub	2028	závisí na většině	doprovod

Zákonná lhůta dohody v úhradovém řízení končí 120 dnů před koncem roku (§ 17 odst. 5), proto podněty pro rok 2028 podáváme do 30. 6. 2027. Bez dohody vydá vyhlášku ministerstvo.

Vlna 1: peníze a daně (předložit 2030, účinnost 1. 1. 2031)

Vlna 1 tvoří jedna malá a tři střední předlohy, které se předkládají v prvním pololetí 2030 a zajišťují zdroje: daně za zdraví s plánovacím výnosem 5 mld. Kč ročně (rozpětí 5–7). Výnos se dělí podle pravidla PEER: nejméně 40 %, nejméně 2 mld. Kč (valorizovaně), pro Fond prevence, zbytek zvyšuje platbu státu do veřejného zdravotního pojištění a nesnižuje odvody z práce. Toto pravidlo patří přímo do zákona o fondu, ne do ročního rozpočtu.

Předpis a ustanovení	Co se mění	Rozsah	Kdo	Předložení	Účinnost	Vazba
Zák. 592/1992 Sb.; § 3c, § 2	Vzorec platby státu podle nákladů na státní pojištěnce; sazba pojistného (13,5 %) se mění jen v daňové reformě. Navazuje na pevný základ z tisku 235 pro rok 2027 a na návrat vzorce § 3c od 2029 (MZ avizuje zmrazení pro 2028)	S	MF s MZ	1. pololetí 2030	1. 1. 2031	J10
Zák. 353/2003 Sb.; daň z vína, § 70 (líh) a sazba piva	Tiché víno 23,40 Kč/l; poloviční sazba pro malé nezávislé vinaře do 1 000 hl (2031–2032, plná sazba 2033); automatická valorizace lihu a piva. Většina textu je správní režim malých vinařů (daňové sklady, zjednodušená evidence). Ověřit: směrnice 92/83/EHS ve znění (EU) 2020/1151 sníženou sazbu pro víno nezná (čl. 5 a 22 se týkají piva a lihu), tedy právní opora a veřejná podpora	M	MF, Celní správa	2030	1. 1. 2031	J8
Nový zákon o dani ze slazených nápojů	Pásma podle cukru, plátce, osvobození, správa Celní správou, určení výnosu. Přijat 2030 a ohlášen ve volebním programu 2029, aby výrobci měli dva roky na reformulaci. Posoudit veřejnou podporu u osvobození malých výrobců; Ověřit: kvalifikace daně vzhledem k čl. 401 směrnice 2006/112/ES	M (25–35 §§)	MF, Celní správa	2030	1. 1. 2032	J9
Nový zákon o Fondu prevence	Státní fond, příjmy z daní za zdraví, rada fondu, roční vyúčtování. Účelové vázání musí obstát vůči zák. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a 23/2017 Sb. (rozpočtová odpovědnost); vzor: zák. 104/2000 Sb. (SFDI)	M (15–25 §§)	MZ, MF	2030	1. 1. 2031	P4 (J8, J9 jako zdroj)

Ověřujeme

Zákon o fondu je účinný dřív než daň ze slazených nápojů, proto fond v letech 2031 až 2032 platí z výnosu daně z vína a valorizace; daň ze slazených nápojů jej doplňuje od 2032.

Vlna 2: primární péče (předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032)

Vlna 2 obsahuje čtyři předlohy a jedno nařízení vlády, z nichž jedna je velká: zákon o primární péči s účinností 1. 1. 2032. Zákon se píše podle pilotu: průběžné vyhodnocení (2029) a závěrečné (2030) se promítnou do znění před jeho schválením. Do účinnosti zákona funguje smluvní model (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.).

Předpis a ustanovení	Co se mění	Rozsah	Kdo	Předložení	Účinnost	Vazba
Zák. 372/2011 Sb.; nová hlava	Tým sdružené péče a centrum: definice, minimální funkce, smluvní síť ordinací, spádové území jako plánovací jednotka, skuteční majitelé a místní koncentrace, klinická nezávislost, pohotovost v centrech nad 10 lékařů. Vzor: centrum duševního zdraví (Ověřit: § 44b až 44d). Ověřit: soulad pravidel vlastnictví a koncentrace s čl. 49 SFEU (rozsudek C-169/07 Hartlauer) a rozbor ÚOHS	L (30–40 §§)	MZ (tým pro primární péči)	2. pololetí 2030	1. 1. 2032	J1, J2, J3
Zák. 48/1997 Sb.; § 17, § 18, § 22, § 46, přílohy	Víceletá smlouva se všemi pojišťovnami, platba za funkce, samostatná indikace sestry, delší indikace domácí péče, povinnost zajistit registraci do 30 dnů, hrazená zubní prevence do 18 let. Ověřit: čísla § 18 a § 22	M–L (40–60 bodů); v jedné předloze s hlavou 372/2011	MZ	2. pololetí 2030	1. 1. 2032	J1, J2, J4
NV 307/2012 Sb.	Dojezdové doby podle spádů, lhůta pro zajištění registrace	S–M	MZ, vláda	po schválení zákona, 2031	1. 1. 2032	J1, J4
Zák. 325/2021 Sb.; eŽádanka	Triážní údaj, měření čekání s doporučením i bez něj	S (jen pokud neprojde ve vlně 0)	MZ	2030	1. 1. 2032	J5
Zák. 372/2011 Sb., stížnosti (Ověřit: část osmá) a zák. 349/1999 Sb. (VOP)	Zdravotnický ombudsman s povinností reagovat do 30 dnů	M	MZ, Kancelář veřejného ochránce práv (konzultace)	2030	1. 1. 2032	doprovod
Zák. 48/1997, 551/1991, 280/1992 Sb.; vyhl. 418/2003 Sb.	Zákonné vymezení rozšířené péče a ochranného limitu (nález Pl. ÚS 36/11); fondy prevence pojišťoven se mění na fondy rozšířené péče. Ověřit: rozsah výroku Pl. ÚS 36/11 a obsah vyhl. 418/2003 Sb.	M	MZ	2030	1. 1. 2032	P4

Ověřujeme

Vlna 3: síť lůžkové péče (předložit 2031, přijmout 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033)

Zákon o síti lůžkové péče je druhá velká předloha období: předkládá se 2031, přijatý bude 2032, účinný nejpozději 1. 1. 2033 a první krajské plány vznikají 2033. Jako jediná mění práva krajů a vlastníků nemocnic, a proto stojí na ústavním a unijním rozboru hotovém před nástupem vlády. Plán sítě sám zabere 12 až 18 měsíců.

Předpis a ustanovení	Co se mění	Rozsah	Kdo	Předložení	Účinnost	Vazba
Nový zákon o síti lůžkové péče	Krajský plán služeb na 10 let, čtyři skupiny lůžek, kontrolní body, fond přeměny s milníky, garance příjmu, pandemická rezerva, rozhodování sporů vládou	L (40–70 §§)	MZ (tým pro síť), kraje	2031	nejpozději 1. 1. 2033 (přijetí 2032)	J6 , J7
Zák. 48/1997 Sb.; § 46 až 52 (část desátá, síť poskytovatelů)	Povinnost pojišťoven naplňovat plán; výběrová řízení (dnes je vyhlašuje krajský úřad) podle plánu	M	MZ	2031, v jedné předloze se zákonem o síti	jako zákon o síti	J6
Zák. 374/2011 Sb. (ZZS)	Plán pokrytí, posílení základen jako podmínka sloučení oddělení	S–M	MZ	2031, v jedné předloze	jako zákon o síti	J6 , J7
Zák. 129/2000 Sb. (kraje); zák. 372/2011 Sb. (oprávnění)	Působnost kraje v plánu, soulad oprávnění s plánem	S	MZ	2031, v jedné předloze	jako zákon o síti	J6
Pověřovací akt SGEI (akt vlády a krajů, ne zákon)	Garance příjmu jako vyrovnávací platba podle rozhodnutí Komise 2012/21/EU	akt	vláda, kraje	před první výplatou garance	nejpozději s účinností zákona	J6

Před předložením je třeba mít hotové čtyři podklady: ústavní rozbor (čl. 8 a 101 Ústavy, čl. 11, 26 a 31 Listiny), dopadovou studii fondu přeměny, posouzení, proč nestačí dnešní nástroje (§ 17 a § 46 až 52 zák. 48/1997 Sb., NV 307/2012 Sb., Věstník MZ), a pověřovací akt SGEI. Centralizace onkochirurgie (první vlna – játra, slinivka, jícen – od 1. 9. 2026 podle Věstníku MZ 10/2026, další obory 2027–2030) ukazuje, že část sítě jde měnit bez zákona; zákon je nutný pro desetiletý plán, fond přeměny a garanci příjmu.

Provozní garance příjmu se v modelu vyplácí v letech 2033 až 2040 (viz Část V), tedy až po účinnosti zákona o síti (nejpozději 1. 1. 2033) a prvních krajských plánech; samostatný právní základ pro dřívější výplaty proto není potřeba.

Vlna 4: dokončení (předložit 2032–2034, účinnost 2033 a později)

Vlna 4 dokončuje reformu: deset předloh předložených v letech 2032 až 2034, z nichž většina doplňuje jádro, ale nepodmiňuje jeho start. Po volbách 2033 závisí její pokračování na zprávě nezávislého hodnotitele (brána B4) a na složení vlády. Zákony o alkoholu a o dlouhodobé péči jsou politicky nejcitlivější; strana je předkládá voličům jako rozhodnutí, ne jako hotový slib.

Předpis a ustanovení	Co se mění	Rozsah	Kdo	Předložení	Účinnost	Vazba
Zák. 96/2004 Sb. a zák. 378/2007 Sb. (§ 80)	Sestra v pokročilé praxi s předepisováním	M	MZ	2032	1. 1. 2033	J2
Zák. 48/1997 Sb.; § 41a (Ověřit: číslo §)	Základní sazba DRG a valorizace zákonem, rizikový koridor; navazuje na konvergenci CZ-DRG 1:1,7 na 1:1,3 do 2031	M	MZ	2032	1. 1. 2033	doprovod
Zák. 551/1991 a 280/1992 Sb.	Zastoupení pojištěnců; musí navázat na reformu MZ (správní rady o 9 členech), jinak jde proti platnému stavu. Přímá volba (tisk 479) není součástí jádra	M	MZ	2032	1. 1. 2033	doprovod
Zák. 372/2011 Sb. (NZIS)	HSPA jako oficiální rámec hodnocení, povinná zpráva	S	MZ, ÚZIS	2032	1. 1. 2033	P5
Institut pro hodnocení technologií (HTA): rozšíření mandátu SÚKL a ÚZIS	Hodnocení výkonů a organizačních modelů. Plánujeme s touto cestou; nový zákon o nezávislé instituci (L) jen, pokud ministerstvo získá kapacitu	M (nový zákon: L)	MZ	2032	1. 1. 2033 (nový zákon 1. 1. 2034)	doprovod
Zák. 65/2017, 40/1995, 128/2000 Sb.	Zmocnění obcí k nočnímu prodeji, reklama, zdravotní varování na alkoholu. Varování vyžaduje notifikaci TRIS (tříměsíční standstill)	M	MZ, obce	2032	1. 1. 2033	doprovod
Nový zákon o minimální ceně alkoholu	Kalibrovaná cena za gram alkoholu; test přiměřenosti podle C-333/14	M	MZ, MF	2032	1. 1. 2034	doprovod
Zák. 108/2006 Sb. (§ 36); zák. 48/1997 Sb. (§ 17a, § 22b)	Sdílené financování sociálně-zdravotních služeb; navázat na zák. 38/2025 Sb. a rekodifikaci MPSV (2031). Ověřit: čísla § po novele 38/2025 Sb.	M	MZ, MPSV	2033	1. 1. 2034	P3 , J7
Zák. 96/2004 a 48/1997 Sb.	Psychoterapie jako zdravotní služba a její úhrada	M	MZ	2033	1. 1. 2034	doprovod
Zákon o pojištění dlouhodobé péče	Samostatný zákon, jen pokud padne rozhodnutí	L	MZ, MPSV, MF	2034, podmíněno	2036 a později	P3

Ověřujeme

Jak dlouho trvá zákon

Velká předloha trvá 24 až 42 měsíců od věcného záměru do účinnosti, střední novela 11 až 21 měsíců. Dvě krajní hodnoty rozhodují o tom, co musí být hotové dřív, než vláda nastoupí.

Krok	Velká předloha (L)	Střední novela (M)	Co lze udělat v opozici
Věcný záměr a jeho projednání	4–6 měsíců	nepotřebuje	celý věcný záměr
Paragrafové znění, RIA	4–6 měsíců	2–3 měsíce	osnova a pracovní znění
Meziresortní připomínkové řízení a vypořádání	2–3 měsíce	1–2 měsíce	nic, probíhá ve vládě
Legislativní rada vlády, vláda	2–3 měsíce	1–2 měsíce	nic
Sněmovna (tři čtení), Senát, prezident	6–12 měsíců	4–8 měsíců	jednání s kluby, pozměňovací návrhy
Legisvakance	6–12 měsíců	3–6 měsíců	nic
Celkem	24–42 měsíců	11–21 měsíců	

Od nástupu vlády v lednu 2030 zbývá do 1. 1. 2032 přesně 24 měsíců, tedy dolní hranice velké předlohy. S hotovým věcným záměrem se řetězec zkrátí na 20–36 měsíců, s hotovým záměrem i pracovním zněním s RIA na 16–30 měsíců. Samotný věcný záměr tak dává 1. 1. 2032 jen při průběhu v dolní čtvrtině rozpětí; se zněním a RIA vychází zhruba uprostřed.

U střední novely se řetězec s hotovým zněním zkrátí na 9–18 měsíců. Termín 1. 1. 2031 pro vlnu 1 je od nástupu vlády 12 měsíců, tedy ve spodní třetině rozpětí: držíme ho jen s hotovým zněním a RIA při nástupu vlády a s legisvakancí na dolní hranici. Jinak se daně i vzorec platby státu posunou o rok.

Zákon o síti (předložit 2031, přijmout 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033) má od nástupu vlády 36 měsíců, tedy horní polovinu rozpětí. Rezerva je u něj větší, ale ústavní rozbor a posouzení veřejné podpory musí být hotové dřív, protože jinak zdrží celý řetězec.

Pro věcné záměry v letech 2028–2029 z toho plynou tři pravidla:

- Věcné záměry obou velkých předloh (primární péče, síť) a znění daňových a finančních novel jsou hotové do brány `B2` (12/2029–1/2030).
- Zákon o primární péči má při nástupu vlády i pracovní znění s RIA, jinak termín 1. 1. 2032 nedrží.
- Ústavní rozbor sítě, pověřovací akt SGEI a posouzení veřejné podpory jsou hotové do 6/2029, aby v roce 2030 nezdržely vládu.

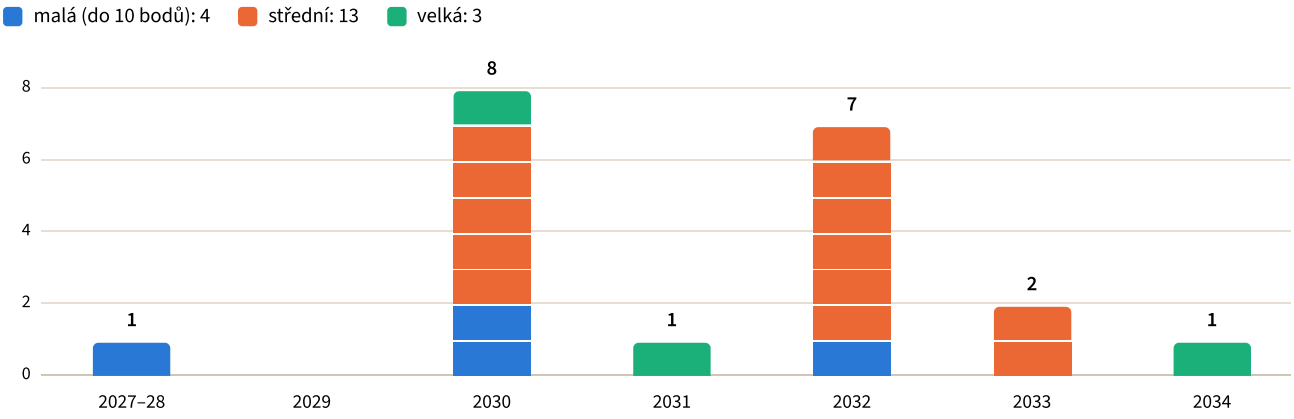
Opoziční příprava nenahrazuje úřední znění: legislativní odbor ministerstva je musí převzít a zpracovat. Proto počítáme s posílením o tým pro primární péči a tým pro síť (viz Část VIII).

Legislativní zátěž podle let

Ve dvaceti předlohách vln 0 až 4 jsou čtyři malé, třináct středních a tři velké. Graf ukazuje, že vrchol připadá na rok 2030, kdy se předkládají finanční a daňové zákony spolu se zákonem o primární péči, a na rok 2032, kdy se předkládá balíček 3.

Legislativní zátěž vrcholí v letech 2030 a 2032: osm a sedm předloh

Počet předloh podle roku předložení a rozsahu; 20 předloh vln 0–4: 4 malé, 13 středních, 3 velké



V roce 2030 se předkládají finanční a daňové zákony spolu se zákonem o primární péči, v roce 2032 balíček vlny 4. V roce 2031 je jen zákon o síti, ale Sněmovna tehdy projednává obě velké předlohy současně. Vlna 0 jde z opozice přes ministerstvo, pojišťovny a pozměňovací návrhy; jako samostatnou předlohu z ní počítáme jednu malou, souhrnně za roky 2027–2028.

Zdroj: Studie v3, Část VII, součet tabulek vln 0–4; stav předpisů k 20. 10. 2026. Jedna předloha může novelizovat více zákonů.

součet tabulek vln 0–4 v této části · 20 předloh, rok předložení 2027–2034

V roce 2031 je jen zákon o síti, ale ve Sněmovně se tehdy projednávají obě velké předlohy současně. Institut HTA je zařazen jako rozšíření mandátu SÚKL a ÚZIS (M); jako nový zákon by byl třetí velkou předlohou období.

Tři řízení vůči Evropské komisi

Reforma otevírá tři řízení vůči Evropské komisi, každé se zpožděním měřeným v měsících, a žádné nesmí zůstat na poslední chvíli. Dvě z nich (veřejná podpora a SGEI) rozhodují o tom, zda lze vyplatit peníze fondu přeměny a garanci příjmu; třetí (TRIS) rozhoduje o termínu účinnosti zákonů o alkoholu.

Řízení	K čemu slouží	Právní základ	Lhůta	Kdo a kdy
TRIS, notifikace technických předpisů	Zdravotní varování na alkoholu (novela 65/2017 a 40/1995 Sb.). Ověřit: zda minimální cena alkoholu spadá pod notifikační povinnost; i při záporné odpovědi návrh Komisi předložíme, protože test přiměřenosti podle C-333/14 je citlivý	směrnice (EU) 2015/1535	tři měsíce standstill; při podrobném stanovisku Komise nebo členského státu se prodlužuje	MZ přes ÚNMZ (Ověřit: kontaktní místo); návrh se notifikuje před předložením vládě, tedy 2031–2032
SGEI, pověřovací akt a vyrovnávací platba	Garance příjmu nemocnicím v plánu sítě jako úhrada služby obecného hospodářského zájmu	rozhodnutí Komise 2012/21/EU (nemocnice bez stropu částky); kritéria Altmark, C-280/00	bez notifikace, pokud akt splní podmínky rozhodnutí: obsah pověření, doba nejvýše 10 let, kontrola nadměrné náhrady aspoň jednou za tři roky (Ověřit: čl. 2, 4 a 6)	vláda a kraje; akt hotový před první výplatou garance
Veřejná podpora, posouzení a případná notifikace	Investiční část fondu přeměny (5–10 mld. Kč), snížená sazba daně z vína pro malé vinaře, osvobození malých výrobců od daně ze slazených nápojů, platby soukromým týmům	čl. 107 a 108 SFEU; nařízení (EU) 2015/1589	předběžné posouzení Komise dva měsíce od úplné notifikace (Ověřit); formální šetření může trvat déle než rok	ministerstva přes ÚOHS jako koordinátora veřejné podpory (Ověřit: zák. 215/2004 Sb.); právní stanovisko 2029, notifikace vlny 1 v roce 2030, fondu přeměny 2031

Ověřujeme

Pravidla vlastnictví a místní koncentrace v primární péči nejsou veřejná podpora, ale zásah do svobody usazování (čl. 49 SFEU; rozsudek C-169/07 Hartlauer). Směrnice o službách na zdravotní služby nedopadá (čl. 2 odst. 2 písm. f) směrnice 2006/123/ES), takže notifikace podle ní odpadá, rozbor přiměřenosti ale zůstává.

Co jde bez zákona

Osm nástrojů umožňuje začít reformu bez nového zákona, ale každý má hranici, kterou překoná až zákon. Právní oporou smluvního modelu je poslední věta § 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.: úhradová vyhláška se použije, pokud se poskytovatel a pojišťovna nedohodnou o způsobu a výši úhrady jinak. Ministerstvo tento prostor vykládá úzce (stanovisko z roku 2012: pojišťovna vyhlášku jednostranně nevyloučí); Ověřit: aktuální výklad.

Ověřujeme

Nástroj	Právní opora	Co umožňuje	Hranice
Smlouva pojišťovny s týmem	smlouva podle § 15 a § 17 zák. 48/1997 Sb.	Pětiletá smlouva, sesterská složka, příplatek za návštěvu, odměna za výsledky	Platí jen pro jednu pojišťovnu; o smlouvách rozhoduje vedení pojišťovny, střet zájmů autora je popsán v úvodu studie; Ověřit: vztah k § 46 (výběrové řízení) u nových smluv
Úhradová vyhláška	§ 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.	Sestry u týmových praxí, platba za funkce	Ročně jednou; rozhoduje ministr, když dohoda nevznikne do 120 dnů před koncem roku
Seznam zdravotních výkonů	vyhl. 134/1998 Sb. (Ověřit: zákonné zmocnění)	Nové výkony: telemonitoring, konzultace, navigace, USG	Výkon bez ceny v úhradové vyhlášce se neplatí; hodnotu bodu stanoví až vyhláška
Činnosti sester	vyhl. 55/2011 Sb. (Ověřit: zmocnění v zák. 96/2004 Sb.)	Poradny chroniků, hodnocení upozornění, rozšířené kompetence v mezích zákona	Nesmí překročit zákon: předepisování léčiv (§ 80 zák. 378/2007 Sb.) patří do vlny 4
Věstník MZ	metodika; precedens: centralizace onkochirurgie, první vlna – játra, slinivka, jícen – od 1. 9. 2026 podle Věstníku MZ 10/2026, další obory 2027–2030	Standard týmu a centra, minimální objemy pro čtyři obory	Není právní předpis; závaznost vzniká až smlouvami s pojišťovnami (Ověřit)
Obce a kraje	§ 39 zák. 128/2000 Sb. (nakládání s majetkem obce), rozpočet obce nebo kraje	Prostory pro týmy, senior taxi	Nelze přikázat pojišťovně ani poskytovateli
Výkup praxí uvnitř týmu	zák. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), vzorová smlouva	Nezávislý odhad ceny, úvěr se splátkami na 5 až 10 let	Žádná platba ze smlouvy s pojišťovnou; státní záruka potřebuje vlastní právní základ (Ověřit)
AI zapisovatel a telemonitoring	změna zákona se nepředpokládá (Ověřit: § 11c a vyhl. 30/2025 Sb. citované v minulé verzi)	Provoz v ordinacích	Zakázky musí od začátku požadovat MDR (nařízení (EU) 2017/745), EHDS (nařízení (EU) 2025/327) a NIS2 (směrnice (EU) 2022/2555); AI Act (nařízení (EU) 2024/1689)

Ověřujeme

Zákon je nezbytný pro tři věci: víceleté jistoty vůči všem pojišťovnám, pravidla vlastnictví a koncentrace a práva krajů a vlastníků v plánu sítě. Pokud strana přesvědčí MZ k vyhlášce a VZP k pilotu, začne reforma bez jediného zákona.

Věcné záměry k napsání v opozici

Deset podkladů musí být hotových do brány B2 (12/2029–1/2030), aby je vláda mohla předložit v prvních měsících roku 2030; tři z nich mají teze už do brány B1 (6/2028). Rozdělení mezi členy resortního týmu (RT) projedná schůzka 9. 11. 2026, termíny jsou návrh k diskusi.

Věcný záměr	Rozsah	Garant	Termín hotovosti	Obsah a podmínka
Zákon o primární péči (nová hlava 372/2011 Sb. a novela 48/1997 Sb.)	L	doplní RT 9. 11.	teze B1 (6/2028); záměr s pracovním zněním a RIA B2 (12/2029)	Tým a centrum, pravidla vlastnictví, pohotovost center, víceletá smlouva; zohlední průběžné vyhodnocení pilotu
Zákon o síti lůžkové péče (vlna 3)	L	doplní RT 9. 11.	teze B1 (6/2028); záměr B2 (12/2029)	Krajský plán, fond přeměny, garance příjmu, pandemická rezerva; ústavní rozbor a dopadová studie fondu
Právní stanovisko k SGEI a veřejné podpoře	studie	doplní RT 9. 11.	6/2029	Fond přeměny, garance příjmu, daňové úlevy pro malé vinaře a výrobce; návrh pověřovacího aktu
Finanční novela: platba státu a daně z vína, lihu a piva	S + M	doplní RT 9. 11.	znění a RIA B2 (12/2029)	§ 3c a § 2 zák. 592/1992 Sb., zák. 353/2003 Sb.; správní režim malých vinařů; právní oporu snížené sazby ověřit
Zákon o dani ze slazených nápojů	M	doplní RT 9. 11.	znění a RIA B2 (12/2029); ohlášení ve volebním programu 2029	Pásma podle cukru, osvobození, správa Celní správou
Zákon o Fondu prevence	M	doplní RT 9. 11.	teze B1 (6/2028); znění a RIA B2 (12/2029)	Pravidlo dělení výnosu (2 mld. Kč fondu, zbytek platba státu); stanovisko MF k zák. 218/2000 a 23/2017 Sb. do 6/2029
Zdravotnický ombudsman a stížnosti	M	doplní RT 9. 11.	osnova B2 (12/2029); znění připravuje MZ 2030	Část osmá zák. 372/2011 Sb., zák. 349/1999 Sb.; konzultace s Kanceláří veřejného ochránce práv
Rozšířená péče, ochranný limit a fondy pojišťoven	M	doplní RT 9. 11.	ústavní rozbor 6/2029; osnova B2 (12/2029)	Nález Pl. ÚS 36/11; zák. 48/1997, 551/1991, 280/1992 Sb.
Balíček 3: sestra v pokročilé praxi, DRG zákonem, rozšíření mandátu SÚKL a ÚZIS (HTA)	M	doplní RT 9. 11.	teze po B2 (2030); není podmínkou B2	Zák. 96/2004, 378/2007, 48/1997 Sb.; koridor DRG navázat na konvergenci 1:1,7 na 1:1,3 do 2031
Regulace alkoholu: varování, reklama, noční prodej, minimální cena	M	doplní RT 9. 11.	teze po B2 (2030–2031); notifikace TRIS 2031–2032	Zák. 65/2017, 40/1995, 128/2000 Sb.; test přiměřenosti C-333/14; předkládá se voličům jako rozhodnutí

Ověřit před podáním návrhů

Dvanáct ustanovení a výroků je třeba před podáním prvního návrhu ověřit v konsolidovaném znění; do té doby jsou v tabulkách označena „Ověřit“.

- Konečné znění tisku 235 a úhradové vyhlášky na rok 2027 (605 mld. Kč).
- Čísla § 18, § 22, § 22b, § 17a a § 41a zák. 48/1997 Sb. a § 36 zák. 108/2006 Sb. po novele 38/2025 Sb.
- Zákonné zmocnění vyhl. 134/1998 Sb. a 55/2011 Sb.
- Čísla § 44b až 44d a označení části osmé zák. 372/2011 Sb.
- Rozsah výroku Pl. ÚS 36/11 a obsah vyhl. 418/2003 Sb.
- Spisová značka nálezu o přílepcích (Pl. ÚS 77/06).
- Směrnice 92/83/EHS ve znění (EU) 2020/1151: opora pro sníženou sazbu u vína; čl. 401 směrnice 2006/112/ES u daně ze slazených nápojů.
- Odkaz „§ 31a“ u zák. 325/2021 Sb. a zák. 300/2025 Sb. (v minulé verzi uváděné bez ověření).
- P1 (zrychlení aprobací, nábor ze zahraničí) může přidat zák. 95/2004 Sb. jako sedmnáctý novelizovaný zákon.
- Čl. 2, 4 a 6 rozhodnutí 2012/21/EU a lhůty řízení o veřejné podpoře.
- Zda minimální cena alkoholu spadá pod směrnici (EU) 2015/1535.
- Vztah smluv o víceletých týmech k § 46 zák. 48/1997 Sb. (výběrová řízení).

Část VIII — Proces změny: fáze, brány a harmonogram 2026–2038

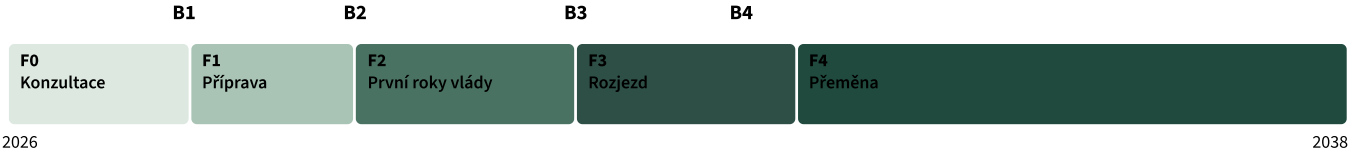
Reforma má pět fází a čtyři brány; první dvě fáze, od listopadu 2026 do prosince 2029, jsou konzultační a přípravné. V opozici nelze přijmout zákon, ale lze podepsat pilot, podat podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 a napsat věcné záměry zákonů. Hlavní poselství tohoto období zní: „Představujeme plán a hledáme pro něj podporu. Do voleb chceme mít dohodu s odborníky, hotové věcné záměry a běžící pilot.“

Každá brána má měřitelné kritérium z dat dostupných v reálném čase, veřejné hodnocení a tři možné výsledky: pokračovat, upravit, nebo zmenšit na variantu B. Všechny termíny platí pro základní scénář „Vláda 2030“, tedy Piráti ve vládě od přelomu let 2029 a 2030. Doplňkový scénář, v němž část kroků převezme dnešní vláda, popisuje tabulka dvou scénářů níže.

Fáze a brány

Fáze F0 začíná v listopadu 2026 a fáze F4 končí kolem roku 2038, kdy má být v provozu asi 520 týmů a podíl akutní lůžkové péče klesnout z 29,7 % na 26 %. Každá fáze končí bránou, kterou řídící orgán reformy projde jen s daty v ruce.

Každá fáze končí bránou, kterou projdeme jen s daty v ruce



Klikněte na bránu a uvidíte, co v ní musí platit a co se stane, když ne.

11/2026–6/2028

F0 · Konzultace a koalice podpory

- konzultace verze 3, kulaté stoly, memoranda o podpoře
- pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030, novele zák. 325/2021 Sb. a reformě hygienické služby
- podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 (do 30. 6. 2027) a do seznamu výkonů
- dohoda o pilotu (kraj, VZP, obce)

7/2028–12/2029

F1 · Příprava vládnutí

- věcné záměry zákona o primární péči, zákona o síti, finanční novely a daňových zákonů
- volební program
- pilot běží
- koaliční vyjednávání

2030–2031

F2 · První dva roky ve vládě

- vlna 1 předložena 2030, účinnost 1. 1. 2031
- vlna 2 předložena 2030, účinnost 1. 1. 2032
- vlna 3 předložena 2031
- závěrečné vyhodnocení pilotu 2030; úhradové vyhlášky 2031 a 2032

2032–2033

F3 · Náběh

- zákon o primární péči účinný 1. 1. 2032
- zákon o síti přijat 2032, účinný nejpozději 1. 1. 2033, první krajské plány 2033
- vlna 4 (sestra v pokročilé praxi, DRG zákonem, hodnocení technologií) od roku 2033

2034–2038

F4 · Přeměna a ukotvení

- náběh týmů k asi 520 kolem roku 2038
- přeměna 8 000 akutních lůžek podle krajských plánů
- podíl akutní lůžkové péče klesne z 29,7 % na 26 % kolem roku 2038

Textová verze

Fáze a období	Co se v ní stane	Brána na konci fáze
F0 Konzultace a koalice podpory, 11/2026–6/2028	konzultace verze 3, kulaté stoly, memoranda o podpoře; pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030, novele zák. 325/2021 Sb. a reformě hygienické služby; podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 (do 30. 6. 2027) a do seznamu výkonů; dohoda o pilotu (kraj, VZP, obce)	B1 Mandát, červen 2028. Musí platit: Připomínky jsou vypořádané a zveřejněné. Plán je projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi (praktici, sestry, lékařská komora, pojišťovny, kraje, obce, pacienti, odbory) a jejich výhrady jsou zapracované. Zkouška ve třech regionech je podepsaná. Strana potvrdila, s jakým výnosem daní za zdraví rozpočet reformy počítá. Když ne: Co s některou organizací projednané není nebo zůstalo bez dohody, do volebního programu nejde. Místo zkoušky s krajem náhradní smlouva s jednou pojišťovnou.
F1 Příprava vládnutí, 7/2028–12/2029	věcné záměry zákona o primární péči, zákona o síti, finanční novely a daňových zákonů; volební program; pilot běží; koaliční vyjednávání	B2 Koaliční smlouva, přelom let 2029 a 2030. Musí platit: Jádro plánu je v koaliční smlouvě a v programu vlády. Zákony jsou v plánu vlády na rok 2030. Když ne: Do plánu vlády jde jen dohodnuté jádro. Zbytek zůstává programem pro další období.
F2 První dva roky ve vládě, 2030–2031	vlna 1 předložena 2030, účinnost 1. 1. 2031; vlna 2 předložena 2030, účinnost 1. 1. 2032; vlna 3 předložena 2031; závěrečné vyhodnocení pilotu 2030; úhradové vyhlášky 2031 a 2032	B3 Lidé a data, prosinec 2031. Musí platit: V prvních týmech je obsazená aspoň polovina míst pro sestry. Zákon o primární péči je schválený. Kraje pracují na plánech sítě. Když ne: Reforma pokračuje bez nových budov zdravotních center (varianta B). Všechno, co na budovách nezávisí, běží dál.
F3 Náběh, 2032–2033	zákon o primární péči účinný 1. 1. 2032; zákon o síti přijat 2032, účinný nejpozději 1. 1. 2033, první krajské plány 2033; vlna 4 (sestra v pokročilé praxi, DRG zákonem, hodnocení technologií) od roku 2033	B4 Nezávislé hodnocení, rok 2033, před volbami. Musí platit: Nezávislý hodnotitel (statistický ústav ÚZIS s univerzitou) vyhodnotí osm hlavních ukazatelů. Když ne: Hodnotitel doporučí pokračovat, upravit, nebo zmenšit. Rozhodnutí i důvody se zveřejní.

Fáze a období	Co se v ní stane	Brána na konci fáze
F4 Přeměna a ukotvení, 2034–2038	náběh týmů k asi 520 kolem roku 2038; přeměna 8 000 akutních lůžek podle krajských plánů; podíl akutní lůžkové péče klesne z 29,7 % na 26 % kolem roku 2038	–

roadmapa reformy · 5 fází, 4 brány · základní scénář Vláda 2030

První dvě brány jsou politické: `B1` měří, zda má plán podporu odborníků, `B2` zda se dostal do koaliční smlouvy. Druhé dvě jsou věcné: `B3` měří, zda jsou sestry a data, `B4` zda reforma funguje podle nezávislého hodnotitele.

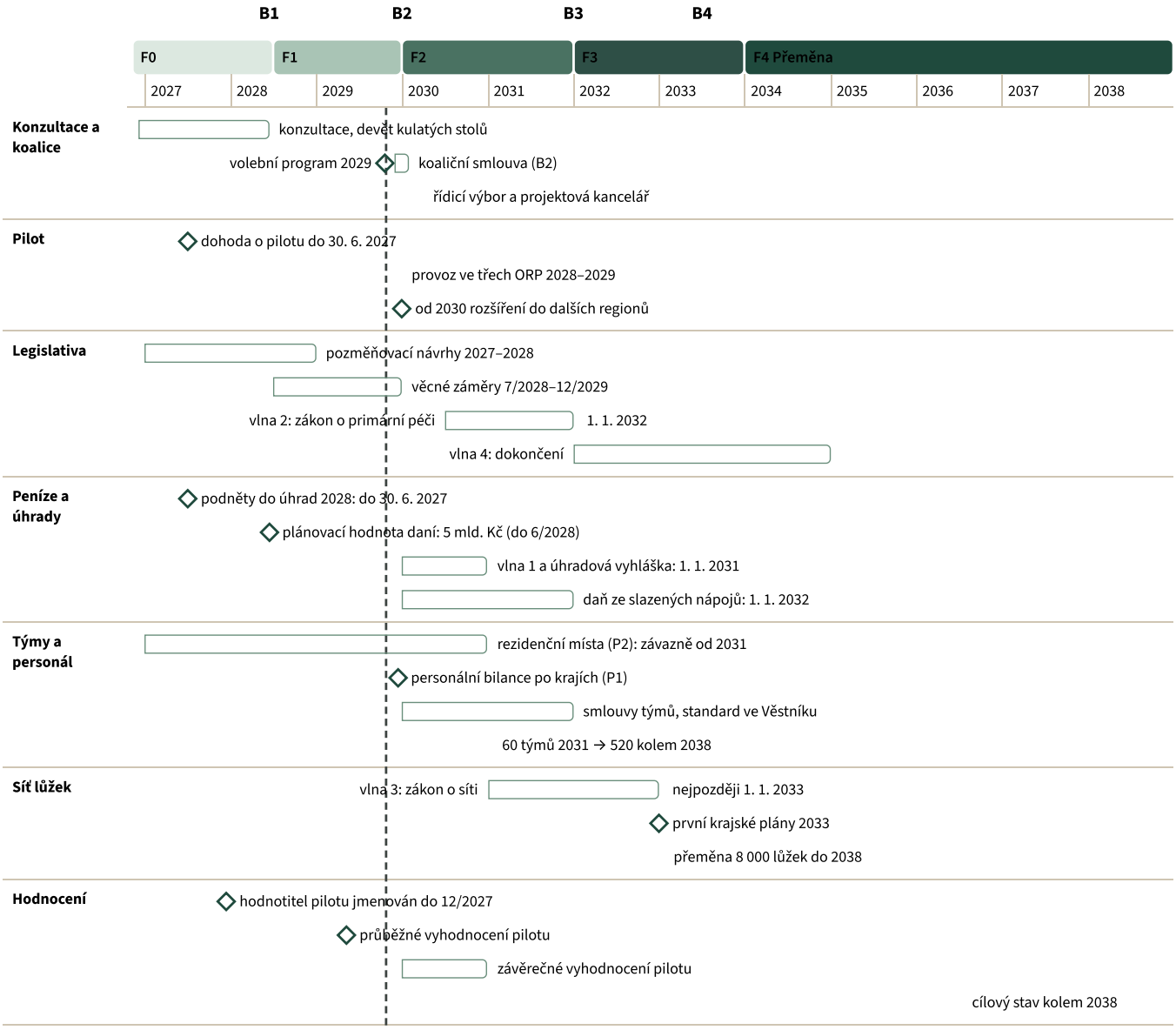
Fáze	Období	Co se v ní stane
F0 Konzultace a koalice podpory	11/2026–6/2028	konzultace verze 3, kulaté stoly, memoranda o podpoře; pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030, novele zák. 325/2021 Sb. a reformě hygienické služby; podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 (do 30. 6. 2027) a do seznamu výkonů; dohoda o pilotu (kraj, VZP, obce)
F1 Příprava vládnutí	7/2028–12/2029	věcné záměry zákona o primární péči, zákona o síti, finanční novely a daňových zákonů; volební program; pilot běží; koaliční vyjednávání
F2 První dva roky ve vládě	2030–2031	vlna 1 předložena 2030, účinnost 1. 1. 2031; vlna 2 předložena 2030, účinnost 1. 1. 2032; vlna 3 předložena 2031; závěrečné vyhodnocení pilotu 2030; úhradové vyhlášky 2031 a 2032
F3 Náběh	2032–2033	zákon o primární péči účinný 1. 1. 2032; zákon o síti přijat 2032, účinný nejpozději 1. 1. 2033, první krajské plány 2033; vlna 4 (sestra v pokročilé praxi, DRG zákonem, hodnocení technologií) od roku 2033
F4 Přeměna a ukotvení	2034–2038	náběh týmů k asi 520 kolem roku 2038; přeměna 8 000 akutních lůžek podle krajských plánů a podíl akutní lůžkové péče 26 % kolem roku 2038

Výsledek každé brány je jeden ze tří: pokračovat, upravit, nebo zmenšit. Rozhodnutí i jeho důvody se zveřejňují; co se děje při nesplnění jednotlivé brány, uvádí tabulka v pravidlech rozhodování níže.

Harmonogram 2026–2038

Harmonogram má tři pevné body: 30. 6. 2027 (dohoda o pilotu a podněty do dohodovacího řízení), volby do Sněmovny v říjnu 2029 a 1. 1. 2032 (účinnost zákona o primární péči). Graf je rozdělený na dvě období, aby se daly popisky přečíst.

Finanční a daňové změny jdou na 1. 1. 2031 a velké zákony na 1. 1. 2032 až 2033, takže se nekumulují s rokem 2029



PN je pozměňovací návrh poslaneckého klubu. Účinnost podnětů z 30. 6. 2027 už od 1. 1. 2028 závisí na dnešním ministerstvu a v základním scénáři se s ní nepočítá; první vyhláška nové vlády platí od 1. 1. 2031. Přesná data krajských voleb 2028 a voleb 2029 jsou orientační.

Textová verze

Dráha	Termín	Co se děje	Krok
Konzultace a koalice	7. 12. 2026 – 6/2028	Schválení verze 3 (7. 12. 2026), připomínky do 31. 3. 2027, kulaté stoly 2/2027–6/2028.	1–2
Konzultace a koalice	do voleb 10/2029	Volební program 2029 s jádrem J1–J10, ohlášením daně ze slazených nápojů, personální bilancí po krajích a otevřeným modelem nákladů.	12
Konzultace a koalice	12/2029–1/2030	Brána B2: jádro v koaliční smlouvě a programovém prohlášení; předlohy vln 1–3 v legislativním plánu vlády 2030.	13
Konzultace a koalice	do 3/2030	Řízení ve vládě: řídicí výbor, projektová kancelář (0,4 mld. Kč ročně), dva nové týmy legislativního odboru MZ.	14
Pilot	do 30. 6. 2027	Dohoda o pilotu ve třech ORP: kraj, který se přihlásí, VZP a obce.	4
Pilot	1. 1. 2028, provoz 2028–2029	Start pilotu ve třech ORP, provoz dva roky.	7

Dráha	Termín	Co se děje	Krok
Pilot	od 2030	Pilot se postupně rozšiřuje do dalších regionů s kontrolními oblastmi.	17
Legislativa	2027–2028	Pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030, novele zák. 325/2021 Sb. a reformě hygienické služby (podle projednávání ve Sněmovně).	6
Legislativa	7/2028–12/2029	Věcné záměry zákona o primární péči, zákona o síti, finanční novely, daňového zákona a zákona o Fondu prevence; teze tří záměrů už k B1.	10
Legislativa	předložit 2. pol. 2030, účinnost 1. 1. 2032	Vlna 2: zákon o primární péči (J1–J4); investice do center se uvolňují až po splněné bráně B3.	18, 24
Legislativa	předložit 2032–2034, účinnost 2033–2034	Vlna 4: sestra v pokročilé praxi s preskripcí, základní sazba DRG zákonem, HSPA v zákoně (P5), hodnocení technologií, sdílené financování sociálně-zdravotní péče (P3).	26
Peníze a úhrady	podat do 30. 6. 2027	Podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 a do seznamu výkonů. Účinnost 1. 1. 2028 jen při vůli dnešního MZ, jinak 1. 1. 2031.	3
Peníze a úhrady	do 6/2028	Strana potvrdí plánovací hodnotu daní za zdraví pro rozpočet reformy (5 mld. Kč ročně, rozpětí 5–7) vedle cíle PEER (10–15 mld. Kč) a pravidlo dělení podle PEER: nejméně 40 % Fondu prevence, aspoň 2 mld. Kč, zbytek platbě státu.	8
Peníze a úhrady	předložit 1. pol. 2030, účinnost 1. 1. 2031	Vlna 1: nový vzorec platby státu (J10), daň z tichého vína a valorizace (J8; víno poloviční sazbou 2031–2032, plná 2033), zákon o Fondu prevence (P4). Úhradová vyhláška 2031: sesterská složka úhrady, platba za funkce, nové výkony.	15, 20
Peníze a úhrady	přijat 2030, účinnost 1. 1. 2032	Zákon o dani ze slazených nápojů (J9), pásma podle cukru.	16
Týmy a personál	podnět 2027, závazně od rozpočtu 2031	Podnět do dohodovacího řízení 2027 a do rozpočtu 2028; závazně od rozpočtu 2031.	P2
Týmy a personál	zveřejnit do B2 (12/2029)	Zveřejněná personální bilance po krajích; měření v bráně B3 (12/2031).	P1
Týmy a personál	od 2030 do účinnosti zákona	Smluvní model před zákonem: pětileté smlouvy týmů se všemi pojišťovnami, standard týmu ve Věstníku MZ.	19
Týmy a personál	od 2031	Náběh týmů a sester: 60 týmů v roce 2031, 120 v roce 2032, 330 v roce 2035; kolem roku 2038 asi 520 týmů.	21
Síť lůžek	předložit 2031, přijmout 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033	Vlna 3: zákon o síti lůžkové péče (J6, J7: krajský plán na 10 let, čtyři skupiny lůžek, fond přeměny, garance příjmu); pověřovací akt SGEI před první výplatou garance.	22
Síť lůžek	2033	První krajské plány sítě (12–18 měsíců práce) s doloženou kapacitou následné a dlouhodobé péče a dojezdem záchranné služby.	25
Síť lůžek	od 2033	Přeměna akutních lůžek podle krajských plánů: 8 000 do roku 2038, asi 1 330 ročně; každé lůžko až po prokázané kapacitě dlouhodobé péče a dojezdu; stop při obložnosti nad 85 %.	28
Hodnocení	do 12/2027	Jmenování nezávislého hodnotitele pilotu (ÚZIS s univerzitou), zveřejněný protokol a kontrolní ORP.	5
Hodnocení	jaro 2029	Průběžné vyhodnocení pilotu po roce provozu, promítnuté do věcného záměru zákona o primární péči.	11
Hodnocení	2030	Závěrečné vyhodnocení pilotu, promítnuté do paragrafového znění vlny 2.	17
Hodnocení	kolem roku 2038	Cílový stav: 520 týmů, asi 4 000 sester navíc, 8 000 přeměněných lůžek, podíl akutní lůžkové péče 26 %.	29

harmonogram 2026–2038 · 7 drah · základní scénář Vláda 2030 · termíny podle této studie a oponentního posudku verze 2

Na 1. 1. 2029 reforma nic neklade: ten den nabíhá strop pobytu podle § 22b zák. 48/1997 Sb., zrušení § 52 zák. 108/2006 Sb. a vrací se vzorec platby státu. Finanční a daňové změny jdou na 1. 1. 2031 a velké zákony na 1. 1. 2032 až 2033, takže se poskytovatelům ani pojišťovnám nekumulují s rokem 2029.

Zkratka PN v grafu znamená pozměňovací návrh poslaneckého klubu. Krok „vyhláška a SZV 2028“ označený MZ závisí na dnešním ministerstvu a v základním scénáři se s ním nepočítá; první vyhláška, kterou připraví nová vláda, platí od 1. 1. 2031.

- Ověřit: přesná data krajských voleb 2028 a voleb do Sněmovny 2029 podle rozhodnutí prezidenta; v grafu jsou orientačně.

Ověřujeme

Dva scénáře

Základní scénář „Vláda 2030“ počítá s tím, že do voleb v říjnu 2029 dnešní vláda z reformy nic nepřevezme. Doplňkový scénář „Dnešní vláda převezme část“ má nízkou pravděpodobnost a týká se jen vlny 0: vyhlášek, Věstníku a pozměňovacích návrhů k vládním předlohám. Zákony a daně se v něm neposouvají.

Krok	Základní scénář Vláda 2030	Doplňkový scénář Dnešní vláda převezme část	Na čem to závisí
Pilot ve třech ORP (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.)	provoz 2028–2029	stejně	dohoda kraje, VZP a obcí do 6/2027; o smlouvě rozhoduje vedení VZP, ne vláda
Podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028	podány do 30. 6. 2027	stejně	kluby poskytovatelů a pojišťovny, které podnět převezmou
Sestry u týmových praxí v úhradové vyhlášce	1. 1. 2031	1. 1. 2029 až 2030, nejdřív 2028	vůle dnešního MZ převzít podnět z dohodovacího řízení
Nové výkony v seznamu výkonů (telemonitoring, konzultace lékař–lékař)	1. 1. 2031	1. 1. 2029 až 2030, nejdřív 2028	Pracovní skupina k SZV, MZ

Krok	Základní scénář Vláda 2030	Doplňkový scénář Dnešní vláda převezme část	Na čem to závisí
Kompetence sester (vyhl. 55/2011 Sb.)	2031	2029	soulad s prioritou ministra (sesterská preskripce)
Standard týmu ve Věstníku MZ	2030	2028	MZ; vzorem je centralizace onkochirurgie (první vlna – játra, slinivka, jícen – od 1. 9. 2026 podle Věstníku MZ 10/2026, další obory 2027–2030)
Triážní údaj v eŽádance	zákonem ve vlně 2, účinnost 1. 1. 2032	pozměňovací návrh k novele zák. 325/2021 Sb., 2028	přijetí pozměňovacího návrhu ve Sněmovně
Víceleté smlouvy i pro týmy	zákonem ve vlně 2, účinnost 1. 1. 2032	pozměňovací návrh k reformě v. z. p. 2030 (Sněmovna 2027, účinnost 2028)	podpora koalice pro pozměňovací návrh opozice
Valorizace daní z lihu a piva, sazba na tiché víno	1. 1. 2031 (víno v plné sazbě 2033)	beze změny	poslanecký návrh opozice bez podpory vlády typicky neprojde prvním čtením
Nový vzorec platby státu (§ 3c zák. 592/1992 Sb.)	1. 1. 2031	beze změny	tisk 235 vrací vzorec pro rok 2029, MZ avizuje zmrazení pro rok 2028
Daň ze slazených nápojů	přijata 2030, účinná 1. 1. 2032	beze změny	ohlášení ve volebním programu 2029, vládní většina
Zákon o primární péči	účinnost 1. 1. 2032	beze změny	věcný záměr hotový při nástupu vlády, výsledky pilotu
Zákon o síti lůžkové péče	přijetí 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033, první krajské plány 2033	minimální objemy pro vybrané obory přes Věstník dřív, zákon beze změny	ústavní rozbor, SGEI, dopadová studie

Všechny cíle a ukazatele v této studii počítají se základním scénářem. Doplňkový scénář je příležitost, ne plán: když nastane, náběh týmů začne dřív, ale žádná brána se neposune.

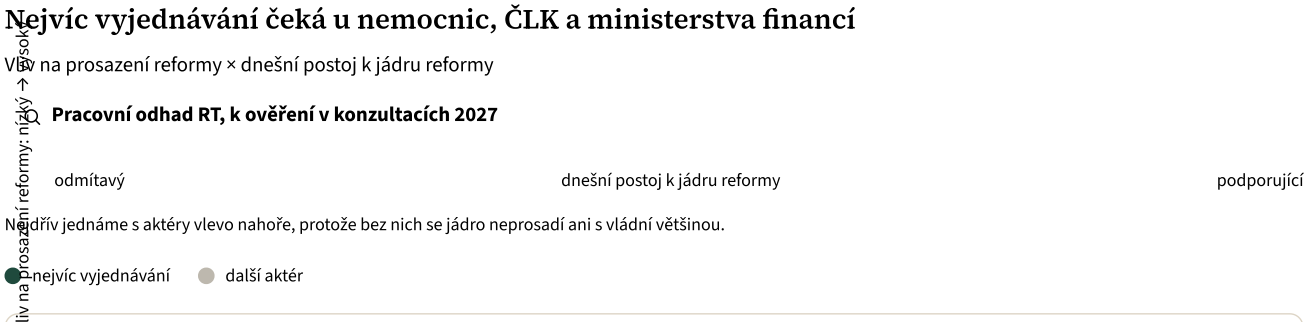
Konzultační fáze 2026–2029

Do brány `B1` v červnu 2028 musí být plán projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi a jejich výhrady zapracované: SPL ČR, SPLDD ČR, ČAS, ČLK, VZP, SZP ČR, Asociace krajů ČR, SMO ČR, pacientské organizace a odbory. Co není projednané nebo zůstalo bez dohody, do volebního programu nejde. Konzultace začínají schválením verze 3 resortním týmem 7. 12. 2026; předchází jí schůzka 27. 10. 2026 k verdiktu posudku a prioritam a schůzka 9. 11. 2026 k rozdělení věcných záměrů mezi členy týmu. Do té doby je třeba vyřídit přihlášku nového člena RT, která čeká od 25. 9. 2026: na věcné záměry bude potřeba každý člověk.

Politický kalendář určuje pořadí jednání. Po komunálních volbách v říjnu 2026 se ustavují nová vedení obcí, takže obce pilotu oslovujeme v prvním čtvrtletí 2027. Krajské volby na podzim 2028 přijdou až po bráně `B1`, a proto musí smlouva pilotu obstát i při změně vedení kraje.

Nejvíc vyjednávání čeká u nemocnic, ČLK a ministerstva financí

Vliv na prosazení reformy × dnešní postoj k jádru reformy



Textová verze

Umístění je pracovní odhad resortního týmu, ne zjištěný postoj; první jednání v roce 2027 ho ověří a mapa se překreslí.

Vyjednávat: velký vliv, výhrady

- MF a NRR: první krok předat model a požádat o technickou oponenturu (2028)
- ČLK: první krok jednání s vedením komory nad verzí 3 (1. pololetí 2027)
- nemocnice: AČMN a krajské: první krok kulatý stůl k síti lůžek (kontakt 2027, kulatý stůl 2028)
- Asociace krajů ČR: první krok výzva krajům k přihlášce do pilotu (1. čtvrtletí 2027)
- odbory: LOK-SČL, OSZSP ČR: první krok kulatý stůl k síti lůžek (2028)

Získat závazek: velký vliv, podpora

- potenciální koaliční partneři: první krok setkání zdravotních expertů stran (2028–2029)
- VZP: první krok návrh smlouvy pilotu vedení VZP (1. čtvrtletí 2027, dohoda do 30. 6. 2027)
- SPL ČR: první krok pracovní skupina ke standardu týmu (1. čtvrtletí 2027)
- SZP ČR: první krok jednání o náhradním modelu (2027)
- ČAS: první krok společná pracovní skupina (1. čtvrtletí 2027)

Informovat: menší vliv, výhrady

- SPLDD ČR: první krok schůzka k dětským týmům (1. čtvrtletí 2027)
- vinaři a výrobci nápojů: první krok jednání o režimu malých vinařů (konzultace 2028, ohlášení v programu 2029)

Zapojit: menší vliv, podpora

- SMO ČR: první krok setkání s novými vedeními obcí (1. čtvrtletí 2027)
- APSS ČR: první krok společná bilance kapacit (2028)
- pacientské organizace: první krok veřejná konzultace verze 3 (od 12/2026)
- Mladí praktici: první krok dotazník a setkání (1. pololetí 2027)

Podklad: studie v3, ř. 1846–1873 (mapa ř. 1852–1854, tabulka aktérů ř. 1856–1873).

mapa aktérů · 16 subjektů · pracovní odhad RT, k ověření

Mapa je pracovní odhad resortního týmu, ne zjištěný postoj: každé umístění ověří první jednání v roce 2027 a mapa se po něm překreslí. Nejdřív jednáme s aktéry vlevo nahoře, protože bez nich se jádro neprosadí ani s vládní většinou.

Aktér	Co od něj potřebujeme	Co mu nabízíme	První krok	Kdy
SPL ČR	spolutvorbu standardu týmu a pětileté smlouvy, podporu pilotu	sesterskou složku úhrady, pětiletou smlouvu, zrušení preskripčních omezení, vzorovou smlouvu o výkupu praxe	pracovní skupina ke standardu týmu	1. čtvrtletí 2027
SPLDD ČR	souhlas s dětskými týmy a s registrací dětí na venkově u praktika pro dospělé v týmu	PLDD nerušíme, dětské týmy se sestrami, řešení rezidencí	schůzka k dětským týmům	1. čtvrtletí 2027
Mladí praktici	zájem vstoupit do týmů v pilotních ORP, zpětnou vazbu k podmínkám	týmovou praxi místo samoty, výkup praxe, kompetence včetně ultrazvuku	dotazník a setkání	1. pololetí 2027
ČLK	aspoň neutralitu ke kompetencím sester a k triážnímu údaji v eŽádance	jmenovitého ošetřujícího lékaře v týmu, klinickou nezávislost, méně administrativy	jednání s vedením komory nad verzí 3	1. pololetí 2027
ČAS	spolutvorbu sesterských kompetencí a sesterské složky	rozšířené kompetence, samostatnou indikaci, sestru v pokročilé praxi ve vlně 4	společná pracovní skupina	1. čtvrtletí 2027
Odbory (LOK-SČL, OSZSP ČR)	podporu přeměny lůžek a náboru sester	přeměnu místo rušení, garanci příjmu z fondu přeměny, nová místa v týmech	kulatý stůl k síti lůžek	2028
VZP	pilot, sesterskou složku v dohodovacím řízení	měřitelné výsledky, data pro řízení sítě, méně odvratitelných hospitalizací	návrh smlouvy pilotu vedení VZP	1. čtvrtletí 2027, dohoda do 30. 6. 2027
SZP ČR	stejný standard smlouvy u zaměstnaneckých pojišťoven, náhradní smluvní model	víceleté smlouvy jako pozměňovací návrh k reformě v. z. p. 2030	jednání o náhradním modelu	2027
Asociace krajů ČR	kraj pro pilot, pravidla krajského plánu sítě	fond přeměny, garanci příjmu, krajský plán místo centrálního rozhodnutí	výzva krajům k přihlášce do pilotu	1. čtvrtletí 2027

Aktér	Co od něj potřebujeme	Co mu nabízíme	První krok	Kdy
SMO ČR	obecní prostory, senior taxi	lékaře blíž lidem, spolufinancování dopravy, podíl na plánování	setkání s novými vedeními obcí	1. čtvrtletí 2027
Nemocnice (AČMN, Asociace krajských nemocnic)	spolupráci na pravidlech plánu sítě a přeměny	investiční fond přeměny 5–10 mld. Kč, garanci příjmu, pojistku obložnosti 85 %	kulatý stůl k síti lůžek	kontakt 2027, kulatý stůl 2028
APSS ČR	data o kapacitě dlouhodobé péče po krajích	kapacitu dlouhodobé péče jako podmínku každé přeměny, sociální účet	společná bilance kapacit	2028
Pacientské organizace	připomínky k cestě pacienta, triáži a ukazatelům	garanci termínu podle naléhavosti, jmenovitého lékaře, zdravotnického ombudsmana	veřejná konzultace verze 3	od 12/2026
Vinaři a výrobci nápojů	přijatelnost náběhu daní, reformulaci nápojů	poloviční sazbu pro malé vinaře 2031–2032, ohlášení daně ze slazených nápojů dva roky předem, pásma podle cukru	jednání o režimu malých vinařů	konzultace 2028, ohlášení v programu 2029
MF a NRR	technickou shodu na metodice nákladů a na vzorci platby státu, posouzení fondu prevence vůči rozpočtovým pravidlům	otevřený model, rozpětí nákladu 15–25 mld. Kč ročně, daně za zdraví 5 mld. Kč jako částečný zdroj	předat model a požádat o technickou oponenturu	2028
Potenciální koaliční partneři	jádro v koaliční smlouvě	společné autorství, sdílený harmonogram, varianty A, B a C	setkání zdravotních expertů stran	2028–2029

Kalendář kulatých stolů. Termíny jsou návrh RT; každý stůl má jeden výstup, který se zveřejní.

Termín	Téma	U stolu	Výstup
2/2027	Standard týmu sdružené péče a pětiletá smlouva	SPL ČR, SPLDD ČR, Mladí praktici, ČAS, VZP, SZP ČR	návrh standardu týmu
4/2027	Sestry v primární péči: kompetence a sesterská složka	ČAS, SPL ČR, ČLK, pojišťovny, MZ (pozvat)	podnět do dohodovacího řízení o úhradách 2028 (do 30. 6. 2027)
5/2027	Pilot ve třech ORP	kraj, VZP, obce, hodnotitel	dohoda o pilotu do 30. 6. 2027
9/2027	Cesta pacienta a eŽádanka s triážním údajem	ČLK, odborné společnosti, SPL ČR, pacientské organizace	pozměňovací návrh k novele zák. 325/2021 Sb.
11/2027	Financování: platba státu a daně za zdraví	MF (pozvat), NRR, pojišťovny, PEER	podklad pro plánovací hodnotu daní za zdraví a pravidlo dělení podle PEER
2/2028	Síť lůžkové péče a přeměna	Asociace krajů ČR, AČMN, Asociace krajských nemocnic, odbory, záchranné služby	pravidla krajského plánu sítě
4/2028	Dlouhodobá a sociálně-zdravotní péče	APSS ČR, MPSV (pozvat), kraje, SMO ČR	podmínka kapacity před přeměnou lůžek
5/2028	Prevence a daně za zdraví	vinaři, pivovary, výrobci nápojů, pacientské organizace	náběh daní a režim malých vinařů
6/2028	Bilanční konference	všichni účastníci	vypořádání připomínek a záznam o projednání plánu s 10 klíčovými organizacemi pro bránu `B1`

Co musí být hotové do brány `B1` (červen 2028).

- ☐ Verze 3 schválená resortním týmem 7. 12. 2026 a zveřejněná ke konzultaci
- ☐ Připomínky vypořádané a vypořádání zveřejněné
- ☐ Plán projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi a jejich výhrady zapracované
- ☐ Smlouva pilotu podepsaná, jinak náhradní smluvní model u jedné pojišťovny
- ☐ Podněty do dohodovacího řízení o úhradách 2028 podané do 30. 6. 2027
- ☐ Pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030, k novele zák. 325/2021 Sb. a k reformě hygienické služby podané
- ☐ Strana potvrdila plánovací hodnotu daní za zdraví pro rozpočet reformy: 5 mld. Kč ročně (rozpětí 5–7), vedle cíle PEER 10–15 mld. Kč

Co musí být hotové do brány `B2` (prosinec 2029 až leden 2030).

- ☐ Věcné záměry zákona o primární péči, zákona o síti, finanční novely a daňových zákonů hotové
- ☐ Průběžné vyhodnocení pilotu zveřejněné (jaro 2029)
- ☐ Volební program 2029 s jádrem reformy a s ohlášením daně ze slazených nápojů
- ☐ Personální bilance po krajích a otevřený model nákladů zveřejněné
- ☐ Text jádra pro koaliční smlouvu a programové prohlášení připravený
- ☐ Seznam předloh do legislativního plánu vlády 2030 a obsazení řídicího výboru a projektové kanceláře připravené

Pilot ve třech ORP

Pilot běží dva roky, 2028 a 2029, ve třech ORP jednoho kraje, který se k pilotu přihlásí, pokud se kraj, VZP a obce dohodnou do konce června 2027. Ověřuje proveditelnost týmu sdružené péče, ne zdravotní dopad. Pořadí je pilot → zákon: zákon o primární péči má účinnost 1. 1. 2032 a do té doby týmy fungují na smlouvě podle § 17 zák. 48/1997 Sb.

Design. Tři ORP různého typu: město, venkov s řídkým osídlením a ORP, kde chybí praktici; dohromady 100 až 150 tisíc obyvatel. K nim tři až šest kontrolních ORP vybraných podle podobnosti před startem. Pilot stojí na dnešním právu: týmová praxe podle vyhlášky, sestry navíc dodatkem smlouvy, obecní prostory, senior taxi z rozpočtu obce nebo kraje a navigace po screeningu z fondu prevence pojišťovny.

Kolik. Pilot ve třech ORP stojí 30 až 50 mil. Kč ročně, nezávislé hodnocení asi 5 mil. Kč. Jeden tým s deseti lékaři a deseti sestrami navíc vychází asi na 13 mil. Kč ročně, senior taxi asi na 1,1 mil. Kč na vůz.

- Ověřit: kdo zaplatí nezávislé hodnocení (kraj, VZP, nebo grant na výzkum zdravotních služeb).

Ověřujeme

Hodnotitel. Nezávislý hodnotitel (ÚZIS s univerzitou) je jmenovaný před startem, do konce roku 2027. Před startem zveřejní protokol a výpočet statistické síly. Tři ORP a dva roky nestačí na spolehlivé měření odvratitelných hospitalizací (asi 900 případů ročně na 150 tisíc obyvatel); chybějící efekt proto nelze číst jako důkaz, že dopad není.

Co se měří. Všechny ukazatele pilotu stojí na datech, která existují v reálném čase, ne na ročních výstupech ÚZIS.

Oblast	Ukazatel	Zdroj dat
Personál	obsazenost míst sester, odchody, čas na dokumentaci	smlouvy a výkazy pojišťovny, šetření v týmech
Dostupnost	nově registrovaní, pojištěnci bez praktika ve spádu, dny do prvního volného termínu	registr pojištěnců VZP, eŽádanka
Kontinuita	index obvyklého poskytovatele (UPC), jmenovitý ošetřující lékař u každého pacienta	vykázaná péče
Chronici	diabetici a lidé se srdečním selháním s kontrolou podle protokolu, očkování 65+	vykázaná péče
Péče doma	návštěvy, pacienti 75+ v návštěvní službě, jízdy senior taxi	výkazy týmů, obce
Hospitalizace	odvratitelné a všechny hospitalizace pacientů týmu proti kontrolním ORP	vykázaná péče (popisně)
Pacienti	zkušenost pacientů a pečujících	dotazník hodnotitele
Peníze	skutečné náklady na pacienta a rok, náklady pojišťovny proti kontrolním ORP	účty pojišťovny

Termíny.

- Do 30. 6. 2027: dohoda kraje, VZP a obcí; současně podnět do dohodovacího řízení o úhradách 2028.
- 2. pololetí 2027: výběr ORP a kontrolních ORP, nábor sester, jmenování hodnotitele, zveřejnění protokolu.
- 1. 1. 2028: start provozu.
- 6/2028: podepsaný a běžící pilot je kritériem brány B1.
- Jaro 2029: průběžné vyhodnocení po roce provozu; vstupuje do věcného záměru zákona o primární péči.
- 2030: závěrečné vyhodnocení; vstupuje do paragrafového znění vlny 2. Od roku 2030 se pilot postupně rozšiřuje do dalších regionů s kontrolními oblastmi, aby šel změřit zdravotní dopad.

Co když se nedohodne. Když kraj a VZP do června 2027 dohodu neuzavřou, nastupuje náhradní smluvní model u jedné pojišťovny: týmové praxe, které se přihlásí, bez krajského rámce a bez obecní dopravy. Měření je pak slabší, protože chybí kontrolní ORP; zákon se opře víc o zahraniční zkušenost a první vlna týmů po roce 2032 se hodnotí jako rozšířený pilot. Když pilot ukáže, že týmy neshánějí sestry nebo že praktici nevstoupí, je to výsledek, který má do zákona promluvit stejně jako úspěch: reforma se vrací k variantě B.

O smlouvě s týmy rozhoduje vedení VZP, ne její Správní rada; střet zájmů autora jako člena Správní rady VZP uvádí úvod studie.

Řízení reformy

Do konce roku 2029 řídí přípravu resortní tým s Institutem Pi a poslaneckým klubem; od roku 2030 přebírá řízení řídicí výbor reformy, který jediný schvaluje přechod branou. Struktura ve vládě se ustaví do tří měsíců od jmenování vlády, aby stihla první legislativní plán 2030.

V opozici řídí resortní tým, ve vládě řídicí výbor s nezávislým hodnotitelem

Řízení přípravy a provádění reformy; řídicí výbor jediný schvaluje přechod branou

V opozici: fáze F0 a F1, 2026–2029

Ve vládě: fáze F2 až F4, od roku 2030

kdo řídí · orgán nebo partner · doporučení, zpráva · organizační vazba

Textová verze

V opozici: fáze F0 a F1, 2026–2029

- Předsednictvo strany: schvaluje volební program a plánovací hodnotu daní
- Poslanecký klub: pozměňovací návrhy k vládním předlohám
- Resortní tým (RT): vede studii, konzultace a věcné záměry zákonů
- Institut Pi: analýzy, oponentura, podpora věcných záměrů
- Partneři konzultace: komory, sdružení praktiků, sestry, odbory, pojišťovny, kraje, obce, nemocnice, pacienti
- Pilot ve třech ORP: kraj, VZP a obce; nezávislý hodnotitel jmenovaný před startem

Vazby v opozici

- Předsednictvo strany — Resortní tým (RT)
- Poslanecký klub — Resortní tým (RT)
- Institut Pi — Resortní tým (RT)
- Resortní tým (RT) — Partneři konzultace
- Resortní tým (RT) — Pilot ve třech ORP

Ve vládě: fáze F2 až F4, od roku 2030

- Vláda: legislativní plán, předlohy, rozpočet
- Řídicí výbor reformy: MZ, MPSV, MMR, MF, pojišťovny, kraje, obce, praktici, pacienti; čtvrtletně; schvaluje přechod branou
- Nezávislý hodnotitel: ÚZIS s univerzitou, hodnotí každou bránu veřejně
- Projektová kancelář reformy: registr opatření, rizik a ukazatelů, podklady pro brány; 0,4 mld. Kč ročně
- MZ: legislativa + tým pro primární péči + tým pro síť
- MPSV: sociální účet, dlouhodobá péče
- MF: platba státu, daně za zdraví
- Kraje: krajské plány sítě, fond přeměny
- Pojišťovny: pětileté smlouvy, data pro brány

Vazby ve vládě

- Řídicí výbor reformy → Vláda (doporučuje)
- Nezávislý hodnotitel → Řídicí výbor reformy (zpráva výboru i veřejnosti)
- Řídicí výbor reformy → Projektová kancelář reformy
- Projektová kancelář reformy → MZ
- Projektová kancelář reformy → MPSV
- Projektová kancelář reformy → MF
- Projektová kancelář reformy → Kraje
- Projektová kancelář reformy → Pojišťovny

Podklad: studie v3, ř. 1946–1958; složení řídicího výboru ř. 89 (krok 14).

řízení reformy · v opozici (F0–F1) a ve vládě (F2–F4)

V opozici nese odpovědnost resortní tým: vede konzultace, píše věcné záměry a připravuje pozměňovací návrhy, které podají poslanci. Předsednictvo strany schvaluje to, co strana slibuje veřejně: volební program a plánovací hodnotu daní za zdraví.

Ve vládě se řídicí výbor schází čtvrtletně a doporučuje vládě, co pokračuje, co se upraví a co se zmenší. Projektová kancelář reformy (0,4 mld. Kč ročně) vede registr opatření, rizik a ukazatelů a připravuje podklady pro brány. Nezávislý hodnotitel (ÚZIS s univerzitou) hodnotí každou bránu veřejně a jeho zpráva jde výboru i veřejnosti současně.

Legislativní odbor MZ potřebuje dva nové týmy, pro primární péči a pro síť, protože dvě velké předlohy běží v letech 2030 a 2031 souběžně. Pojišťovny jsou ve výboru i mezi vykonavateli: uzavírají pětileté smlouvy a dodávají data z registrů, na kterých stojí brána B3.

- Ověřit: zda má řídicí výbor vzniknout usnesením vlády, nebo až zákonem o primární péči.

Ověřujeme

Pravidla rozhodování a kapacita státu

O přechodu každou branou rozhodují čtyři pravidla, která platí od roku 2026 do roku 2038 bez ohledu na to, kdo vládne. Jejich smyslem je, aby neúspěch jednoho nástroje neshodil celou reformu a aby se nic nepřeměnilo naslepo.

- **Žádná brána bez dat.** Chybí-li data, brána se odkládá; nerozhoduje se podle odhadu ani podle kalendáře.
- **Neúspěch nástroje zastaví jen ten nástroj.** Reforma jako celek kvůli jednomu neúspěchu nekončí; nástroj, který nefunguje, se upraví nebo zastaví.
- **Brána `B3` nesplněna → varianta B.** Když do konce roku 2031 nebude obsazena aspoň polovina míst sester v týmech první vlny, centra se nestaví a reforma pokračuje týmy, sestrami, prevencí, paliativou, konzultacemi a fondem přeměny.
- **Akutní lůžko se nepřemění bez náhrady.** Kraj musí nejdřív prokázat kapacitu následné a dlouhodobé péče a dojezd záchranné služby; obložnost akutních lůžek nad 85 % přeměnu v daném kraji zastaví.

Brána	Data pro rozhodnutí	Když není splněna
`B1` Mandát (6/2028)	zveřejněné vypořádání připomínek, záznam o projednání plánu s 10 klíčovými organizacemi a o zapracování jejich výhrad, smlouva pilotu, usnesení strany o daních	co není projednané nebo zůstalo bez dohody, do volebního programu nejde; místo pilotu náhradní smluvní model u jedné pojišťovny
`B2` Koaliční smlouva (12/2029–1/2030)	text koaliční smlouvy a programového prohlášení, legislativní plán vlády 2030	do legislativního plánu jde jen dohodnuté jádro; zbytek zůstává programem pro další období
`B3` Lidé a data (12/2031)	obsazenost míst sester z registrů pojišťoven, stav zákona o primární péči, stav krajských plánů	varianta B (bez center)
`B4` Nezávislé hodnocení (2033)	zpráva nezávislého hodnotitele (ÚZIS s univerzitou)	hodnotitel doporučí pokračovat, upravit, nebo zmenšit; rozhodnutí i důvody se zveřejní před volbami

Kapacita státu je tvrdé omezení. Ministerstvo zvládne za jedno volební období realisticky dvě velké a čtyři až šest malých nebo středních předloh. Velké předlohy období 2029–2033 jsou dvě: zákon o primární péči a zákon o síti lůžkové péče. Velká předloha trvá od věcného záměru po účinnost 24 až 42 měsíců, proto musí být věcné záměry hotové už při nástupu vlády.

Malé a střední předlohy období jsou nový vzorec platby státu (§ 3c zák. 592/1992 Sb.), novela zák. 353/2003 Sb. (víno a valorizace), zákon o dani ze slazených nápojů jako střední zákon a zákon o Fondu prevence. Další dvě místa drží rezerva pro novelu zák. 325/2021 Sb., pokud triážní údaj neprojde pozměňovacím návrhem, a novela zák. 374/2011 Sb. navázaná na síť. Institut pro hodnocení technologií se při nedostatku kapacity nahradí rozšířením mandátu SÚKL a ÚZIS; úplnou mapu předpisů podle vln uvádí Část VII.

Předpokladem je posílení legislativního odboru MZ o tým pro primární péči a tým pro síť hned v roce 2030. Bez toho vlna 3 sklouzne o rok a zákon o síti nabude účinnosti až v roce 2034 nebo později.

Část IX — Ukazatele a vyhodnocení

Reformu hodnotíme nadřazeným cílem z Hospodářské strategie PEER a dvaceti ukazateli: osmi hlavními, podle kterých rozhoduje brána `B4` v roce 2033, a dvanácti doplňkovými, které slouží jako pojistky a vysvětlení. Cíle odvozujeme z mechanismů opatření `J1` – `J10` ve scénáři „Vláda 2030“; kde mechanismus číslo neunese, píšeme „sledujeme bez cíle“.

Cíle jsou posunuté proti verzi 2 o tři roky, protože týmy první vlny začínají 1. 1. 2031 a zákon o primární péči je účinný 1. 1. 2032. Cíl „2033“ znamená hodnotu, kterou hodnotitel uvidí ve zprávě `B4` v roce 2033, tedy v řadě případů data za rok 2032. Doplňkový scénář „Dnešní vláda převezme část“ cíle nemění, jen o 1–2 roky předsouvá vlnu 0.

Hlavní slabinou verze 2 bylo zpoždění dat: ÚZIS a Eurostat zveřejňují většinu řad s odstupem 1,5 až 3 roky. Brány `B1` – `B3` proto stojí na registrech pojišťoven, eŽádance a Národním registru zdravotnických pracovníků (NRZP), ne na ročenkách.

Číselné cíle označené „návrh“ jsou výchozí pro konzultaci; upřesní je vyhodnocení pilotu (průběžné po roce provozu, závěrečné 2030) a protokol nezávislého hodnotitele.

Nadřazený cíl: +5 let života ve zdraví

Hospodářská strategie PEER stanoví cíl prodloužit délku života ve zdraví o pět let během jedné generace. Studie ho přebírá jako cíl, ke kterému míří všech pět cílů reformy. Ukazatel je délka života ve zdraví (Healthy Life Years, Eurostat hlth_hlye): dnes 61,2 roku u mužů a 62,4 roku u žen, průměr EU 63,5 a 64,2, Švédsko asi 71 a 73 let (podle Hospodářské strategie PEER). Cíl je tedy asi 66 let u mužů a 67 let u žen. Ověřit: rok dat v Eurostatu.

Ověřujeme

Ukazatel stojí na subjektivním šetření EU-SILC a hýbe se pomalu, proto o branách nerozhoduje. Mezi kroky ho nesou odvratitelná úmrtnost (`H7`) a doplňkové ukazatele prevence (`D5` až `D8` , `D11`). Ověřit: průběžnou hodnotu pro rok 2038 dohodnout s PEER a ÚZIS.

Ověřujeme

Vedle hlavního ukazatele H6 sledujeme i ukazatel strategie PEER, podíl nemocniční péče na výdajích (46,5 % proti 36,4 % v EU podle NERV 2024), s cílem PEER snížit ho o 10 procentních bodů do roku 2035. Studie k němu přispívá přeměnou akutních lůžek (H6), indikačním omezením místo objemových limitů (Pil2.2) a přesunem plánovaných výkonů do jednodenní a ambulantní péče.

Osm hlavních ukazatelů

Osm hlavních ukazatelů H1 – H8 pokrývá celý řetězec od dostupnosti přes kontinuitu a lůžka po finanční ochranu; politické výstupy převezmou právě je. Každý je vázaný na opatření J1 – J10 nebo podmínky P1 – P5 , které ho mají hýbat, a u každého je uvedeno, z čeho se dá rozhodnout o bráně dřív než z ročenky.

Ukazatel	Definice	Výchozí hodnota (rok, zdroj)	Cíl 2033 (B4 ; data za 2032)	Cíl 2038	Mechanismus	Zpoždění dat a zdroj pro brány
H1 Lidé bez registrujícího praktika	Podíl pojištěnců bez registrace u praktika, zvlášť dospělí a děti, po ORP	Nově měřit od 2028. Děti: asi 182 tis. bez kapitace u dětského praktika (2022, ÚZIS 2023)	Měření zavedeno; v ORP s týmem pokles aspoň o polovinu proti základu 2028 (návrh)	V ORP s týmem nikdo bez jmenovitého lékaře	J1 (tým se spádem), J3 , J5 (měření), P1 , P2	Registrace v registrech pojišťoven: měsíce. ÚZIS: roční. Brány B1 , B3
H2 Týmy podle standardu a obsazená místa sester	Počet týmů podle standardu J1 včetně smluvních sítí; podíl obsazených míst sester z míst ve smlouvě	0 týmů podle standardu (241 týmových praxí); asi 1 sestra na praktika (v2; ověřit rok NRZP)	Trajektorie z Části V splněna aspoň z 90 % (návrh); obsazeno aspoň 50 % míst sester, tedy práh B3 trvá	520 týmů kolem 2038; obsazeno aspoň 80 % míst (návrh; omezuje to nábor: asi 1 840 všeobecných sester z VŠ a VOŠ ročně v letech 2026–2037)	J1 , J2 , P1	Smlouvy a vykázané úvazky u pojišťoven, NRZP: čtvrtletně. Brány B3 , B4
H3 Čekání podle triážní kategorie	Podíl pacientů přijatých ve lhůtě své kategorie z eŽádanky (urgentní do 2 týdnů, do 6 týdnů, plánované); medián dnů po oborech a krajích	Nově měřit. Kolonoskopie po pozitivním testu 84,2 dne (2024, NZIS Open); u specialistů se čekání neměří	Měří se ze všech eŽádanek; lhůtu splňuje aspoň 80 % urgentních (návrh)	Aspoň 90 % ve všech třech kategoriích (návrh); čekání pacientů bez žádanky se neprodlužuje	J5 (eŽádanka s triáží), J3 (méně zbytečných žádanek), měkký gatekeeping (triáž v eŽádance, přednost v objednání)	eŽádanka: průběžně. Předpoklad: povinná eŽádanka (novela zák. 325/2021 Sb.). Brány B3 , B4
H4 Kontinuita péče (UPC)	Index obvyklého poskytovatele: podíl kontaktů s jmenovaným ošetřujícím lékařem týmu z vykázaných kontaktů	Nově měřit; cílová hodnota z v2 ≥ 0,7 (Barker 2017, PMID 28148478)	≥ 0,7 v týmech vlny 1 a 2	≥ 0,7 ve všech týmech	J1 (jmenovitý lékař), J2 ; pojistka proti vícečlenným týmům (Bates 2025, Kegreiss 2026)	Vykázané kontakty u pojišťoven: čtvrtletně. Brána B4
H5 Hospitalizace pro ACSC	Hospitalizace pro stavy ošetřitelné ambulantně (seznam AHRQ/OECD) na 100 tis. dospělých	592 (v2, ÚZIS NRH; OECD 473; ověřit rok a standardizaci)	550	530	J1 , J2 (chroničtí pacienti, sledování srdečního selhání), J3	NRH: zpoždění asi 1,5 roku. Pro bránu výkazy pojišťoven čtvrtletně, v pilotu od 2028
H6 Podíl akutní lůžkové péče	Podíl vlastní akutní lůžkové péče na úhradách pojišťoven	29,7 % (2024, ÚZIS OIS-11-24)	28 %	26 % kolem 2038	J6 , J7 (fond přeměny; kapacita následné péče jako podmínka)	ÚZIS roční; úhrady podle pojišťoven čtvrtletně. Čte se spolu s D1 – D4
H7 Odvratitelná úmrtnost	Standardizovaná předčasná úmrtnost do 75 let na 100 tis., léčitelná a preventabilní zvlášť	Léčitelná 107,2 (EU27 86,8), preventabilní 173,9 (EU27 150,9); 2023, Eurostat hlth_cd_apr	Sledujeme bez cíle	Sledujeme bez cíle; hodnotí se odstup od EU27	J1 – J5 nepřímo; J8 , J9 nepřímo	Eurostat: rok 2023 je dostupný až 2026. Pro brány se nepoužívá
H8 Katastrofické výdaje domácností	Podíl domácností, jejichž přímé platby za zdraví přesáhnou 40 % kapacity k platbě; celkem a nejchudší pětina	6 % domácností, nejchudší pětina 21 % (2023; v 2018 4,5 % a 14 %; WHO/Europe 2025, ČSÚ Šetření o rodinných účtech). Medián 40 evropských zemí 6 %	Nezhoršit: aspoň ne nad 6 % celkem a 21 % v nejchudší pětině	Sledujeme bez číselného cíle; pokles je možný hlavně přes doplatky a stomatologii, které jádro reformy neřeší	Reforma poplatky nezavádí; J8 a J9 mohou zatížit nejchudší, proto se sledují	ČSÚ a WHO/Europe: dvouleté zpoždění. Brána B4

Tři poznámky k číslům. U H5 odpovídá cíl 530 dorovnání zhruba poloviny rozdílu k OECD (592 − 473 = 119), jak předpokládá model; v 2033 je to hodnota z v2 posunutá o tři roky. U H7 neumíme účinek reformy oddělit od dlouhodobých trendů a bez kontrolní skupiny ho nepřiřadíme reformě, proto číselný cíl nestanovujeme. U H8 vyplývá cíl „nezhoršit“ z toho, že žádné opatření nezavádí poplatky ani přímé platby; rozdíl vůči dokumentu Zdravotnictví pro 21. století je záměrný.

Dvanáct doplňkových ukazatelů

Dvanáct doplňkových ukazatelů D1 – D12 hlídá přeměnu lůžek a vysvětluje, proč se hlavní ukazatele hýbou; tři z nich (D2 , D3 , D4) jsou pojistky, které můžou přeměnu zastavit. Cíle pro alkohol, játra, kolonoskopii a očkování jsme podle posudku buď odvodili z mechanismů, nebo snížili, nebo vypustili.

Ukazatel	Definice	Výchozí hodnota (rok, zdroj)	Cíl 2033	Cíl 2038	Mechanismus	Zpoždění dat a zdroj
D1 Akutní lůžka	Smluvní akutní lůžka (NZIP/ÚZIS), absolutně a na 1 000 obyvatel; OECD (3,99) jen pro mezinárodní srovnání	48 036 lůžek, 4,4 na 1 000 (2024)	Žádná přeměna před schváleným krajským plánem (první plány 2033)	Asi 40 000 lůžek, tedy 3,7 na 1 000 (přeměněno 8 000); 3,5 až po 2038 a jen při splněných ukazatelích	J6 , J7	ÚZIS ročně; smlouvy pojišťoven čtvrtletně
D2 Obložnost standardních akutních lůžek	Roční využití standardních akutních lůžek, celkem a po krajích	56 % (2024; Ústecký kraj 45,8 %, Zlínský 61,6 %; ÚZIS SSS-05-02)	Sledujeme bez cíle (přeměna teprve začíná); v žádném kraji nad 85 %	65–70 %: při stejné poptávce 56 % × 48 036 / 40 000 = 67 %; strop 85 % trvá	J6 ; pojistka: nad 85 % stop přeměny v kraji (Madsen 2014: +9 % úmrtnost)	ÚZIS ročně; pro pojistku výkazy poskytovatelů (ověřit frekvenci)
D3 Kapacita následné a dlouhodobé péče	Lůžka následné a dlouhodobé péče, volná kapacita v kraji a pracovníci dlouhodobé péče na 100 seniorů	28 551 lůžek (2024, OIS-11-28 a 11-49); 2,5 pracovníka na 100 seniorů (OECD 5,6)	Každý kraj před přeměnou prokáže kapacitu následné a dlouhodobé péče a dojezd (pravidlo rozhodování č. 4)	Podle krajských plánů. Potřeba asi 39 000 zdravotních i sociálních lůžek (Přecechtěl a Hlávka 2025; zdravotní část: dnes chybí 2–3 tisíce, do 2035 dalších nejméně 8 tisíc, MZ ČR 2025, s. 65) a 21 000 pečovatelů (APSS ČR) je odhad potřeby, ne závazek reformy	J7 , P3 (sociální účet)	ÚZIS, registr poskytovatelů MPSV, kraje; ročně
D4 Dojezd ZZS	Podíl výjezdů v limitu dojezdu, po ORP	Ověřit: hodnota z ÚZIS (výjezdy ZZS, aktualizace ročně k 30. 6.)	Nezhoršit v žádném ORP s přeměnou	Nezhoršit	J6 (pojistka)	ÚZIS, ZZS krajů; ročně
D5 Čekání na kolonoskopii po pozitivním testu	Průměrná doba od pozitivního TOKS do kolonoskopie	84,2 dne (2024; v 2019 61,2 dne; NZIS Open PPS-02-07); na kolonoskopii dochází jen 60–70 % lidí s pozitivním testem (MZ ČR 2025, s. 36)	Sledujeme bez cíle	Nejvýše 61 dnů (návrat na úroveň 2019). Cíl 31 dní z v2 vypuštěn: navigace poptávku zvýší	J5 , J1 (navigace po screeningu), P4	NZIS Open: ročně
D6 Screening tlustého střeva	Pokrytí lidí v cílové skupině (50–75 let; od 2026 má být 45–75 let, MZ ČR 2025, s. 40)	31,1 % (2024, ÚZIS; OECD 42 %; cílová skupina 50–75 let). Ověřit: přepočet výchozí hodnoty na cílovou skupinu 45–75 let a termín změny u NSC	35 % (návrh)	40 % (návrh; v2 měla 42 %)	J1 , J2 (sestra zve a naviguje), P4	ÚZIS NRHZS: ročně
D7 Očkování proti chřipce 65+	Podíl očkovaných seniorů	24,6 % (v2; ověřit sezónu, ÚZIS NR-28-02)	30 % (návrh)	40 % (návrh; 60 % z v2 vypuštěno)	J2 (připomínka sestrou), P4	ÚZIS, e-vakcinace: ročně po sezóně
D8 Spotřeba alkoholu	Registrovaná spotřeba čistého alkoholu na osobu 15+	11,2 l (2023; OECD 8,5 l; OECD Health at a Glance 2025). Ověřit: hodnota za rok 2024 v OECD Health Statistics (v pracovních podkladech 10,6 l, OECD 8,4 l)	Sledujeme bez cíle	Sledujeme bez cíle	J8	OECD Health Statistics: asi 1,5 roku
D9 Cukr v prodaných nápojích	Cukr v prodaných nealkoholických nápojích podle pásma sazby	Nově měřit; základ 2031 (rok před účinností)	Základ zveřejněn; sledujeme bez cíle	Sledujeme bez cíle; cíl stanoví hodnotitel po prvním roce účinnosti (směr: Andreyeva 2022, PMID 35648398)	J9 (účinnost 1. 1. 2032)	Ověřit zdroj dat z daňových přiznání; ročně
D10 Úmrtnost na chronická onemocnění játer	Standardizovaná úmrtnost K70, K73–K74 na 100 tis.	19,5 (2023; EU27 13,7; Eurostat)	Sledujeme bez cíle	Sledujeme bez cíle	J8 nepřímo	Eurostat: asi 2,5 roku
D11 Výdaje na prevenci	Podíl preventivní péče (HC6) na běžných výdajích na zdravotnictví	2,7 % (v2, OECD SHA; ověřit rok)	2,9 %	3,0 %	P4 : nejméně 2 mld. Kč ročně (40 % výnosu) z daní za zdraví, asi +0,25 procentního bodu (při běžných výdajích kolem 800 mld. Kč; ověřit)	OECD/ČSÚ: 1,5–2 roky
D12 Podíl úhrad praktikům a týmům	Podíl úhrad pojišťoven na všechny praktiky včetně dětských (001, 002) a platby týmům	6,4 %, tedy 32,1 mld. Kč (2024, OIS-11-24)	Asi 7,0 %	Asi 7,5 %: platby týmům 4,8–7,5 mld. Kč při úhradách asi 600 mld. Kč dávají +0,8 až +1,25 procentního bodu. Cíl 9 % z v2 vypuštěn	J1 , J2	Pojišťovny čtvrtletně; ÚZIS ročně

Ověřujeme

Kdo měří a kdy

Měří nezávislý hodnotitel, kterým je ÚZIS společně s univerzitou, jmenovaný před startem pilotu v roce 2028. Zveřejní protokol předem, včetně výpočtu statistické síly: tři ORP a dva roky provozu nestačí na spolehlivé měření hospitalizací (asi 900 odvratitelných případů ročně ve 150 tisících obyvatel), a výsledek pilotu se proto nesmí číst jako důkaz, že zdravotní dopad chybí.

Jako rámec slouží HSPA, které má být podle podmínky `P5` oficiálním hodnotícím rámcem v zákoně. Rámec spustila OECD s ministerstvem 24. 5. 2023 (122 ukazatelů, u 30 chybí metodika nebo data); ÚZIS počítá, Rada HSPA schvaluje a ukazatele reformy se stanou jeho součástí. Hodnocení dělá ÚZIS v oficiálním rámci, ne nástroj autorů studie: autor je zároveň autorem HSPA Monitoru, a proto HSPA Monitor není zdrojem hodnocení (střet zájmů je uveden v úvodu studie).

Roční zpráva vychází do 31. května za předchozí rok a opírá se o registry pojišťoven a o ta data ÚZIS, která jsou k dispozici. Zbytek (NRH, Eurostat, WHO/Europe) se doplní dodatkem do 30. září. Termín před 30. 6. je zvolený záměrně: zpráva tak stihne přípravu dohodovacího řízení o úhradách (návrh k diskusi).

Údaje za týmy a spádová území se zveřejňují čtvrtletně, celostátní hodnoty až v roční zprávě. Řídicí výbor ji projednává čtvrtletně a schvaluje přechod bránou; před `B4` hodnotitel předá zprávu v roce 2033 s doporučením pokračovat, upravit, nebo zmenšit. V opozici (F0–F1) se měří jen pilot a základní hodnoty z otevřených dat. Ověřit: kdo hodnotitele pilotu jmenuje a kdo ho platí (kraj, VZP a ministerstvo společně).

Ověřujeme

Data pro brány

Tři zdroje dávají data pro brány dřív než ročenky: registry pojišťoven, eŽádanka a NRZP; pilot k nim přidává vlastní měření. Ostatní řady přicházejí s ročním až tříletým zpožděním a slouží k potvrzení, ne k rozhodování. Pravidlo „žádná brána bez dat“ znamená, že brána, jejíž ukazatel nemá zdroj v tabulce níže, se nehlasuje.

Zdroj	Co z něj bereme	Zpoždění	Ukazatele
Registry pojišťoven	Registrace u praktika, smlouvy a vykázané úvazky sester, vykázané kontakty pro index UPC, úhrady, hospitalizace	Měsíce až čtvrtletí; nutná smlouva o výměně dat s hodnotitelem (ověřit frekvenci u VZP a ostatních pojišťoven)	`H1`, `H2`, `H4`, `H5` (průběžně), `H6`, `D12`
eŽádanka	Triážní kategorie, datum žádanky a termín vyšetření	Reálný čas po zavedení povinné eŽádanky (novela zák. 325/2021 Sb. je u vlády); do té doby jen pilot	`H3`
NRZP	Počty a úvazky sester a lékařů, pracoviště	Ověřit frekvenci aktualizace; slouží jako kontrola k registrům pojišťoven	`H2`
ÚZIS (NRH, NRHZS, NZIS Open), Eurostat, WHO/Europe, OECD	Roční řady, mezinárodní srovnání	1,5 až 3 roky (např. úmrtnost 2023 je dostupná 2026, katastrofické výdaje 2023 vyšly 2025)	`H5`, `H6`, `H7`, `H8`, `D1` – `D11`

Největší riziko je nízká kvalita dat, ne jejich zpoždění: index UPC a obsazenost míst sester vznikají z vykázaných kontaktů a úvazků, takže je lze ovlivnit vykazováním. Hodnotitel proto data ověřuje vzorkem proti dokumentaci a proti NRZP.

Brána, ukazatel, prahová hodnota

Každá ze čtyř bran má práh postavený na datech, která existují v době rozhodnutí; prahy u `B4` jsou návrh k diskusi. Neuspokojivý výsledek zastaví jen ten nástroj, kterého se týká; reforma jako celek kvůli jedné chybě nekončí.

Brána	Ukazatel nebo kritérium	Prahová hodnota	Data v reálném čase	Při nesplnění
`B1` Mandát (6/2028)	Projednání plánu: SPL ČR, SPLDD ČR, ČAS, ČLK, VZP, SZP ČR, Asociace krajů ČR, SMO ČR, pacientské organizace, odbory	Plán je projednaný se všemi 10 klíčovými organizacemi a jejich výhrady jsou zapracované	Zveřejněné vypořádání výhrad každé z 10 organizací	Co není projednané nebo zůstalo bez dohody, do volebního programu nejde
`B1` Mandát (6/2028)	Pilot: kraj, VZP a obce; nezávislý hodnotitel; definice `H1` – `H4` a datové toky	Pilot podepsán, hodnotitel jmenován, definice schváleny hodnotitelem	Smlouva o pilotu, protokol hodnotitele	Náhradní smluvní model u jedné pojišťovny
`B1` Mandát (6/2028)	Připomínky a daňový závazek	Připomínky vypořádané a zveřejněné; strana potvrdila plánovací hodnotu daní za zdraví (5 mld. Kč ročně, rozpětí 5–7) vedle cíle PEER	Zveřejněný dokument o vypořádání, usnesení strany	Zveřejnění s uvedenou výhradou
`B2` Koaliční smlouva (12/2029–1/2030)	Jádro `J1` – `J10` v koaliční smlouvě a programovém prohlášení; předlohy v legislativním plánu vlády 2030; průběžné vyhodnocení pilotu (`H1`, `H2`, `H4` v pilotních ORP)	Politická dohoda; v pilotu obsazeno aspoň 50 % míst sester (návrh, stejný práh jako `B3`)	Texty smlouvy; pilotní data z registrů pojišťoven	Při `H2` pod 50 % v pilotu jádro bez center (varianta B)

Brána	Ukazatel nebo kritérium	Prahová hodnota	Data v reálném čase	Při nesplnění
B3 Lidé a data (12/2031)	H2 : obsazená místa sester v týmech první vlny; zákon o primární péči; krajské plány sítě	Aspoň polovina míst sester obsazena; zákon schválen; plány rozpracované	Registry pojišťoven (ne ÚZIS), NRZP; hlasování Sněmovny; usnesení krajů	Varianta B (bez center)
B4 Nezávislé hodnocení (2033)	Zpráva hodnotitele: H1 – H6 , H8 a pojistky D2 , D3 , D4	Pokračovat: H2 aspoň 90 % trajektorie, H5 ≤ 550, H4 ≥ 0,7, H3 aspoň 80 % urgentních, H1 klesající, žádná pojistka porušena. Upravit: 1–2 ukazatele mimo práh nebo pojistka porušena v jednom kraji. Zmenšit: H2 pod 50 %, tři a více ukazatelů mimo práh nebo pojistka porušena ve více krajích	Registry pojišťoven, eŽádanka, NRZP (data za 2032); ÚZIS dodatkem	Rozhodnutí a důvody se zveřejní; pozastavení přeměny v postižených krajích

Převodník z verze 2

Z 29 ukazatelů verze 2 zůstalo 18 řádků, ty se sloučily do 16 ukazatelů verze 3, 11 řádků vypadlo a 4 ukazatele přibyly, což dává přesně 20. Verze 2 přitom v textu mluvila o dvaceti ukazatelích a v tabulce jich měla 29; tento rozpor tím zaniká.

Co se stalo	Ukazatele verze 2	Ukazatel verze 3 a důvod
Sloučeno	Týmy sdružené péče; sestry na praktika	H2 : oba měří totéž, tedy obsazenost týmu podle standardu
Sloučeno	Čekání ke specialistovi s doporučením a bez něj; veřejně měřené čekací doby	H3 : jeden ukazatel s rozpadem podle triážní kategorie a podle toho, zda má pacient žádanku
Převzato, cíl změněn	Bez praktika; UPC; odvratitelné hospitalizace; podíl akutní lůžkové péče; akutní lůžka; obložnost; kolonoskopie; screening střeva; očkování 65+; alkohol; játra; cukr; výdaje na prevenci; podíl úhrad praktikům	H1 , H4 , H5 , H6 , D1 , D2 , D5 – D12 : cíle posunuty o tři roky, snížené nebo odvozené z mechanismů, případně „sledujeme bez cíle“
Vyřazeno: výstup, ne výsledek	Podíl pacientů 75+ s návštěvní službou; hospitalizace na 100 tis.	Návštěvní služba (J4) se sleduje v registru opatření; celkový počet hospitalizací nerozliší dobrou a špatnou změnu
Vyřazeno: bez mechanismu nebo s nejasnou definicí	Mamografický screening; preventivní prohlídka u praktika; obezita dospělých	Mamografie je silná stránka bez zásahu reformy; prohlídka má dvě definice (62,0 % podle MZ, 52,6 % podle ÚZIS PPS-08-01); obezita se mění pomalu a mechanismus chybí
Vyřazeno: přesunuto jinam	Podíl lůžkových zařízení celkem; saldo veřejného zdravotního pojištění; výnos daní za zdraví; veřejné ukazatele následné péče; soulad místa péče u paliativních pacientů; dny na akutním lůžku z čekání na sociální službu	Lůžková zařízení celkem zahrnují centrová léčiva a následnou péči a hlavní cíl neměří; saldo a výnos daní patří do Části V; kvalitu následné péče zveřejní rámec HSPA; paliativa jdou do policy briefů; kapacitu následné péče nově měří D3
Nově	Katastrofické výdaje domácností; odvratitelná úmrtnost; kapacita následné a dlouhodobé péče; dojezd ZZS	H8 , H7 , D3 , D4 : chyběly v tabulce úspěchu, přestože je diagnóza a pojistky přeměny lůžek potřebují

Část X — Rizika a pojistky

Reformu nejvíc ohrožují tři rizika: nedostatek sester, podhodnocené náklady a nedostatečná legislativní kapacita ministerstva. Registr v této části eviduje devatenáct rizik; ke každému uvádí měřitelný časný signál, pojistku, vlastníka a bránu, u které se o něm rozhoduje. Místo obecných opatrnostních vět platí pravidla, která reformu předem zastaví, zmenší nebo posunou, než nesplněný předpoklad zatíží rozpočet.

Matice rizik

Pět z devatenácti rizik má vysokou pravděpodobnost i vysoký dopad

Pravděpodobnost × dopad · odborný odhad autorů, Projektová kancelář ho přehodnocuje čtvrtletně

Dopad	Pravděpodobnost: střední	Pravděpodobnost: vysoká
vysoký	**Mít pojistku připravenou** · 6 R4 MF/NRR odmítne vzorec platby státu R6 Ústavní napadení zákona o síti R9 Řetězce a koncentrace vlastnictví praxí R11 Obložnost a dostupnost při přeměně lůžek R14 Nedohodnutý pilot R18 Politická únava a ztráta podpory odborníků	**Řešit hned** · 5 R1 **Nedostatek sester a odliv z nemocnic** R2 Úbytek praktiků R3 **Podhodnocené náklady** R12 **Kapacita legislativy MZ** R13 Koaliční partner nepodpoří
střední	**Sledovat** · 4 R7 SGEI a veřejná podpora R8 Notifikace TRIS R10 Ztráta kontinuity v týmech R17 IT: eŽádanka	**Sledovat a tlumit** · 4 R5 Lobby nápojového průmyslu a vinařů R15 Zpoždění dat R16 Souběh 1. 1. 2029 R19 Střet zájmů autora (vnímání)

pole „řešit hned“ **Aa** tučně: tři největší rizika (sestry, náklady, legislativní kapacita)

Textová verze

Riziko	Kategorie	Pravděpodobnost	Dopad	Brána
R1 Nedostatek sester a odliv z nemocnic	personál	vysoká	vysoký	B3 (12/2031); nesplněno = varianta B
R2 Úbytek praktiků	personál	vysoká	vysoký	B1, B3
R3 Podhodnocené náklady	peníze	vysoká	vysoký	B1, B2
R12 Kapacita legislativy MZ	implementace	vysoká	vysoký	B2
R13 Koaliční partner nepodpoří	politika	vysoká	vysoký	B2
R4 MF/NRR odmítne vzorec platby státu	peníze	střední	vysoký	B2; účinnost 1. 1. 2031
R6 Ústavní napadení zákona o síti	právo	střední	vysoký	předložení 2031; B3
R9 Řetězce a koncentrace vlastnictví praxí	implementace	střední	vysoký	B3, B4
R11 Obložnost a dostupnost při přeměně lůžek	implementace	střední	vysoký	krajský plán sítě; B3, B4
R14 Nedohodnutý pilot	implementace	střední	vysoký	B1 (6/2028)
R18 Politická únava a ztráta podpory odborníků	politika	střední	vysoký	B1
R5 Lobby nápojového průmyslu a vinařů	politika	vysoká	střední	B2
R15 Zpoždění dat	evidence	vysoká	střední	B3
R16 Souběh 1. 1. 2029	implementace	vysoká	střední	B2
R19 Střet zájmů autora (vnímání)	politika	vysoká	střední	B1
R7 SGEI a veřejná podpora	právo	střední	střední	předložení 2031; B3
R8 Notifikace TRIS	právo	střední	střední	B2 (legislativní plán)
R10 Ztráta kontinuity v týmech	implementace	střední	střední	vyhodnocení pilotu 2030; B3
R17 IT: eŽádanka	implementace	střední	střední	B1, B3

Podklad: studie v3, ř. 2078–2112 (registr rizik ř. 2092–2112).

matice rizik · 19 rizik, 4 pole

Do pravého horního pole patří pět rizik; tři největší mají každé vlastní bránu s pravidlem návratu. Hodnocení pravděpodobnosti a dopadu je odborný odhad autorů, který Projektová kancelář po konzultacích přehodnocuje čtvrtletně.

Registr rizik

Registr eviduje 19 rizik; ke každému patří časný signál, který lze změřit dřív, než riziko způsobí škodu, pojistka, kdo ho hlídá a brána, u které se o něm rozhoduje. Řazení: nejdřív rizika s vysokou pravděpodobností i dopadem. Registr vede Projektová kancelář reformy a čtvrtletně ho předkládá Řídicímu výboru, který překročený signál projedná na nejbližším zasedání.

Riziko	Kategorie	Prav.	Dopad	Časný signál (měřitelný)	Pojistka	Kdo hlídá	Brána
R1 Nedostatek sester a odliv z nemocnic	personál	vysoká	vysoký	Obsazenost sesterských míst v týmech pilotu a vakance sester v nemocnicích dotčeného kraje (registry pojišťoven, čtvrtletně); počet přihlášek na VŠ a VOŠ ošetřovatelství při ~680 absolventech VŠ a ~570 VOŠ ročně. I bez reformy chybí za 12 let asi 2 tisíce všeobecných sester: potřeba nejméně 24 000 úvazků proti 11 078 z VŠ a asi 11 000 z VOŠ (dopočet studie z MZ ČR 2025, s. 114); 4 000 sester pro týmy jsou nad tímto rámcem	Náběh v etapách; plat na úrovni nemocniční sestry; placení jen obsazených funkcí; přesun z nemocnic jen tam, kde se práce změnila, a s nabídkou každému dotčenému (rekvalifikace, přechod do primární, domácí či paliativní péče); P1 personální bilance po krajích včetně náboru ze zahraničí a zrychlení aprobací	Projektová kancelář; Nezávislý hodnotitel	B3 (12/2031); nesplněno = varianta B
R2 Úbytek praktiků	personál	vysoká	vysoký	Roční úbytek PLD v registrech pojišťoven nad horní hranicí 110–180; počet lidí bez praktika (J5)	J3 kompetence praktiků (zrušení preskripčních omezení, nové výkony, např. USG); P2 rezidenční místa; ochrana hodnoty praxe při vstupu do týmu; sestra přebírá péči o chroniky; PLDD se neruší	SPL ČR s Projektovou kanceláří	B1 , B3
R3 Podhodnocené náklady	peníze	vysoká	vysoký	Skutečné platby týmům v pilotu na pojištěnce mimo rozpětí 4,8–7,5 mld. Kč ročně v plném náběhu; čistý náklad mimo rozpětí 15–25 mld. Kč	Plánování s rozpětím místo bodu; graf citlivosti; zveřejněný model s verzí a datem; oddělení toho, co už je v plánu MZ (10 mld. Kč z v. z. p. na podporu praxí); přepočet z nákladů pilotu před B2	Projektová kancelář; MF v Řídicím výboru	B1 , B2
R12 Kapacita legislativy MZ	implementace	vysoká	vysoký	Ve vládním plánu víc než dvě velké předlohy; věcné záměry zákona o primární péči a zákona o síti nehotové k 12/2029; neobsazené týmy pro primární péči a pro síť v legislativním odboru	Vlny 0–4; za období jen dvě velké předlohy; HTA rozšířením mandátu SÚKL/ÚZIS místo nového zákona; posílení legislativního odboru; začít smlouvou a vyhláškou; věcné záměry psát už v opozici	Řídicí výbor; RT s Institutem Pi (F0–F1)	B2
R13 Koaliční partner nepodpoří	politika	vysoká	vysoký	Jádro J1 – J10 chybí v návrzích koaliční smlouvy a programového prohlášení; veřejné výhrady partnera k J8 – J10 (daně, platba státu)	Konzultace a memoranda s potenciálními partnery 2026–2029; navazování na vládní reformy pozměňovacími návrhy, ne protinávrhem; jádro rozdělené na nástroje přijatelné postupně; varianty B a C	RT; poslanecký klub	B2
R4 MF/NRR odmítne vzorec platby státu	peníze	střední	vysoký	Negativní stanovisko MF v připomínkovém řízení; zmrazení platby pro 2028 se opakuje i pro další roky; vzorec chybí v programovém prohlášení	Výpočet vzorce (J10 , § 3c zák. 592/1992 Sb.) v jedné tabulce včetně automatického růstu ~11,7 mld. Kč, který vyvolá vyšší sazba; 100 Kč měsíčně na státního pojištěnce ≈ 7,2 mld. Kč ročně; jednání s MF a NRR od programu 2029; při odmítnutí zůstává příspěvek z daní (3–5 mld. Kč) a reforma se zmenšuje na B	Řídicí výbor (MF, pojišťovny); v opozici poslanecký klub	B2 ; účinnost 1. 1. 2031
R6 Ústavní napadení zákona o síti	právo	střední	vysoký	Ústavní rozbor (čl. 8 a 101 Ústavy, čl. 11 Listiny) před předložením shledá zásah do samosprávy nebo vlastnictví bez dostatečné náhrady; výhrady Legislativní rady vlády	Nejdřív nástroje bez zákona (§ 17 a § 46 zák. 48/1997 Sb., NV 307/2012 Sb., Věstník; precedent onkochirurgie: první vlna – játra, slinivka, jícen – od 1. 9. 2026 podle Věstníku MZ 10/2026, další obory 2027–2030); přeměna místo rušení; garance příjmu jako náhrada; dopadová studie fondu přeměny; nezávislý právní posudek	Legislativní odbor MZ	předložení 2031; B3
R9 Řetězce a koncentrace vlastnictví praxí	implementace	střední	vysoký	Podíl praxí a týmů v ORP pod jedním skutečným vlastníkem (veřejný registr) se blíží krajskému stropu 20 %; platby mezi propojenými firmami	Veřejní skuteční vlastníci; posouzení koncentrace ve spádovém území s vyjádřením obce; pravidla plateb mezi propojenými firmami; klinická nezávislost; krajský strop 20 %; dotace jen obci	Pojišťovny; Nezávislý hodnotitel	B3 , B4

Riziko	Kategorie	Prav.	Dopad	Časný signál (měřitelný)	Pojistka	Kdo hlídá	Brána
R11 Obložnost a dostupnost při přeměně lůžek	implementace	střední	vysoký	Průměrná obložnost akutních lůžek v kraji nad 85 % včetně sezónních špiček; podíl obyvatel s urgentním příjmem do 30 minut pod 95 %; dny na akutním lůžku z čekání na sociální službu	Stop přeměny v kraji při obložnosti nad 85 % (Madsen 2014: +9 % úmrtnost); J7 kapacita následné a dlouhodobé péče předem; posílení základen ZZS před sloučením; přeměna, ne rušení	Kraj; Nezávislý hodnotitel	krajský plán sítě; B3 , B4
R14 Nedohodnutý pilot	implementace	střední	vysoký	Do 6/2027 není dohoda kraje, VZP a obcí; po komunálních volbách 10/2026 se mění vedení obcí	Tři ORP v kraji, který se k pilotu přihlásí; nezávislý hodnotitel jmenovaný před startem; náhradní smluvní model (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.) u jedné pojišťovny; jednání ihned po ustavení obcí	RT; Institut Pi	B1 (6/2028)
R18 Politická únava a ztráta podpory odborníků	politika	střední	vysoký	Počet z 10 klíčových organizací, se kterými je plán projednaný a jejich výhrady zapracované (cíl všech 10); odchody z kulatých stolů; odmítavé stanovisko komory nebo společnosti	Zveřejněné vypořádání připomínek; spolutvorba standardu týmu se SPL ČR a SPLDD ČR; memoranda o podpoře; jasné otázky v každém kole konzultací; PLDD se neruší	RT; Institut Pi	B1
R5 Lobby nápojového průmyslu a vinařů	politika	vysoká	střední	Stanoviska svazů výrobců proti sazbám v připomínkovém řízení; počet poslaneckých pozměňovacích návrhů k osvobození	Náběh (víno poloviční sazba 2031–2032, plná 2033); poloviční sazba pro malé vinaře; daň ze slazených nápojů ohlášená v programu 2029 s pásmy podle cukru; výnos vázaný na prevenci; plánuje se jen 5 mld. Kč; neúspěch daně zastaví jen daň	RT; poslanecký klub	B2
R15 Zpoždění dat	evidence	vysoká	střední	Ukazatel brány nemá k termínu aktuální hodnotu; zpoždění dat ÚZIS a OECD 1–3 roky	Brány stavět na datech z registrů pojišťoven, NRZP a eŽádanky; „žádná brána bez dat“ = brána se odloží	Nezávislý hodnotitel (ÚZIS + univerzita)	B3
R16 Souběh 1. 1. 2029	implementace	vysoká	střední	Od 1. 1. 2029 naběhne strop pobytu podle § 22b zák. 48/1997 Sb. a zrušení § 52 zák. 108/2006 Sb. (zák. 38/2025 Sb.), skončí pevný základ z tisku 235; v pilotu klesají výkony nebo rostou odmítnuté registrace proti srovnávacím ORP	Na tento den neklademe žádný krok reformy: finanční novela 1. 1. 2031, zákon o primární péči 1. 1. 2032; vyhodnocení pilotu očištěné o vliv těchto změn	Nezávislý hodnotitel; Projektová kancelář	B2
R19 Střet zájmů autora (vnímání)	politika	vysoká	střední	Kritika v médiích a odborných stanoviscích; žádost o vyloučení autora z jednání o pilotu	Prohlášení o střetu zájmů v úvodu (Správní rada VZP, PEER, HSPA Monitor); autor se vyloučí z hlasování Správní rady VZP o pilotu; nezávislý hodnotitel; zveřejněný model a data	autor; RT	B1
R7 SGEI a veřejná podpora	právo	střední	střední	Výhrady ÚOHS nebo Evropské komise v předběžném posouzení pověřovacího aktu a veřejné podpory	Pověřovací akt SGEI podle rozhodnutí 2012/21/EU; posouzení veřejné podpory zahájit před vlnou 3, u osvobození malých výrobců ve vlně 1 totéž; záloha: investiční část fondu přeměny (5–10 mld. Kč) bez provozní garance	Legislativní odbor MZ; MF	předložení 2031; B3
R8 Notifikace TRIS	právo	střední	střední	Komise nebo členský stát vydá podrobné stanovisko k notifikovanému znění, což může prodloužit lhůtu	Notifikovat souběžně s meziresortním řízením; do harmonogramu počítat tříměsíční lhůtu s rezervou; týká se zdravotních varování a minimální ceny alkoholu (vlna 4), ne jádra	Legislativní odbor MZ	B2 (legislativní plán)
R10 Ztráta kontinuity v týmech	implementace	střední	střední	Index UPC týmů v pilotu je pod srovnatelnými samostatnými praxemi; klesá podíl kontaktů s jmenovaným ošetřujícím lékařem	Jmenovitý ošetřující lékař u každého pacienta; dvojice lékař–sestra; malé týmy; kontinuita v odměně; kontrolní bod pilotu (Bates 2025, Kegreiss 2026, Kovacevic 2023)	Nezávislý hodnotitel pilotu	vyhodnocení pilotu 2030; B3
R17 IT: eŽádanka	implementace	střední	střední	Novela zák. 325/2021 Sb. (povinná eŽádanka) neprojde nebo je bez triážního pole do 6/2028; podíl žádanek s vyplněným triážním údajem	Pozměňovací návrh k novele; měření čekání z dat pojišťoven nezávisle na eŽádance; měkký gatekeeping (přímý přístup ke specialistovi zůstává, sankce nedopadá na pacienta)	Poslanecký klub; MZ; pojišťovny	B1 , B3

Co by nás zastavilo

Platí čtyři stop pravidla, která Řídicí výbor uplatňuje čtvrtletně a při přechodu přes každou ze čtyř bran (B1 v 6/2028, B2 v 12/2029 až 1/2030, B3 ve 12/2031, B4 v roce 2033). Rozhodují data, ne nálada, a každé rozhodnutí se zveřejňuje.

- **Žádná brána bez dat.** Brána se uzavře jen na datech, která v době rozhodování existují: registry pojišťoven, NRZP a eŽádanka. Chybí-li data, brána se odloží a důvod se zveřejní. Data ÚZIS se zpožděním slouží k následnému ověření, ne jako podmínka brány.
- **Neúspěch nástroje zastaví jen ten nástroj.** Neprojde-li například daň ze slazených nápojů nebo nový vzorec platby státu, týmy a sestry pokračují; Projektová kancelář přepočte krytí (viz Část V) a rozsah reformy se upravuje podle stupňů A, B, C níže.
- **Nesplněná brána B3 znamená variantu B.** Ve 12/2031 musí být obsazena aspoň polovina míst sester v týmech první vlny (data z registrů pojišťoven), schválen zákon o primární péči a rozpracovány krajské plány sítě. Jinak se centra nestavějí a reforma pokračuje bez nich.
- **Akutní lůžko se nepřemění, dokud kraj neprokáže kapacitu a dojezd.** Kraj musí doložit kapacitu následné a dlouhodobé péče (J7) a dojezd k urgentnímu příjmu. Při průměrné obložnosti akutních lůžek nad 85 % se přeměna v daném kraji zastaví (Madsen a kol., Health Aff 2014: obložnost nad 85 % je spojena s o 9 % vyšší úmrtností).

Brána B4 v roce 2033 nemá jen ano a ne: nezávislý hodnotitel (ÚZIS s univerzitou) doporučí pokračovat, upravit, nebo zmenšit. Zmenšení znamená přechod na nižší stupeň níže, ne návrat k nule.

Jak reforma zmenší rozsah

Reforma se zmenšuje po stupních A, B, C a v žádném z nich nepřijde o položky, které na centrech nezávisí: prevenci, paliativní týmy, konzultace lékař–lékař a fond přeměny. Srovnání je tím férové: rozdíl mezi A a B tvoří jen centra a budovy. Náklad každého stupně uvádí Část V.

Stupeň	Co obsahuje	Spouštěč přechodu na nižší stupeň	Kdo rozhoduje
A. Plná, s centry	Týmy sdružené péče a centra, sestry, prevence, paliativa, konzultace, fond přeměny, zákon o primární péči a zákon o síti	A na B: brána B3 (12/2031) nesplněna, tedy méně než polovina míst sester v týmech první vlny, neschválený zákon o primární péči nebo nerozpracované krajské plány; nebo pilot (vyhodnocení 2030) ukáže, že praktici do týmů nevstupují	Řídicí výbor na doporučení Nezávislého hodnotitele
B. Bez center	Týmy, sestry, prevence, paliativa, konzultace, fond přeměny; bez budov a center	B na C: hodnotitel v bráně B4 (2033) doporučí zmenšit; nebo finanční novela s novým vzorcem platby státu (J10) neprojde a sesterská složka nemá trvalé krytí	Řídicí výbor na doporučení Nezávislého hodnotitele
C. Minimální	Opatření, která nepotřebují nové velké zákony: smluvní model (smlouva podle § 17 zák. 48/1997 Sb.), úhradová vyhláška, seznam výkonů, kompetence sester a praktiků, eŽádanka s triážním údajem	— (nejnižší stupeň; zbytek se předává dalšímu období)	Řídicí výbor

Bez ohledu na stupeň se nikdy nezmenší tři věci: měření ukazatelů a čekání, pojistky u lůžek (obložnost 85 %, kapacita dlouhodobé péče, dojezd) a nezávislé hodnocení. Hlídají reformu i ve variantě C.

Ověřit: číselné prahy přechodu z B na C (například podíl obsazených míst sester po B3) stanoví Řídicí výbor před bránou B1.

Ověřujeme

Část XI — Deset oblastí Manifestu: policy briefy

Deset oblastí Manifestu mimo jádro reformy je zpracováno jako 10 krátkých briefů se 45 opatřeními; každý brief má vlastní tempo a nesmí brzdit jádro J1 –J10. Posudek napočítal ve v2 asi 55 opatření v této vrstvě a upozornil, že čtenář nepozná jádro od doprovodu. Proto zde zůstávají jen opatření, která nejsou řešena v Části III, a duplicity (zubní prevence, revize léků, kompetence sester) jsou nahrazeny odkazem.

Doprovod se řídí pravidlem rozhodování D21: neúspěch jednoho briefu zastaví jen tento brief, nikdy jádro. Termíny jsou uvedeny v základním scénáři „Vláda 2030“; opatření, která lze udělat smlouvou, vyhláškou nebo metodikou bez zákona, začínají už ve fázi F0. Zákonné části jsou zařazeny do vln 2 a 4 podle Části VII a počítají s tím, že za volební období projdou realisticky jen dvě velké předlohy.

Každý brief má stejnou stavbu: cíl, opatření, nástroj, termín, náklad, vazba na jádro a otevřené otázky pro RT. Náklad uvádíme jen tam, kde ho má v2 a posudek ho nezpochybnil; jinak stojí „nevyčísleno“. Kde se v3 odchyluje od Programu pro moderní zdravotnictví 2021–2024, je to označeno slovy „Odchylka od programu 2021“ a shrnuto v závěrečné tabulce.

Oblast	Cíl	Opatření	Hlavní nástroj	Nejdřívější termín	Vazba na jádro	Garant v RT
1. Hodnocení účelnosti a standard péče	Každá nová úhrada a každý nový model péče prošly nezávislým hodnocením	4	Metodika ÚZIS, později zákon nebo rozšíření mandátu SÚKL a ÚZIS	2027 (metodika pro pilot); zákon 2033 a později	J1 (pilot), brána B4	doplní RT
2. Rozšířená péče	Za nadstandard nelze koupit rychlost ani lepší výsledek	4	Novela zákonů o pojištění a o fondech	1. 1. 2032	P4 , oblast 1	doplní RT
3. Pojišťovny, DRG, evidence nároků	Hlas pojištěnců a zveřejněné čekací doby	4	Pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030, později novely	2027–2028 (návrhy); zákony 2033 a později	J1 , J5 , J10	doplní RT

Oblast	Cíl	Opatření	Hlavní nástroj	Nejdřívější termín	Vazba na jádro	Garant v RT
4. Transparence a otevřená data	Srovnatelná data o poskytovatelích bez nového papírování a komise bez střetu zájmů	5	Metodika ÚZIS, novela zák. 372/2011 Sb.	2027 (bez zákona); zákon 2033 a později	J5 , P5	doplní RT
5. Dostupné léky	Předvídatelný doplatek, dostupnost léků, ochrana pojišťoven před drahou léčbou	4	Novely zákonů o léčivech a o pojištění, společný rizikový fond	návrh 2032–2033	Část III (revize léků)	doplní RT
6. Světový klinický výzkum	Dvojnásobek akademických klinických studií	4	Akční plán strategie klinických hodnocení, dotační program	2028, pokud vypíše současná vláda; jinak 2031	J1 (pilot jako studie)	doplní RT
7. Stomatologie	Vyšší účast na prevenci a nižší platby u zubaře	5	Úhradová vyhláška, SZV, novela zák. 48/1997 Sb.	2028 (SZV, šetření); zákon 1. 1. 2032	P4 , Pilíř 4	doplní RT
8. Vzdělání a podmínky personálu	Lidé pro týmy: rezidenční místa a podmínky práce sester	5	Dotační titul MZ, vyhláška, personální bilance	rozpočet 2028 (podnět); závazně 2031	J2 , P1 , P2 , brána B3	doplní RT
9. Práva pacientů	Bezplatná cesta k ombudsmanovi s vymahatelným doporučením	5	Novela zák. 372/2011 Sb. a 349/1999 Sb.	2028–2029 (přání); ombudsman 1. 1. 2032	J1 (standard center)	doplní RT
10. Duševní zdraví	Stabilní komunitní péče a rychlý první kontakt	5	Úhrada, financování sociální části center, novela zák. 96/2004 Sb. a 48/1997 Sb.	2027 (mapa center); zákony 2033 a později	J1 (psycholog v týmu), P3	doplní RT

1. Hodnocení účelnosti a standard péče

Cíl. Každá nová úhrada a každý nový model péče, včetně modelů této studie, projde nezávislým hodnocením přínosu a nákladů.

Opatření

- Metodika hodnocení organizačních modelů pod ÚZIS, použitá poprvé na pilotu (D18).
- Hodnocení započítává dopad na veřejné rozpočty jako celek, včetně úspor a nákladů v sociálním systému, díky propojení dat MZ a MPSV (Hospodářská strategie PEER).
- Nezávislá instituce pro hodnocení technologií s otevřenými daty a právem pacientů vstoupit do hodnocení; hodnotí léky, výkony, prostředky, digitální nástroje i organizační modely.
- Standard hrazené péče jako výstup hodnocení, včetně standardu týmů a následné péče, soutěž pojišťoven nad standardem a pravidelná revize.
- Napojení na evropské společné klinické hodnocení (nařízení 2021/2282, od ledna 2025 pro onkologika), které bude pro Česko povinným vstupem.

Nástroj. Metodika ÚZIS bez zákona; poté buď nový zákon o institutu (velká předloha, vlna 4), nebo rozšíření mandátu SÚKL a ÚZIS (malá až střední novela), pokud nebude kapacita na velkou předlohu (D3). Vzory: NICE (od roku 1999), G-BA a IQWiG, HAS, SBU.

Výchozí stav: na doporučených postupech, indikátorech kvality, HSPA, predikci personálních kapacit a hodnocení programů prevence pracuje od 19. 1. 2023 Národní institut kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ), společné pracoviště MZ a ÚZIS (nikez.mzcr.cz; MZ ČR 2025, s. 53 a 58). Metodiku hodnocení organizačních modelů (M1.1) navrhujeme vést v NIKEZ.

Termín. Metodika 2027 (F0), rozhodnutí o podobě instituce v F1 (2028–2029). Zákon nebo rozšířený mandát se předkládá až po zákonech o primární péči a o síti, účinnost 2033 a později; v2 počítala s Balíčkem 3 v roce 2030.

Náklad. Nevyčísleno.

Vazba na jádro. Hodnocení pilotu (J1) a nezávislé hodnocení v bráně B4 (2033) stojí na této metodice; bez ní by se o týmech rozhodovalo podle síly zájmových skupin.

Odchylka od programu 2021. Standard solidární péče z hodnocení technologií přebíráme, ale nezačínáme od nuly: zákon 289/2025 Sb. už zavedl evropské hodnocení technologií a MZ má implementační plán, na který navazujeme.

Otevřené otázky pro RT

- Institut jako nová instituce, nebo rozšíření mandátu SÚKL a ÚZIS? Ověřit: volná kapacita SÚKL a ÚZIS pro hodnocení výkonů a organizačních modelů.

Ověřujeme

- Kdo hodnotí organizační modely v letech 2028–2033, než instituce vznikne?

2. Rozšířená péče: možnost volby bez úplatků

Cíl. Zákon odděluje plně hrazený standard od volitelné nadstandardní péče tak, aby si za nadstandard nešla koupit rychlost ani lepší výsledek léčby.

Opatření

- Zákonné vymezení druhů rozšířené péče, doplatku a ochranného limitu pro zranitelné; hranici stanoví zákon, nikoli vyhláška.
- Plně hrazená základní varianta, kterou musí poskytovatel nabídnout jako první a bez vlivu na termín.

- Přeměna fondů prevence pojišťoven (od roku 2026 upraveny zákonem 289/2025 Sb.) na fondy rozšířené péče s možností připojištění; prevenci převezme tým a Fond prevence (P4).
- Transparentní ceník a nezávislé posouzení hranice: co je léčebně lepší a přiměřeně nákladné, patří do standardu a nelze to prodávat (oblast 1).

Rozšířenou péčí nikdy nebude kratší čekání, přednostní pořadí, přístup k lékaři, hrazené léky, léčba s lepším výsledkem ani neodkladná péče.

Nástroj. Novela zákonů 48/1997, 551/1991 a 280/1992 Sb. a vyhlášky 418/2003 Sb. (střední předloha, vlna 2). Východiskem je nález Pl. ÚS 36/11 z 20. 6. 2013, který zrušil nadstandard z novely 298/2011 Sb. hlavně proto, že varianty vymezovala jen vyhláška.

Termín. Předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032 (vlna 2). V2 uváděla Balíček 2 v roce 2029; ve scénáři D1 to nelze.

Náklad. Nevyčísleno.

Vazba na jádro. Nemíchá se s prevencí: tu financuje Fond prevence z daní za zdraví (P4), fond rozšířené péče slouží jen službám nad standard.

Odchylka od programu 2021. Opouštíme návrh, že pojišťovna „není vázána výstupy“ hodnocení technologií a že se doplatek platí přímo u poskytovatele. Hranici určí zákon s nezávislým posudkem a kratší čekání se nikdy neprodává; změna je v souladu s nálezem Pl. ÚS 36/11.

Otevřené otázky pro RT

- Ověřit právníkem: rozsah výroku nálezu Pl. ÚS 36/11 a zda smí seznam variant stát v prováděcím předpise.
- Jak zabránit zužování standardu ve prospěch nadstandardu? V2 navrhuje zákonné vymezení, nezávislé hodnocení a ochranný limit; chybí zkouška na datech.

3. Pojišťovny, DRG a evidence nároků

Cíl. Pojištěnec má hlas tam, kde se rozhoduje o jeho penězích, a pojišťovna eviduje a zveřejňuje, jak dlouho se na péči čeká.

Opatření

- Evidence plnění nároku včetně čekání, navazující na eŽádanku s triážním údajem (J5); v pilotu od roku 2028 ve smlouvě s VZP, plošně nejdřív s úhradovou vyhláškou 2031.
- Jeden ucelený návrh správy pojišťoven jako pozměňovací návrh k reformě „Moderní v. z. p. 2030“ (správní rady o 9 členech): hlas pojištěnců, veřejná jednání a podklady, jmenovité hlasování, žádní zástupci poskytovatelů v orgánech pojišťoven, losovaný panel pojištěnců s právem vyžádat veřejné slyšení.
- Pravidla DRG zákonem: základní sazba, valorizace, přechod a platba za připravenost; navazuje na konvergenci CZ-DRG z 1:1,7 na 1:1,3 do roku 2031, kterou ministr označil za prioritu. Vedle rozpětí sazeb sledujeme podíl akutní lůžkové péče hrazené jednotnou základní sazbou: 3,4 % v roce 2022, přes 25 % v roce 2025, cílem je aspoň 30 % (MZ ČR 2025, s. 74, 76 a 82).
- Pružnost v krizi: zmocnění vlády k dočasné odchylce s odůvodněním Sněmovně a trvalý rizikový koridor ±5 %. Výchozí stav: úhradová vyhláška 2025 zúžila rizikový koridor o dalších 5 % (MZ ČR 2025, s. 82); zúžení o 5 % a trvalý koridor ±5 % nejsou totéž.

Součástí návrhu správy je i přímá volba zástupců pojištěnců v zaměstnaneckých pojišťovnách přes identitu občana (tisk 479 z roku 2023). V jádru reformy tato volba není (D16). Pojišťovny dnes mají nepřímé zastoupení pojištěnců a jejich jednání nejsou veřejná; Správní rada VZP má 30 členů, z nichž 20 volí Sněmovna a 10 jmenuje vláda.

Nástroj. Pozměňovací návrhy k reformě v. z. p. 2030 (Sněmovna 2027, účinnost 2028); novely zákonů 551/1991 a 280/1992 Sb. (zastoupení pojištěnců) a § 41a zákona 48/1997 Sb. (DRG), vlna 4; evidence čekání přes novelu zákona 325/2021 Sb. (vlna 0, jinak vlna 2) a úhradovou vyhlášku.

Termín. Pozměňovací návrhy 2027–2028 (F0). DRG zákonem a zastoupení pojištěnců: předložení po roce 2031, účinnost 2033 a později. V2 uváděla evidenci nároku jako podmínku smluv od roku 2028; v3 ji v pilotu zavádí smlouvou a plošně až s vyhláškou 2031.

Náklad. Nevyčísleno. U přímé volby je třeba odhad nákladů voleb: ministerstvo v roce 2023 namítalo náklady v desítkách milionů korun a riziko pro udržitelnost a toto tvrzení dosud nikdo nevyvrátil.

Vazba na jádro. Pojišťovny uzavírají pětileté smlouvy s týmy (J1) a naplňují krajský plán sítě (J6); měření čekání je součástí J5.

Odchylka od programu 2021. Program navrhoval radu pojištěnců volenou přímo u všech pojišťoven. V2 to změnila na přímou volbu jen u zaměstnaneckých pojišťoven a volbu celé Správní rady VZP Sněmovnou; v3 nepodává samostatnou předlohu, ale slučuje oba prvky do jednoho návrhu k reformě ministerstva, aby nevznikly dva návrhy správy pojišťoven. Indikační omezení místo objemových limitů se vrací do Pilíře 2 (Část III).

Otevřené otázky pro RT

- Ověřit: náklady voleb, očekávaná účast a postup při účasti pod 5 %.

Ověřujeme

- Ověřit: jak se 9členná správní rada podle reformy MZ promítne do VZP s dnešními 30 členy a volbou Sněmovnou.

Ověřujeme

- Střet zájmů: autor studie je členem Správní rady VZP; návrh má proto posoudit RT bez jeho hlasu (viz úvod studie).

4. Transparence a otevřená data

Cíl. Pacient i plátce vidí srovnatelná data na úrovni poskytovatele bez ročenek se zpožděním a bez nového papírování.

Opatření

- Otevřená anonymizovaná data na úrovni poskytovatele, sestavená z toho, co poskytovatelé už vykazují.
- Informace pro pacienta před zákrokem a volné kapacity v reálném čase.
- HSPA jako oficiální rámec hodnocení v zákoně (P5): ÚZIS počítá, Rada HSPA schvaluje, ministerstvo vydává zprávu; roční aktualizace po krajích a ORP a úplná zpráva každé čtyři roky včetně ukazatelů reformy.
- Hodnocení reformy provádí ÚZIS s univerzitou v oficiálním rámci (D20), ne nástroj autorů studie.
- Střet zájmů v komisích a poradních orgánech ministerstva (M4.5). Každý člen komise, pracovní skupiny nebo poradního orgánu ministerstva, SÚKL a ÚZIS podává veřejné prohlášení o zájmech (zaměstnání, smlouvy, honoráře, podíly, členství v orgánech) za poslední tři roky a každý rok ho obnovuje. Kdo má zájem na projednávané věci, nehlasuje a nepřipravuje podklad. Hlasování jsou jmenovitá a zápisy veřejné do 30 dnů. Cílem jsou komise bez střetu zájmů; kde se bez odborníků z praxe neobejdou, platí aspoň úplná průhlednost. Týká se zejména pracovní skupiny k seznamu výkonů, komisí k úhradám a kategorizaci, komise k rozmístění přístrojů, dotačních a výběrových komisí a akreditačních komisí. Ověřit: úplný seznam komisí a poradních orgánů ministerstva a znění jejich statutů.

Ověřujeme

Východisko: rámec HSPA pro Česko spustila OECD s ministerstvem 24. 5. 2023 (122 ukazatelů, u 30 chybí metodika nebo data). Indikátory kvality, resortní referenční statistiky a HSPA patří mezi programové cíle NIKEZ, společného pracoviště MZ a ÚZIS fungujícího od 19. 1. 2023 (nikez.mzcr.cz; MZ ČR 2025, s. 53, 56 a 58); rámec P5 navrhujeme vést v NIKEZ. Na online objednání se k lékaři dostalo 19,6 % lidí proti 39,8 % v EU (Eurostat isoc_ci_ac_i). Zákon 159/2006 Sb. o střetu zájmů dopadá na veřejné funkcionáře, ne na členy komisí a poradních orgánů ministerstva; jejich prohlášení o zájmech dnes nejsou veřejná a hlasování nejsou jmenovitá. Evropská agentura pro léčivé přípravky prohlášení svých expertů zveřejňuje a podle míry zájmu omezuje jejich roli v jednání.

Nástroj. Metodika a zveřejňování ÚZIS bez zákona; pro zákonnou povinnost malá novela zákona 372/2011 Sb. (NZIS), vlna 4. Střet zájmů v komisích: příkaz ministra a statuty komisí bez zákona (F0), zákonné zakotvení ve stejné novele.

Termín. Otevřená data a metodika od 2027 (F0, podněty ÚZIS a ministerstvu); zákonná povinnost zprávy účinná 2033 a později. V2 slibovala první úplnou zprávu do 30. 6. 2030; ta nezávisí na novém zákonu, ale na vydání zprávy ÚZIS a ministerstvem. Ověřit u ministerstva: zda byla první úplná zpráva, plánovaná na leden 2025, zveřejněna (k 20. 10. 2026 ji studie nedohledala). Střet zájmů v komisích: podnět ministerstvu 2027; po nástupu vlády 2030 příkazem ministra; v zákoně 2033 a později.

Náklad. Nevyčísleno; transparentnost nesmí přidat poskytovatelům papírování.

Vazba na jádro. Čekací doby a lidé bez praktika měří J5 ; ukazatele reformy jsou 20 ukazatelů v Části IX.

Otevřené otázky pro RT

- Střet zájmů: autor je autorem HSPA Monitoru; oficiální rámec patří ÚZIS a Radě HSPA a studie jej nesmí zaměňovat s Monitorem.
- Kdo financuje 30 ukazatelů, kterým dnes chybí metodika nebo data?

5. Dostupné léky

Cíl. Pacient zná doplatek předem, lék je dostupný i při výpadcích a drahá léčba vzácných nemocí neohrozí malou pojišťovnu ani péči o ostatní.

Opatření

- Dostupnost: seznam základních léků se zajištěnou dostupností a mechanismus pro výpadky (podle Manifestu kolem 2 200 aktivních výpadků proti 580 v roce 2019).
- Doplatky: online srovnávač doplatků; lidé zaplatili v roce 2025 na doplatcích 19,7 mld. Kč (1 803 Kč na obyvatele) a tržby z doplatků vzrostly meziročně o 51,3 % (ÚZIS, Lékárenská péče 2025).
- Lékárník: kurýrní rozvoz s lékárnickou kontrolou a širší pravomoci v prevenci a očkování. Revize léků u lidí nad 65 let s pěti a více léčivými látkami je v Části III a zde se neopakuje.
- Léky na vzácná onemocnění: společný rizikový fond všech pojišťoven (dále FRP), metodika hodnocení technologií pro malé populace, podmíněná úhrada podle výsledku léčby, tvrdé vyjednávání ceny i společně s dalšími státy EU a individuální rozhodování s pevnou lhůtou a odůvodněním.

Pět a více léků denně užívá 46,6 % lidí nad 65 let (průměr SHARE 36,2 %). Vzory: britské lékárny v NHS očkují, Belgie hradí revizi léků, Nizozemsko má kurýrní výdej, Skotsko a Belgie mají oddělené mechanismy pro orphan léky.

Nástroj. Novely zákonů o léčivech a o veřejném zdravotním pojištění, FRP zákonem, smlouvy pojišťoven. Ověřit: konkrétní ustanovení a zařazení do vln, v seznamu vln posudku brief chybí.

Ověřujeme

Termín. Návrh: předložit po roce 2031, účinnost 2032–2033 (vlna 4); srovnávač doplatků a seznam základních léků lze zavést i bez zákona. Příčinu skoku tržeb z doplatků o 51,3 % ověřit u ÚZIS nebo SÚKL.

Náklad. Nevyčísleno. Centrová léčiva (6,8 % úhrad, dvouciferný růst) reforma neřeší; hodnocení účelnosti (oblast 1) a FRP jsou jediné nástroje, které na ně míří.

Vazba na jádro. Revize léků lékárníkem je součástí týmové péče v Části III; tento brief ji nemění.

Odchylka od programu 2021. Program navrhoval fond pro léky na vzácná onemocnění s limitem na pacienta a rozdílem hrazeným ze sbírek. V3 navrhuje FRP všech pojišťoven a zakazuje závislost léčby na sbírce, pokud léčba splní podmínky veřejné úhrady; limit na pacienta nezavádíme.

Otevřené otázky pro RT

- Kdo FRP financuje (příspěvky pojišťoven podle rizika, nebo platba státu)? Posudek vytýká, že zdroj chybí.
- Jaká je lhůta rozhodnutí o individuální úhradě a kdo je odvolacím orgánem?

6. Světový klinický výzkum

Cíl. Počet akademických klinických studií se zdvojnásobí z 64 na 128, aby se výsledky reformy a nových modelů péče daly hodnotit na českých datech.

Opatření

- Program Agentury pro zdravotnický výzkum pro akademické studie: audit, monitoring, statistická podpora a mikrogranty, napojený na evropskou síť ECRIN (členem je Česko přes infrastrukturu CZECRIN od roku 2018).
- Samostatná linka pro výzkum zdravotních služeb a primární péče.
- Roční zveřejnění počtu studií po krajích a vyhodnocování praktických dopadů; transparentní rozdělování prostředků.
- Pilotní týmy reformy vyhodnotit jako studii s kontrolní skupinou (D18).

V Česku je registrováno 932 klinických studií, z toho 64 akademických (7 %). Nově zapojených účastníků bylo v roce 2023 4 620, o 32 % méně než v roce 2015; Národní strategie klinických hodnocení 2035 (MZ, 15. 7. 2026) číselné cíle nemá.

Nástroj. Akční plán Národní strategie klinických hodnocení 2035 a dotační program Agentury; zákon není potřeba.

Termín. Podnět k akčnímu plánu v F0. První výzva samostatné linky 2028 jen tehdy, pokud ji vypíše dnešní vláda; v základním scénáři 2031. Zdvojnásobení počtu studií ve v2 platilo do roku 2030; v3 je posouvá na rok 2033.

Náklad. Nevyčísleno.

Vazba na jádro. Pilot týmů (`J1`) se vyhodnocuje jako studie; nezávislé hodnocení `B4` (2033) z něj čerpá.

Otevřené otázky pro RT

- Rozpočet Agentury pro zdravotnický výzkum byl v letech 2024 a 2025 asi 1,2 mld. Kč ročně (AZV; MZ ČR 2025, s. 154). Ověřit: podíl, který jde dnes na akademické studie.

Ověřujeme

- Kdo bude kontrolní skupinou pilotu a kdo studii zaregistruje před startem v roce 2028?

7. Stomatologie

Cíl. Zastavit pokles preventivních prohlídek u zubaře (52,1 % pojištěnců v roce 2023 proti 55,1 % v roce 2019) a snížit platby u zubaře, které spolu s doplatky na léky patří k hlavním příčinám katastrofických výdajů nejchudších domácností (WHO 2025).

Opatření

- Navazující úhrada: po základní fotokompozitní výplni hrazené dospělým od ledna 2026 (zákon 289/2025 Sb.) prověřit úhradu ošetření kořenových kanálků i u stoliček; náklad vyčíslit před návrhem.
- Sazby, které udrží smluvní zubaře mimo velká města, plně hrazené základní výkony (extrakce, prevence, dětská stomatologie), pružnější regulace a revize úhrad výrobků.
- Hrazená dentální prevence do 18 let (fluoridový lak, pečetění fisur, instruktáž) je popsána v Části III, Pilíř 4, a zde se neopakuje.
- Samostatnější dentální hygienistky a ordinace dentální hygieny ve středních a velkých centrech pro děti a seniory; jako pilot, ne jako hotové řešení.
- Celostátní šetření orálního zdraví dětí ve věku 5, 12 a 15 let podle metodiky WHO v roce 2028 a pak každých pět let. Poslední šetření je z roku 2003, takže podíl dětí bez kazu dnes nejde změřit.

Zubních lékařů je 76,0 na 100 tisíc obyvatel (Eurostat 2024). Absolventů ubývá: 296 v roce 2022 a 268 v roce 2024 (2,5 na 100 tisíc proti 3,7 v EU). Na stomatologii šlo 19,3 mld. Kč, tedy 3,8 % úhrad. Vzory: Švédsko (bezplatná péče pro děti a mladé, od roku 2025 do 19 let), Dánsko, Norsko, německý Bonusheft.

Nástroj. Úhradová vyhláška (ročně), vyhláška 134/1998 Sb. (seznam výkonů) a novela zákona 48/1997 Sb., příloha 1 (prevence do 18 let, vlna 2). Šetření orálního zdraví vyžaduje zadání ministerstva a financování.

Termín. Podněty do dohodovacího řízení (do 30. 6. 2027) a do seznamu výkonů s cílem 1. 1. 2028; šetření 2028 jen pokud je zadá dnešní ministerstvo, jinak 2031. Zákonná úprava prevence do 18 let spolu se zákonem o primární péči: předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032.

Náklad. Dentální prevence 0,3 až 0,5 mld. Kč ročně při plném pokrytí, kryto z Fondu prevence (je součástí prevence 1,3 mld. Kč v modelu, viz Část V). Úhrada kořenových kanálků a sazby mimo velká města: nevyčísleno.

Vazba na jádro. Prevence navazuje na `P4` a Pilíř 4; katastrofické výdaje domácností jsou jedním z ukazatelů v Části IX (D14).

Otevřené otázky pro RT

- Ověřit: kolik by stála úhrada ošetření kořenových kanálků stoliček u dospělých a kdo ji ponese.

Ověřujeme

- Ověřit: zda šetření orálního zdraví dětí zadá Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, nebo bude součástí pilotu.

Ověřujeme

8. Vzdělání a podmínky personálu

Cíl. Lidé pro týmy: rezidenční místa navázaná na skutečnou potřebu a pracovní podmínky, které z primární péče nedělají jen přesun nedostatku z nemocnic.

Opatření

- Rezidenční místa (`P2`): počet míst ve všeobecném praktickém lékařství a v pediatrii navázat na cíl ministerstva o 1 000 úvazků praktiků více do roku 2035, s ročním výpočtem potřebných míst z registru ÚZIS.
- Lékaři: přehledné akreditace na webu ministerstva, jasná délka specializační přípravy a odpovědnost pracovišť, placené stáže, započítání přesčasů a centra primární péče jako místa výcviku rezidentů.
- Sestry: rozšířené kompetence formou akreditovaných kurzů (`J2` , viz Část III) a administrativa přesunutá na recepci a zapisovatele; nutriční terapeuti, fyzioterapeuti a hygienistky jako plnohodnotní členové týmu.
- Pracovní podmínky sester: práce bez nočních služeb, předvídatelný rozpis (večerní a sobotní ordinace s příplatky), plat na úrovni nemocniční sestry stejné kvalifikace, návratové programy, zkrácené úvazky a péče o děti zdravotníků. Přechod nemocničních sester do primární péče se podporuje jen tam, kde se práce v nemocnici prokazatelně změnila.
- Nábor ze zahraničí a zrychlení aprobací jako součást personální bilance po krajích (`P1`).

Východisko: 41 % lékařů je starších 55 let (EU 35 %; OECD/EK Health at a Glance: Europe 2024, data 2022). Ze všeobecného praktického lékařství atestuje 160 až 200 lékařů ročně, zatímco počet praktiků klesá o 110 až 180 ročně. Ministerstvo podpořilo ve všeobecném praktickém lékařství 150, 140 a 140 rezidenčních míst v letech 2023 až 2025 a v pediatrii 80, 70 a 70 (dotační program MZ Rezidenční místa; MZ ČR 2025, s. 97). Vysoké školy dnes dávají asi 680 a vyšší odborné školy asi 570 absolventů ošetřovatelství ročně; jen nových všeobecných sester je za 10 až 12 let potřeba nejméně 24 000 úvazků (MZ ČR 2025, s. 112 a 114). Vládní program pro nelékařské profese (přes 12,8 mld. Kč, 2026 až 2037) má zvýšit kapacity prvních ročníků nejméně o 20 %, u všeobecného ošetřovatelství až o 40 %, a na vysokých školách vychovat 11 078 všeobecných sester, 2 539 porodních asistentek a 1 547 dětských sester (vládní program pro nelékařské profese 2026–2037; MZ ČR 2025, s. 113–114). Sesterská profese je z 95 % ženská, proto musí nabídka práce zohlednit péči o rodinu.

Nástroj. Dotační titul ministerstva na rezidenční místa, akreditace, úhradová vyhláška (příplatky za večerní a sobotní ordinaci) a personální bilance po krajích (`P1`). Zákon není nutný.

Termín. Podnět do rozpočtu 2028 (F0), o kterém rozhoduje dnešní vláda; v základním scénáři závazný roční výpočet míst od rozpočtu 2031. Kurzy sester náběhově s pilotem od 2028.

Náklad. Akreditované kurzy sester asi 50 mil. Kč ročně (v2). Odměna za kompetence (v2: asi 800 mil. Kč ročně) patří k opatření `J2` ; konečné číslo i počty sester viz Část V. Rezidenční místa a pracovní podmínky: nevyčísleno.

Vazba na jádro. `J2` (sesterská složka a kompetence), `P1` personální bilance, `P2` rezidenční místa a brána `B3` „Lidé a data“ (12/2031), kde se měří obsazení míst sester.

Odchylka od programu 2021. Program počítal s náborem zdravotníků a s aprobacemi ze zemí mimo EU; v2 je vynechala. V3 je vrací do personální bilance (`P1`), protože bez náboru ze zahraničí jsou cíle pro sestry ještě méně reálné.

Otevřené otázky pro RT

- Ověřit: kolik rezidenčních míst je podle registru ÚZIS potřeba ročně (kolik jich ministerstvo vypisuje, je pro roky 2023–2025 doplněno výše).

Ověřujeme

- Jaký plat sestry v primární péči vychází při srovnání s nemocniční sestrou stejné kvalifikace a kdo rozdíl uhradí?

9. Práva pacientů

Cíl. Pacient, jehož stížnost úřad nevyřídí v zákonné lhůtě, má bezplatnou cestu k ombudsmanovi s doporučením do 90 dní a povinnou odpovědí úřadu do 30 dní.

Opatření

- Zdravotnický ombudsman bez poplatků a bez právníka, navazující na nemocničního ombudsmana z novely 290/2025 Sb.; například jako nová působnost Veřejného ochránce práv.
- Vymahatelnost doporučení: úřad nebo poskytovatel musí do 30 dní sdělit, jak zjednal nápravu, nebo písemně zdůvodnit, proč ne; jinak ombudsman věc zveřejní, vyrozumí nadřízený orgán a může podat podnět k řízení o oprávnění poskytovatele.
- Roční zveřejňování počtů a délek šetření stížností, průzkumy zkušeností pacientů po poskytovatelích a reforma akreditací směrem k respektu a bezpečnosti.
- Porodnictví podle práva a WHO: přítomnost blízké osoby u porodu jako výchozí pravidlo, nepřerušený kontakt matky s novorozencem, oddělení jen ze závažného zdravotního důvodu, zapsaného v dokumentaci, na co nejkratší dobu; odebrání dítěte z péče rodičů může nařídit jen soud. Hrazenou péči porodních asistentek a pravidlo, že se žádná porodnice nezavře bez jejich sítě v území, řeší Část III (`Pil2.6`). Přítomnost blízkých jako výchozí pravidlo i v nemocnici a sociálním zařízení, zejména u dětí a umírajících; každé omezení musí mít konkrétní, přiměřený a přezkoumatelný důvod, být zapsané a pacient se proti němu může ohradit.
- Dříve vyslovené přání bez ověřeného podpisu a jeho registr (§ 36 zákona 372/2011 Sb.) jako poslanecký návrh.

Východisko: krajské úřady vyřídily v letech 2020 až 2025 2 290 stížností. Zákonné lhůty 30, 90 a 120 dní trvaly ve skutečnosti 38, 172 a 270 dní a ministerstvo samo píše, že jsou „fakticky neúčinné“ (MZ, Zpráva o fungování systému stížností 2026, příloha 9).

Nástroj. Novela části osmé zákona 372/2011 Sb. a zákona 349/1999 Sb. (střední předloha, vlna 2); Dříve vyslovené přání poslaneckým návrhem (malá novela).

Termín. Dříve vyslovené přání: poslanecký návrh 2028–2029 (vlna 0). Ombudsman: předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032; v2 uváděla účinnost od 2031, což scénář `D1` nedovoluje.

Náklad. Nevyčísleno.

Vazba na jádro. Ve variantě A má každé centrum jednoduchý postup pro stížnosti a plán péče s dříve vysloveným přáním je ochranou práv (`J1` , standard týmu).

Otevřené otázky pro RT

- Ověřit: zda má Veřejný ochránce práv kapacitu a zda přijme novou působnost, nebo je lepší samostatný ombudsman.

Ověřujeme

- Ověřit: znění úpravy dříve vyslovených přání v návrhu, který poslanecký klub připravuje.

Ověřujeme

10. Duševní zdraví

Cíl. Odstupňovaná péče, v níž první kontakt nezávisí na psychiatrovi a komunitní centra mají stabilní financování, místo sítě center jen na papíře.

Opatření

- První kontakt: psycholog v každém týmu primární péče (`J1` , viz Část III) s vazbou na nejbližší centrum, krízové linky a online první pomoc.
- Krátké hrazené intervence na několik sezení bez čekání na psychiatra a hrazená psychoterapie podle potřeby.
- Psychoterapie jako zdravotní služba: oddělit tři věci, které se dnes míchají, tedy kvalifikaci (navazuje na úpravu poradenské psychoterapie od 7. 2026), psychoterapii jako zdravotní službu a pravidla úhrady z veřejného pojištění.
- Stabilní financování sociální části center ze sítě sociálních služeb kraje (§ 36 zákona 108/2006 Sb.) místo ročních dotací; týmy center rozšířit o sociální pracovníky, peer konzultanty, psychoterapeuty a adiktology.
- Roční mapa center od roku 2027: podíl obyvatel s centrem do 30 minut, počet center s plným týmem a čekání na první kontakt; rezidenční místa v psychiatrii a dětské psychiatrii navázaná na cíl.

Východisko: strategie z roku 2013 počítala do roku 2023 se 100 centry, na konci roku 2023 jich fungovalo 31. NKÚ (kontrolní akce 23/22, 2024) doložil, že centrům chybí odborný personál a že financování jejich sociální části není upraveno, a síť 100 center do roku 2030 označil za nereálnou. Psychiatrů je 16,3 na 100 tisíc proti 19,5 v EU. Vláda uvolnila 207 mil. Kč na nejméně 15 nových center. Vzory: NHS Talking Therapies, Belgie 2010, Itálie 1978, nizozemský GZ-psycholog.

Nástroj. Smlouvy a úhradová vyhláška pro krátké intervence; novela zákonů 96/2004 a 48/1997 Sb. pro psychoterapii; novela zákona 108/2006 Sb. pro financování sociální části center (střední předlohy, vlna 4).

Termín. Mapa center a ukazatele od 2027 jako podnět ministerstvu (F0); psycholog v týmu v pilotu od 2028 a plošně se zákonem o primární péči od 1. 1. 2032; zákony o psychoterapii a financování center předložit po roce 2031, účinnost 2033 a později. V2 slibovala dokončení sítě 100 center do konce roku 2030; ve scénáři `D1` v3 datum pod vlastním jménem neslibuje. Signál: pokud v roce 2028 nebude aspoň 70 center s plným týmem, zveřejní se důvody a cíl se přepočítá.

Náklad. Nevyčísleno. Vládní 207 mil. Kč je výdaj státu, ne náklad této studie; psycholog v týmu je zahrnut v nákladech týmů (viz Část V).

Vazba na jádro. J1 (psycholog ve standardu týmu) a P3 (sdílené financování sociálně-zdravotní péče, na kterou se napojuje financování sociální části center).

Odchylka od programu 2021. Program navrhoval nové nelékařské povolání pro poradenství v duševním zdraví. V3 je nahrazuje psychologem v týmu a úpravou poradenské psychoterapie z roku 2026, která už platí.

Otevřené otázky pro RT

- Kdo hradí psychoterapii a v jakém rozsahu sezení? Ověřit: náklad hrazené psychoterapie před návrhem novely.

  🔍 **Ověřujeme**

- Ověřit: kolik center má dnes plný tým a zda kraje počítají s převzetím sociální části center do sítě sociálních služeb.

  🔍 **Ověřujeme**

Odchylky od programu 2021 shrnutě

Verze 3 se od Programu pro moderní zdravotnictví 2021–2024 odchyluje v osmi bodech, z nichž sedm leží v oblastech této Části. Každá odchylka je pojmenována, aby strana neměla dva různé programy.

Téma	Program 2021–2024	Verze 3	Důvod	Brief
Standard z hodnocení technologií	Převzato	Aktualizováno, navazuje na zákon 289/2025 Sb.	Evropské hodnocení technologií už je zavedené	1
Rozšířená péče	Pojišťovna není vázána hodnocením, doplatek přímo u poskytovatele	Hranici stanoví zákon, posoudí ji nezávislé hodnocení, kratší čekání se neprodává	Nález Pl. ÚS 36/11	2
Správa pojišťoven, tisk 479	Rada pojištěnců volená přímo u všech pojišťoven	Jeden návrh jako pozměňovací návrh k reformě MZ; mimo jádro reformy	Návrh MZ (správní rady o 9 členech), náklady voleb dosud nevyčísleny	3
Objemové limity	Nahradit indikačními omezeními a revizní činností	Vráceno do Pilíře 2 (Část III)	Propojuje DRG, hodnocení a dostupnost	3
Léky na vzácná onemocnění	Fond s limitem na pacienta, rozdíl ze sbírek	Společný rizikový fond (FRP) pojišťoven, nikdy ze sbírek, bez limitu na pacienta	Zdroj fondu zbývá určit	5
Nábor ze zahraničí a aprobace	Zahrnuto	Vráceno do personální bilance (P1)	Bez náboru jsou cíle pro sestry méně reálné	8
Poradce pro duševní zdraví	Nové nelékařské povolání	Psycholog v týmu a poradenská psychoterapie z roku 2026	Úprava z roku 2026 už platí	10
Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů za prevenci	Navrženo	Nepřebereme	Vysoké mrtvé náklady	—

Garant každého briefu doplní RT na schůzce 9. 11. 2026, kde se rozdělují věcné záměry mezi členy. Konzultace s příslušnými komorami, sdruženími a pojišťovnami proběhne v F0 u každého briefu zvlášť a výsledek se započítá do brány B1 jen tam, kde brief souvisí s jádrem.

Příloha A — Registr opatření

Verze 3 vede v registru 89 řádků, tedy 82 různých opatření a 7 odkazů, které v oblastech Manifestu jen ukazují na opatření vedená jinde.

Jádro tvoří 10 opatření (J1 – J10), podmínky 5 (P1 – P5), doplňková opatření pilířů 33 (Pil1 pět, Pil2 šest, Pil3 tři, Pil4 dvanáct, Pil5 sedm) a Doprovod 45 řádků ze 10 oblastí Manifestu, z toho 38 vlastních opatření.

Zákon potřebuje 36 opatření, vyhlášku 16 a smlouvu nebo úhradu pojišťovny 7. Zbylých 27 opatření nepotřebuje žádný předpis: jde o metodiku nebo Věstník (14), rozpočet (6) a jiný nástroj (7). Část VII sdružuje zákonná opatření do 20 předloh.

Počty podle vrstvy a nástroje

Vrstva	Zákon	Vyhláška	Smlouva / úhrada	Metodika / Věstník	Rozpočet	Jiné	Opatření celkem	Odkazy (započteny jinde)
Jádro J1 – J10	7	3	0	0	0	0	10	0
Podmínky P1 – P5	3	0	0	1	1	0	5	0
Pilíře, doplňková opatření	11	10	5	4	1	2	33	0
Doprovod, 10 oblastí Manifestu	15	3	2	9	4	5	38	7
Celkem	36	16	7	14	6	7	86	7

Každé opatření je zařazeno podle svého hlavního kroku; vedlejší nástroje, jako pilot smlouvou před pozdějším zákonem, stojí ve sloupci Nástroj. Vyhláška znamená úhradovou vyhlášku nebo vyhlášku o seznamu výkonů.

Jak číst registr

Vlna 0 jsou kroky z opozice 2027–2028 a z pilotu, vlny 1 až 4 jsou zákony s předložením 2030 až 2034 a účinností od 1. 1. 2031 výše. Náklad je roční náklad v roce 2038 podle čísel studie, výnos je označen jako výnos. Kód `Pil1.1` až `Pil5.7` označuje doplňkové opatření pilíře, protože kódy `P1` až `P5` patří podmínkám.

Evidence odpovídá záložce Evidence; znak † značí stupeň odvozený z textu studie, protože karta pro opatření chybí (ověřit). Hodnota „není“ znamená, že opatření je organizační nebo fiskální a vlastní důkaz nemá.

Jádro a podmínky (`J1` – `J10` , `P1` – `P5`)

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
J1	Standard týmu sdružené péče a pětiletá smlouva	Jádro	Pilíř 1	Zákon: Smlouva podle § 15 a § 17 zák. 48/1997 Sb. (pilot, náhradní cesta); standard ve Věstníku MZ; vlna 2: nová hlava zák. 372/2011 Sb. (L, 30–40 §§) a § 17, § 46 zák. 48/1997 Sb.	0 → 2	5,86 (lékařská složka 3,73 + odměna za výsledky 1,60 + provoz center 0,53)	MZ; VZP a další pojišťovny; SPL ČR, SPLDD ČR; kraj, který se k pilotu přihlásí	Pilot 2028–2029; zákon předložit 2. pol. 2030, účinnost 1. 1. 2032	Pilot stejně; standard ve Věstníku 2028; víceleté smlouvy přes PN, účinnost 2028	`H1` , `H2` , `H4` , `H5` , `D12`	střední (E1, E2, E4)
J2	Sesterská složka úhrady a rozšířené kompetence sester	Jádro	Pilíř 1	Vyhláška: Úhradová vyhláška (§ 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.); novela vyhl. 55/2011 Sb. (S); vlna 2: § 17, § 18 zák. 48/1997 Sb.; vlna 4: zák. 96/2004 Sb., § 80 zák. 378/2007 Sb.	0 → 2 → 4	5,70 (sestry navíc 3,97 + další profese 1,73)	MZ; ČAS; SPL ČR; pojišťovny; VŠ; odbory	Podnět do 30. 6. 2027; v pilotu 2028; vyhl. 55/2011 Sb. 2030–2031; úhr. vyhláška 2031; samostatná indikace sestry 1. 1. 2032; APN 1. 1. 2033	Úhr. vyhláška 2029–2030 (nejdříve 2028); vyhl. 55/2011 Sb. 2029	`H2` , `H4` , `H5` , `D6` , `D7` , `D12`	silná pro bezpečnost, slabá pro úspory (E5)
J3	Kompetence praktiků (preskripční omezení, nové výkony, USG)	Jádro	Pilíř 1	Vyhláška: Správní řízení SÚKL o podmínkách úhrady (část šestá zák. 48/1997 Sb.); novela vyhl. 134/1998 Sb. (S–M) a úhr. vyhláška; kurzy podle zák. 95/2004 Sb.	0	0,50	SVL ČLS JEP; SPL ČR; odborné společnosti; SÚKL; MZ	Podněty 2027–2028; nové výkony od 1. 1. 2031; revize preskripce po skupinách 2030–2032	První výkon nejdříve 1. 1. 2028	`H1` , `H3` , `H5`	není (organizační; doplní pilot)
J4	Návštěvní služba a doprava k lékaři (senior taxi)	Jádro	Pilíř 5	Vyhláška: Příplatek za návštěvu smluvně v pilotu, pak úhr. vyhláška; výkon návštěvy sestry (vyhl. 134/1998 Sb.); senior taxi: zák. 128/2000 Sb. nebo krajská dotace; vlna 2: NV 307/2012 Sb.	0 → 2	1,14 (příplatek za návštěvy 0,80 + senior taxi 0,34 z rozpočtů obcí a krajů)	Týmy a praktici; pojišťovny; obce a ORP; kraje; SMO ČR	Pilot 2028; příplatek v úhr. vyhlášce 2031; NV s účinností zákona o primární péči 1. 1. 2032; senior taxi kdykoli	Příplatek 2029–2030 (nejdříve 2028)	— (sleduje se v registru)	není†
J5	eŽádanka s triážním údajem, měření čekání a lidí bez praktika	Jádro	Pilíř 3	Zákon: PN k vládní novele zák. 325/2021 Sb.; bonus za dostupnost v úhr. vyhlášce; vlna 2: § 17, § 46 zák. 48/1997 Sb., NV 307/2012 Sb., záložně novela zák. 325/2021 Sb. (S)	0 → 2	nevyčísleno (infrastruktura MZ; výkony viz `Pil1.4`)	Poslanecký klub (PN); MZ; pojišťovny; SPL ČR, SAS ČR; ÚZIS; hodnotitel	PN 2027; data o lidech bez praktika od 2027 dobrovolně; bonus 2031; zákonná garance termínu 1. 1. 2032	PN přijat 2028	`H1` , `H3` , `D5`	není (nástroj měření)

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
J6	Krajský plán sítě lůžkové péče (10 let, čtyři skupiny lůžek, fond přeměny)	Jádro	Pilíř 2	Zákon: Nový zákon o síti lůžkové péče (L, 40–70 §§); novela § 46–52 zák. 48/1997 Sb.; zák. 374/2011, 129/2000, 372/2011 Sb.; pověřovací akt SGEI	3	1,31 garance příjmu v 2038 (průměr asi 1,0 ročně 2033–2040) + investice 5–10 jednorázově	MZ (tým pro síť); kraje; ÚZIS; pojišťovny	Věcný záměr do B2 ; předložit 2031, přijmout 2032, účinnost nejpozději 1. 1. 2033; první plány 2033	— (minimální objemy ve Věstníku viz Pil2.1)	H6 , D1 , D2 , D4	slabá (E11, E13, E14)
J7	Kapacita následné a dlouhodobé péče jako podmínka každé přeměny	Jádro	Pilíř 2	Zákon: Kontrolní bod v zákoně o síti; standard a vyšší sazba v úhr. vyhlášce; vlna 4: § 36 zák. 108/2006 Sb., § 22b zák. 48/1997 Sb.	3 (+ 4)	v rámci J6 ; kapacita dlouhodobé péče (39 000 lůžek, 21 000 pečovatelů do 2035) leží mimo čistý náklad	Kraje; MZ; MPSV; pojišťovny; SMO ČR	Měření čekání a návrh standardu F0; standard a sazba v úhr. vyhláškách 2031 a 2032; kontrolní bod od účinnosti zákona o síti, první posouzení 2033	—	H6 , D1 , D3	není (pojistka obložnosti 85 %: střední, E15)
J8	Daň z tichého vína (poloviční sazba pro malé vinaře) a valorizace daní z lihu a piva	Jádro	Pilíř 4	Zákon: Novela zák. 353/2003 Sb. (M): sazby, § 70, režim malých vinařů; unijní opora k ověření	1	výnos (ne náklad): víno 3,3–4,3 + valorizace 0–1, součást 5	MF; Celní správa; MZ	Předložit 2030, účinnost 1. 1. 2031; víno poloviční sazba 2031–2032, plná 1. 1. 2033	— (beze změny)	D8 , D10 (H7 , H8 sledují)	střední†
J9	Pásmová daň ze slazených nápojů	Jádro	Pilíř 4	Zákon: Nový zákon (M, 25–35 §§); TRIS a veřejná podpora k ověření	1	výnos (ne náklad): asi 1,5 (1,3–1,8), klesající	MF; Celní správa; MZ	Ohlášení v programu 2029; předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032	— (beze změny)	D9 (H7 , H8 sledují)	silná (E19)
J10	Nový vzorec platby státu za státní pojištěnce	Jádro	všechny pilíře	Zákon: Novela zák. 592/1992 Sb., § 3c a § 2 (S)	1	přesun ze státního rozpočtu: asi 13,0 z čistého nákladu 21,5 (asi 180 Kč měsíčně na státního pojištěnce)	MF s MZ	Předložit 1. pol. 2030, účinnost 1. 1. 2031	— (beze změny)	—	není (fiskální pravidlo)
P1	Personální bilance po krajích (nábor ze zahraničí, zrychlení aprobací)	Podmínka	Pilíře 1 a 5	Metodika/Věstník: Zveřejněná bilance (MZ, NRZP, ÚZIS); případně zák. 95/2004 Sb. (ověřit)	0 (zák. 95/2004 Sb. ověřit)	v rezervě 10 % (2,07 v 2038, společně s P2)	MZ; kraje; ÚZIS; VŠ; odbory	Zveřejnit do B2 (12/2029); měření v bráně B3 (12/2031)	—	H1 , H2	není
P2	Rezidenční místa (praktici, pediatři)	Podmínka	Pilíř 1	Rozpočet: Dotační titul MZ; financování z fondu obecně prospěšných činností (zák. 289/2025 Sb.); roční výpočet míst z registru ÚZIS	0	v rezervě 10 % (viz P1); model předpokládá +50 atestací ročně od 2033	MZ; odborné společnosti; ÚZIS	Podnět do dohodovacího řízení 2027 a do rozpočtu 2028; závazně od rozpočtu 2031	Podnět do rozpočtu 2028 (rozhoduje dnešní vláda)	H1	není (předpoklad modelu)

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
P3	Sociální účet a sdílené financování sociálně-zdravotní péče	Podmínka	Pilíř 5	Zákon: Novela § 36 zák. 108/2006 Sb., § 17a a § 22b zák. 48/1997 Sb. (M); zákon o pojištění dlouhodobé péče (L) jen při rozhodnutí	4	mimo čistý náklad reformy (sociální účet roste o asi 57 ročně do 2035)	MPSV; MZ; pojišťovny; kraje; obce	Věcný záměr do 12/2029; předložit 2033, účinnost 1. 1. 2034; rozhodnutí o pojištění dlouhodobé péče do konce 2031	—	D3	není (studie na zakázku APSS)
P4	Fond prevence zdravotních pojišťoven (nejméně 40 % výnosu daní za zdraví, nejméně 2 mld. Kč)	Podmínka	Pilíř 4	Zákon: Zákon o Fondu prevence (M–L, 15–25 §§) s novelou zák. 280/1992 a 551/1991 Sb.; soulad se zák. 218/2000 a 23/2017 Sb.	1	2,0 při plánovací hodnotě (prevence 1,3 + komunitní programy 0,7); 40 % výnosu nad ni	MZ; MF; pojišťovny; rada fondu; ÚZIS (hodnocení)	Teze do B1 (6/2028); předložit 2030, účinnost 1. 1. 2031	— (beze změny)	D5 , D6 , D7 , D11	není
P5	HSPA jako oficiální rámec hodnocení v zákoně	Podmínka	všechny pilíře	Zákon: Malá novela zák. 372/2011 Sb. (NZIS, S)	4	nevyčísleno	MZ; ÚZIS; Rada HSPA	Předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033; PN k hygienické službě 2027–2028	—	— (rámec všech 20 ukazatelů)	není

Pilíře: doplňková opatření (Pil1.1 – Pil5.7)

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
Pil1.1	Dětské týmy a PLDD (dětská sestra v týmu, děti na venkově u praktika pro dospělé v týmu, přednost pediatrie v pilotu)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 1	Smlouva/úhrada: Smlouva s pojišťovnou a úhr. složky podle J1 – J3 ; plošně zákon o primární péči	0 → 2	v rámci J1 – J3	MZ; SPLDD ČR; Česká pediatrická společnost; pojišťovny	Pilot 2028; plošně 1. 1. 2032	Pilot stejně	H1	není
Pil1.2	Večery, víkendy a pohotovost (ordinace do 19 h a v sobotu dopoledne, krajská telefonická triáž, pohotovost v centrech nad 10 lékařů)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 1	Smlouva/úhrada: Prodloužená doba jako funkce týmu (J1); pohotovost v zákoně o primární péči; navazuje na zák. 290/2025 Sb., vyhl. 380/2025 Sb.	2	0,75	Týmy; kraje; pojišťovny; ZZS	Prodloužená doba s týmy od 2031–2032; triáž dohodnout s kraji; pohotovost v centru nejdříve 1. 1. 2032	—	—	není
Pil1.3	Výkup praxí odcházejících lékařů (vzorová smlouva, nezávislé ocenění, splátky, příspěvek 250–500 tis. Kč na převzetí praxe, státní záruka)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 1	Smlouva/úhrada: Zák. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a vzorová společenská smlouva; státní záruka: rozpočtové rozhodnutí vlády	0	transfer mezi lékaři 0,3–0,6 (ne náklad systému); příspěvek nevyčíslen	RT se SPL ČR; vláda (záruka)	Vzorová smlouva 2027; záruka rozhodnutím vlády 2030	Vzorová smlouva 2027 (stejně)	H1	není

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
Pil1.4	Konzultace lékař–lékař, zpětná zpráva, přímé objednání	Pilíř (dopl.)	Pilíř 1	Vyhláška: Novela vyhl. 134/1998 Sb. (S–M) a cena v úhr. vyhlášce	0	1,50	MZ; Pracovní skupina k SZV; pojišťovny; SAS ČR	Podnět 2027; platí od 1. 1. 2031	Nejdříve 1. 1. 2028	H3	není
Pil1.5	Centra primární péče: dotace na budovy (150 nových, 150 rekonstrukcí, 220 úprav praxí)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 1	Rozpočet: Národní dotační program; podíl obcí a krajů; EU fondy po 2027; smlouva o budoucím nájmu s týmem na 10 let; § 39 zák. 128/2000 Sb.	0 → 2	investice 17–23 jednorázově (provoz center 0,53 viz J1); jen varianta A	Obce; kraje; MZ; MMR	Stavba podmíněna branou B3 (12/2031); investice 2030–2038	—	H2	slabá (E8)
Pil2.1	Minimální objemy a personální standard (porodnictví, kardiologie, traumatologie, dětská lůžka) a platba za připravenost	Pilíř (dopl.)	Pilíř 2	Metodika/Věstník: Věstník MZ (precedent 6/2026, 10/2026); úhr. vyhláška a smlouvy podle § 17 zák. 48/1997 Sb.	0	nevyčísleno (platba za připravenost v rámci J6)	MZ; odborné společnosti; ÚZIS; pojišťovny	Podnět F0; Věstníky 2030–2031; prahy s úhr. vyhláškami 2031 a 2032	Od 2028 (dnešní ministerstvo)	H6	slabá (E11)
Pil2.2	Indikační omezení místo objemových limitů	Pilíř (dopl.)	Pilíř 2	Vyhláška: Úhr. vyhláška (§ 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb.); indikační omezení v SZV (vyhl. 134/1998 Sb.); DRG zákonem viz M3.3	0	nevyčísleno	MZ; odborné společnosti; SÚKL a ÚZIS; pojišťovny	Podněty do dohodovacího řízení; první skupiny výkonů v úhr. vyhlášce 2031	2029–2030	H6	není
Pil2.3	Pediatrická lůžka: minimální standard dětských lůžkových oddělení	Pilíř (dopl.)	Pilíř 2	Metodika/Věstník: Standard (Česká pediatrická společnost, ÚZIS) vydaný Věstníkem MZ; uplatní krajské plány	0 → 3	nevyčísleno	Česká pediatrická společnost; ÚZIS; MZ; kraje	Návrh F0–F1; Věstník F2 (2030–2031); krajské plány od 2033	—	D1	není
Pil2.4	Dojezd záchranné služby a garance dostupnosti (95 % obyvatel kraje do 30 minut k urgentnímu příjmu)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 2	Zákon: Kontrolní bod v zákoně o síti; NV 307/2012 Sb. (vlna 2); novela zák. 374/2011 Sb. (vlna 3)	2 → 3	nevyčísleno (posílení základen ZZS)	MZ; kraje; ZZS; ÚZIS	Výchozí dojezdy F0; NV od 1. 1. 2032; novela zák. 374/2011 Sb. předložit 2031, účinnost 1. 1. 2033	—	D4	střední (E12)
Pil2.5	Pandemická rezerva (15 % lůžek intenzivní péče, asi 860 z 5 727)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 2	Zákon: Součást krajského plánu v zákoně o síti; koncepce intenzivní péče MZ (Věstník 4/2026)	3	nevyčísleno	Kraje; MZ	S krajskými plány 2033	—	—	není
Pil2.6	Komunitní porodní asistence: hrazená péče porodní asistentky v těhotenství, u fyziologického porodu a v šestinedělí; podmínka každé změny v síti porodnic	Pilíř (dopl.)	Pilíř 2	Vyhláška: Seznam výkonů (vyhl. 134/1998 Sb.) a úhr. vyhláška; smlouvy podle § 17 zák. 48/1997 Sb.; metodika centra porodní asistence ve Věstníku MZ; podmínka v zákoně o síti (J6)	0 → 2	nevyčísleno (propočet pro v4)	MZ; pojišťovny; odborné společnosti porodníků a porodních asistentek; kraje	Podnět do 30. 6. 2027; smlouvy od úhr. vyhlášky 2031; podmínka v zákoně o síti od 2033	Výkony od 1. 1. 2028	—	silná až střední (E21, E22)

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
Pil3.1	Dálkové sledování (srdeční selhání první, hypertenze s měřením doma, CHOPN a diabetes jen v pilotu)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 3	Vyhláška: § 11c zák. 372/2011 Sb. a vyhl. 30/2025 Sb. (platí); výkony v SZV (vyhl. 134/1998 Sb.); kompetence sestry vyhl. 55/2011 Sb.	0	0,66 společně s Pil3.2; úspory u srdečního selhání 0,24	MZ; pojišťovny; týmy	Pilot 2028; hrazený výkon od 1. 1. 2031	Hrazený výkon 1. 1. 2028	H5	silná pro srdeční selhání (E17)
Pil3.2	AI zapisovatel (jen pilot)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 3	Metodika/Věstník: Zakázky s požadavky MDR, EHDS, NIS2 a AI Act; stanovisko SÚKL a metodika MZ ke klasifikaci; změna zákona se nepředpokládá	0	v 0,66 (2 300 Kč na lékaře a měsíc, americká cena)	MZ; SÚKL; týmy v pilotu	Pilot 2028; plošně až po vyhodnocení	—	—	střední (E16)
Pil3.3	Portál pacienta a pravidla pro digitální nástroje	Pilíř (dopl.)	Pilíř 3	Metodika/Věstník: Navazuje na Portál lékaře a pacienta (MZ, od 1/2026); pravidla: data v EU, zdravotnický prostředek IIa, AI Act, NIS2	0	nevyčísleno	MZ; ÚZIS	Do dvou let od nástupu vlády; EHDS 2029 a 2031	—	—	není
Pil4.1	Minimální cena alkoholu	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Zákon: Nový zákon o minimální ceně alkoholu (M); test přiměřenosti C-333/14; TRIS k ověření	4	stát nevybere; vyšší DPH 0,2–0,5	MZ; MF	Notifikace 2031–2032; předložit 2032, účinnost 1. 1. 2034	—	D8, D10	silná, přenos na ČR neslibujeme (E18)
Pil4.2	Zmocnění obcí omezit noční prodej alkoholu (22–6 h)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Zákon: Zák. 65/2017 Sb., 128/2000 Sb. (S–M)	4	bez výnosu	MZ; obce	Ověřit: dřívější poslanecký návrh; předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	—	D8	slabá†
Pil4.3	Zpřísnění reklamy na alkohol tam, kde ji sledují děti	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Zákon: Zák. 40/1995 Sb.	4	bez výnosu	MZ	Předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	—	D8	není
Pil4.4	Zdravotní varování na obalech alkoholu	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Zákon: Nový zákon; notifikace TRIS (standstill tři měsíce)	4	bez výnosu	MZ	Předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	—	D8	slabá†
Pil4.5	Daň podle gramu alkoholu ve všech nápojích (volba pro program 2029)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Zákon: Sjednocení sazeb v zák. 353/2003 Sb.	4	+2 až +3 nad víno; do plánu se nepočítá	MF	Debata do voleb 2029; účinnost nejdříve 2033	—	D8	není
Pil4.6	Zubní prevence do 18 let (fluoridový lak, pečetění fisur, instruktáž)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Vyhláška: Podnět do SZV (vyhl. 134/1998 Sb.); zákon (zák. 48/1997 Sb., příloha 1) ve vlně 2	0 → 2	0,3–0,5 (součást prevence 1,3; ověřit)	MZ; Pracovní skupina k SZV; pojišťovny	Zákon předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032	SZV nejdříve 1. 1. 2028 (cíl podnětu)	D11	silná† (Marinho 2013, Ahovuo-Saloranta 2017)
Pil4.7	Očkování seniorů proti chřipce (pozvání sestrou, očkování v lékárnách)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Vyhláška: Hrazený výkon v SZV a úhr. vyhlášce	0	v rámci prevence 1,3	MZ; pojišťovny; lékárny	Úhr. vyhláška nové vlády (2031)	2029–2030	D7	slabá† (Spinks 2020)
Pil4.8	Navigace po pozitivním screeningu (sestra týmu; pilot ve dvou krajích)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Vyhláška: Hrazený výkon po pilotu; plátce (pojišťovna, nebo NFP) ověřit	0	v rámci prevence 1,3	MZ; pojišťovny; NFP	Pilot s evaluací (start ověřit); výkon po pilotu	—	D5, D6	střední†

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
Pil4.9	Krátká intervence u praktika	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Vyhláška: SZV; vyhl. 70/2012 Sb. ve znění 403/2025 Sb.	0	v rámci prevence 1,3 (ověřit)	MZ; pojišťovny; praktici	Úhr. vyhláška nové vlády (2031)	Nejdříve 1. 1. 2028 (cíl podnětu)	D8	střední†
Pil4.10	Strava a pohyb (školní stravování, reklama dětem, nutriční terapeut s programem pro prediabetes, Škola podporující zdraví po pilotu)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Vyhláška: Aktualizace vyhl. 107/2005 Sb.; omezení reklamy podle nutričního profilu WHO; pilot v jednom kraji	0	nevyčísleno	MZ; SZÚ; školy	Termín v textu neuveden (ověřit); vyhodnocení po třech letech	—	—	střední†
Pil4.11	Daň z tabáku a nikotinu: valorizace a růst 5 % ročně nad inflaci od 2028 do podílu 75 % na ceně; nikotinové výrobky zdaněné podle obsahu nikotinu	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Zákon: Novela zák. 353/2003 Sb. spolu s J8 (vlna 1)	1	výnos mimo plánovací hodnotu: odhadem +1,5–2 za každý rok růstu (ověřit)	MF; Celní správa; MZ	Podnět současné vládě 2027; předložení 2030, účinnost 1. 1. 2031	Prodloužení dnešního plánu od 2028	—	střední (WHO best buy)
Pil4.12	Zvýhodnění těch, kdo aktivně pečují o své zdraví (Hospodářská strategie PEER): nižší pojistné za doložitelné zapojení a zlepšení v čase, ne za razítko z prohlídky; hrazené odvykání kouření; pilot povinně pro ročníky do 40 let s reformou DPFO	Pilíř (dopl.)	Pilíř 4	Zákon: Novela zák. 592/1992 Sb. (zvýhodnění na pojistném) spolu s reformou zák. 586/1992 Sb. (DPFO); vázání přírůstku daně z tabáku v zákoně o Fondu prevence (P4 , vlna 1)	1 → 2	odvykání asi 0,5 z přírůstku daně; zvýhodnění na pojistném nevyčísleno (ověřit)	MZ; MF; pojišťovny	Odvykání s P4 od 1. 1. 2031; pilot zvýhodnění do 40 let od 1. 1. 2032	—	—	střední
Pil5.1	Delší a samostatná indikace domácí péče (sestra se specializací)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 5	Zákon: Zák. 48/1997 Sb. (§ 18, § 22; vlna 2); vyhl. 55/2011 Sb. (vlna 0)	0 → 2	nevyčísleno (úhr. vyhláška 2027 přidává domácí péči 8,5 %)	MZ; ČAS; pojišťovny	Zákon předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032	Vyhláška 2028 (rozhodne dnešní MZ)	H5	silná pro bezpečnost, slabá pro úspory (E5)
Pil5.2	Mobilní paliativní tým v okrese (jeden na 70–150 tis. obyvatel)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 5	Smlouva/úhrada: Úhrada pojišťoven a smlouva; podnět do dohodovacího řízení 2028	0	0,90 (horní mez, 150 týmů)	Pojišťovny; kraje; MZ	Úhr. vyhláška 2031; náběh 2031–2034	Podnět do 30. 6. 2027, platí od 2028	H5	silná pro místo úmrtí (E20)
Pil5.3	Společný plán péče, koordinátor a hrazený výkon plánování péče	Pilíř (dopl.)	Pilíř 5	Vyhláška: Výkon „plánování péče“ (vyhl. 134/1998 Sb.)	0	nevyčísleno	MZ; pojišťovny	Úhr. vyhláška 2031	Podnět 1. 1. 2028	H5	není

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
Pil5.4	Podpora pečujících rodin (odlehčovací služby, edukace, kontakt na sestru, dlouhodobé ošetřovné)	Pilíř (dopl.)	Pilíř 5	Jiné: Nástroj neurčen (MPSV, kraje, pojišťovny); ověřit	—	nevyčísleno (ověřit)	MPSV; kraje; pojišťovny	Ověřit	—	—	není
Pil5.5	Konziliární paliativní tým v nemocnicích s 200 a více akutními lůžky	Pilíř (dopl.)	Pilíř 5	Smlouva/úhrada: Úhrada jako konzilium (úhr. vyhláška)	0	nevyčísleno	Nemocnice; pojišťovny	Start v největších nemocnicích; termín neuveden	—	—	není
Pil5.6	Nabídka plánu péče při hospitalizaci křehkého seniora a plán ve sdíleném záznamu	Pilíř (dopl.)	Pilíř 5	Jiné: Sdílený záznam; úhrada v pobytových službách navazuje na P3	—	nevyčísleno	MZ; poskytovatelé	Termín neuveden	—	—	není
Pil5.7	Dříve vyslovené přání: jednodušší ověření, centrální registr, povinnost respektovat	Pilíř (dopl.)	Pilíř 5	Zákon: Poslanecký návrh; § 36 zák. 372/2011 Sb. (S)	0	nevyčísleno (registr)	Poslanecký klub	Poslanecký návrh 2028–2029, závisí na většině	Stejně	—	není

Ověřujeme

Doprovod: 10 oblastí Manifestu (M1.1 – M10.5)

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
M1.1	Metodika hodnocení organizačních modelů pod ÚZIS, poprvé na pilotu	Doprovod	Oblast 1	Metodika/Věstník: Metodika ÚZIS bez zákona	0	nevyčísleno	ÚZIS	2027 (F0)	Stejně	—	není
M1.2	Nezávislá instituce pro hodnocení technologií (léky, výkony, digitální nástroje, organizační modely)	Doprovod	Oblast 1	Zákon: Rozšíření mandátu SÚKL a ÚZIS (M); nový zákon (L) jen při kapacitě; navazuje na zák. 289/2025 Sb.	4	nevyčísleno	MZ	Rozhodnutí o podobě F1 (2028–2029); předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033 (nový zákon 1. 1. 2034)	—	—	není
M1.3	Standard hrazené péče jako výstup hodnocení; soutěž pojišťoven nad standardem	Doprovod	Oblast 1	Zákon: Součást zákona nebo mandátu instituce (M1.2)	4	nevyčísleno	MZ; pojišťovny	2033 a později	—	—	není
M1.4	Napojení na evropské společné klinické hodnocení	Doprovod	Oblast 1	Jiné: Nařízení (EU) 2021/2282; zák. 289/2025 Sb.	—	nevyčísleno	MZ; SÚKL	Průběžně; datum neuvedeno	—	—	není
M2.1	Zákonné vymezení druhů rozšířené péče, doplatku a ochranného limitu	Doprovod	Oblast 2	Zákon: Novela zák. 48/1997, 551/1991, 280/1992 Sb. a vyhl. 418/2003 Sb. (M); nález Pl. ÚS 36/11	2	nevyčísleno	MZ	Předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032	—	—	není
M2.2	Plně hrazená základní varianta nabídnutá jako první, bez vlivu na termín	Doprovod	Oblast 2	Zákon: Součást M2.1	2	nevyčísleno	MZ	Jako M2.1	—	—	není

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
M2.3	Přeměna fondů prevence pojišťoven na fondy rozšířené péče	Doprovod	Oblast 2	Zákon: Součást M2.1 ; fondy upravil zák. 289/2025 Sb.	2	nevyčísleno	MZ; pojišťovny	Jako M2.1	—	—	není
M2.4	Transparentní ceník a nezávislé posouzení hranice nadstandardu	Doprovod	Oblast 2	Zákon: Součást M2.1 ; posouzení viz oblast 1	2	nevyčísleno	MZ	Jako M2.1	—	—	není
M3.1	Evidence plnění nároku včetně čekání (navazuje na J5)	Doprovod	Oblast 3	Smlouva/úhrada: Smlouva s VZP v pilotu; úhr. vyhláška; novela zák. 325/2021 Sb.	0	nevyčísleno	VZP; pojišťovny; MZ	Pilot 2028; plošně nejdříve s úhr. vyhláškou 2031	Pilot stejně	H3	není
M3.2	Jeden návrh správy pojišťoven (hlas pojištěnců, veřejná jednání, jmenovité hlasování, losovaný panel, přímá volba v zaměstnaneckých pojišťovnách)	Doprovod	Oblast 3	Zákon: PN k reformě v. z. p. 2030; zák. 551/1991 a 280/1992 Sb. (tisk 479 mimo jádro)	0 → 4	nevyčísleno (náklady voleb neznámé)	Poslanecký klub; RT	PN ve Sněmovně 2027; zastoupení pojištěnců zákonem: předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	PN stejně	—	není
M3.3	Pravidla DRG zákonem (základní sazba, valorizace, přechod, platba za připravenost)	Doprovod	Oblast 3	Zákon: § 41a zák. 48/1997 Sb. (M; číslo § ověřit)	4	nevyčísleno	MZ	Předložit 2032, účinnost 1. 1. 2033	—	—	není
M3.4	Pružnost v krizi: zmocnění vlády k odchylce a rizikový koridor ±5 %	Doprovod	Oblast 3	Zákon: Součást M3.3	4	nevyčísleno	MZ	Jako M3.3	—	—	není
M4.1	Otevřená anonymizovaná data na úrovni poskytovatele	Doprovod	Oblast 4	Metodika/Věstník: Metodika a zveřejňování ÚZIS bez zákona	0	nevyčísleno (bez nového papírování)	ÚZIS; MZ	Od 2027 (F0)	Stejně	—	není
M4.2	Informace pro pacienta před zákrokem a volné kapacity v reálném čase	Doprovod	Oblast 4	Metodika/Věstník: Metodika ÚZIS; navazuje na Pil3.3	0	nevyčísleno	ÚZIS; MZ	Od 2027 (F0)	Stejně	—	není
M4.3	HSPA jako oficiální rámec v zákoně (odkaz na P5)	Doprovod	Oblast 4	Odkaz: Viz P5	4	viz P5	viz P5	Viz P5	—	—	není
M4.4	Hodnocení reformy provádí ÚZIS s univerzitou, a ne nástroj autorů studie	Doprovod	Oblast 4	Jiné: Nezávislý hodnotitel (smlouva s MZ)	—	0,40 společně s koordinací reformy	ÚZIS; univerzita	Jmenován před startem pilotu (do konce 2027); zpráva pro B4 2033	—	—	není
M4.5	Střet zájmů v komisích a poradních orgánech ministerstva: veřejná prohlášení o zájmech, vyloučení z hlasování, jmenovitá hlasování a veřejné zápisy	Doprovod	Oblast 4	Jiné: Příkaz ministra a statuty komisí bez zákona (F0); zákon: nové ustanovení o poradních orgánech v zák. 372/2011 Sb. (vlna 4)	0 → 4	nevyčísleno (bez nového papírování pro poskytovatele)	MZ; SÚKL; ÚZIS	Podnět 2027; příkaz ministra po nástupu vlády 2030; zákon 2033 a později	Příkaz ministra kdykoli	—	není
M5.1	Seznam základních léků se zajištěnou dostupností a mechanismus pro výpadky	Doprovod	Oblast 5	Metodika/Věstník: Zavést lze bez zákona; další kroky novely zákonů o léčivech (ověřit)	4	nevyčísleno	MZ; SÚKL	Bez zákona kdykoli; zákon: předložit po 2031, účinnost 2032–2033	—	—	není
M5.2	Online srovnávač doplatků	Doprovod	Oblast 5	Metodika/Věstník: Bez zákona	0	nevyčísleno	MZ (ověřit)	Datum neuvedeno	—	H8	není

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
M5.3	Lékárník: kurýrní rozvoz s kontrolou a širší pravomoci v prevenci a očkování	Doprovod	Oblast 5	Zákon: Novely zákonů o léčivech a o v. z. p. (ověřit ustanovení)	4	nevyčísleno	MZ	Předložit po 2031, účinnost 2032–2033	—	—	není
M5.4	Léky na vzácná onemocnění: společný rizikový fond pojišťoven (FRP), podmíněná úhrada, individuální rozhodnutí s lhůtou	Doprovod	Oblast 5	Zákon: FRP zákonem; smlouvy pojišťoven	4	nevyčísleno (zdroj fondu neurčen)	MZ; pojišťovny	Předložit po 2031, účinnost 2032–2033	—	—	není
M6.1	Program AZV pro akademické klinické studie (audit, monitoring, mikrogranty; ECRIN)	Doprovod	Oblast 6	Rozpočet: Akční plán Národní strategie klinických hodnocení 2035; dotační program	0	nevyčísleno	MZ; AZV	Podnět F0; výzva 2031	Výzva 2028	—	není
M6.2	Samostatná linka pro výzkum zdravotních služeb a primární péče	Doprovod	Oblast 6	Rozpočet: Dotační program AZV	0	nevyčísleno	MZ; AZV	První výzva 2031	Výzva 2028	—	není
M6.3	Roční zveřejnění počtu studií po krajích a vyhodnocování dopadů	Doprovod	Oblast 6	Metodika/Věstník: Neuvedeno (ověřit)	0	nevyčísleno	MZ (ověřit)	Datum neuvedeno	—	—	není
M6.4	Pilotní týmy vyhodnotit jako studii s kontrolní skupinou	Doprovod	Oblast 6	Metodika/Věstník: Registrace studie před startem; protokol hodnotitele (J1)	0	nevyčísleno (pilot 30–50 mil. ročně, hodnocení asi 5 mil.)	Hodnotitel; RT	Registrace před startem 2028; běh 2028–2029	Stejně	—	není
M7.1	Úhrada ošetření kořenových kanálků i stoliček (náklad vyčíslit před návrhem)	Doprovod	Oblast 7	Vyhláška: Úhr. vyhláška; SZV	0	nevyčísleno	MZ; pojišťovny	Podnět do 30. 6. 2027; platnost podle úhr. vyhlášky nové vlády (2031)	Nejdříve 1. 1. 2028	H8	není
M7.2	Sazby udržující smluvní zubaře mimo velká města; plně hrazené základní výkony; pružnější regulace	Doprovod	Oblast 7	Vyhláška: Úhr. vyhláška; SZV	0	nevyčísleno	MZ; pojišťovny	Jako M7.1	Nejdříve 1. 1. 2028	H8	není
M7.3	Hrazená dentální prevence do 18 let (odkaz na Pil4.6)	Doprovod	Oblast 7	Odkaz: Viz Pil4.6	0 → 2	viz Pil4.6	viz Pil4.6	Viz Pil4.6	Viz Pil4.6	D11	není
M7.4	Samostatnější dentální hygienistky a ordinace dentální hygieny (pilot)	Doprovod	Oblast 7	Jiné: Pilot; nástroj neuveden (ověřit)	—	nevyčísleno	MZ (ověřit)	Datum neuvedeno	—	—	není
M7.5	Celostátní šetření orálního zdraví dětí v 5, 12 a 15 letech (WHO), poté po pěti letech	Doprovod	Oblast 7	Rozpočet: Zadání MZ a financování	0	nevyčísleno	MZ; SZÚ (ověřit)	2031 (2028 jen pokud zadá dnešní MZ)	2028	—	není
M8.1	Rezidenční místa (odkaz na P2)	Doprovod	Oblast 8	Odkaz: Viz P2	0	viz P2	viz P2	Viz P2	Viz P2	H1	není
M8.2	Lékaři: přehledné akreditace, délka přípravy, placené stáže, přesčasy, centra jako místa výcviku	Doprovod	Oblast 8	Rozpočet: Dotační titul MZ; akreditace	0	nevyčísleno	MZ	Podnět do rozpočtu 2028; závazně od 2031	Podnět 2028	—	není
M8.3	Sestry: akreditované kurzy kompetencí, administrativa na recepci a zapisovatele (odkaz na J2)	Doprovod	Oblast 8	Odkaz: Viz J2	0	viz J2	MZ	Kurzy s pilotem od 2028	Viz J2	H2	není

Kód	Opatření	Vrstva	Pilíř / oblast	Nástroj (předpis a ustanovení)	Vlna	Náklad (mld. Kč ročně)	Kdo	Termín: základní scénář Vláda 2030	Termín: doplňkový scénář	Ukazatel	Evidence
M8.4	Pracovní podmínky sester (bez nočních služeb, předvídatelný rozpis, plat na nemocniční úrovni, návratové programy)	Doprovod	Oblast 8	Vyhláška: Úhr. vyhláška (příplatky za večer a sobotu); plat v sesterské složce J2	0	v J2	MZ; pojišťovny; odbory	Od úhr. vyhlášky 2031	—	H2	není
M8.5	Nábor ze zahraničí a zrychlení aprobací (odkaz na P1)	Doprovod	Oblast 8	Odkaz: Viz P1	0	viz P1	viz P1	Viz P1	—	H1, H2	není
M9.1	Zdravotnický ombudsman bez poplatků (např. nová působnost veřejného ochránce práv)	Doprovod	Oblast 9	Zákon: Novela části osmé zák. 372/2011 Sb. a zák. 349/1999 Sb. (M)	2	nevyčísleno	MZ; Kancelář VOP	Předložit 2030, účinnost 1. 1. 2032	—	—	není
M9.2	Vymahatelnost doporučení ombudsmana (odpověď do 30 dnů, zveřejnění, podnět k řízení o oprávnění)	Doprovod	Oblast 9	Zákon: Součást M9.1	2	nevyčísleno	MZ	Jako M9.1	—	—	není
M9.3	Roční zveřejňování počtů a délek šetření stížností; průzkumy zkušeností pacientů; reforma akreditací	Doprovod	Oblast 9	Metodika/Věstník: Neuvedeno (ověřit)	0	nevyčísleno	MZ (ověřit)	Datum neuvedeno	—	—	není
M9.4	Porodnictví podle práva a WHO; přítomnost blízkých jako výchozí pravidlo	Doprovod	Oblast 9	Jiné: Nástroj neuveden (ověřit)	—	nevyčísleno	MZ (ověřit)	Datum neuvedeno	—	—	není
M9.5	Dříve vyslovené přání (odkaz na Pil5.7)	Doprovod	Oblast 9	Odkaz: Viz Pil5.7	0	viz Pil5.7	viz Pil5.7	Viz Pil5.7	Viz Pil5.7	—	není
M10.1	Psycholog v každém týmu primární péče (odkaz na J1)	Doprovod	Oblast 10	Odkaz: Viz J1	0 → 2	v J1	viz J1	Pilot 2028; plošně 1. 1. 2032	Viz J1	—	není
M10.2	Krátké hrazené intervence a hrazená psychoterapie podle potřeby	Doprovod	Oblast 10	Smlouva/úhrada: Smlouvy a úhr. vyhláška	0	nevyčísleno	Pojišťovny; MZ	Datum neuvedeno	—	—	není
M10.3	Psychoterapie jako zdravotní služba (kvalifikace, služba, úhrada)	Doprovod	Oblast 10	Zákon: Novela zák. 96/2004 a 48/1997 Sb. (M)	4	nevyčísleno	MZ	Předložit 2033, účinnost 1. 1. 2034	—	—	není
M10.4	Stabilní financování sociální části center duševního zdraví ze sítě sociálních služeb kraje	Doprovod	Oblast 10	Zákon: Novela § 36 zák. 108/2006 Sb. (M)	4	nevyčísleno	MPSV; kraje	Předložit po 2031, účinnost 2033 a později	—	—	není
M10.5	Roční mapa center duševního zdraví; rezidenční místa v psychiatrii	Doprovod	Oblast 10	Metodika/Věstník: Podnět ministerstvu	0	nevyčísleno	MZ; RT	Od 2027 (F0)	Stejně	—	není

Duplicity, které v3 sloučila

V3 sloučila 11 témat, která v2 vedla na více místech; v Doprovodu zůstalo sedm odkazů na šest z nich. Doprovod klesl z asi 55 opatření ve v2 na 44 řádků, z toho 37 vlastních; verze 3.1 přidala jeden řádek (M4.5).

Téma	Kde bylo ve v2	Kde je ve v3 jednou
Zubní prevence do 18 let	Pilíř 4, oblast 7 Manifestu, hrazené hygieny	Pil4.6 ; M7.3 je jen odkaz

Téma	Kde bylo ve v2	Kde je ve v3 jednou
Revize léků u lidí nad 65 let	Část III a oblast 5 Manifestu	Část III, v rámci týmové péče; M5.3 ji neopakuje
Kompetence sester	J2 , oblast 8 Manifestu, indikace v Pilíři 5	J2 ; M8.3 je jen odkaz; Pil5.1 nese pouze domácí péči
Rezidenční místa a nábor	P1 a P2 , oblast 8 Manifestu	P1 a P2 ; M8.1 a M8.5 jsou jen odkazy
Psycholog v týmu	J1 , oblast 10 Manifestu	J1 ; M10.1 je jen odkaz
HSPA jako rámec hodnocení	P5 , oblast 4 Manifestu	P5 ; M4.3 je jen odkaz
Dříve vyslovené přání	Pilíř 5, oblast 9 Manifestu	Pil5.7 ; M9.5 je jen odkaz
Přímá volba v pojišťovnách (tisk 479)	samostatně a v reformě správy	M3.2 , jeden návrh
Indikační omezení místo limitů	Pilíř 2 a oblast 3 Manifestu	Pil2.2 ; M3.3 řeší jen DRG zákonem
Instituce pro hodnocení technologií	Balíček 3 a oblast 1 Manifestu	M1.2
Plánování péče	domácí péče (krok 4) a závěr života (krok 1)	Pil5.3

Legislativní zátěž podle roku

Zátěž legislativního plánu po letech (20 předloh: 4 malé, 13 středních a 3 velké) ukazuje graf v Části VII; registr z něj přebírá vlnu a termín každého opatření.

Příloha B — Vypořádání oponentního posudku

Vypořádání posudku

Stav k 21. 10. 2026, po závěrečné redakci: plně vypořádáno je 8 z 10 výhrad a 16 z 20 oprav, částečně 2 výhrady a 3 opravy, otevřena zůstává 1 oprava (jména oponentů). Částečné body brzdí bilance sester po krajích, ověření paragrafů v legislativní mapě a nezveřejněný model; ve studii zůstává 80 otevřených ověření, jejichž seznam je na konci záložky.

Deset výhrad verdiktu

#	Výhrada (zkráceně)	Jak ji v3 řeší	Kde ve v3	Stav
1	Harmonogram bez scénářů	Dva scénáře: Vláda 2030 a doplňkový scénář převzetí části; pět fází a brány B1 – B4	Část VIII, harmonogram a dva scénáře	Vypořádáno; přesná data voleb 2028 a 2029 jsou v seznamu ověření
2	Běžící vládní reformy chybí	Tabulka vládních reforem, souběh s reformou a navazující pozměňovací návrhy	Část VI	Vypořádáno; termíny předloh (VeKLEP, PN k tisku 235) jsou v seznamu ověření
3	Personální předpoklady bez bilance	Bilance sester a praktiků po letech (440 sester ročně, PLD 2035 asi 3 900–4 500), podmínka brány B3	Část V, personální bilance; Část I	Částečně: chybí bilance po krajích (úkol P1 do brány B2); místo 30 000 úvazků bez zdroje uvádí v3.1 potřebu nejméně 24 000 úvazků všeobecných sester z vládního programu
4	Platby týmům a rozpětí	Platby 4,8–7,5 mld. Kč (střed 6,1); rozpětí 15–25 mld. Kč z Monte Carlo a tabulky scénářů	Část V, čistý náklad a citlivost	Vypořádáno
5	Srovnání variant	Varianty A, B, C se společným základem 7,6 mld. Kč; A 21,5, B 17,8, C 11,3 mld. Kč i v Části II	Část II, varianty; Část V	Vypořádáno
6	Daně za zdraví	Jedno číslo 5 mld. Kč (2 mld. NFP, 3 mld. platba státu); odvody z práce se nesnižují	Část V, odkud peníze; Část III, J8 a J9	Vypořádáno; právní forma NFP a daňové údaje J8 v seznamu ověření
7	Cíle ukazatelů	20 ukazatelů (H1 – H8 , D1 – D12); cíle odvozené z mechanismů, snížené, nebo vypuštěné; očkování sjednoceno na 40 % kolem 2038	Část IX	Vypořádáno; výchozí hodnoty a prahy B4 jsou návrh, ověření v seznamu
8	Lůžková část	Jeden základ 48 036 lůžek; přeměna 8 000 lůžek 2033–2038 na asi 40 000; fond přeměny 2033–2040 (průměr 1, vrchol 1,3 mld. Kč); pojistka obložnosti 85 %	Část III, pilíř 2; Část V	Vypořádáno
9	Legislativní mapa neúplná	Kapitola o zákonech a řízeních: vlny 0–4, 20 předloh, TRIS a tři řízení vůči Komisi	Část VII	Částečně: čísla paragrafů a zmocnění je třeba ověřit v konsolidovaném znění
10	Přes sto opatření, redakce, střet zájmů	44 řádků doprovodu v deseti briefech; autor se ve Správní radě VZP zdrží hlasování o pilotu a smlouvách k reformě (úvod, R19 , brief 3); překlepy opraveny	Část XI; Část X; Stav dokumentu	Vypořádáno

Dvacet oprav

#	Úkol z posudku	Co v3 udělala	Kde ve v3	Stav
1	Scénáře a harmonogram	Dva scénáře a přepracovaný harmonogram; zákon o síti přijat 2032, účinný nejpozději 1. 1. 2033	Část VIII	Vypořádáno
2	Vládní reformy v modelu	Tabulka reforem a souběh; onkochirurgie (1. vlna od 1. 9. 2026, Věstník MZ 10/2026) jako precedent	Část VI	Vypořádáno
3	Personál	Bilance po letech a podmínka brány `B3`	Část V; Část III	Částečně: chybí tabulka po krajích
4	Platby týmům	Platby 4,8–7,5 mld. Kč, střed 6,1	Část V	Vypořádáno
5	Rozpětí a graf citlivosti	Rozpětí 15–25 mld. Kč, Monte Carlo, tabulka scénářů a graf citlivosti (tornádo) jako widget v textu	Část V, čistý náklad a citlivost	Vypořádáno
6	Varianty B a C	Společný základ 7,6 mld. Kč; B 17,8 a C 11,3 mld. Kč	Část II; Část V	Vypořádáno
7	Daně	Jedno číslo 5 mld. Kč, pravidlo rozdělení; fond kryje jen prevenci; platba státu za reformu asi 13 mld. Kč, tedy asi 180 Kč měsíčně	Část V, odkud peníze	Vypořádáno
8	Model a NRR tab. D.1	Slib zveřejnit model; tabulka D.1 v textu	Část I; Část V	Částečně: model zatím nezveřejněn, hodnoty D.1 neověřeny v primárním zdroji
9	Lůžka: jeden základ, pojistka	Jeden základ 48 036 lůžek; pojistka obložnosti 85 %	Část III, pilíř 2; Část V	Vypořádáno
10	Překryvy úspor	Úspory vedeny hierarchicky, bez dvojího počítání	Část V, úspory	Vypořádáno
11	Ukazatele: alkohol, játra, kolonoskopie, očkování, katastrofické výdaje	Cíle odvozeny z mechanismu, sníženy, nebo vypuštěny; `H8` přidán	Část IX	Vypořádáno
12	Kompetence praktiků	Samostatné jádro `J3`	Část III, `J3`	Vypořádáno; údaje SÚKL a výkony odbornosti 001 v seznamu ověření
13	Gatekeeping	Triážní pole v eŽádance a telefonická triáž krajů jako vstup do rychlé cesty	Část II, cesta pacienta; Část III	Vypořádáno
14	Kapitoly o zákonech a procesu	Část VII (zákony a řízení) a Část VIII (proces)	Část VII; Část VIII	Částečně: čísla paragrafů k ověření
15	Registr opatření a Část IV v briefech	Registr: 89 řádků (82 opatření, 7 odkazů) s nástrojem, vlnou, termíny a ukazateli	Záložka Registr opatření	Vypořádáno
16	Střet zájmů	Zdržení se hlasování ve Správní radě VZP o pilotu a smlouvách k reformě	Stav dokumentu; Část X; Část XI	Vypořádáno
17	Oponenti	Jména nedoplněna	Stav dokumentu	Otevřeno: jména oponentů verzí 1 a 2 doplní RT
18	Evidence	Kringos s DOI, ESB vypuštěno; Bates, Kegreiss a Kovacevic s PMID nebo DOI; Chowdhury nalezen, ve v3 necitován; Kozhimannil jen u porodnic	Část II; Část III; záložka Evidence a zdroje	Vypořádáno
19	Redakce	Pracovní poznámky a číslování grafů odstraněny; překlepy opraveny	Celý text	Vypořádáno
20	Politická verze	Politická verze 3 hotová a sladěná s čísly v3 (odkaz)	Samostatný dokument	Vypořádáno

Otevřená ověření

Ve studii zůstává 97 otevřených ověření, stav 25. 10. 2026. Verze 3 jich měla 80 (asi 110 značek „Ověřit“ po sloučení duplicit, stav 21. 10. 2026); verze 3.1 uzavřela ověření zdroje potřeby sester a jejich věku, zúžila ověření k VOŠ, rezidenčním místům, rozpočtu AZV, potřebě lůžek dlouhodobé péče a eŽádance a přidala čtyři nová k číslům, čtyři k novým opatřením `Pil2.6` a `M4.5` a sedm k daním z tabáku a podpoře prevence (`Pil4.11` , `Pil4.12`); sladění se strategií PEER přidalo čtyři (rok dat a průběžný cíl délky života ve zdraví, propočet podílu nemocniční péče, právní forma zvýhodnění na pojistném) a jedno odpadlo s novou podobou `Pil4.12` (objem dnešních příspěvků z fondů pojišťoven). Je to pracovní seznam pro resortní tým; odpovědné osoby a termíny navrhujeme rozdělit na schůzi 9. 11. 2026.

Stav dokumentu

- E-mailová adresa resortního týmu pro připomínky.
- Jména oponentů verzí 1 a 2.

Část I a Část V: data a financování

- Počet dospělých bez registrujícího praktika podle registrů všech sedmi pojišťoven (výchozí hodnota ukazatele).
- Definice tří čísel rezerv pojišťoven (43,2, asi 32 a 45,7 mld. Kč) a vazba poklesu zůstatku na kumulované saldo.
- Hodnoty tab. D.1 NRR včetně příjmů v. z. p. po letech a zda projekce už zahrnuje navýšení platby státu pro rok 2027 (tisk 235).
- Kapacita endoskopických pracovišť po krajích a její rezerva.
- Rozložení 10 mld. Kč z implementačního plánu MZ 2.1 po letech.
- Roční počet absolventek oboru praktická sestra a kolik jich nastoupí do zdravotnictví (počet absolventek VOŠ doplněn ve v3.1).
- Veřejná adresa, kde bude zveřejněn model a tabulka vstupů.

Část III, pilíře 1 a 3

- Počet přípravků s preskripčním omezením na odbornost praktika a počet takových preskripcí ročně (SÚKL).
- Ultrazvukové výkony, které dnes smí vykazovat odbornost 001.
- Plné jméno autora a přesný název textu prof. Bronského.
- Zda a v jakém rozsahu kraje po účinnosti zák. 290/2025 Sb. provozují telefonickou triáž.
- Stav a harmonogram dnešní vládní novely zák. 325/2021 Sb. (č. j. 748/26) a termín povinné eŽádanky (návrh uvádí 1. 7. 2027); výchozí stav podle zák. 236/2025 Sb. doplněn ve v3.1.
- Zda SÚKL vydal stanovisko k AI zapisovatelům.
- Harmonogram přechodu Portálu lékaře a pacienta do ostrého provozu.
- Datum, od kdy platí povinnosti vysoce rizikové AI pro zdravotnické prostředky po změnách AI Actu.

Část III, pilíř 2

- Předběžný údaj 46 018 akutních lůžek za rok 2025: trvalé snížení, nebo změna ve vykazování.
- Nálezy Ústavního soudu k omezení krajské samosprávy zákonem ve veřejném zájmu.
- Pověřovací akt SGEI: kdo ho vydá, jak sladit patnáctiletý závazek s desetiletým limitem a čl. 2, 4 a 6 rozhodnutí 2012/21/EU.
- Skupiny výkonů s dostatečně přesnými daty o indikaci pro první vlnu indikačních omezení.
- Krajské rozložení potřeby lůžek dětské a dorostové psychiatrie.
- Data o skutečných dojezdových časech záchranné služby po krajích a výchozí hodnota ukazatele D4.
- Stav a obsah koncepce intenzivní péče MZ (Věstník 4/2026).
- Číslo výzvy IROP s podmínkou zrušit 20 akutních a zřídit 20 následných lůžek a počet takto přeměněných lůžek (nové ve v3.1).

Část III, pilíře 4 a 5

- Podíl objemu vína od producentů do 1 000 hl ročně a zda odhad 3,3–4,3 mld. Kč počítá malé vinaře jako osvobozené.
- Sazby tichého vína a daní ze slazených nápojů v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku.
- Právní opora snížené sazby pro malé vinaře (čl. 9a směrnice 92/83/EHS, oznámení Komisi, postup MF z roku 2023).
- Daň ze slazených nápojů: notifikace TRIS, hranice osvobození nejmenších výrobců a kvalifikace podle čl. 401 směrnice 2006/112/ES.
- Právní forma Fondu prevence a soulad s rozpočtovými pravidly.
- Zda lze zmocnění obcí omezit noční prodej alkoholu předložit dřív jako poslanecký návrh.
- Výchozí proočkovanost proti chřipce 65+ (sezóna, ÚZIS NR-28-02).
- Start a financování pilotu navigace po pozitivním screeningu.
- Plátce navigace, očkování a krátké intervence (pojišťovna, nebo NFP) a zda je zubní prevence 0,3–0,5 mld. Kč uvnitř prevence 1,3 mld. Kč.
- Potřeba lůžek dlouhodobé péče do 2035 (35, nebo 39 tisíc): jak se řady překrývají (zdravotní část oddělena ve v3.1 podle MZ ČR 2025, s. 65–66), a nezávislé ověření vstupů studie pro APSS ČR.
- Termín pilotu společného rozpočtu sociálně-zdravotní péče a zda jde smluvně bez novely.
- Náklad, nositel a termín podpory pečujících rodin.
- Přesné znění § 36 odst. 2 až 6 zák. 372/2011 Sb. a úprava dříve vyslovených přání v návrhu poslaneckého klubu.

Část VI

- Záznam reformy veřejného zdravotního pojištění 2030 ve VeKLEP.
- Která předloha ponese další kroky sociálně-zdravotního pomezí.
- Hlasování klubu o PN č. 1796 a 1813 k tisku 235.
- Účinnost reformy hygienické služby od 1. 1. 2028.
- Předloha a termín sesterské preskripce.
- Veřejný dokument MZ s trajektorií konvergence CZ-DRG (rozpětí krajských sazeb; podíl péče za jednotnou sazbou doplněn ve v3.1).
- Zda dnešní vedení MZ dál vychází z dokumentu MZ ČR, Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví 2025 (stav k 1. 8. 2025), který studie používá k ověření dat (nové ve v3.1).
- Přechodná ustanovení a čísla paragrafů po novele zák. 38/2025 Sb.

Část VII

- Spisová značka nálezu o přílepcích (Pl. ÚS 77/06).
- Vzor centra duševního zdraví (§ 44b až 44d) a soulad pravidel vlastnictví a koncentrace s čl. 49 SFEU (C-169/07 Hartlauer), včetně rozboru ÚOHS.
- Čísla § 18 a § 22 zák. 48/1997 Sb. v předloze o primární péči.
- Úprava stížností v zák. 372/2011 Sb. (část osmá) a v zák. 349/1999 Sb.
- Rozsah výroku Pl. ÚS 36/11, obsah vyhl. 418/2003 Sb. a zda smí seznam variant stát v prováděcím předpise.

- Číslo paragrafu pro pravidla DRG v zák. 48/1997 Sb. (§ 41a).
- Zda minimální cena alkoholu podléhá notifikaci a kontaktní místo TRIS (ÚNMZ).
- Lhůty řízení o veřejné podpoře a koordinace přes ÚOHS podle zák. 215/2004 Sb.
- Aktuální výklad poslední věty § 17 odst. 5 zák. 48/1997 Sb. a vztah smlouvy týmu k § 46 (výběrové řízení).
- Zákonná zmocnění pro seznam výkonů (vyhl. 134/1998 Sb.) a činnosti sester (vyhl. 55/2011 Sb.).
- Závaznost standardu ve Věstníku MZ přes smlouvy pojišťoven a právní základ státní záruky.
- § 11c zák. 372/2011 Sb. a vyhl. 30/2025 Sb. pro AI zapisovatele a telemonitoring.

Část VIII

- Přesná data krajských voleb 2028 a voleb do Sněmovny 2029.
- Kdo jmenuje a platí nezávislého hodnotitele pilotu (kraj, VZP, ministerstvo, grant).
- Zda řídicí výbor vznikne usnesením vlády, nebo až zákonem o primární péči.

Část IX

- Rok NRZP pro výchozí počet sester na praktika (`H2`).
- Přepočet výchozí hodnoty `D6` na cílovou skupinu 45–75 let a termín změny u NSC (nové ve v3.1).
- Spotřeba alkoholu za rok 2024 v OECD Health Statistics pro `D8` (nové ve v3.1).
- Rok a standardizace výchozí hodnoty ACSC 592 (`H5`).
- Frekvence výkazů obložnosti pro pojistku (`D2`).
- Zdroj dat o slazených nápojích z daňových přiznání (`D9`).
- Rok výchozího podílu výdajů na prevenci 2,7 % a přepočet +0,25 bodu (`D11`).
- Frekvence dat od VZP, ostatních pojišťoven a z NRZP pro hodnotitele.

Část X

- Číselné prahy přechodu z varianty B na C, které stanoví Řídicí výbor před bránou B1.

Část XI

- Volná kapacita SÚKL a ÚZIS pro hodnocení výkonů a organizačních modelů.
- Náklady voleb do správních rad, očekávaná účast a postup při účasti pod 5 %.
- Jak se devítičlenná správní rada podle reformy MZ promítne do VZP s dnešními 30 členy.
- Zda ÚZIS a MZ zveřejnily první úplnou zprávu o výkonnosti systému (HSPA) plánovanou na leden 2025.
- Konkrétní ustanovení a zařazení briefu o lécích do vln.
- Příčina skoku tržeb z doplatků o 51,3 %.
- Podíl akademických studií na rozpočtu Agentury pro zdravotnický výzkum (rozpočet asi 1,2 mld. Kč doplněn ve v3.1).
- Úhrada a náklad ošetření kořenových kanálků stoliček u dospělých.
- Kdo zadá šetření orálního zdraví dětí.
- Kolik rezidenčních míst je potřeba ročně (počty podpořených míst 2023–2025 doplněny ve v3.1).
- Kapacita Veřejného ochránce práv pro novou působnost, nebo samostatný ombudsman.
- Náklad hrazené psychoterapie.
- Kolik center duševního zdraví má plný tým a zda kraje převezmou sociální část center.

Příloha C — Evidence a zdroje

Tabulka důkazů

Tabulka hodnotí 22 tvrzení studie proti 32 ověřeným zdrojům: 5 tvrzení je doloženo silně, 8 středně a 7 slabě; u 5 se formulace zmírňuje a jedna citace (ESB 2026) se vypouští.

Síla důkazu: silná = systematický přehled nebo RCT přímo k tvrzení; střední = velká observační studie nebo nesourodý přehled; slabá = ekologická studie, popis politiky nebo přenos z jiné země. Zdroje jsou ověřeny v PubMed (30) nebo přes Consensus (2: Clemente 2024, Kegreiss 2026).

Pilíř 1: týmy, kontinuita, sestry

Č.	Tvrzení studie	Kde ve studii	Zdroj	Typ a síla důkazu	Ve v3
E1	Kontinuita s týmž lékařem souvisí s nižší úmrtností a méně akutními hospitalizacemi	Část II (teorie změny), Pilíř 1	Pereira Gray 2018 (PMID 29959146); Sandvik 2022 (PMID 34607797); Barker 2017 (PMID 28148478)	Systematický přehled bez metaanalýzy (22 studií, 18 s nižší úmrtností) a dvě observační studie; střední	Ponechat jako souvislost, ne jako slíbený účinek reformy. Sandvik: šance úmrtí 0,75 po více než 15 letech u téhož lékaře oproti prvnímu roku.
E2	Vícečlenné týmy mohou snižovat vztahovou kontinuitu	Pilíř 1, pojistka (jmenovitý lékař, UPC)	Bates 2025 (PMID 41181853); Kegreiss 2026 (DOI); Kovacevic 2023 (PMID 37976620)	Dva scoping reviews (39 a 21 studií) a systematický přehled (29 článků); výsledky nesourodé; střední	Ponechat jako pojistku: každý pacient má jmenovitého ošetřujícího lékaře a UPC je kontrolní bod pilotu, ne jen ukazatel odměny.
E3	Kontinuita s praxí zčásti nahrazuje kontinuitu s lékařem	Pilíř 1, zástup v týmu	McDonald 2024 (PMID 38806258)	Retrospektivní observační studie, Alberta; slabá	Zmírnit: nejlepší výsledky má pacient, který vidí vlastního lékaře nebo lékaře z téže praxe. Nepoužívat jako důvod vypustit jmenovitého lékaře.
E4	Velké praxe mívají nižší kontinuitu	Pilíř 1, velikost týmu	Barker 2017 (PMID 28148478)	Průřezová studie, 230 472 pacientů, 200 praxí v Anglii; střední	Ponechat. UPC 0,59 ve velkých praxích proti 0,70 v malých; podporuje malé týmy a dvojici lékař–sestra.
E5	Péče vedená sestrou je stejně bezpečná nebo bezpečnější než péče lékaře	Pilíř 1, `J2`	Paier-Abuzahra 2024 (PMID 39529012); Laurant 2018 (PMID 30011347)	Přehled šesti systematických přehledů; Cochrane přehled 18 RCT; silná pro bezpečnost, slabá pro úspory	Ponechat s upřesněním: efekt je největší u nejvýše kvalifikovaných sester a VŠ sestra v ambulanci není nurse practitioner. Úspory nejsou prokázány; Laurant vylučuje duševní zdraví.
E6	Balíčkové platby za chronické nemoci výdaje zvyšují	Pilíř 1, úhrada týmů, lekce ze zahraničí	Karimi 2021 (PMID 33947604)	Diference v diferencích s párováním, pojišťovací data Nizozemska 2008–2015; střední	Ponechat jako varování: platba týmům neslibuje úspory a úhradový model má zahrnout sledování výdajů na pacienta.
E7	Nové role v primární péči (ARRS, Anglie) zvyšují spokojenost, ne měřenou kvalitu	Pilíř 1, lekce ze zahraničí	Penfold 2025 (PMID 38936883)	Ekologická studie 2020–2023, 17 588 úvazků; slabá	Ponechat jako varování: +0,8 p. b. spokojenosti na úvazek, bez vlivu na QOF; role se najímaly tam, kde bylo víc lékařů, ne v nedostatkových oblastech.
E8	Multioborová střediska v Estonsku postupovala pomaleji, než se čekalo	Pilíř 1, lekce ze zahraničí	Habicht 2023 (PMID 36764032)	Popis politiky za 30 let reforem; slabá	Ponechat jako zkušenost, ne důkaz účinku. Ověřit: čísla o 60 střediscích a 56 % populace mimo rozšířené služby v plném textu, abstrakt je neuvádí.
E9	Silná primární péče souvisí s lepším zdravím a méně odvratitelnými hospitalizacemi, ale s vyššími výdaji	Část II, přehled úspor	Kringos 2013 (PMID 23569048)	Mezinárodní srovnání evropských zemí, průřezové; slabá	Ponechat. Zdroj je dohledán; v2 správně uvádí vyšší celkové výdaje a reforma nesmí slibovat úspory.
E10	Podpůrné sestry pro duševní zdraví práci praktika nenahradily, jen přidaly konzultace	Pilíř 1, lekce ze zahraničí	Magnée 2016 (PMID 27431902)	Observační studie, rutinní data 161–338 praxí, 2010–2014; střední	Zmírnit: ponechat jen „přidaly dlouhé konzultace, nenahradily praktika“. Dodatek „nezlepšily výsledky (ESB 2026)“ vypustit; Magnée výsledky pacientů nesledoval.

Ověřujeme

Pilíř 2: lůžka, centralizace, obložnost

Č.	Tvrzení studie	Kde ve studii	Zdroj	Typ a síla důkazu	Ve v3
E11	Centralizace onkochirurgie snižuje pooperační úmrtnost (politická verze: „o třetinu“)	Pilíř 2 (slučování oddělení), politická verze	Grilli 2021 (PMID 33944635)	Systematický přehled a metaanalýza 41 studií, OR 0,68 (0,54–0,85), I^2 80 %; slabá, autoři píší o nízké kvalitě a pravděpodobně nadsazeném odhadu	Zmírnit: „spojena s nižší úmrtností; důkazy jsou nízké kvality a účinek je pravděpodobně nadsazený“. Formulaci „o třetinu“ vypustit.
E12	Zánik porodnického oddělení na venkově zvyšuje podíl porodů mimo nemocnici a předčasných porodů	Pilíř 2, pojistka dojezdu (`J6`)	Kozhimannil 2018 (PMID 29522161)	Retrospektivní kohortní studie s přerušenými časovými řadami, 4,94 mil. porodů v USA; střední, přenos do ČR omezený	Ponechat. Mimo nemocnici +0,70 p. b., předčasné porody +0,67 p. b. v okresech nesousedících s městem. Prodloužení dojezdu je úvaha studie v2, ne výsledek Kozhimannil; k paliativě se zdroj nevztahuje.
E21	Kontinuální péče vedená porodní asistentkou má méně zásahů a méně předčasných porodů bez zhoršení výsledků	Pilíř 2 (`Pil2.6`)	Sandall 2016 (PMID 27121907)	Cochranův přehled 15 randomizovaných studií, 17 674 žen; silná	Ponechat. Platí pro ženy s nízkým a smíšeným rizikem, ne pro vysoce riziková těhotenství; proto `Pil2.6` vyžaduje dohodu o předání.
E22	Porody v jednotkách vedených porodními asistentkami jsou pro dítě stejně bezpečné jako v porodnici a levnější	Pilíř 2 (`Pil2.6`)	Birthplace in England 2011 (PMID 22117057); Schroeder 2012 (PMID 22517916)	Prospektivní kohorta 64 538 porodů s nízkým rizikem a ekonomická analýza; střední, přenos do ČR omezený jinou organizací péče	Ponechat s výhradou: plánovaný porod doma měl u prvorodiček vyšší riziko, proto studie staví na jednotkách při porodnici a komunitních asistentkách s dohodou o předání.

Č.	Tvrzení studie	Kde ve studii	Zdroj	Typ a síla důkazu	Ve v3
E13	Menší snížení lůžek bylo spojeno s větším poklesem úmrtnosti: jedno úmrtí méně na tři zachovaná lůžka	Pilíř 2, pojistky	Siverskog 2022 (PMID 36206659)	Ekologická studie 21 švédských regionů, 2001–2019; slabá až střední	Zmírnit a uvést přesně jako jednu studii: regiony s menším snížením lůžek měly větší pokles úmrtnosti, ekvivalent jednoho úmrtí na tři zachovaná lůžka. Nejde o pravidlo pro české kraje s obložností standardních lůžek 56 %.
E14	Nový Zéland snížil počet lůžek o třetinu při zachování přístupu	Pilíř 2, ilustrace	Davis 2007 (PMID 18007169)	Trendová a víceúrovňová analýza 6,6 mil. propuštění, 1988–2001; slabá	Ponechat jako ilustraci s cenou: délka pobytu klesla na polovinu, opakované příjmy vzrostly o čtvrtinu a zlepšování úmrtnosti se zpomalilo. Podporuje podmínku J7.
E15	Obložnost nad 85 % zvyšuje úmrtnost o 9 %	Pilíř 2, pojistka (stop přeměny v kraji)	Madsen 2014 (PMID 25006151); Eriksson 2017 (PMID 27981468)	Observační studie 2,65 mil. přijetí v Dánsku; systematický přehled 52 studií (vyšší úmrtnost ve 18 z 30 studií); střední	Ponechat jako pojistku, psát „souvisí s“, ne „způsobuje“. Madsen porovnával vysokou a nízkou obložnost; práh 85 % je konvenční hranice nedostatku lůžek.

Pilíře 3 až 5: technologie, daně, paliativa

Č.	Tvrzení studie	Kde ve studii	Zdroj	Typ a síla důkazu	Ve v3
E16	AI zapisovatel zkracuje čas na dokumentaci o asi desetinu	Pilíř 3	Lukac 2025 (PMID 41497288); Afshar 2025 (PMID 41625485); Chowdhury 2026 (PMID 41729180)	Tři RCT; střední (malé efekty, krátké sledování, nástroje se lišily)	Zmírnit: v RCT 238 lékařů zkrátil čas jen jeden ze dvou nástrojů (Nabla −9,5 %), druhý (DAX) nezměnil nic; nástroje se použily u 33,5 % a 29,5 % návštěv, nepřesnosti byly „občasné“. Afshar (66 zdravotníků): −0,36 h denně, úbytek práce mimo pracovní dobu nebyl robustní. Chowdhury (nalezeno, ve v3 necitováno) srovnával dva nástroje bez skupiny bez zapisovatele. Chybovost a čistý čas po kontrole měří pilot.
E17	Dálkové sledování snižuje hospitalizace při srdečním selhání	Pilíř 3	De Lathauwer 2025 (PMID 39834044); Clemente 2024 (DOI)	Dvě metaanalýzy RCT (41 studií, 16 312 pacientů; 16 studií, 4 629 pacientů); silná	Ponechat. První hospitalizace pro srdeční selhání OR 0,78, úmrtnost OR 0,81; po hospitalizaci pro dekompenzaci hospitalizace z jakékoli příčiny RR 0,82. Intervence jsou nesourodé, průměrné sledování 9,9 měsíce.
E18	Minimální cena alkoholu: Skotsko −13,4 % úmrtí	Pilíř 4	Wyper 2023 (PMID 36963415)	Kontrolovaná analýza přerušených časových řad (Skotsko proti Anglii); silná pro Skotsko	Ponechat s upřesněním: −13,4 % úmrtí plně připisovatelných alkoholu, hospitalizace −4,1 % (nevýznamné). Přenos „poloviční účinku“ na Česko je scénář bez opory a tak se i označí.
E19	Pásmová daň ze slazených nápojů snižuje prodeje	Pilíř 4, J9	Andreyeva 2022 (PMID 35648398); Rogers 2023 (PMID 36701272)	Systematický přehled a metaanalýza 86 studií (62 v metaanalýze); analýza přerušených časových řad u dětí; silná pro ceny a prodeje	Ponechat: promítnutí do ceny 82 %, pokles prodejů 15 %, elasticita −1,59; změna spotřeby nevýznamná. Rogers: nižší obezita jen u dívek ve věku 10 až 11 let (−1,6 p. b.), proto zdravotní účinek nezapočítávat.
E20	Domácí a mobilní paliativní péče umožní víc lidem zemřít doma	Pilíř 5	Gomes 2013 (PMID 23744578)	Systematický přehled a metaanalýza 23 studií (16 RCT); silná pro místo úmrtí	Doplnit: v2 má pro paliativní týmy jen odhad kapacity, ne recenzovanou oporu. Domácí paliativní péče zvyšuje šanci úmrtí doma (OR 2,21) a mírně snižuje zátěž příznaky; nákladová efektivita je neprůkazná.

Citace, které se ve v3 mění

Citace v2	Výsledek ověření	Ve v3
Kringos 2013 (Health Affairs)	Nalezeno: Kringos DS a kol., Health Aff 2013;32(4):686–94, PMID 23569048, DOI. Vyhledání podle citace v posudku selhalo, vyhledání podle tématu uspělo.	Ponechat s DOI
Chowdhury 2026 (JAMIA)	Nalezeno: Chowdhury A a kol., JAMIA 2026;33(5):990–9, PMID 41729180, DOI. Randomizovaná zkřížená studie 160 lékařů; porovnává dva nástroje, čas mimo pracovní dobu se významně nelišil.	Nalezeno, ve v3 necitováno (studie srovnává jen dva nástroje mezi sebou)
ESB 2026 (Teorie změny, bod 4)	Nedohledáno: v seznamu zdrojů v2 chybí a PubMed ani Consensus odpovídající práci nenašly.	Nedohledáno — ve v3 vypuštěno
„80 % problémů za čtvrtinu nákladů“, „ztráty z nemocnosti přes 400 mld. Kč“ (podklady z Drivu)	V textu v2 se nevyskytují.	Do v3 nepřenášet bez primárního zdroje

Seznam zdrojů

Studie cituje 4 skupiny zdrojů: datové, legislativní, odborné (32 ověřených citací) a vlastní podklady strany, které se necitují. Za základní datový zdroj lůžek platí ÚZIS/NZIP; OECD slouží jen k mezinárodnímu srovnání.

Datové zdroje

Poskytovatel	Datové sady a dokumenty	Použití a poznámka
ÚZIS ČR, NZIP	Datové souhrny OIS-11-24 (náklady pojišťoven podle segmentů), OIS-11-20, OIS-11-47, OIS-11-28 a OIS-11-49 (lůžka), SSS-05-02 a SSS-05-03 (obložnost), NR-28-02, OIS-13-01 (predikce příspěvku na péči), PPS-02-01, PPS-08-01; Národní registr hospitalizovaných; Lékárenská péče 2025	Základ pro lůžka: 48 036 akutních lůžek v roce 2024 (4,4 na 1 000 obyvatel)
OECD	Health Statistics (DF_PHYS, DF_BEDS_ICU, DF_BEDS_FUNC, DF_IMMUN, DF_GRAD); Health at a Glance 2025; Rámec pro hodnocení výkonnosti zdravotního systému v ČR (2023)	Jen mezinárodní srovnání (3,99 akutních lůžek na 1 000)
Eurostat	hlth_rs_prs2, hlth_rs_physcat, hlth_cd_asdr2, isoc_ci_ac_i	Mezinárodní srovnání počtu lékařů, standardizované úmrtnosti a využívání internetu
ČSÚ a MPSV	Projekce obyvatelstva 2023 a krajská projekce 12/2024; Zdravotnické účty 2024; Spotřeba potravin 2024; Vybrané údaje o sociálním zabezpečení 2024; ISPV 2025	ISPV: plat sestry 62 177 Kč, odvody 33,8 %
Národní rozpočtová rada	Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 2026, tab. D.1	Mezera 59,6 a 104,2 mld. Kč podle v2. Ověřit: hodnoty z primárního zdroje, posudek je neověřil
APSS ČR	Deloitte pro APSS ČR: Studie dlouhodobé sociální péče v ČR (6/2026)	Do 2035 asi 35 tisíc pobytových míst (76 → 111 tisíc) a 21 000 pečovatelů navíc; jen sociální služby
Přecechtěl a Hlávka	Studie efektivního zdravotnictví (2025)	Jediný zdroj čísla 39 000: potřeba nových lůžek dlouhodobé a následné péče do 2035, zdravotních i sociálních
MZ ČR (datový zdroj)	MZ ČR, Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví 2025, verze 2.0 (stav k 1. 8. 2025), https://nzip.cz/koncepce2025; v textu „MZ ČR 2025, s. X“	Použito jen k ověření dat: sestry a program pro nelékařské profese, lůžka následné péče, produkce akutní lůžkové péče, DRG, rezidenční místa, eRecept a eŽádanka, screening, kompetence sester, IROP, NIKEZ, AZV. Kde existuje primární zdroj, je uveden vedle
MZ ČR a státní správa	Implementační plán 2.1 Reforma primární péče (12/2025); vládní program pro nelékařské zdravotnické profese 2026–2037 (přes 12,8 mld. Kč; potřeba nejméně 24 000 úvazků všeobecných sester, výstupy 11 078 / 2 539 / 1 547); dotační program MZ Rezidenční místa 2023–2025; NIKEZ (nikez.mzcr.cz); Národní screeningové centrum ÚZIS; výzva IROP 2021–2027 k lůžkové následné péči; SÚKL, statistiky eReceptu 2024; Agentura pro zdravotnický výzkum; Zpráva o fungování systému stížností 2026; Národní strategie klinických hodnocení 2035; Bilance ministra 9. 7. 2026; Portál lékaře a pacienta (pilotní provoz od 1/2026); SÚKL Výroční zpráva 2024; NKÚ 23/22; Celní správa ČR, statistiky inkasa	Úhrada, kompetence sester, eŽádanka, spotřební daně
Poslanecká sněmovna, VZP	Sněmovní tisky 235 a 280/0; VZP 15. 7. 2026 (týmové praxe)	Platba státu, týmové praxe
Zahraniční a mezinárodní	WHO Regional Office for Europe, 30. 9. 2025: WHO/Europe report outlines steps to protect households in Czechia from increasing out-of-pocket payments; European Observatory (Spain HSR 2024, Health System Summaries NL a DK 2024); ERS 2016; Nivel 2024; HMRC, Soft Drinks Industry Levy statistics; Institute for Government (SDIL); Decreto-Lei 103/2023; RD 137/1984; Søvsø 2019	Zkušenosti ze zahraničí, SDIL, katastrofické výdaje domácností
Třetí strany	PAQ Research: Jak na zdanění slazených nápojů (10/2023)	Horní odhad výnosu (12–17 mld. Kč), do rozpočtu reformy se nepočítá
HSPA Monitor (skorezdravotnictvi.cz)	Deset až patnáct miliard (16. 8. 2026), propočet výnosu daní	Provozují autoři studie; uvádět jako nástroj, ne jako nezávislý zdroj, a výslovně v pasaži o střetu zájmů

Ověřujeme

Legislativní zdroje

Předpisy se citují v konsolidovaném znění k 20. 10. 2026. Sloupec o využití vychází z textu v2; název je uveden jen tam, kde je jistý.

Předpis	Název nebo předmět	Využití ve studii
Zákon č. 48/1997 Sb.	o veřejném zdravotním pojištění	§ 17 odst. 5 (smlouva týmu), § 17a a § 22b (propojení se sociální péčí)
Zákon č. 372/2011 Sb.	o zdravotních službách	nová hlava o primární péči; § 7a (pohávka), § 11c (telemonitoring)
Zákon č. 592/1992 Sb.	o pojistném na veřejné zdravotní pojištění	§ 3c, platba státu (J10)
Zákon č. 108/2006 Sb.	o sociálních službách	§ 36 (sdílené financování), § 52 (zrušení od 1. 1. 2029)
Zákon č. 38/2025 Sb.	novela: strop podle § 22b a zrušení § 52 zákona č. 108/2006 Sb.	vztah k vládním reformám
Zákon č. 300/2025 Sb.	reforma příspěvku na péči (účinnost převážně 1. 6. 2028, § 8a)	sdílené financování sociálně-zdravotní péče
Zákon č. 289/2025 Sb.	fond prevence pojišťoven od 2026; úhrada výplní	Pilíř 4, prevence

Předpis	Název nebo předmět	Využití ve studii
Zákon č. 290/2025 Sb.	novela: nemocniční ombudsman	zdravotnický ombudsman, stížnosti
Zákon č. 325/2021 Sb.	o elektronizaci zdravotnictví	novela s povinnou eŽádankou, § 31a (J5)
Zákon č. 353/2003 Sb.	o spotřebních daních	§ 70 (valorizace líhu a piva), tíchné víno (J8), pásmová daň (J9)
Zákon č. 96/2004 Sb. a zákon č. 378/2007 Sb.	o nelékařských zdravotnických povoláních; o léčivích (§ 80)	sestry v pokročilé praxi s předepisováním (balíček 3)
Zákon č. 40/1995 Sb.	o regulaci reklamy	zpřísnění reklamy na alkohol (2028)
Zákon č. 65/2017 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb.	o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; o obcích	zmocnění obcí omezit noční prodej alkoholu (2027)
Vyhláška č. 55/2011 Sb.	o činnostech zdravotnických pracovníků	rozšířené kompetence sester (J2)
Vyhláška č. 158/2022 Sb. a vyhláška č. 324/2024 Sb.	novely vyhlášky č. 55/2011 Sb.: činnosti sester bez indikace lékaře; kompetence specializované sestry v léčbě ran	výchozí stav kompetencí sester (Část I, J2)
Zákon č. 375/2022 Sb.	o zdravotnických prostředcích	předepisování vybraných zdravotnických prostředků sestrami (Část I)
Zákon č. 236/2025 Sb.	novela zákona č. 325/2021 Sb. o elektronizaci zdravotnictví, účinná od 1. 1. 2026	výchozí stav eŽádanky (J5 , Pilíř 3)
Vyhláška č. 99/2012 Sb.	o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb	minimální objemy výkonů, standard
Vyhláška č. 134/1998 Sb.	seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami	konzultace, nové výkony praktiků (J3), fluoridový lak
Vyhláška č. 30/2025 Sb.	telemonitoring (k § 11c zákona č. 372/2011 Sb.)	provoz telemonitoringu a zapisovatele
Vyhláška č. 380/2025 Sb.	minimální rozsah pohávky (asi 31 hodin týdně)	večery a víkendy
Vyhláška č. 70/2012 Sb. ve znění vyhlášky č. 403/2025 Sb.	preventivní prohlídky	krátká intervence u praktika
Vyhláška č. 107/2005 Sb.	o školním stravování	aktualizace (cukr, sůl)
Sněmovní tisky 235, 280/0 a 479	tisk 235: platba státu a vyměřovací základ; tisk 479: přímá volba do správních rad zaměstnaneckých pojišťoven	část o vládních reformách, tisk 479 mimo jádro
Evropské právo	směrnice Rady 92/83/EHS ve znění směrnice (EU) 2020/1151 (čl. 9a); rozhodnutí Komise 2012/21/EU (SGEI); rozsudek SDEU C-333/14 (minimální cena alkoholu, Skotsko)	spotřební daň z vína, veřejná podpora, minimální cena
Judikatura	nález Pl. ÚS 36/11 (20. 6. 2013), který zrušil úpravu nadstandardu z novely 298/2011 Sb.	Fond rozšířené péče; Ověřit: rozsah výroku (právník, 2027)

Ověřujeme

Ověřit: čl. 9a směrnice 92/83/EHS a obsah reformy pojištění 2030 (zatím jen vnitřní připomínkové řízení) z primárního zdroje. Názvy zákonů č. 300/2025 a 289/2025 Sb. a vyhlášek č. 30/2025, 380/2025 a 403/2025 Sb. uvádí v2 jen podle předmětu; před tiskem doplnit úřední název z e-Sbírky.

Ověřujeme

Odborná literatura

Ze 29 citací níže je 27 ověřeno v PubMed a 2 přes Consensus (Clemente 2024, Kegreiss 2026; PMID nebyl nalezen). Položky jsou seřazeny abecedně.

- Afshar M a kol. A Pragmatic Randomized Controlled Trial of Ambient Artificial Intelligence to Improve Health Practitioner Well-Being. NEJM AI 2025;2(12). PMID 41625485 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41625485/), DOI 10.1056/aioa2500945 (https://doi.org/10.1056/aioa2500945)
- Andreyeva T a kol. Outcomes Following Taxation of Sugar-Sweetened Beverages: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open 2022;5(6):e2215276. PMID 35648398 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35648398/), DOI 10.1001/jamanetworkopen.2022.15276 (https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.15276)
- Barker I a kol. Association between continuity of care in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive conditions. BMJ 2017;356:j84. PMID 28148478 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28148478/), DOI 10.1136/bmj.j84 (https://doi.org/10.1136/bmj.j84)
- Bates SM a kol. Can multidisciplinary teams improve the quality of primary care? A scoping review. eClinicalMedicine 2025;88:103497. PMID 41181853 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41181853/), DOI 10.1016/j.eclinm.2025.103497 (https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103497)
- Birthplace in England Collaborative Group. Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011;343:d7400. PMID 22117057 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22117057/), DOI 10.1136/bmj.d7400 (https://doi.org/10.1136/bmj.d7400).
- Chowdhury A a kol. Comparing ambient scribes: a randomized crossover clinical trial. JAMIA 2026;33(5):990–999. PMID 41729180 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41729180/), DOI 10.1093/jamia/ocag018 (https://doi.org/10.1093/jamia/ocag018)
- Clemente M a kol. Long-term impact of home-based monitoring after an admission for acute decompensated heart failure. eClinicalMedicine 2024;71:102541. DOI 10.1016/j.eclinm.2024.102541 (https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102541) (Consensus)

- Davis P a kol. Do hospital bed reduction and multiple system reform affect patient mortality? Med Care 2007;45(12):1186–94. PMID 18007169 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18007169/), DOI 10.1097/MLR.0b013e3181468c92 (https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e3181468c92)
- De Lathauwer ILJ a kol. Remote patient monitoring in heart failure. Eur J Heart Fail 2025;27(9):1670–85. PMID 39834044 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39834044/), DOI 10.1002/ejhf.3568 (https://doi.org/10.1002/ejhf.3568)
- Eriksson CO a kol. The Association Between Hospital Capacity Strain and Inpatient Outcomes in Highly Developed Countries. J Gen Intern Med 2017;32(6):686–96. PMID 27981468 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27981468/), DOI 10.1007/s11606-016-3936-3 (https://doi.org/10.1007/s11606-016-3936-3)
- Gomes B a kol. Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness. Cochrane Database Syst Rev 2013;(6):CD007760. PMID 23744578 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23744578/), DOI 10.1002/14651858.CD007760.pub2 (https://doi.org/10.1002/14651858.CD007760.pub2) (nově navrženo pro Pilíř 5)
- Grilli R a kol. The effects of centralizing cancer surgery on postoperative mortality. J Health Serv Res Policy 2021;26(4):289–301. PMID 33944635 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33944635/), DOI 10.1177/13558196211008942 (https://doi.org/10.1177/13558196211008942)
- Habicht T, Kasekamp K, Webb E. 30 years of primary health care reforms in Estonia. Health Policy 2023;130:104710. PMID 36764032 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36764032/), DOI 10.1016/j.healthpol.2023.104710 (https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104710)
- Karimi M a kol. Bundled payments for chronic diseases increased health care expenditure in the Netherlands. Health Policy 2021;125(6):751–9. PMID 33947604 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947604/), DOI 10.1016/j.healthpol.2021.04.004 (https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2021.04.004)
- Kegreiss S a kol. Impact of multiprofessional collaboration in primary care practices on continuity of care: a scoping review. BMC Prim Care 2026. DOI 10.1186/s12875-026-03507-y (https://doi.org/10.1186/s12875-026-03507-y) (Consensus)
- Kovacevic L a kol. The impact of collaborative organisational models and general practice size on patient safety and quality of care in the English NHS. Health Policy 2023;138:104940. PMID 37976620 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37976620/), DOI 10.1016/j.healthpol.2023.104940 (https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104940)
- Kozhimannil KB a kol. Association Between Loss of Hospital-Based Obstetric Services and Birth Outcomes in Rural Counties in the United States. JAMA 2018;319(12):1239–47. PMID 29522161 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29522161/), DOI 10.1001/jama.2018.1830 (https://doi.org/10.1001/jama.2018.1830)
- Kringos DS a kol. Europe's strong primary care systems are linked to better population health but also to higher health spending. Health Aff 2013;32(4):686–94. PMID 23569048 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23569048/), DOI 10.1377/hlthaff.2012.1242 (https://doi.org/10.1377/hlthaff.2012.1242)
- Laurant M a kol. Nurses as substitutes for doctors in primary care. Cochrane Database Syst Rev 2018;(7):CD001271. PMID 30011347 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30011347/), DOI 10.1002/14651858.CD001271.pub3 (https://doi.org/10.1002/14651858.CD001271.pub3)
- Lukac PJ a kol. Ambient AI Scribes in Clinical Practice: A Randomized Trial. NEJM AI 2025;2(12). PMID 41497288 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41497288/), DOI 10.1056/aioa2501000 (https://doi.org/10.1056/aioa2501000)
- Madsen F a kol. High levels of bed occupancy associated with increased inpatient and thirty-day hospital mortality in Denmark. Health Aff 2014;33(7):1236–44. PMID 25006151 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25006151/), DOI 10.1377/hlthaff.2013.1303 (https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.1303)
- Magnée T a kol. Consultations in general practices with and without mental health nurses. BMJ Open 2016;6:e011579. PMID 27431902 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27431902/), DOI 10.1136/bmjopen-2016-011579 (https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011579)
- McDonald T a kol. The Impact of Primary Care Clinic and Family Physician Continuity on Patient Health Outcomes. Ann Fam Med 2024;22(3):223–9. PMID 38806258 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38806258/), DOI 10.1370/afm.3107 (https://doi.org/10.1370/afm.3107)
- Paier-Abuzahra M a kol. Effects of task-shifting from primary care physicians to nurses: an overview of systematic reviews. Hum Resour Health 2024;22:74. PMID 39529012 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39529012/), DOI 10.1186/s12960-024-00956-3 (https://doi.org/10.1186/s12960-024-00956-3)
- Penfold C a kol. Additional Roles Reimbursement Scheme uptake, patient satisfaction, and QOF achievement. Br J Gen Pract 2025;75(750):e35–42. PMID 38936883 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38936883/), DOI 10.3399/BJGP.2024.0083 (https://doi.org/10.3399/BJGP.2024.0083)
- Pereira Gray DJ a kol. Continuity of care with doctors: a matter of life and death? BMJ Open 2018;8:e021161. PMID 29959146 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29959146/), DOI 10.1136/bmjopen-2017-021161 (https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-021161)
- Rogers NT a kol. Associations between trajectories of obesity prevalence in English primary school children and the UK soft drinks industry levy. PLoS Med 2023;20(1):e1004160. PMID 36701272 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36701272/), DOI 10.1371/journal.pmed.1004160 (https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004160)
- Sandall J a kol. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Syst Rev 2016;(4):CD004667. PMID 27121907 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27121907/), DOI 10.1002/14651858.CD004667.pub5 (https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5).
- Sandvik H a kol. Continuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care. Br J Gen Pract 2022;72(715):e84–90. PMID 34607797 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34607797/), DOI 10.3399/BJGP.2021.0340 (https://doi.org/10.3399/BJGP.2021.0340)

- Schroeder E a kol. Cost effectiveness of alternative planned places of birth in woman at low risk of complications: evidence from the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2012;344:e2292. PMID 22517916 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22517916/), DOI 10.1136/bmj.e2292 (https://doi.org/10.1136/bmj.e2292).
- Siverskog J, Henriksson M. The health cost of reducing hospital bed capacity. Soc Sci Med 2022;313:115399. PMID 36206659 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36206659/), DOI 10.1016/j.socscimed.2022.115399 (https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115399)
- Wyper GMA a kol. Evaluating the impact of alcohol minimum unit pricing on deaths and hospitalisations in Scotland. Lancet 2023;401(10385):1361–70. PMID 36963415 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36963415/), DOI 10.1016/S0140-6736(23)00497-X00497-X>)

Další citace z přílohy E studie v2 nebyly pro v3 znovu ověřeny a do textu v3 se přenesou jen po ověření PMID nebo DOI: Robinson 2021, O'Donnell 2019, Anderson 2021, Rehm 2022, Wagenaar 2009, Nelson 2013 a 2014, Guindon 2022, Kilian 2023, Šteleméкas 2021, Tran 2022, Manthey 2023, Holmes 2014, Teng 2019, Scarborough 2020, Cobiac 2024, Emmert-Fees 2023, Colchero 2017, Baker 2020, Wranik 2019, Mitchell 2015, Ito 2024, Kasekamp 2025, Badora-Musiał 2021, Karasiewicz 2020, Kósa 2020, Bramwell 2024, McDermott 2025, McManus 2018, Örtqvist 2021, Avdic 2024, de Linde 2025, Asheim 2025 a další. Ověřit: DOI u každé z nich před tiskem.

🔍 **Ověřujeme**

Vlastní podklady strany

Podklady z Drivu a Notionu jsou interní a necitovatelné. Každé číslo z nich se musí dohledat v primárním zdroji, jinak se ve v3 nepoužije.

Podklad	Stav	Pravidlo pro v3
Akční plán HS (PEER, 10/2026)	interní podklad, necitovatelný	Čísla citovat z veřejné Hospodářské strategie PEER (cíl daní za zdraví 10 až 15 mld. Kč)
Strukturální reforma Česka v6 (9/2026)	interní podklad, necitovatelný	Nepoužívat jako zdroj
Zdravotnictví pro 21. století (5/2026)	interní podklad, necitovatelný	Rozdíl vzhledem k v3 (regulační poplatky se nenavrhují) lze zmínit v textu
Zdravotnictví do hospodářské strategie V1 (5/2026)	interní podklad, necitovatelný	Obsahuje čísla bez zdroje; nepřebírat
Reforma zdravotnictví: Teze a důkazy (2/2026)	interní podklad, necitovatelný	Výstup AI rešerše s průmyslovými a americkými zdroji; využít jen jako seznam stop k primárním zdrojům
Notion: wiki Zdravko 2025–2029 a legislativní hlídka (týden 43/2026)	interní podklad, necitovatelný	Stav legislativy ověřit v e-Sbírce a na webu Sněmovny
Dopis MUDr. Pavla Neňičky (2023)	interní podklad, necitovatelný	Postoj (zachovat PLDD, dětské týmy) převést do konzultace s SPLDD ČR
Pirátská hospodářská strategie (PEER, 8/2026; majak.pirati.cz/documents/647)	schválený program strany	Východisko studie (oddíl „Z čeho studie vychází"); citovat jako program strany, ne jako důkaz
Manifest reformy českého zdravotnictví (7. 5. 2026); Stanovisko Pirátů k návykovému chování	dokumenty strany	Citovat jen veřejně dostupná znění, jako postoj strany, ne jako důkaz
HSPA Monitor a repozitář HSPA	vlastní nástroj autora	Uvádět jako nástroj; hodnoty ověřit v primárních datech (kapitoly se stavem review-pending se v číslech samy rozcházejí)

Co zůstává ověřit před zveřejněním

- Ověřit: mezeru 59,6 a 104,2 mld. Kč v NRR 2026, tab. D.1, z primárního zdroje.

🔍 **Ověřujeme**

- Ověřit: výsledek třetího čtení tisku 235.

🔍 **Ověřujeme**

- Ověřit: obsah a stav reformy pojištění 2030 (zatím jen vnitřní připomínkové řízení) a parametry reformy hygienické služby.

🔍 **Ověřujeme**

- Ověřit: jednu definici rezerv pojišťoven (zůstatek základních fondů ke konci 2025) a její zdroj; hodnoty 43,2, asi 32 a 45,7 mld. Kč vysvětlit definicemi.

🔍 **Ověřujeme**

- Ověřit: čísla o Estonsku (60 středisek, 56 % populace) v plném textu Habicht 2023.

🔍 **Ověřujeme**

- Ověřit: ISPV 2025, plat sestry 62 177 Kč a odvody 33,8 %, v původní tabulce.

🔍 **Ověřujeme**

Jak poslat připomínku

Čte se vám to lépe jako PDF? Tady je celá studie.

Připomínky nám ale prosím pošlete souhrnně, ne jako poznámky vepsané do PDF. Nejlepší cesta je formulář na webu **https://web-b5qk.vercel.app/studie**: u každého odstavce je tlačítko „Připomínka“ a dole na stránce formulář pro připomínku ke studii jako celku. Stačí jméno a e-mail; nic z toho nezveřejňujeme. Pokud píšete za organizaci, pošlete jednu souhrnnou připomínku s odkazem na část a odstavec studie.

Interaktivní grafy, časové osy a kalkulačky jsou ve čtečce na webu; v PDF jsou jejich statické podoby. Místa označená „Ověřit“ jsou údaje, které autoři zatím neověřili v primárním zdroji.

Dokument vygenerovaný z webové čtečky studie dne 25. 10. 2026. Aktuální znění, vypořádání připomínek a seznam otevřených ověření jsou na https://web-b5qk.vercel.app/studie.